

目 录

序

绪论..... 1

针灸保健（15则）..... 1a

常灸三里说（1.2）..... 14

保命灼艾第一说（3）..... 14

艾灸防疫说（4）..... 19

多灸延年说（5）..... 15

气海常温说（6.7）..... 15

鼠类灸脐说（8）..... 15

岁灸丹田说（9）..... 16

颊灸关元说（10）..... 16

中风预防灸（11）..... 16

灸防疟病说（12）..... 17

产后自灸说（13）..... 17

灸扶阳气说（14）..... 17

蒸脐防病说（15）..... 18

针灸急症（24则）..... 19

尸厥（16~22）..... 19

热厥（23）..... 24

气厥（24~26）..... 24

暑厥（27.28）..... 27

血厥（29）..... 29

食厥（30）..... 29

痰厥（31.32）..... 30

疫毒昏厥（33）..... 31

呼吸骤停 (34,35)	32
中风 (36)	34
溺水 (37)	37
青霉素过敏性休克 (38)	37
跌仆 (39)	39
头面五官病症 (86则)	41
头疾 (22则)	41
头痛 (40~44)	41
眩晕 (45~56)	43
中毒性脑病后遗症 (57)	49
斑秃 (58~61)	51
面疾 (8则)	54
头面肿 (62~64)	54
面疾 (65)	56
口眼喎斜 (66~69)	56
目疾 (12则)	58
目赤 (70,71)	58
目痛 (72)	59
暴盲、失明 (73~78)	60
金针拨翳 (79,80)	63
斜视 (81)	63
鼻疾 (7则)	64
鼻渊 (82)	64
鼻干 (83)	65
衄血 (84~87)	65
鼻息肉 (88)	67
口齿疾 (13则)	68
木舌 (89)	68
舌肿痛 (90,91)	68

舌出不入 (92)	69
吐舌 (93)	70
失语 (94)	71
牙痛 (95~99)	71
牙关脱臼 (100)	74
牙槽风 (101)	74
咽喉疾 (21则)	75
咽喉肿痛 (102~116)	75
乳蛾 (117~119)	81
音哑 (120~121)	82
梅核气 (122)	83
耳疾 (3则)	84
耳肿痛 (123)	84
耳鸣 (124)	85
耳聋 (125)	85
中身病症 (103则)	85
胸部疾 (17则)	86
咳嗽 (126~131)	86
哮喘 (132, 133)	88
心痹 (134~138)	89
心律失常 (139~141)	91
怔忡 (142)	95
腹部疾 (63则)	96
黄疸 (143~147)	96
慢性肝炎 (148)	97
蛔厥 (149)	98
急性胰腺炎 (150)	99
痞气 (151~155)	101
呃逆 (156~158)	104

噎气 (159,160)	105
噎膈 (161)	106
反胃 (162,163)	107
胃脘痛 (164~169)	109
腹痛 (170~176)	111
霍乱 (177,178)	114
食物中毒 (179,180)	116
泄泻 (181~187)	117
痢疾 (188~199)	120
疝气 (200~205)	125
背腰疾 (8 则)	127
曲背 (206)	127
腰痛 (207~213)	128
二阴病症 (15 则)	130
前阴臊臭 (214)	130
淋浊 (215~219)	131
遗精 (220)	134
阳萎 (222)	134
急性腮腺炎合并睾丸炎 (222)	136
肠风便血 (223~227)	137
疮癖 (228)	139
四肢病症 (52 则)	140
痿症 (229,230)	140
痹症 (16 则)	140
肩痹 (231~235)	140
臂痹 (236,237)	142
指痹 (238)	143
腿痹 (239~241)	143
膝痹 (242)	145

足痹 (243, 244)	145
骨痹 (245)	146
痹风 (243)	147
手足麻木 (247, 248)	147
枯涩痹 (249)	148
腰脚痛 (250, 251)	149
坐骨神经痛 (252)	149
脚气 (253~258)	150
脚肿 (259)	152
转筋 (260)	153
脚蹠 (261)	153
历节风 (262)	153
手足抽搐症 (263)	154
伤足 (264)	155
中风后遗症 (265~280)	156
全身性病症 (66则)	166
伤寒 (281~284)	166
流行性出血热 (285, 286)	168
虚劳 (287~296)	169
高血压 (297)	173
癲、狂、痫 (298~317)	176
邪祟 (318~321)	184
郁症 (322~325)	186
肿胀 (325~334)	187
疟疾 (335~337)	191
消渴 (337)	192
多汗 (339, 340)	193
痰火 (341, 342)	193
痹风 (343, 344)	194
肾风 (345)	195

无脉症 (346)	196
儿科病症 (16则)	198
急、慢惊风 (347~356)	198
脐风 (357)	203
疳疾 (358)	203
胸前突起 (359)	204
赤丹 (360~362)	205
妇科病症 (24则)	206
痛经 (363, 364)	206
崩漏 (365, 366)	207
带下 (367)	208
阴部瘙痒 (368, 369)	209
热入血室 (370)	211
脱脐 (371)	211
难产 (372~379)	212
引产 (380)	216
产后昏厥 (381~384)	217
产中假死 (385)	218
产后风 (386)	219
外科病症 (79则)	220
瘰癧 (387~396)	220
瘰 (397)	223
胶瘤 (398)	223
破伤风 (399)	224
痈疽 (17则)	224
喉内痈 (400)	224
乳痈 (401~404)	224
肠痈 (405, 406)	228
臀痈 (407, 408)	231

腿痈 (409)	232
臀痈 (410)	232
天疽 (411)	234
心口疽 (412)	234
脱疽 (413~416)	235
发背 (417~425)	236
疮疡 (426~431)	241
漏疮 (432)	243
杨梅疮 (429, 430)	244
疔 (433~434)	245
疖 (445)	251
流注 (446, 447)	252
痰核 (448)	252
鹤膝风 (449)	253
赘瘤 (450~452)	254
蛇丹 (453)	255
瘰 (454)	256
身痒 (455)	257
遍身青 (456)	258
紫癜风 (457)	258
箭伤 (458)	259
虫兽伤 (7 则)	259
狼咬伤 (459)	259
犬咬伤 (460~462)	259
蝎螫 (463)	261
毒蛇咬伤 (464, 465)	262

绪 论

脉案、医案、医话概念 “脉”，《说文解字》释作“血理分表^{〔1〕}行体者”。本指脉（血）管；或作血气运行之道。后来，文人墨客也将它作为中医诊断学的代词，如《三国志·魏书·华佗传》：“广陵太守陈登得病，肺中烦懣，面赤不食。佗脉之曰：府君胃中有虫数升，欲成内疽，食醒物所为也。”这里的“脉”，已经由原来的名词当作动词使用，非独切脉之谓，而是在脉诊的过程中，包括了望、闻、问诊的全部内容。“案”，诊也。《汉书·王嘉传》：“内侍案脉”；或作考解，如《汉书·贾谊传》：“案之当今之务”。《正字通》曰：“凡官府兴除成例，及狱讼论定者，皆曰案。”中医所说的“案”，意义亦由此引伸，如清·俞震纂辑的《古今医案按》曾曰：“医之有方案，犹刑名家之例案也。……执律以绳人罪，其轻重出入，必有例案。医之治病，亦犹是也。”“脉”、“案”两字连用，用现在的话说，就是中医诊治病症过程的原始文字记录。它的特点是即时书就、短小精悍、重点突出、简单明了。与现在的门诊病历雷同。例如：

范郎中夫人。中统五年八月二十日。先因劳役，饮食失节，加之忧思气结，病心腹胀满，旦食则呕，暮不能食，两胁刺痛，

诊其脉弦而细。《黄帝内经·五乱》篇云：清气在阴，浊气在阳，乱于胸中，是以大惋。《内经》曰：清气在下则生飧泄，浊气在上则生真胀，此阴阳返作病之逆从也。至夜，浊阴之气当降不降，腹胀尤甚。又云：脏寒生满病。大抵阳气运化精微，聚而不散，故为胀满。先灸中脘穴，乃胃之募，引胃中生发之气上行，次以补中益气汤助之。

（《卫生宝鉴》）

脉案经过本人或他人加工整理以后的成品称之为医案。一些脉案中所无而实际上所有的有关内容，在整理的过程中可以通过回忆、追询、分析、归纳后作出必要的补充，但应该实事求是，取舍适当，要从大处落墨，不要小题大作，更不能无中生有，画蛇添足。因此，医案的内容较脉案充实、完整。后之学者，苟能汲其精髓，摩其章法，则于四时疫病，大致楚楚，了如指掌，受惠无穷。它的特点是源于脉案而高于脉案。例如：

丁丑夏，锦衣张少泉公夫人。患病症二十余载，曾经医数十，俱未验。来告予，诊其脉，知病入经络，故手足牵引，眼目黑瞤，入心则搐叫，须依理取穴，方保得痊。张公营书而知医，非常人也。悉听予言，取鸠尾、中脘，快其脾胃；取肩髃、曲池等穴，理其经络，疏其痰气，使气血流通，而痛自定矣。次日即平安，然后以法制化痰健脾之药，每日与服。

（《针灸大成》）

医话，是中医著述中的一种体裁，类似当今文学中的随笔小品。它包括读书体会、临证心得、学术评论，以及掌故、见闻等等。前人称之为“话其闻见、心得、阅历”，具有“辅助医学，名流性灵”的作用。不过，医话中也有一种是医生自己的临床验案经过自己或他人的加工整理而成的。但它的写法与脉案、医案有所不同，往往由医生自己或他人用谈话

的形式进行描述，因而娓娓动听，引人入胜，增加了读者兴趣。它的特点是内容短小、题材广泛、文笔流畅、形式多变。它或论医理、或论医法、或记医家故实，或记医林中的遗闻轶事。可益人于广见博闻。所以，近人沈仲圭氏曰：“学医，最好读名家医话”。（见《清代名医医话精华》）例如：

许希，开封人。以医为业，补翰林医学。景佑元年，仁宗不豫，侍医数进药不效，人心忧恐。冀国大长公主荐希。希诊曰：“针心下包络之间，可亟愈。”左右争以为不可。诸黄门折以身试，试之无所害，遂以进针而帝疾愈。命为翰林医官，赐绯衣银鱼及器币。希拜谢已，又西向拜。帝问其故。对曰：“扁鹊，医师也。今者，非臣之功，殆臣师之赐，安敢忘师乎。”乃请以所得金兴扁鹊庙。帝为筑庙于城西隅，封灵应侯。其后庙益完，学医者归趋之。因立太医局于其旁。希至殿中省尚药奉御卒。著《神应针经要诀》行于世。

（《宋史·许希传》）

注

〔1〕褻(xì斜)：《释文》注“褻，亦作邪。”这里通斜，斜行，褻布之意。

二

脉案、医案、医话源流 脉案、医案、医话（以下简称案话）的缘起，在我国已颇具历史。如《周礼·医师章》曰：“凡民有疾病者，分而治之。死终，则各书其所以，而入于医师”，说明我国早在二千多年以前的东周和春秋早期已经有案话的书写和保管制度。不过，这些资料，今不复存。至于当时有无针灸案话，卒无考。目前我们所能见到的早期针灸案话，就其所出先后而论，似以医话为先。

关于医话的渊源，何廉臣氏曾说：“唐·王勃撰《医话序》一卷，即医话之鼻祖也。”（见《存存斋医话稿·序》）王勃，是唐代著名的文学家，唐初四杰之一，擅骈文律诗，所作《滕王阁序》，风格清新，对仗工稳，语言流利，更为世人叫绝。但《王安子集》及《中国医籍考》均不见有《医话序》著目，此论不知何出？其实，中医的医话之作，更远于唐。如《左传》所载医缓治晋景公姬嬖的膏肓之疾就是例证。尽管内容近乎荒诞，但它却真实地记录了医缓诊断明确，针药并用和期决死生的高超医技。再如《史记》中的扁鹊治虢太子尸厥，取三阳五会，砥针厉石，太子复苏。《后汉书·三国志》中的华佗治太祖头风等等，皆属医话。但医话专著的出现，约始于清代，如黄凯钧的《友渔斋医话》、刘奎的《松峰医话》、王孟英的《柳州医话》、陆以湜的《冷庐医话》等等，可谓繁富。在针灸学文献上，虽不乏有医话之作，然医话专著竟告阙如，实乃针坛憾事。

关于医案的渊源，近人刘蔚楚氏说：“医案之作，其滥觞于春秋时乎？《左传》记医缓之治晋侯；《国语》记医和之治平公。厥后，汉司马迁撰《史记》，传扁鹊、仓公而词益富，可引也。其传仓公，陈理精奥，说者谓非太史公所能，殆仓公自录，上之史氏者？太史公修饰而为之传，则又为自著医案之祖矣。”这些出之于文人之手的医家传记，给后人留下了先贤的宝贵经验。但就其体裁而论，这些都可归之于医话范畴。不过，仓公治病，必记病家姓名、性别、里居、症候、脉象、治疗经过及转归等等，已经初步具备了医案的基本格式。因此，“医案之起，起于西汉”之说，不无道理。若此论能够成立，那么仓公的针灸“诊籍”自然是针灸医案的始祖了。中医学中专事记录医案的专书，大约始于金元时

代，如元刻本的《罗谦甫治验集》，不过当时还不称医案。真正使用“医案”这个名词出版的专书，要首推明代汪机撰写的《石山医案》了。嗣后，新安医学派的《孙文恒医案》和江瓘父子选编的《名医类案》等也相继问世，但这些都是方药而不是针灸医案。在古代的针灸著作中，首先使用“针灸医案”这个名词的，要数明代著名针灸大师杨继洲的《针灸大成》。书载杨氏医案30则，内容丰富，义理精当，是杨氏毕生的心血结晶，几百年来，一直为针灸学界所称道。但专以针灸医案出现的著作，迨至晚清以后才续续而出，如清邓宪章等述编的《针灸医案》，民国姚寅生的《（增图编纂）针灸医案》、梅过居士的《针灸医案》等等。此外，还有一些虽不用“医案”之名而专记针灸治案的专著，如承淡安的《针灸治疗实验集》、赵尔康的《金针治验录》、沈佐廷的《沈氏针灸实验录》等等，都为继承和发扬针灸医学作出了贡献。

脉案之作，理应早于“医案”，因为脉案是医案的基础，医案是脉案的升华。换言之，没有脉案，便不可能会有医案。所谓“皮之不存，毛将安傅。”但从文献出现的先后时序看，医案专著却早于脉案专著。但这并不等于说脉案之作迟于医案之作，无论如何脉案是早于医案的。怎么会出现这种情况？可能与脉案乃即时书就，少留存底有关。及门弟子虽有抄方录案之习，亦多备作日后研习之用。若脉案有缘梓行成书，已经本人或他人加工整理，构成医案，而脉案本身，则往往因被医案取代而渐渐湮灭。所以，在中医文献上很少见有以“脉案”为名的专著。不过，文献上也有名曰医案而实为脉案或包含脉案的情况。如清·叶桂所撰的《临证指南医案》、程文囿的《程杏轩医案》、王泰林、方耕霞的《王旭高临证

医案》等，书中大部分案例仍然保留了随见随录的脉案形式。

三

脉案、医案、医话作用 何廉臣氏曾说：“案者治病之实录，临证之南针也。书多空泛，率意而为，论虽奇不能必其有用，理虽足不要次其可行。案则事实具在，难于假错，读书不如读案，古人已有言之者。”（见《重印全国名医验案类编》）论虽不无偏颇，但他充分表述了前人经验于后世临床的指导和参改价值。既可以摹章效法，吸取精华，提高临床疗效，也可以知虚虑谬，避免重蹈覆辙。其实，研习案话，不惟对临床医生，就是对基础理论研究也一样重要。

人云：案话是从一个侧面缩写了的一部中国医学史，处处反映了祖国医学来龙去脉的基本面貌。此虽非不刊之论，但也有其一定的道理。因为不同时代的案话，真实地反映了不同时代的医家、医事、医理、医方、医法……等等。它是实践的结晶，也是历史的见证。例如从医缓治晋景公一案，可以窥知早在春秋时期，祖国医学已有较高的诊断水平，从“攻之不可，达之不及，药不至焉”这段文字，便可以断定当时治病之法，已经是针、灸、药并用。但使用的针具还是（砭）石针。扁鹊治虢太子尸厥，文载“厉针砥石”，说明到了战国时期，金属针问世，在治疗上，已从单一的（砭）石针过渡到针、石并用；在临床方面，以针灸抢救危急病症，已经取得相当成就。从华佗治头眩用“铍刀决脉”和樊阿“针背入一二寸，巨阙胸藏针下五六寸”，以及华佗治督邮徐毅胃病误针等案，可知当时已以针代砭。这与“季世无复佳石，故以铁代之尔”（见服虔注《左传》）和“古者攻病则有砭，今其术绝矣”（见颜师古注《汉书·艺文志》）的记述完

全相符。淳于意的“诊籍”，表明早在西汉初年已经有病案书写；从窦材的医案里，不仅可以了解到当时灸法盛行，而且开始应用“睡圣散”先麻醉后施灸。透过窦材、张子和、李东垣的医案，说明宋元时期针灸已经出现温阳、泻血、补土等不同流派……等等。这些资料，不易在中医通史上读得，却能在案话中证实。

人云：案话是一部活的临床教科书，成败利钝，彰明较著。医学来源于实践，经过先民的不断总结，上升为理论，理论倒过来又指导实践。如此往复循环，将医学不断推向前进。案话多属临床实绩，功果得失，全在其中，读者一目了然。案中有同病异治者，法虽殊而功则一；有异病同治者，穴虽同而效则殊；亦有同病同治者，有方枘圆凿者；有一波未平，一波又作，跌宕起伏，化险为夷者；有方以为正，又复是奇，忽复是正，云谲波诡，不可纪极者，……略举数端，足见其内容之丰赡。变化出入，圆机活法，足可嘉惠后学。

四

脉案、医案、医话书写 通览中医文献，对于脉案、医案、医话的写法，一般都尽人而为，并无固定格式。但也有人作过专门研究。如明代嘉靖年间川医韩悉所撰的《韩氏医通》，首先提出了书写“病历”的格式；嗣后，喻嘉言的《寓意草》、丁雄飞的《行医八字图》，以及近人胡安邦的《百病诊断门径》等等，都自成体例，各有发明，为后人研究病历格式奠定了基础。

医案源于脉案，但高于脉案。脉案不一定成为医案，医案则必来自脉案。脱离脉案的医案，岂不成为无源之水，无本之木，虚泛浮漂空中楼阁，刻意杜撰，害人害己。因此，

若要写好医案，必先要写好脉案。但脉案之作，亦世无定式。纵观诸家，主要有以下几种：

一种是先列出症状、脉象，后分析病因、病机，最后拟出治法、经穴。如：

一人秋冬患肿，午前上甚，午后下甚，口渴乏力，脉涩弱，食减。此气怯，汗不能出，郁而为痿。遂灸肺俞、大椎、合谷、水分。

（《夷坚志》）

一种是先列出病因、症候，再阐述病机、治法、经穴。如：

壬申夏，户部尚书王疏翁，患痰火炽盛，手臂难伸。予见形体强壮，多是痰湿流注经络之中。针肩髃，疏通手太阴与手阳明经之湿痰，复灸肺俞穴，以理其本，则痰气可清而手臂能举矣。

（《针灸大成》）

一种是先述病因、病机，并出症候，然后提出治法、经穴、方义。如：

范郎中夫人。中统五年八月二十日。先因劳役，饮食失节，加之忧思气结，病心腹胀满，旦食则呕，暮不能食，两胁刺痛。诊其脉弦而细，……《内经》曰：清气在下则生飧泄，浊气在上则生腹胀，此阴阳反作，病之逆从也。至夜，浊阴之气当降不降，腹胀尤甚。又云：脏寒生满病。大抵阳主运化精微，聚而不散，故为胀满。先灸中脘穴，乃胃之募，引胃中生发之气上行。次以此方（即温中益气汤）助之。

（《卫生宝鉴》）

一种是先列出病机，次阐述症状，再分析病情，提出治法，最后开列处方、手法。如：

素体丰硕，痰湿滋生，风阳上扰，时有眩晕，右侧肢体行动不力，筋脉拘急，膝腠为甚，行履而须扶杖，言语无塞塞之象，寐

象时酣时醒，面红下肢寒冷，小溲频数有不禁之感，病起五年，目前尚属稳定。切脉寸口弦而带滑，颌厌、耳门脉大于足三脉，而又太冲较大，太溪细弱，冲阳脉平，脐下无悸动，舌苔薄黄腻。按脉论证，属上盛下虚之疾，预防复中。虽患者伴有多年痹症宿疾，指节挛屈，关节肿大。然揆度缓急，当以防治类中为此。处方：(1)风池(泻)，颌厌(泻)，丰隆(泻)，行间(泻)，太溪(补)，足三里(补)，涌泉(补)；(2)环跳，阳陵泉，侠溪，肩髃，曲池，合谷(左泻右补)。二次治左，一次治右；先取病侧，后取健侧。手法：捻转、提插。足三里用针向行气法，使气下行至足跗，涌泉用雷火针灸10分钟。

(《陆瘦燕针灸论著医案选》)

上述形式(除现代者外)，见仁见智，各有特点。看起来自由活泼，洒脱利落，但也存在着某些不足。主要表现在层次不够清晰，内容尚欠完整，给人有丢三落四之感，也不利于日后整理、使用。因此，有人主张脉案书写应该有一个基本格式。但内容也并不完全一致，现试举两则如下：

《韩氏医通》六法兼施病历格式

某处 有某人 某年、月、日 填医案(病历)一宗

望诊 望形(包括肥胖、瘦瘠；形长、中、短、魁、眇)

望色(包括赤、青、黑、白、黄，丰、润、枯、槁)

闻诊 闻声音(包括浊、下、清、高、平、短、细、暗、长、洪、散)

问诊 何处苦楚？何因所致？何日为始？昼夜孰甚？寒热孰多？喜恶何物？曾服何药？曾经何地？

切诊 切脉理

论病原 禀赋孰甚，其病今在何类，标本孰居，毕竟何如等

治方术 应用何法、何方

《寓医草》与门人议病式

某年、某月。某地。某人、年纪若干？

形之肥瘦长短若何？色之黑白枯润若何？声之清浊长短若何？人之形志苦乐若何？病始何日？初服何药？次后再服何药？某药稍效？某药不效？时下昼夜孰重？寒热孰多？饮食喜恶多寡？二便滑涩有无？脉之三部九候何候独异？二十四脉中何脉独见、何脉兼见？其症或内伤，或外感，或兼内外，或不内外？依经断为何病？其标本先后何在？汗、吐、下、和、寒、温、补、泻何施？其药宜用七方中何方？十剂中何剂？五气中何气？五味中何味？以何汤名加减和合？其功效验定于何时？一一详名、务令纤毫不爽，起众信从允为医门科式，不必演文可也。

这些格式，结构紧凑，内容全面，症、因、理、法、方、药，首尾连贯，一气呵成，当然是一种较好的格式。但作为门诊脉案（病历），似有精简的必要。现在一般的门诊脉案，大致包括以下几个部分的内容：

1.主诉：包括发病日期，治疗经过，目前情况，以及有关的已往病史等。

2.检查：包括望、闻、切诊（含脉象、经络腧穴压痛、敏感、迟钝等），以及现代医学的理、化检查等。

3.辨证：包括经络、脏腑、气血辨证；并根据辨证结果作出诊断。

4.治法：包括治疗原则、治疗处方、治疗手法等。

例如：

主诉：头痛年余。每逢神志紧张、疲劳时加剧。近来寐象不佳，终日头脑昏沉、肢软无力，而头痛益作，日发数次，每次痛如锥刺，有跳痛感，痛侧面部发烧，偶伴惊悸呃逆。痛极时用拳击局部或按摩，稍可缓解。

检查：精神萎靡，面色苍白，语沉无力，脉细而弦，舌干质紫。无肢瘫等现象。

辨证：长期失眠，心肾不交，以致精神萎靡，惊悸怔忡。平素纳谷欠香，则生化之源不济，气血不足，运行无力，血行不畅，不通则痛，血瘀也，脉弦舌紫可证。

诊断：偏头痛（血淤型）。

治法：疏经通络，活血化淤。

处方：太阳（左）透率谷 风池（左） 合谷（双）
列缺（左） 太冲（双） 侠溪（双）

手法：均用捻转泻法。

这种栏目式脉案，看起来就比较明晰醒目，能够较好地反映诊治过程中的基本内容。尽管给人有“框框”之限，但我们还偏向于这种格式。

一张好的脉案，应该对每一病症的症状、病因、检查、辨证、诊断以及治则，处方等等作出比较全面的记述，使人读后有亲临其症、亲听其言之感。不能只记述症状、处方，不分析病因病机，不作出明确诊断，也没有治疗大法。严格地说，这仅仅是一种对症治疗，缺乏理论阐明，这样，使读者只知其然而不知其所以然，得不到多大的帮助和启发。

一张好的脉案，内容丰富固然重要，而且要求记述得系统、条理，不能凌乱芜杂，纠缠不清，更不能主次颠倒。重

重复复。譬如，某医记胃脘痛：先述患者大便燥结，三日一行；次述胃脘作痛，两胁胀满；再说口苦纳呆，泛泛欲呕；脘腹腹胀；疼痛拒按；口干、咽痛、面赤易怒……等等。把上部症状和下部症状、局部症状和全身症状、自觉症状和医生观察到的症状等等，夹杂纠缠，主次不分。

一张好的脉案，还应该做到脉因相符，症治相合。但在不少脉案中，还存在着病因和脉症不符，脉症和理法脱节，理法和处方不合等现象。也就是说，症、因、理、法、方、穴不能有机地结合，这样，容易造成主次颠倒，前后脱节，析理片面，自相矛盾。因此，要写好脉案，对每一病症的成因、表现、分型、治则、处方等等要有一个明确完整的概念，做到心中有数，这样，写起来才能抓住要点，有的放矢。

另外，一张好的脉案，文字上应该尽量做到简洁、明快、流畅，对于一些可有可无的文字，应尽量予以删除。有人说：中医的脉案，应该具有中医的特色。这当然无可厚非。所谓中医特色，无非是充分反映中医特有的四诊八纲、辨证论治。当然，正确地使用中医的名词术语，也是脉案的一大特色，但不要过份地去追求一些晦涩、古奥的名词，例如把腹痛写为“河鱼”，月经写为“桃信”等等，不合大众化要求。脉案虽不必“白香山之诗老妪能解”，但也应尽量做到通俗易懂。

医案的写作应该在脉案的基础上进行。主要是对脉案进行内容上的增删、理论上的升华、文字上的提炼和所治病症的趋向和转归分析等等，使之系统化、完整化。读者可以从中获得许多有益的启发。不过，应该指出，所谓内容上的增删，应该一是一，二是二，实事求是，决不能为了脉、因、症、治的“完整”和论理的需要而徒增其无，也不可因脉、因、症、

治不合或论理上的困惑而徒删其有。但这并不是说所有内容应该一概纳入。必要的筛选应该是允许的。理论升华是医案的至要之处，也是读者企望得到教益的部分。它是作者学术思想的体现，写得好，能够起到画龙点睛的作用。医案的文字，应该但求质量，无求数量，在能够说明问题的基础上，力求精炼。洋洒千言，不能必其有用，寥落数字，不可照其之实，均存其弊。也不要专事崇饰虚文。有的医案，文字虽然华丽，但内容空洞无物，对读者帮助不大。古人云：“症有不治，药无十全”。对于病症治后的转归，或成或败，应该如实反映。不能好大喜功，侈言治验，更忌伪造验方，妄言效案。所谓有治必愈，无病不痊。大言炎炎，欺人欺世。若此医案，后人得之，真假难辨，杀人多矣。此乃医界蠹虫，不可效法。

脉案、医案、医话，是中医交流临床经验和传播中医学术的一种主要形式。它既表现了中医辨证论治的共同特点，又反映了各个不同流派在诊疗方法上的独特风格。它既是理论指导实践的产物，又是通过实践证实理论的结晶。因此，历代医家对案话的记述都极为重视。

案话是科学的作品，是关系到把学术经验传授后学的文字性材料，因此，撰写、整理，都应该本着严肃、认真、负责的态度，把诊治过程和作者的学术思想情况真实地反映出来，为继承和发扬祖国医学作出应有的贡献。

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

针 灸 保 健(15则)

常灸三里说(2则)

1.若要安，丹田、三里不曾干^{〔1〕}。

(《针灸资生经》)

注

〔1〕干，干燥。意为要经常施灸，勿使灸疮暂癒。

2.若要安，三里莫要干。

(《医说》)

保命灼艾第一说(1则)

3.夫人之真元，乃一身之主宰。真气壮则人强，真气虚则人病，真气脱则人死。

保命之法，灼艾第一，丹药第二，附子第三。人至三十，可三年一灸脐下三百壮，五十，可二年一灸脐下三百壮，六十，可一年一灸脐下三百壮，令人长生不老。余五十时，常灸关元五百壮，即服保命丹、延寿丹，渐至身体轻健，淡进饮食。六十三时，因忧怒，忽见死脉于左手寸部，十九动而一止，乃灸关元、命门各五百壮，五十日后，死脉不复见矣。每年常如此灸，遂得老年康健。乃为歌曰：一年辛苦惟三百，灸取关元功力多，健体轻身无病患，彭篪寿算更如何。

(《扁鹊心书》)

艾灸防疫说(1则)

4. 凡人吴〔1〕蜀〔2〕地游宦，体上常须三两处灸之，勿令疮暂差，则瘴疠温疟毒气不能着人也，故吴蜀多行灸法。

(《备急千金要方》)

注

〔1〕吴，指今江苏南部和江北部一带。

〔2〕蜀：四川的别称。

多灸延年说(1则)

5. 废书缘惜眼 多灸为随年
莫道桑榆晚 为霞尚满天

(刘禹锡《酬乐天咏老见示》)

气海常温说(2则)

6. 柳公度：善摄生，年八十余，步履轻便，或祈其术，曰：“吾初无术，但未尝以元气佐喜怒，(使)气海常温耳。”

(《旧唐书·柳又华传》)

7. 今人既不能不以元气佐喜怒矣，若能时灸气海使温，亦其次也。予旧多病，常苦气短，医者教灸气海，气遂不促。自是每岁须一二次灸之，则以气怯故也。

(《针灸资生经》)

鼠粪灸脐说(1则)

8. 旧传有人年老而颜如童子者，盖每岁以鼠粪灸脐中一壮故也。

又予年逾壮，觉左手足无力，偶灸此而愈。

(《针灸资生经》)

岁灸丹田说(1则)

9.有寇魁年八十，筋力绝人，盛寒卧地饮水，了不为异……
岁灸丹田百炷，行之达四十余年。

(《能改斋漫录》)

频灸关元说(1则)

10.绍兴间，刘武军中，步卒王超者，本太原人。后入重湖为盗，曾遇异人，授以黄白住世之法，年至九十，精彩腴润，辛卯年间，岳阳民家，多受其害，能日淫十女不衰，后被擒。临刑，监官问曰：汝有异术，信乎？曰：无也，惟火力耳。每夏秋之交，即灼关元千炷，久久不畏寒暑，累日不饥。至今脐下一块，如火之暖，岂不闻土成砖，木成炭，千年不朽，皆火力也。死后，刑官令剖其腹之暖处，得一块非肉非骨，凝然如石，即艾火之效耳。

(《扁鹊心书》)

中风预防说(1则)

11.凡人未中风一两月前，或三五月前，非时足胫上忽酸重顽痹，良久方解，此将中风之候。急灸三里、绝骨四处三壮，后用葱、薄荷、桃柳叶煎汤淋洗，驱逐风气于疮口出，灸疮春较秋灸，秋较春灸，常令两脚有疮为妙。凡人不信此法，饮食不节，酒色过度，忽中此风，言语謇涩，半身不遂，宜七处齐下火，各三壮，风在左灸右，右灸左。百会、耳前发际、

肩井、风市、三里、绝骨、曲池七穴神效。

(《针灸资生经》)

灸防疮病说(1则)

12.河洛间土地多寒，儿喜病疮，其俗生儿三日，喜逆灸以防之，又灸颊以防噤。

(《诸病源候论》)

产后自灸说(1则)

13.男女相悦，使相配偶。妇人产乳，必食子衣。产后以火自灸，令汗出，五日便平复。

(《北史·流求国传》)

灸扶阳气说(2则)

14.为医者，要知保扶阳气为本。人至晚年，阳气衰，故手足不暖，下元虚惫，动作艰难。盖人有一息气在则不死，气者，阳所生也，故阳气尽必死。人于无病时，常灸关元、气海、命关^{〔1〕}、中脘，更服保元丹，保命延寿丹，虽未得长生，亦可保百余年寿矣。

(《扁鹊心书》)

注

〔1〕命关：指足太阴脾经食窦穴。

按 血属阴，气属阳。人身以阳气为本，故曰阳气尽则死。《素问·生气通天论》曰：“阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰也”。窦公愈病，特别强调阳气在生命活

动中的作用，认为“阳精若壮千年寿，阴气加强必毙伤”，“阴气未消终是死，阳精若在必长生”。因此，他在临床治疗和摄生方面，注重以“保扶阳气为本”。提倡“灼艾第一，丹药第二，附子第三”。而人体阳气又与脾胃关系最密。无病施灸，防患于未然，实乃保健之要法。关元、气海，虽属任脉，而位居下焦，与肾关系密切，用之能温补肾阳，益元固本，食窦属脾，乃是太阴脉气所发，配中脘以温补脾阳，“能接脾脏真气”。窦公的这种学术思想，为后世针灸流派中的温补学派奠定了基础。

蒸脐防病说（1则）

15.五灵脂（八钱生用）、斗子青盐（五钱生用）、乳香（一钱）、没药（一钱）、天鼠粪（即夜明砂。二钱微炒）地鼠粪（三钱微炒）、葱头（干者二钱）、木通（三钱）、麝香（少许），上为细末，水和莖面作圆圈，置脐上，将前药末以二钱，放于脐内，用槐皮剪钱，放于药上，以艾灸之。每岁一壮。药与钱不时添换，依后开日时，取天地阴阳正气，纳入五脏，诸邪不侵，百病不入，长生耐老，脾胃强壮。

（《针灸大成》）

针 灸 急 症(24则)

尸 厥(7 则)

16. 扁鹊过虢。^{〔1〕}虢太子死，扁鹊至虢宫门下，问中庶子喜方者^{〔2〕}曰：“太子何病，国中治穰^{〔3〕}过于众事？”中庶子曰：“太子病血气不时^{〔4〕}，交错而不得泄^{〔5〕}，暴发于外，则为中害，精神^{〔6〕}不能止^{〔7〕}邪气，邪气蓄积而不得泄，是以阳缓而阴急，故暴厥^{〔8〕}而死。”扁鹊曰：“其死何如时？”曰：“鸡鸣至今。”曰：“收乎^{〔9〕}？”曰：“未也，其死未能半日也。”“言臣齐勃海秦越人也，家在于郑，未尝得望精光^{〔10〕}，侍谒^{〔11〕}于前也。闻太子不幸而死，臣能生之。”中庶子曰：“先生得无诞之乎？何以言太子可生也！臣闻上古之时，医有俞跗^{〔12〕}，治病不以汤液^{〔13〕}、醴醢^{〔14〕}、铍石、拔引^{〔15〕}、案扞^{〔16〕}、毒熨^{〔17〕}，一拨见病之应^{〔18〕}，因^{〔19〕}五脏之输，乃割皮解肌，诀脉^{〔20〕}结筋^{〔21〕}，据髓脑^{〔22〕}，揲荒^{〔23〕}爪幕^{〔24〕}，湔浣肠胃，漱涤^{〔26〕}五脏，练精易形^{〔27〕}。先生之方能若是，则太子可生也；不能若是，而欲生之，曾不可以告咳婴之儿^{〔28〕}！”终日^{〔29〕}，扁鹊仰天叹曰：“夫子之为方也，若以管窥天，以郄视文^{〔30〕}；越人之为方也，不待切脉、望色、听声、写形^{〔31〕}，言病之所在。闻病之阳，论得其阴，闻病之阴，论得其阳。病应见于大表，不出千里，决者至众，不可曲止也。子以吾言为不诚，试入诊太子，当闻其耳鸣而鼻张，循其两股，以至于阴^{〔32〕}，当尚温也。”中庶子闻扁鹊言，

目弦然而不瞋^{〔33〕}，舌拈然^{〔34〕}而不下，乃以扁鹊言入报虢君。

虢君闻之大惊，出见扁鹊于中阙^{〔35〕}曰：“窃^{〔36〕}闻高义^{〔37〕}之日久矣，然未尝得拜谒于前也。先生过小国，幸而举之^{〔38〕}，偏国寡臣^{〔39〕}幸甚！有先生则活，无先生则弃捐填沟壑，长终而不得反。”言未卒^{〔40〕}，因嘘唏服臆^{〔41〕}，魂精泄横^{〔42〕}，流涕长潸^{〔43〕}，忽忽承映^{〔44〕}，悲不能自止，容貌变更。扁鹊曰：“若太子病，所谓尸厥^{〔45〕}者也。太子未死也。”扁鹊乃使弟子子阳厉针砥石，以取外三阳五会。有间，太子苏。乃使子豹为五分之熨^{〔46〕}，以八减之齐^{〔47〕}和煮之，以更熨两胁下^{〔48〕}。太子起坐。更适阴阳^{〔49〕}，但服汤二旬而复故。故天下尽以扁鹊为能生死人^{〔50〕}。扁鹊曰：“越人非能生死人也，此自当生者，越人能使之起耳。”

（《史记·扁鹊仓公列传》）

注

〔1〕虢：国名。此指东虢，在今河南三门峡和山西平乐一带。

〔2〕中庶子喜方者：爱好方术的中庶子。中庶子，古官名，负责诸侯卿大夫的庶子的教育管理。

〔3〕治穰：举行祈祷（以巫术消除灾难）。

〔4〕血气不时：血气运行不正常。

〔5〕泄：疏泄。

〔6〕精神：指正气。

〔7〕止：制止。

〔8〕暴厥：突然昏倒，不省人事。

〔9〕收乎：收殓，装殓了没有。

〔10〕精光：指仪容风采。

〔11〕侍谒：侍奉进见。

〔12〕俞跗：传说中黄帝时名医。

〔13〕汤液：汤剂。

- [14]醴酒：酒剂。醴，甜酒；酒，滤酒。
- [15]折引：导引。
- [16]案抚：按摩。案，通“按”；抚（wǔ务），动摇。
- [17]毒熨（wèi为）：药物熨贴。
- [18]一按见病之应：一进行诊察，就可知疾病的所在。
- [19]因：顺着。
- [20]决脉：疏导经脉。
- [21]结筋：连结筋脉。
- [22]榻（nǔ诺）脑髓：按治脑髓。
- [23]揉（shé舌）荒：揉，持；荒，同育。触动膏育。
- [24]爪幕：爪，同抓；幕，同膜。梳理膈膜，
- [25]澣（jiān肩）浣：洗涤污垢。
- [26]漱涤：清洗
- [27]练精易形：修炼精气，改变形体。
- [28]咳（hé孩）婴之儿：刚会笑的婴儿。
- [29]终日：许久。
- [30]以郛视文：从隙缝里看图形花纹。
- [31]写形：审察病人的形态。
- [32]阴：指阴部。
- [33]目弦然而不瞑：目呆不眨之情。
- [34]拑然：舌头翘起。
- [35]中阙：宫庭的中门。阙，宫庭前两侧对称的门楼。
- [36]窃：谦指自己。
- [37]高义：崇高的德行。
- [38]幸而举之：有幸抬举我。这里有救助之意。
- [39]偏国寡臣：偏远国家的我。寡臣，帝君自谦之词。
- [40]卒：完毕，終了。
- [41]嘘唏：哭泣。服（bì必）膻：气满壅结。
- [42]魂精诞横：精神散乱，恍惚。
- [43]流涕长潸：长时间的流眼泪。

〔44〕忽忽承火：泪珠滚动的样子。

〔45〕尸厥：一种昏仆假死的病症。

〔46〕厉针砥石：研磨针石。厉、砥都是磨的意思。

〔47〕外三阳五会：关于三阳五会，众说纷纭，仅取其二，以供参考。《针灸甲乙经》，“百会，一名三阳五会。”《史记正义》：“《素问》云：手足各有三阴三阳。太阴、少阴，厥阴；太阳、少阳、阳明也。五会谓百会、胸会、听会、气会、膻会也。”

〔48〕五分之熨：温暖之气深入体内五分的熨法。

〔49〕八减之齐：八减方的药剂。八减剂，古方名。齐，同剂。

〔50〕更熨两胁下：交替地热敷两胁下。

〔51〕更适阴阳：再进一步调阴阳。

〔52〕生死人：使死人复生。

17. 李士材〔1〕治吴门周复庵，年近五旬，荒于酒色，忽头痛发热。医以羌活汤〔2〕散之，汗出不止，昏晕不醒。李灸关元十壮而醒。

（《古今医案按》）

注

〔1〕李士材：名中梓，字士材，号念莪。江苏华亭人，明代医学家。

〔2〕羌活汤：即羌活胜湿汤。

按 头痛发热，羌活汤散之不当，致使虚阳外浮，汗出不止，昏晕不醒。关元为任脉与足三阴之会穴，三焦元气之所出，干系命门、真阳，为阴中有阳之穴，灸之有温下焦、益肾气、回阳固脱等作用。

18. 章仲兴令爱〔1〕在阁〔2〕时，昏晕不知人，苏合香丸〔3〕灌醒后，狂言妄语，喃喃不休。士材诊之，左脉七至，大而无伦，右脉三至，微而难见，正所谓两手脉如出两人，此祟邪之脉也。线带系定二大拇指，以艾炷灸两界角甲，至七壮，

鬼即哀词求去，服调气平胃散加桃奴，数日而祟绝。

（《古今医案按》）

注

〔1〕令爱：女儿。

〔2〕在阁：未出嫁。

19. 于熬青衣^{〔1〕}为崔侍御^{〔2〕}所得，忽暴死。梁革曰：此非死，乃尸厥也。刺心及脐下数处，衣以单衣，卧床上缚其手足，置微火于床下，稍苏，以葱粥灌之，青衣遂活。

（《续名医类案》）

注

〔1〕青衣：古时对婢女的代称。如白居易《懒放》诗：“青衣报平旦，呼我起盥栉。”或指传统戏曲脚色行当，大多扮演青年或中年妇女。

〔2〕侍御：官名，又称侍御史。在御史大夫之下。

20. 陈斗岩治一妇人，病厥逆，脉伏，一日夜不苏，药不能进。陈视之曰：可活也。针取手足阳明（合谷，厉兑），气少回，灸百会穴乃醒。

（《承淡安针灸选集》）

21. 舍弟登山，为雨所搏。一夕，气闷几不救，见昆季^{〔1〕}必泣，有欲别之意。予疑其心悲，为刺百会不效，按其肺俞，云其疼如锥刺，以火针微刺之即愈。因此与人治哮喘，只缪肺俞，不缪他穴，惟按肺俞不疼酸者，然后点其他穴云。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕昆季：即弟兄。

按 肺司一身之表，外邪入侵，必先犯肺，肺气壅塞，脉络不通，故见气闷。肺俞者，意在宣肺解表，清肃有权，则邪无所依也。

22. 一妇人时时死去，已二日矣。凡医作风治之，不效，灸中脘五十壮，即愈。

(《扁鹊心书》)

按 忧思惊恐，致伤脾胃，气虚闭塞中焦，升降不利，故时时昏死。治当补脾胃、益中气，俾清阳得升而浊气得降，而中脘取焉。

热 厥(1 则)

23. 济王北^{〔1〕}阿母^{〔2〕}自言足热而慄^{〔3〕}，臣意^{〔4〕}告曰：“热厥也^{〔5〕}。”则刺其足心^{〔6〕}各三所，案之无出血，病旋已。

(《史记·扁鹊仓公列传》)

注

〔1〕济北王：齐悼惠王之子刘志，于汉文帝十六年受封济北王。

〔2〕阿母：乳母。

〔3〕慄：同栗。

〔4〕意：即淳于意。西汉名医。

〔5〕热厥：厥通厥，即热厥。

〔6〕足心：指足底中部。

按 经曰：“阴气衰于下，则为热厥”，热厥之成，责乎肾阴不足，阳热偏亢，阴阳失调，《医学入门》有：“心移热于肾则为热厥”之说。涌泉是肾经井穴，为肾经脉气始发处，对于热厥所致的失神、昏厥现象，针刺涌泉能调和阴阳，清热开窍，引火下行，故《百症赋》曰：“热厥涌泉清”。

气 厥(3 则)

24. 辛未^{〔1〕}，武进王会泉公亚夫人，患危异^{〔2〕}之疾，半月

不饮食，目闭不开久矣。六脉似有如无，此疾非针不苏。同寅诸公，推予即针之，但人神〔3〕所忌，如之何？若待吉日良时，则沦于鬼箴〔4〕矣。不得已，即针内关二穴，〔5〕目即开，而即能食米饮，徐以乳汁调理而愈。同寅诸君，问此何疾也？予曰：天地之气，常则安，变则病，况人禀天地之气，五运迭〔6〕侵于外，七情交战于中，是以圣人蓄气，如持至宝，庸人妄为，而伤太和〔6〕，此轩岐所以论诸痛皆生于气，百病皆生于气，遂有九窍（气）不同之论也。而子和〔7〕公亦尝论之详矣。然气本一也，因所触而为九，怒、喜、悲、恐、寒、热、惊、思、劳也。盖怒气逆甚则呕血及飧泄，故气逆上矣。怒则阳气逆上，而肝木乘脾，故甚则呕血及飧泄也。喜则气和志达，荣卫通和，故气缓矣。悲则心系急，肺布叶举，而上焦不通，荣卫不散，热气在中，故气消矣。恐则精神上，则上焦闭，闭则气逆，逆则下焦胀，故气不行矣。寒则腠理闭，气不行，故气收矣。热则腠理开，荣卫通，汗大泄，故气泄。。惊则心无所倚，神无所归，虑无所定，故气乱矣。劳则喘息汗出，内外皆越，故气耗矣。思则心有所存，神有所归，正气流（留）而不行，故气结矣。

（《针灸大成》）

注

〔1〕辛未：明·隆庆五年，即公元1571年。

〔2〕危异：病情危重，症状奇特。

〔3〕人神：古时认为人体内有一种特殊现象，它按不同的季、月、日、时，存在于一定的部位，如果针刺艾灸这个部位，就会产生意外。

〔4〕鬼箴，旧时谓冥间死人的名簿，在此即死亡之意。

〔5〕迭：轮流。

〔6〕太和：用以形容阴阳之道。

〔7〕子和：即张子和。

按 古时曾用人神、尻神、太乙等来解释针灸过程中突然发生的意外。但多有异议。如高武曰：“如所谓尻神、人神者，果有之，则不分病轻重，犯之当有祸。今又曰，卒急何暇选择？此时人神、尻神亦悯病危而不祸乎？又按尻尾骶骨，即臀尖，曰尻神，则是谓臀尖神矣。何人之一身独臀尖为神乎？是皆不可晓者也，以俟能知者”。本案虽逢人神忌日，但杨公针之即效，这是最有力的说明。今已废置不用。

25. 住院号1011号，黄××，男，24岁，初诊日期：1957年5月5日。患者因情绪刺激，突然昏迷倒地，不省人事、口噤、握拳、四肢掌指部厥冷，约经10分钟，面色苍白、舌苍白、脉沉弦。临床诊断：气厥实证。治则：行气宣窍通神。处方：人中穴，用泻法刺之，百会、大椎、命门，各灸一壮（如绿豆大），针灸后立即苏醒，并已能讲话。

（《司徒铃医案》）

26. 张××，女，28岁。

自诉：因情志抑郁，经常胸闷不舒，头痛，头晕。今与其夫发生口角，突然晕倒，不省人事，四脉厥冷，口噤拳握，呼吸急促，给予指切人中，按压肘窝、腿弯后苏醒，醒后哭啼不休。少时又突然抽搐，口噤不开，呼吸气促。查：脉沉弦，经××医院诊断为“癔病性癫痫”，经治疗效果不显，此为气机逆乱，上壅心胸，蒙闭窍隧。

治以疏肝理气，开窍醒神。针刺人中，四关。两次即愈。

按：四关即双合谷和双太冲穴，合谷为手阳明经原穴，太冲为足厥阴肝经原穴，前者主气，后者主血，两者配合能疏肝理气。人中为督脉穴，督脉循行入脑，刺人中能开窍醒

神，故能收效。

王××，女，26岁。

自诉：素有头痛病史，头晕眼花，活动则心慌气短，胃呆纳少。今突然晕倒，面色苍白，汗出肢凉，片刻苏醒，后因心情郁闷，晕倒不省人事，呼吸微弱。

查：脉细无力。

治取内关、气海，针三次，心慌气短大减，睡眠好转，胸脘舒畅，共针灸八次后复常。

按：内关为手厥阴心包经络穴，通于阴维，能宽胸理气，气海为任脉穴，为三焦之气出入之区，针刺加灸能温补元阳，调理气机。内关与气海配伍，能使清阳上升，浊阴下降，阴阳升降复常则晕厥可复。

（方吉庆医案）

暑 厥（2则）

27. 阿××，男，26岁，技工，门诊号6082。

代诉：患者于炎夏旷野作业期间，初感头不适，心悸气促，继而大汗淋漓，旋即昏倒，由同伴背负到诊。

查：体质虚胖，神志不清，面色苍白，冷汗如油，四肢厥冷，双目上视，瞳孔缩小，心律整，率促而弱，双肺呼吸音稍粗，腹柔，肝脾未扪及，膝反射减弱，无明显病理反射，血压测不到，苔薄白，脉微若绝。

此系受酷暑蒸薰，汗出过多，致阴液耗损，加之形气本虚，正气耗散过甚，故猝然昏倒，则病暑厥。

治以回阳救逆，补气固脱为主。

置患者于诊床，头低位，解开衣扣，擦干冷汗并保温，继用毫针补刺人中、内关、足三里、涌泉穴，同时用大艾炷

灸百会、神阙（隔盐）。经反复捻针及直接灸5壮后，患者神志渐复苏，始为低声呻吟，继而睁开眼睛，诉灸处热痛，经再连续捻针及灸至12壮，神志清醒，能正常对答，乃给予糖盐水热饮，待神清，冷汗止，四肢复暖，脉起，血压稳定在120~130/65毫米汞柱而退针停灸，共间歇捻针30分钟，重灸15壮病情得缓，经观察数小时病情稳定而送回家休息。

翌日患者已能自行到诊，视之神志清爽，面色泛红，语言流畅，昨日治疗后尚感微眩晕，但今日除感微疲乏外余无明显不适。心肺正常，血压120/70毫米汞柱，苔薄润，脉缓，病已愈。

按：受暑热薰蒸，骤然昏倒，病多急重，如不及时处理，则会引起不良后果。因此临症时首先区分是暑闭或暑厥。如症见面色红赤，神烦高热，气息粗促，肤热无汗，苔薄黄，脉洪大而数，尿少，则病为暑闭。其病机为暑热内迫，气火壅闭，热邪侵犯心包所致，治以泄热开闭法，针用泻法（十宣、委中刺血），禁灸。此例发病虽同由暑热薰迫所致，但其病机在于暑伤元气，正气耗散过甚，故症见面色苍白，气息微弱，冷汗如油，四肢厥冷，脉微欲绝等症，治应补气固脱，针灸并施。针刺用补法，宜多捻，至神清、脉起方可留针。重灸百会、神阙（隔盐），无问其数，以汗收、肢暖为度。补人中、涌泉，可开上焦清窍并扶阳益气，取内关、足三里，能振奋心主之功能及升提阳明经气，百会为诸阳之会，灸之可升阳醒脑，重灸神阙能回阳救脱。清窍得疏通，阳气得扶，心主得振奋，故厥症可除病则愈。病情缓解后应适当配合调理，以促进身体康复。

（陈全新医案）

28. 病员李××，女，21岁，学生，住院号0047，初诊日

期：1964年7月8日。患者于前一天下午参加集体劳动，在烈日下工作数小时，同时喝了一杯冷水。今晨即觉身热，前头部剧痛，头晕甚，并曾先后呕吐五次，十二时开始发现神识不清，烦躁不宁，辗转反侧，两下肢厥冷已将近一小时，面色赤，舌苔淡黄、脉伏。诊断：暑厥证。治则：泄热开闭醒神。处方：曲泽、委中双侧，刺浮络出血泻之。并没有用任何药物治疗。刺后即见安宁，烦躁减退，半小时后完全清醒，继续针灸治疗四天，痊愈出院。

（司徒铃医案）

血 厥（1则）

29. 司××，男，42岁。

自诉：素有偏头痛史，经××医院诊断为“血管性头痛”。头痛时如锥刺，甚则恶心呕吐。经中西医结合治疗，时好时犯，劳累则发作频繁，不时晕倒，重则不省人事，口噤。

查：面红唇紫，呼吸气粗，脉沉弦，血压为156/93毫米汞柱。诊断为血厥。给予针刺合谷透劳宫、行间、涌泉，针六次即愈。

按：合谷为手阳明大肠经原穴，主气；劳宫为手厥阴心包经荣穴，主血；行间为足厥阴肝经荣穴，主藏血。三穴配伍，能调节气机，镇肝降逆。由于阳盛则热，再用泻涌泉法从阴引阳，引热下行以降逆气，且涌泉为足少阴肾经井穴，能开窍启闭。四穴相伍，共奏平降血气上逆之功而收效。

（方吉庆医案）

食 厥（1则）

30. 刘××，女，31岁。

自诉：素有迁延性肝炎，体质虚弱。因饭后复遇恼怒，胃脘闷胀不舒，恶心欲吐，彻夜胃痛，服去痛片后稍减，胀满如故。起床即感头晕眼花，突然晕倒，不省人事。

查：苔白厚腻，质淡红，脉象沉滑。针刺中脘，内关、足三里，一次苏醒，三次症状消失，食欲增加，共针六次治愈。

按：中脘为八会穴之一，与内关、足三里配伍，内关理气，中脘和中，足三里消食，共收理气和中，消食导滞之效。

（方吉庆医案）

痰厥（2则）

31. 孙××，男，52岁。

自诉：素有哮喘性支气管炎，吐黄稠痰，胸闷憋气，心悸，喉中漉漉有声，哮喘经常发作。因炸辣椒被呛，顿咳不已，痰壅气塞，突然眩仆，神志不清达三小时之久，四肢发凉，呼吸气粗。

查：舌苔白腻，脉弦滑。针刺少商，内关，丰隆后苏醒，共针七次，未再发生昏厥。

按：少商为手太阴井穴，主气，肺为贮痰之器，点刺放血能行气豁痰，开窍醒神。内关、丰隆为调中祛痰之穴。三穴配合，有标本兼顾之妙。

（方吉庆医案）

32. 住院号2400号，李××，女，68岁，初诊日期：1961年11月8日。患者气上逆而喘，喉有痰鸣声，不能讲话，神识昏蒙已半小时，患者因发病前，没有吃饭，只饮了菜汤一大碗，饮后一时许，突觉胸脘满闷，气喘痰鸣，不能讲话。经

西医会诊，认为必须立即用吸痰机吸痰，并要输给氧气进行急救。当时患者面色微暗，舌苔白厚腻，脉沉滑。诊断：痰厥证。治则：行气豁痰通神明。处方：针尺泽、丰隆、中脘，用“寒则留之”的泻法刺之，但在针刺的过程中无气至之感应，针后症状亦无变化，随即用黄豆大的大艾炷，直接灸中脘穴三壮，灸后病者立即痰除气顺，神识清楚，言语自如。

按：直接灸中脘一穴，以温行六腑之气，使水谷能化，津液能行，则痰水不致停留为患，所以灸中脘穴后，患者即觉痰除气顺，神志清醒。“寒证宜灸”是一个不容忽视的传统法宝。

（司徒铃医案）

疫 毒 昏 厥（1 则）

33. 住院号22130，刘××，男，29岁，农民。初诊日期：1961年5月29日。患者于四小时前发病时有发热、呕吐、腹泻、大便有粘液，随即出现神志昏迷、烦躁不安，乃抬来急诊入院，当时血压测不到，体温38℃，白细胞22,600/立方毫米血液，中性87%，大便为粘液便，脓球(++)，大便培养结果发现弗氏痢疾杆菌。西医诊断：中毒型菌痢（极重型），曾用可拉明、正肾上腺素注射及补液、吸氧等抢救一小时还未苏醒，乃邀中医会诊。现症：昏迷不省人事，四肢厥冷，烦躁不宁已三小时，面色苍白，呼吸迫促，唇甲发钳，舌苔黄浊，舌质淡红，脉伏，血压60/0毫米汞柱。诊断：疫毒昏厥。治则：活血，泄热，开闭醒神。处方：十宣出血，曲泽、委中双侧浮络刺出血，刺后约10分钟，神志已完全清醒，脉象转为滑数，血压已可测到110/70毫米汞柱，病情好转。

（司徒铃医案）

呼 吸 骤 停 (2 则)

34. 董××, 女, 20岁, 学生, 住院号78041205。于今年8月12日下午8时整, 因在10分钟前服敌敌畏中毒, 家属见其呕吐物有浓厚的敌敌畏气味而径送我院内科抢救。

自诉: 口服敌敌畏约50毫升。

查: 发育正常, 营养中等, 神志清楚, 颜面苍白, 两瞳孔缩小等圆, 呼吸有蒜臭味, 结膜充血(+), 颈软, 甲状腺不肿大, 血压100/70毫米汞柱, 心率104/分, 律齐, 无杂音, 肺无罗音, 腹平软, 无压痛, 肝脾未触及, 四肢正常, 无病理反射。当即进行常规抢救, 但因护理人员误将应从胃管推入导泻之硫酸镁从静脉注入, 导致病情恶化, 呼吸突然停止, 遂即用葡萄糖酸钙对抗, 经人工呼吸及呼吸三联、甘露醇静注等, 仍未恢复正常的自主呼吸, 乃采用电动同步呼吸器维持达四个小时。其中, 13日零点30分, 并经院内外扩大会诊, 检查: 病人昏迷, 无自主呼吸, 双瞳孔散大约5~6毫米, 对光反射存在, 双眼屈光间质清, 双眼瞳孔乳头生理凹陷消失, $A:V=3:1$, 动脉细小, 未见出血。经讨论, 继续维持甘露醇、地塞米松、阿托平、回苏灵、可拉明等用药, 患者一直未见有起色。笔者是在会诊之后, 于13日子夜1时55分被邀到达抢救室的, 本拟采用新穴“呼吸”以冀万一, 因未备装置有呼吸波的电针器, 乃徒手针刺。先取内关、涌泉以强心醒脑, 针内关行“九阳” (小角度捻转) 手法, 患者未见反应, 接上针涌泉行“六阴” (大角度强捻转) 手法, 患者已有动弹。2时整, 于是继取关元以益气助纳, 手法是模拟呼吸频率而补泻交替进行, 持续捻转约半分钟, 即见患者腹部随着针身运动而有起伏, 再次取下呼吸器插

管，患者已完全恢复了自主呼吸，呼吸24次/分，匀齐；神志已清楚，能睁开眼睛，稍有烦躁，病情好转，后经二昼夜的精心医护，于8月22日治愈出院。

按：用针灸抢救农药中毒和硫酸镁静注所致的呼吸中枢麻痹，在没有先例的情况下，术者面对这例呼吸停止，经人工呼吸，药物治疗等方法未见好转，依靠电动呼吸器维持长达四个小时之久的患者，怎样使此行不至于虚应故事，而针治呼吸骤停该取何穴？又如何行使手法？是个新课题。忆及古典针灸文献中有：“口噤气绝状如死，……以取三阳五会”，因而考虑取用任脉脐下诸穴，选用其中关元，以其上有气海，下通玉泉，为气功意守之所，是呼吸之根，按中医理论，此穴与呼吸关系至为密切。这例患者，针关元后即恢复了正常的自主呼吸，这充分说明了祖国医学是个伟大的宝库，前人的医疗实践经验是可贵可取的。通过这例患者的抢救成功，从而也充分揭示了针刺关元对抢救呼吸骤停具有一定的治疗价值。

（黄其波医案）

35. 黄×，男，28岁，住院号75369。

自诉：因溃疡病入院，施行胃大部分切除术，选择乙醚全麻，用快速气管插管，诱导用2.5%硫喷妥钠0.3克及氯化琥珀胆碱50毫克静注。术前常规给予鲁米那0.1克肌注及阿托品0.5毫克皮下注射。自诱导用药后患者自主呼吸停止，立即行快速气管内插管，同时用麻醉机维持人工呼吸，术中血压及脉搏维持平稳，当手术顺利结束后，仍未见有自主呼吸出现，经应用可拉明、洛贝林及回苏灵等肌肉注射和静脉注射仍无效。

最后应用针刺疗法：主穴取双侧人迎穴，配穴取双侧合

谷穴，每个主穴和配穴组成一对电极，用1.5寸毫针针刺以上穴位，固定好位置后，接上“6.26”治疗机通电（频率20次/分），每次通电持续约半分钟，二次后便出现自主呼吸，由弱到强，很快恢复正常。停用人工呼吸后，自主呼吸保持平稳直到苏醒。

按 本例呼吸停止，属于麻醉意外引起。本例应用呼吸中枢兴奋药无效，当改用针刺人迎穴（膈神经刺激点）立即生效，提示呼吸停止的直接原因是膈肌麻痹。

人迎穴，属阳明胃经，位于颈部喉结旁1.5寸，于动脉应手处取穴，相当于现代医学的膈神经刺激点，即胸锁乳突肌前缘中点，颈总动脉搏动处。进针时，应向下外方（避开颈总动脉）刺入，到达横突后，再退出少许即可。如针刺不当，刺中臂丛神经，可引起上肢抽动，而不出现膈式呼吸，此时应更换进针方向再刺，否则不能发挥激发呼吸的作用。

（侯肇楷医案）

中 风（1 则）

36. 乔××，男，62岁，工人，病历号13822。入院日期1973年5月14日。

代诉：患者素患高血压已五年（最高收缩压可达200毫米汞柱，舒张压不详）。于入院前三天夜间性交后10分钟，突然大汗出，面色苍白，随即右半身不遂，神志尚清，头痛，无恶心呕吐。当即送往附属医院就诊，因不同意腰穿，而转入我院。

查：神志恍惚，双目闭，精神萎靡，且有烦躁不安，时时用左手拍打前额，示意头痛，口臭，瞳孔等大、等圆，对光反射存在，颈抵抗，右半身全瘫，无失语，生理反射消失，

病理反射巴氏征右侧阳性。心界稍向左扩大，心音有力，律整齐，心率为76次/分。两肺清晰。患者不断申述“头痛”，小便尚可知，无大便。体温36.7℃，呼吸16次/分，血压155/95毫米汞柱。诊为中风（高血压、蛛网膜下腔出血）。

先行危重期抢救：1.止血。2.降颅内压。3.镇静。4.氧气间断吸入。5.补充液体。随后针治以镇肝熄风，乃取风池、大椎、太冲、太阳。经九天的积极抢救终于脱险。患者神情，头痛减，眼睑下垂消失，右眼外直肌麻痹消失，右侧巴氏征弱阳性，右半身全瘫。

后遗症期治疗：（1）针刺取风池、廉泉、极泉、曲池、合谷、内关、环跳、阳陵泉、三阴交、申脉、昆仑，以疏通经络。（2）中药配合，降压、通络。

患者经一个月针刺和中药治疗后，头痛消失，可扶小拐行走，上肢可上举过头。经104天治疗，患者可自理生活，右侧肢体活动自如，下肢功能全部恢复，唯右手精细动作不灵活，血压稳定，自动出院。经追访患者目前血压稳定，右侧肢体活动灵活，功能全部恢复，生活完全自理，唯右足右手发胀。

按（1）危重期：本例患者系属平素生活不知谨慎，房室不节致肾精亏损，而肾为先天之本，上注于脑，脑为髓海，肾虚则髓海空虚，肾阴不足则肝木失荣，又因患者年迈性交耗伤精液而致肝阳上亢，肝风内动，乘髓海空虚而上犯于脑则出现蛛网膜下腔出血。故在危重期治疗中采用镇肝熄风。主穴：风池、大椎、太冲。我们体会风池穴除具有前人所述有祛风解表、疏邪清热、明眼目、利机关的功能外，因本穴位于颈后血管神经较丰富部位，能改善脑血管的供血情况，故在临床上以此穴为重点穴。针刺方向针尖向对侧眼窝刺入，

进针深度2寸，不留针为宜。

本例为肾精虚耗，肝风内动之阳闭症，故取太冲以清利肝火，熄内风。针8分～1寸，泻法。大椎可疏三阳之邪，通一身阳气，采用泻法。

作者认为危重期的抢救工作，中西密切配合，是十分必要的，临床上能得到较满意的效果，既可达到急则治其标的目的，又可根据中医辨证论治，治其根本，扶正祛邪治愈疾病。

(2)后遗症期：本例后遗症期的治疗，主要采取了扶正祛邪的醒脑开窍，疏通经络之法。按现代医学的认识，肢体运动障碍的原因，主要是大脑中央前回锥体细胞的坏死及功能障碍。为什么针刺肢体可以帮助肢体功能恢复呢？我们认识如下：

从中医角度，蛛网膜下腔出血之后，因血沿神经纤维穿脑实质而造成“血淤”。淤而不通造成筋骨关节肌肤无所养，故出现半身不遂。我们利用针刺肢体俞穴，收到活血通络，疏通经脉，进而达到活血散淤治愈疾病的目的。正如《灵枢·海论篇》说：“夫十二经脉者，内属于府藏，外络于支节”。

从现代医学角度，出血穿入脑实质，造成锥体细胞失去了指挥功能，或者因锥体细胞已坏死，或者因出血进入脑实质造成中央前回的充血水肿脑软化，而软化灶周围细胞尚未有功能代偿，故肢体出现偏瘫。而经过针刺后肢体功能的重建，说明锥体细胞又活跃起来，这或者是软化灶周围的功能代偿，或者是周围充血水肿的消失。故推测：针刺虽面对肢体俞穴，但患者有酸、麻、胀等感觉，说明刺激在大脑的相应区（如手的定位区）发挥作用，促进了脑血肿或脑水肿的

吸收，并能促进锥体细胞功能恢复或代偿。因此针刺是十分重要和必要的。

(天津中医学院附属医院针灸科医案)

溺 水

37. 欧×，男，4岁，住横州镇城东街108号。于1965年5月14日下午，因玩水而被溺，捞起呼吸停止，四肢冰冷，面黑舌伸，但身尚软，马上进行急救，立即针刺会阴，以疾刺捻转提插法，中冲，人中用速刺捻转手法，当针约1分钟左右，就能开眼转睛，张口哭叫。

尹×妹，女，4岁，住曹村公社里竹大队。于1965年6月30日下午，因玩水被溺，两小时后，始采用上法急救，仅2~3分钟时间开始呼吸苏醒。

按 应将患者抬至空气流通的地方，解开衣扣，取俯卧位，抬高腰部，使头胸部放低，头转向一侧，同时将口撬开，横嵌筷子一根，使水从口流出。

针刺采用会阴为主，配中冲、人中为辅。会阴：取截石体位，男子在阴囊十字纹与肛门之间，以手按之，有凹陷处取；女子在大阴唇后联合部肛门之间取之。成人针5分~1寸，小孩针3~5分深。中冲：在中指之端去指甲1分许取之，左右共两穴，针2分深。人中：在鼻唇沟上1/3的中央，针2分深。首刺会阴，续刺中冲、人中，均用疾刺捻转提插综合手法，倘若经针刺会阴穴，在2~3分钟不苏醒者，难救。

(黎邦榕医案)

青霉素过敏性休克(1则)

38. 李××，女，33岁，已婚，农民。1977年9月6日初

诊。

主诉及病史：咽喉肿痛四天。患者四天来恶寒发热、头痛，咳嗽痰出不爽，鼻流清涕，咽喉干燥作痛，吞咽困难，口渴喜饮，全身不爽。某医诊断为：感冒并急性扁桃体炎。考虑用青霉素、链霉素治疗。乃先作青霉素皮试，在皮试过程中，患者即呼口唇及四肢发麻，头晕不适、心慌、心悸、气怯、恶心、胸中懊恼，烦躁不安，旋即摔倒，人事不省。

临床所见：面色苍白，口唇发绀，全身冷汗淋漓，尤其颜面汗下如注，呼吸微弱，四肢厥逆，脉细欲绝，心率40次/分，血压65/0毫米汞柱。

辨证施治：气闭厥逆，大汗亡阳，脉伏欲绝，病势险笃，证系青霉素药物过敏所致，先治其急，回阳固脱为要，以冀脱险境。

治疗经过：速刺内关穴，呈75°，向心性双手齐刺入针，施捻转补泻行守气法，使针感向上传导；再刺百会穴作平补平泻法，双艾条温灸气海穴约五分钟后，患者已能以微弱的声音说出：“我头晕……”。此时心率回复至50次/分，连续针灸10分钟后，心率62次/分，口唇已逐渐转为红晕，自觉胸膈稍为宽快，心悸惕怵亦转平稳，再留针20分钟后，心率已恢复70次/分，血压回升105/68毫米汞柱，颜面红晕，四肢转温，除稍感眩晕及疲惫之外，其他诸症消失，化险为夷，欣然回家。

按：本案属青霉素过敏性休克，临床偶有发现。往往突然昏厥，若失抢救良机，常能导致严重后果。本案发生在皮试过程中，在药物未能及时供应的紧急情况下，急刺内关，以强心苏厥，阻遏危象发展；头者诸阳之会，元神之府，针

百会以通督振阳醒脑，温灸气海以温煦下元，回阳固脱，针灸兼施，救治及时，终于转危为安。

（杨桐良医案）

跌 仆（1则）

39. 韩貽丰^{〔1〕}摄永宁篆^{〔2〕}。有部民被殴死，已逾夕。即单骑往验，则遍身重伤，僵挺，无生气矣。因念死者父母，年老贫病，惟此子，死则二老必不能生。不得已，因取针针其百会，亦冀^{〔3〕}万一，非谓其必活也。时天气甚寒，令村人各解衣轮熨尸身^{〔4〕}。又熬水令极热，探汤揉尸手足，无何得人气，体顿柔。针至十四针，忽喉中作响，口鼻微有气，诊其脉，脉忽动，乃喜曰：有救矣。至二十一针，则喉间大声出，手足能屈伸，口称遍体痛不可忍，则皆被殴处也。乃呼酒来，以药饮之，伤处糝^{〔5〕}之以药，痛处以针针之。责令凶手保护调养，如限内死，仍抵偿。后伤者痊愈，求和息，乃杖凶者而遣之。

（《续名医类案》）

注

〔1〕韩貽丰：清代医家。著有《太乙神针心法》。

〔2〕摄永宁篆：摄，凡官非实授者或代理，或兼理曰摄。篆，古代官印用篆文，篆即为印信。摄、篆并称谓“摄篆”，即代掌其印信（代理）。永宁，地名（今四川叙永）。

〔3〕冀：希望。

〔4〕轮熨尸身：用正常人的体温来反复温暖死（伤）者身体。

〔5〕糝（sǎn伞）：糝，通糝。此处指在伤处糝药。

按 本例因殴伤而厥，固非真死，但亦危殆。薛立斋在《正体类要》中说：“肢体损于外，则气血伤于内，营卫有

所不贯，脏腑由之不和”。本例亦因重伤造成气血逆乱，阴阳失和，暴厥昏伤。针百会者，可回阳醒神，复苏开窍，证虽危急，但医者应不乱方寸，详加调护，亦可转危为安，起死回生。

头 面 五 官 病 症（86则）

头 疾（22则）

头 痛（5则）

40.有士人患脑热疼，甚则自床投下，以脑拄地，或得冷水粗得，而疼终不已，服诸药不效。人教灸囟会而愈。热疼且可灸，况冷疼乎。凡脑痛、脑旋、脑泻，先宜灸囟会，而强间等穴盖其次也。

41.予少刻苦，年愈壮则脑冷，或饮酒过多，则脑疼如破，后因灸囟会穴，非特脑不复冷，他日酒醉，脑亦不疼矣。

（《针灸资生经》）

按 头风一症，多因风邪上入于脑所致，然热痛用灸，人多惧之。殊不知百病之生，全在气血，“灸者，温暖经络，宣通气血，使逆者得顺，滞者得行”也。故无论寒疼热痛皆可行于灸治也。

42.东垣曰：先师洁古^{〔1〕}治一人病苦头痛，发时两颊青黄、晕眩、目不欲开、懒言、身体沉兀兀^{〔2〕}欲吐。此厥阴、太阴合病，名曰风痰。灸侠溪，以局方玉壶丸^{〔3〕}愈。

（《针灸聚英》）

注

〔1〕洁古，张元素，字洁古，易州人，金代医学家。

〔2〕兀兀：指食物上冲。

〔3〕局方玉壶丸：局方，指《太平惠民和剂局方》。玉壶丸，方用天南星、生半夏各一两，天麻半两，头白面三两，为细末，滴水为丸，梧桐子大，每服三十丸，治风痰吐逆，头痛目眩等。

按 面颊青黄，风邪挟痰上扰清窍，以致清空不宁，痛晕并作。洁古投《局方》玉壶丸化痰，平太阴之虚，灸胆经荣（水）穴侠溪，滋水涵木，制厥阴之胜。风去痰清，清升浊降，针药合用，相得益彰。

43. 楼全善^{〔1〕}治一老妇人，头病岁久不已。因视其手足，有血络皆紫黑，遂用三棱针尽刺出其血，如墨汁者数盏。后视其受病之经刺灸之，而得全愈。即《经》所谓大痹为恶，及头痛久痹不去身，视其血络，尽出其血是也。

（《续名医类案》）

注

〔1〕楼全善，明代医学家。名英，一名公爽。浙江萧山人。著有《医学纲目》，对后世医学有一定影响。

按 经曰：凡诊络脉，脉色青则寒且痛。其暴黑者，留久痹也。邪之客于人，必先舍于皮毛，留而不去；入舍于络脉，郁而不散则脉盛色变。今尽取其血，即《灵枢》“宛陈则除之”之意也。

44. 《素问》论头痛，本于大寒内至骨髓。则头风者，亦本于风寒入脑髓耶。《本事方》论妇人患头风者十居其半。或者妇人无巾以御风寒焉耳。男子间有患之者，非头上少发，必其囟会、前顶之发秃也。欲灸头风，宜先囟会、百会、前顶等穴。其头风连目痛者，当灸上星、神聪、后顶等穴。予尝自灸验，教人灸亦验云。

有人久患头风，吾令灸囟会即愈。

（《针灸资生经》）

眩 晕（12则）

45. 曹操闻召佗，常在左右。操积苦头风眩，佗针随手而差。

（《后汉书·华佗传》）

按 佗，神医。针魏公风眩，应针而瘥。然《后汉书·华佗传》不载其穴。《三国志·魏书》云：“佗针鬲”，卒不可解。《铜人腧穴针灸图经》卷三“脑空”条下载此案，后世多崇之。但亦有云指风府者，详见《扁鹊心书》头晕治验。

46. 有人苦头眩，头不得举，目不得视积年^{〔1〕}。佗使悉解衣倒悬，令头去地一、二寸，濡布^{〔2〕}拭身体令周匝，候视诸脉，尽出五色，佗令弟子数人，以铍刀^{〔4〕}决脉，五色血尽，视赤血，乃下，以膏摩被覆，汗自出周匝，饮以葶苈犬血散，立愈。

（《后汉书·华佗传》）

注

〔1〕积年：多年。

〔2〕濡布：湿布。

〔3〕周匝：原作周币。指擦身一周，或指周围。

〔4〕铍刀：指铍针。

47. 帝^{〔1〕}头眩不能视，侍医张文仲^{〔2〕}、秦鸣鹤^{〔3〕}曰：“风上逆，砭头血可愈。”后^{〔4〕}内幸^{〔5〕}帝殆^{〔6〕}，得自专^{〔7〕}，怒曰：“是可斩，帝体宁^{〔8〕}刺血处耶？”医顿首请命；帝曰：“医议疾，乌^{〔9〕}可罪？且吾眩不可堪，听为之。”医一再刺。帝曰：“吾目明矣！”言未毕，后帘中再拜，谢曰：“天赐我师”。身负缙^{〔10〕}宝以赐。

（《新唐书·高宗则天皇后武氏传》）

注

〔1〕帝：指唐高宗。

〔2〕张文仲：唐代医学家。洛州洛阳（今河南洛阳）人。曾任侍御医、尚药奉御等职。

〔3〕秦鸣鹤：唐代名医。高宗时侍医。精针术。

〔4〕后：指武则天。

〔5〕内幸：暗自希望，庆幸。

〔6〕殆：去世。

〔7〕得自专：独揽权力。

〔8〕宁：岂，难道。

〔9〕乌：无，没有。

〔10〕缁（zēng增）：丝织品的总称。

48. 嘉祐^{〔1〕}初，仁宗寝疾，药未验，间召草泽医^{〔2〕}，始用针自脑后刺入，针方出，开眼曰：“好惺惺。”翌日圣体良已，自尔以目穴为惺惺穴。经初无此名。或曰即风府穴也。

（《续名医类案》）

注

〔1〕嘉祐：宋仁宗年号。

〔2〕草泽医：民间医生。

49. 母氏随执中赴任，为江风所吹，自觉头动摇如在舟车上，如是半年，乃大吐痰。遍服痰药，并灸头风诸穴方愈。

（《针灸资生经》）

50. 一人头风，发则眩晕、呕吐，数日不食。余为针风府穴，向左耳入三寸，去来留十三呼，病人头内觉麻热，方令吸气出针，服附子半夏汤，永不发。华佗针曹操头风，亦针此穴立愈。但此穴入针，人即昏倒。其法向左耳横下针，则不伤大筋而无晕，乃千金妙法也。

（《扁鹊心书》）

按 风府为风邪入脑之门户。《素问·风论》“风气循风府而上，则为脑风，”同时也是治疗头风要穴。《素问·骨空论》：“风从外入，令人振寒，汗出头痛，身重恶寒，治在风府。”《行针指要歌》也说：“或针风，先向风府百会中。”乃因风性轻扬，其病常表现于头部症状，正如《内经》所说：“伤于风者，上先受之。”临床上不论外风、内风，均可取用。但本穴行刺，切莫朝前上斜刺，免伤延髓。窦材针法甚妙，可供参考。

51. 东垣治参政^{〔1〕}，年近七十，春间，病面颜忧赤，若饮酒状，痰稠粘，时眩晕，如在风云中，又加目视不明。李诊两寸洪大，尺弦细无力。此上热下寒明矣。欲药之寒凉，为高年气弱不任，记先师所论，凡治上焦，譬犹鸟集高巖，射而取之。即以三棱针于巖前眉际疾刺廿余，出紫黑血约二合许时，觉头目清利，诸苦皆去，自后不复作。

（《名医类案》）

注

〔1〕参政：古官名，元朝中书省设参政，与左右丞同为副宰相，而位在其下。

按 年近古稀，肾阴已亏。肾亏则肝失所养，肝阳浮于上，当见上热；其阴涸于下，必为下寒，此乃标实本虚之证也。急则治其标，以泄血泻亢盛之热，所苦必除。然不以血肉之品填补真阴，希冀后不复作，恐难矣。

52. 冯××，女，39岁，住宽城区18委491组。初诊于1973年9月17日。

头眩目花，起立站立不稳，已经二月之久。经某院诊断为“内耳眩晕症”，投给葡萄糖、维生素B₁、利眠灵等，时好时犯。近日头眩目花益甚，兼有胸膈满闷，恶心呕吐，

右耳时鸣，每晨起必干呕，含姜稍止。

查其体胖，神疲，闭目欲睡，面色不华，脉来弦滑，心肺无异常变化，舌质淡红，有白腻苔。

根据脉症，断为痰湿中阻，脾失健运，致使清阳不升所致头眩，据治本“除痰须健中，熄风可缓晕”的法则，乃为针中脘补、风池双补、百会、足三里双补，留针15分钟，一日一次，内服止眩汤加茯苓10克、赭石5克、生姜汁5毫升，倍半夏、白术、党参，经服六剂，针12次，干呕停止，眩晕减轻，继针7次，投药同上法六剂，诸症消失而愈。

53.陈××，女性，44岁，住朝阳区四委81组，初诊于1973年4月5日。

头眩目花，时好时犯，现已8月之久。近日头眩加重，曾眩倒一次。兼症有纳少、腰酸、心悸失眠。

查其面色晄白，形弱神疲，舌淡而润，脉来濡弱，两尺细小，血压110/70毫米汞柱。问诊得知，月经16岁初潮，22岁结婚，生8胎，有二次产后失血较多。

根据两尺脉来细小，面白腰酸，形弱神疲，断为髓海不足，肾经虚亏所致眩晕，乃投止眩汤加淡附子3克、茯苓4克、肉桂1.5克、枣仁4克、圆肉4克、人参2克，冲服鹿茸粉0.5克，连进24剂，面转红润，脉来沉缓，诸症均减，为巩固疗效又服三剂而告愈。

54.方××，女，24岁，住长春市二道河子区十八委14组，初诊于1974年4月15日。

头眩目赤，已半月有余，每情绪激动则头眩益甚，近日因与邻里口角，头眩脑胀昏晕等更甚，兼有头痛，抽掣欲动，午后潮热。

查其脉来弦数，舌边红，有黄薄苔，目白珠微赤，血压

130/80毫米汞柱。

根据头眩目赤，因气痛甚，脉来弦数，知系素往肝气偏盛，今怒气内动肝阳，舌边红知营阴已渐不足，见抽掣知系肝风似有内动之势，如不速平肝亢，滋肝阴，必将眩晕卒倒，乃为之针太冲双泻，太溪双补，风池双泻，合谷双泻，留针15分钟，投止眩汤加牛膝4克、夏枯草4克、龟版4克、女贞子6克、白芍4克、玉竹4克，经针16次，连进汤药13剂诸症消失而愈。

考眩晕是一种症状，很多疾病均可发生。中医论治，大抵有三：一为痰火，所谓“无痰不眩，无火不晕”。二为肾虚，所谓“肾气通于耳”，“髓海不足则脑转耳鸣”。三为肝亢，所谓“诸风掉眩，皆属于肝”。治疗应审其因，从其本源，使原因除掉，眩则自解。若系痰浊、肝亢、肾虚所致者，治应祛痰健中，平肝止眩，益肾熄风为主。

余临床每用针药兼施之法，常收显效。内服每用止眩汤——天麻、钩藤、半夏、川芎、蒺藜、陈皮、菊花、竹茹为主方，随症加减，针灸取穴为风池、百会、印堂、三阴交为主。

冯案为痰湿中阻所致眩晕，疗疾重在除痰；陈案为肾虚作眩，疗疾重在益肾；方案为肝亢作眩，疗疾重在平肝，故均以止眩汤辨证加减而收效。

（刘冠军医案）

55. 吴××，女，54岁，1965年11月11日入院。住院号：9414。

是日下午，突然眩晕，房屋旋转，不敢睁眼。伴有恶心，耳鸣、心悸、胸闷、四肢厥冷、爪甲青紫。送××医院急诊，诊断为“美尼尔氏综合征”。注射阿托品、氯普吗嗪、高渗

葡萄糖液后嘱其回家休息。2小时后诸症未见减轻，兼有肢麻，两足抽筋。再送本院急诊。1962年时有同样发作史。经多科治疗，年余得愈。

检查心尖区听诊有Ⅰ—Ⅱ级收缩期吹风样杂音，左耳听觉减退，瞳孔等大，眼球震颤明显，肢冷、爪甲青紫，脉沉涩，苔薄。证系眩晕，乃阳气衰微，荣血上输不足所致。治拟温通督阳。

处方和操作：下脑户、风府、哑门。银温针7壮，每日一次。

治疗经过：入院后随即施治。针后四肢转温，抽筋缓解，肢麻消失，脉复，余症稍减。服眠尔通0.4克入睡。次晨起床缓行。自述头胀，额首如砸。4次后诸症消失，仅感耳鸣，巩固3次后出院。

按：眩晕之作，良由肝肾不足，气血两亏所致。症见恶心、畏光、耳鸣、心悸、胸闷、厥冷、肢麻、抽筋、爪甲青紫，脉沉涩。此阳气衰微、荣血上输不敷。治用银温针针督脉经穴，温通督阳，使气血上承，其疾得愈。

（华延龄医案）

56. 宋××，男，37岁。1965年6月28日住院，住院号：8584。

主诉：1964年12月10日以高处跌下，当时诊断为：第一腰椎压缩性骨折。后脑胀痛，恶心，站立及坐久则甚，平卧稍舒，伴有眩晕。经多种治疗未效。

检查：枕骨部如碗口大小感觉迟钝。舌质淡、苔薄白，脉右沉涩、左缓。证系脑震荡后遗症，督脉受损，瘀血失祛。治宜温通督阳，活血化瘀。

处方和操作：哑门、风府、下脑户、风池。银温针7壮。

每天治一次，每周六次。

初治时虽艾柱较大而患者并不感温，经治一周后感觉好转，症状减轻。治疗三周后已能坐立半天而尚安，头胀痛、眩晕、恶心等症状基本消失，仅在劳累后稍感后脑发胀。

按：督脉“入络脑”，脑受外伤，损及督脉，气血凝滞，则头脑作胀，眩晕。银温针针督脉诸穴，督阳振奋，气血疏通，其疾自愈矣。

（华廷龄医案）

中毒性脑病后遗症（1则）

57. 患者黄××，男，3岁，住宿县城西公社。就诊日期：1976年12月28日。现病史（其母代诉）：患儿于三月前因罹患中毒性脑病及败血症，在宿县××医院诊治。出院后仍遗有左半身瘫痪，双目失明，聋哑，痴呆等症状。体检：发育营养欠佳，神情痴呆，聋哑，左上肢肌力0～1级，下肢肌力1～2级，左巴氏征（+），心肺未见明显异常，肝肋缘下2厘米，剑突下2.5厘米，质软，脾未扪及。眼科检查：双眼球活动受限，巩膜（-），前房（-），瞳孔等大，直径4毫米，直、间接光反射迟钝，晶体、玻璃体清晰；眼底视神经乳头色泽苍白，边缘清楚，生理凹陷存在，视网膜动脉血管变细，未见渗出及出血，黄斑区中心反光隐约可见。诊断：视神经萎缩。

根据病情，治疗上分三个阶段逐步进行，第一阶段以治疗视神经萎缩为主兼治聋哑；第二阶段主治聋哑兼疗偏瘫；第三阶段治疗偏瘫。

经云：“肝受血而能视”，“骨之精为瞳子”。又云：“目者，五脏六腑之精也……神气之所生也。”患儿由于长

期高热灼伤肝肾之阴致使津液亏损，故目不能视物，治以滋肾水养肝血。分三组治之：

一组：肝俞、肾俞、阴谷（均补）。

二组：球后（弱刺）、睛明（弱刺）、曲泉（补）。

三组：目窗、光明（均泻）。

三组交替针刺，逐日一次，每10次为一疗程，休息3天，两个疗程后因天寒停针。

1977年3月继续治疗，至5月患儿视力明显好转。加瞳子髎、阳白，8月患儿已能视物。眼科复查：双眼球活动自如，巩膜（-）、前房（-）、瞳孔等大等圆，间接对光反射灵敏，晶体、玻璃体清晰；眼底：双眼视神经乳头色泽略淡、境界清晰，生理凹陷存在未见扩大，视网膜动脉、静脉无异常改变，未见渗出及出血，黄斑区中心反射存在。

8月中旬开始第二阶段治疗。聋哑为阴液涸竭，气机失调，太阳、少阳风热闭阻使然。“心者神之舍”，所以我们采取清营凉血、熄风和营，调三焦气机，清肝胆邪火为主。取穴：

一组：耳门（泻）、听宫（泻）、太溪（补）、临泣（泻）。

二组：听会（泻）、廉泉（平补平泻）、翳风（泻）、复溜（补）、天井（泻）。

三组：翳风（泻）、风池（泻）、哑门（弱刺）、神门（泻）、百会（平补平泻）、大陵（泻）。

经4个月治疗，患儿神志清爽，已无痴呆之态。经五官科检查，听觉正常，舌运转灵活，能说简单的词汇，嘱其家长多对其作语言训练。

1978年3月开始治疗偏瘫，考虑患儿久病气血亏损，故

仿治痿之法。取穴：曲池（平补平泻）、外关（泻）、足三里（平补平泻）、阳陵（泻）、曲泉（补）、阴谷（补）。

先刺健侧，后刺患侧，15日为一疗程。经三个疗程的治疗，患侧肌肉逐渐丰满，已经能独立行走，上肢活动灵活，唯握力稍差于健侧。停止针刺治疗。嘱其家长辅助其锻炼，随访二年，患儿发育良好，视力：右0.6，左0.6，一切活动均正常。

按：此案分三个阶段进行治疗。患儿为中毒性脑病引起失明、聋哑、偏瘫等后遗症。其病机是高热灼阴。总的治疗方案离不开滋肾水、养肝血、濡筋脉。第一阶段肝俞、肾俞取滋水涵木之意，且有宁神、明目、聪耳之功；阴谷为足少阴合穴，曲泉为足厥阴合穴，二者相得益彰，滋肾水清肝热之力更专；睛明、光明能疏风泻火，调肝明目；目窗既有明目之功又有治耳聋之效，为第二阶段的治疗打下了基础。

第二阶段取穴大陵、神门，取其清营凉血，熄风和营，宁神开窍；百会举阳气下陷，能泻诸阳燔热借以护阴；耳门、听宫、听会、翳风能疏太阳、少阳之邪，调气机，开耳窍；哑门通舌窍。心肾二窍开则耳聪目明，智慧神宁。

第三阶段以补益气血为主，取多气多血的阴明经穴为主，佐以少阴、厥阴之阴谷、曲泉，正因为有上两个阶段的滋阴养血、泻阳护阴的治疗，使偏瘫治疗收到事半功倍之效。

本例纯用针灸治疗，未服用任何药物。

（秦德铨医案）

斑 秃 （4则）

58. 杜××，女，52岁，会计。于1978年3月12日初诊。

自诉：不知如何，头发突然呈椭圆形数片脱落；曾服中西药及搽生发水、白兰地酒等均未能控制。两个月后，头顶及两鬓头发几乎脱光。

依据上诉症状，经用电梅花针治疗一个月，开始长出新发，继续巩固治疗三个月，长出比原来更加乌亮的黑发，原有白发减少，宿患高血压病亦得到控制。两年后随访，病情没有反复，仍见满头黑发。

59.黎××，女，28岁，教师。于1978年11月8日初诊。

自诉：因准备考试，过度疲劳，出现头痛、头晕，失眠，记忆力减退，月经紊乱等症状。继而鬓角出现两块铜钱大小斑秃。一个月后，头发全部脱光，眉毛、腋毛、阴毛等也相继脱落。

依据症状经用电梅花针治疗一个半月，开始长出新发和眉毛、腋毛、阴毛等。继续治疗四个月，头部黑发布满。头痛、失眠等症也相继痊愈，月经恢复正常，体质比原来增强。

60.马××，男，47岁，干部。于1979年5月3日初诊。

自诉：15年前曾突然昏迷倒地致头部撞伤，继而出现头痛、失眠、心烦、记忆力锐减、恶梦缠绵等症；两个月后，发现头部有四块如鸭蛋大小的秃斑，皮肤光亮；三个月后，头发全部脱光。

依据症状，经用电梅花针叩刺和穴位注射药物三个月后，病情显著好转，已长出较为乌黑头发。一年后随访，头发再未反复脱落，且多年失眠之症也得到治愈。

按 斑秃致病原因较多，有因血虚生风，风盛血燥，发失濡养，故重叩风池穴以祛风养血；有因肾气虚不能荣养毛发，亦有因血瘀阻碍生新者，故用药液注射肾俞、心俞、膈

俞、三阴交等穴以益肾、养血、化痰。叩刺头部、督脉、夹脊、背俞穴者，因经脉和脏腑有密切关系，经络是人体气血运行的通道，脊柱两侧为足太阳膀胱经所过，五脏六腑俞穴也都分布在背部，故叩刺之能宣导阳气、疏通经络、养血安神、补肾益精，促进新发再生。

用电梅花针的手法对疗效具有重要关系。治疗时，要求用腕力弹刺。弹刺是利用手腕部灵巧的弹力，当针尖与皮肤表面呈垂直接触后立即弹起。叩打时落针要稳准。要用弹刺、平刺，不要用慢刺、压刺。弹刺时，要做到网状均匀密刺，不要过强或过弱，一定要以病人能耐受的刺激强度为宜。

由于本病与神经、精神因素有关，故来求诊患者，大多数均伴有失眠、梦多、心悸、健忘等症状。而神经营养障碍，内分泌机能失调，脂肪代谢障碍，病灶感染等亦不能排除。通过电梅花针刺激，可能调节了机体的内分泌和神经系统，也提高了机体的免疫功能，尤其是细胞免疫功能，从而达到治病目的。另外，通过电梅花针刺激，可引起局部头皮充血，用以促进毛囊细胞生长，使头发再生。

（张家维、陆明珍医案）

61. 邓小秋，男性，27岁。于5月21日门诊。门诊号44541。

主诉：在20岁时头角开始脱发，同时期检查右肺上野浸润性肺结核，兼有胃痛时发，但不严重。近年来脱发渐渐显著。

症状：头两角脱发逐至额顶（右角秃的大些）头脂皮屑代谢较多，有时头角痛，有时起立头昏，手足多汗。每入夏季饮食减少并易患肠胃病，近因旅途劳顿感冒，引发宿疾，偏坠肿痛，苔薄，脉弱右关寸弦。

患者向有肺病（浸润型肺结核），肺与大肠相为表里，因

之肠胃多病，肺阴弱而肾水亦枯，《素问》：“肾者主蛰，封藏之本，精之处也，其华在发，其充在骨”。骨为髓之余，脑为髓之海。今脑力消耗太过，则髓海空虚，以致肾亏而水不能涵木也。如此，脏与脏失却相关生化制约关系，春之木气上升不充而落发。根据病因和症状，从肺肾肝经论治，计分前后阶段针刺治之。

取穴：

(1)足三里、三阴交（或头、足临泣、本神、太冲、太溪）轮换刺，均补。

(2)头临泣、太溪、本神、侠溪、昆仑、足临泣、曲池，轮换刺，均补。

手法：迎随开闭补泻法。

针刺：逆顺斜刺，留针每次30分钟。

疗程：针15次为一疗程，每日针刺，先后计两个疗程。

效果：针7次落发较少，针11次落发更少，头皮润泽，短发增长，针18次检见新生发，针20次看见新生发多而密，针25次两角秃发处全部生长新发。

（陶竹轩医案）

面 疾（8则）

头 面 肿（3则）

62. 南乡陈君俞，将赴秋试，头项偏肿连一月，状若半壶，其脉洪大。戴人^{〔1〕}出视。《内经》面肿者风，此风乘阳明经也。阳明气血俱多，风肿宜汗，乃与通圣散，入生姜、葱根、豆豉，同煎一大盏。服之微汗，次日以草茎鼻中，大出

血，立消。

(《儒门事亲》)

注

(1)戴人：张子和

(2)通圣散：即防风通圣散。

按 本案用药疏风取汗，完全是刘完素的解表主张。刘氏认为，热为本、风为标，肿属于热。张子和虽说此案是“风乘阳明”，但又指出“阳明气血俱多”，实际上正是阐发了刘氏风热兼化的论点。

63. 一人面上黑肿，左耳下起云，紫如盘蛇，肌肉中如刀刺，手足不知痛。询其所以，因同僚邀游，醉卧三口，觉左臂黑肿如蛇形。服风药渐减，今又发。余曰：非风也，乃湿气客五脏之俞穴^{〔1〕}，前服风药，乃风胜湿，故当暂好，然毒根未去。令灸肾俞二穴，各百壮，服换骨丹^{〔2〕}一料痊愈，面色光润如故。

(扁鹊心书)

注

(1)五脏俞穴：即心俞、肝俞、脾俞、肺俞、肾俞。这里泛指背俞。

(2)换骨丹：方用当归、芍药、人参、铁脚威灵仙、南星、乳香、没药（均去油），麻黄（去节），另煎汁和上药。上各为末，先将前五味和匀，后入乳香、没药，以麻黄汁和匀为丸，如弹子大。每以无皮酒下一丸，出汗。五日一服。仍当服延寿丹、金液丹。

按 面上黑肿，为水泛高原之象，今独灸肾俞，振气化，祛水湿，正合王冰所谓“益火之源以消阴翳”之意。

64. 黄氏小儿，面赤肿，两目不开。戴人以铍针刺经穴之，除两目尖外，乱刺数十针，出血三次乃愈。此法人多不肯从，必欲治病，不可谨护。

(《儒门事亲》)

面 疾（1 则）

65. 庚辰^{〔1〕}岁过扬，大尹黄缜庵公，昔在京朝夕相与，情谊甚笃，进谒留疑^{〔2〕}，不忍分袂，言及三郎患面部疾，数载不愈，甚忧之。昨焚香，卜灵棋课曰：兀兀尘埃久待时，幽窗寂寞有谁知，运逢宝剑人相顾，利遂名成总有期。与识者解曰：宝者珍贵之物；剑者锋利之物，必逢珍贵之人，可愈。今承相顾，知公善针，疾愈有期矣。予针巨髎、合谷等穴，更灸三里，徐徐调之而愈。时工匠刊书，多辱^{〔3〕}蟹^{〔4〕}米之助。

（《针灸大成》）

注

〔1〕庚辰：明·万历八年，即公元1580年。

〔2〕疑：疑为“款”字之误，款的异体字写作“疑”。款，款待。

〔3〕辱：自谦词。承蒙之意。

〔4〕蟹：疑为“斛”字之误。古时以十斗为一斛，南宋末年改五斗为一斛。

口 眼 喎 斜（4 则）

66. 范子默自壬午五月间口眼喎斜，灸听会等三穴即正。右手足麻无力，灸百会、发际等七穴得愈。末年八月间，气塞涎上不能语，金虎丹^{〔1〕}加膩粉服至四丸半，气不通，涎不下，药从鼻中出，魂魄飞扬，如坠江湖中，顷欲绝，灸百会、风池等左右共十二穴^{〔2〕}，气遂通，吐几一碗许，继又下十余行，伏枕半月余遂平。尔后方觉意思少异于常，心中愤乱，即便灸百会、风池等穴立效。

气塞涎上不能语，心中风候也，《巢氏病源》常论之。古方虽



谓但得偃卧，闷绝汗出者，心中风之候，恐未尽也。范公灸得气通，盖灸百会之力，其吐几一碗下十行者，岂服金虎丹加麝粉所致耶？

(《针灸资生经》)

注

〔1〕金虎丹：方药不详。

〔2〕十二穴：《普济本事方》云：十二穴者，谓听会、颊车、地仓、百会、肩髃、曲池、风市、足三里、绝骨、发际、大椎、风池也。治中风，依而用之，无不立效。

67. 洪右，27岁。伤于风者，上先受之，其口眼向右歪斜者，邪风中于阳明之络也，病经三日，面颊仍痛，脉弦数，应以祛风通络治。

地仓透颊车(泻) 风池(泻) 下关(泻) 丝竹空(泻) 合谷(泻左)

(黄鸿舫医案)

68. 汪左，54岁。

年逾五旬，形体丰盛，体丰于外，气馁于内，脾运暗弱，所进饮食，易生湿生痰，积痰成热，客秋劳倦太过，将息失宜，志火失宁，陡然肝火疾热上潜，跌仆成中，神志虽明，而舌强语蹇，口眼歪斜，偏左手足不仁，肌肤浮肿。刻诊脉缓滑，苔腻微黄，症属类中，病在心脾，治亦当以心脾为主。

丰隆(补) 风池(泻) 地仓(补) 瞳子髎(泻)
三阴交(补) 漏谷(补) 环跳(泻) 风市(泻)
肩髃(补) 少海(补) 手三里(补) 臂臑(补)
支正(泻) 通里(泻)

69. 患者：吴××，男，36岁，干部。



病初自觉头痛，面部麻木，持续三天后，发现左侧面肌弛缓，眼睑、口角下垂，不能皱额、蹙眉，闭目不紧，眼裂颇宽，鼻唇沟消失，也不能作唾吐、鼓腮等动作。

处方：瞳子髎、阳白、下关、颊车、地仓（均左侧）。

操作：概用捻转补法针刺。

初三日每天针一次，以后隔日针一次。自针三次后，面部麻木感减轻，第四次后麻木全除，第五次后诸症好转，口歪明显转正，至十次后眼睑已能闭合，诸恙悉除，病告痊愈。

按：本病多由脉络空虚，风寒之邪侵入阳明、少阳之脉，以致经气阻滞，经筋失荣，肌肉纵缓不收，而现面部麻木等症，故遵《标幽赋》：“大抵疼痛实泻，痒麻虚补”的治则，取阳明、少阳两经经穴，概施捻转较轻、角度较小的捻转补法，以通调经脉气血而恢复经筋的失荣。

（楼百层医案）

目 疾（12则）

目 赤（2则）

70. 昔一士人赵仲温，赴试暴病，两目赤肿，睛翳不能识路，大痛不任，欲自寻死。一日，与同侪^{〔1〕}释闷，坐于茗肆^{〔2〕}中，忽钩窗脱钩，其下正中温额上，鬓际裂长三四寸，紫血流数升，血止自快，能通路而归。来日能辨屋脊，次见瓦沟，不数日复故。此不药不针，误出血而愈矣，夫出血者，乃发汗之一端也，亦偶得出血法耳。

（《儒门事亲》）

注

〔1〕同倂；倂（chí音柴）：辈，类也。这里指同辈人。

〔2〕茗肆：茶馆。

71. 余尝病目赤，或肿或翳，作止无时。偶至亲息帅府间，病目百余口，羞明隐涩，肿痛不已。忽眼科姜仲安云：宜上星至百会速以緋针刺四五十刺；攒竹穴、丝竹穴，上兼眉际一十刺；及鼻两孔内，以草茎弹之。出血三处，出血如泉，约二升许，来日愈大半；三日平复如故。余自叹曰：百日之苦，一朝而解，学医半世，尚阙^①此法，不学可乎？

（《儒门事亲》）

注

〔1〕阙：同缺。

目 痛（1则）

72. 吴孚先治一人目痛，取竹叶一片，刺鼻之迎香穴，出血而痊。鼻内迎香穴，乃手足阳明交经也。

（《续名医类案》）

按 凡用迎香治疗目痛者，多指内迎香。《扁鹊神应针灸玉龙经》曰：“目热，心火上炎两眼红……内迎香，在鼻孔内，用芦叶或箬叶（即箬竹之叶）作卷搐之，出血为好。”读者鉴之。目痛一症，原因众多，大致外感风热，郁闭经络，久而变火，火郁不宣，遂致红肿热痛，怕日羞明；当然也有因肝胆火炽，循经上扰目窍而致者。本案用（内）迎香搐鼻，针对前者，刺时当取血，具有疏风泄热、通络明目、消肿止痛的作用。但应注意消毒。或用小三棱针点刺出血亦可。

暴盲、失明（6则）

73.戴人女僮至西华，目忽暴盲不见物。戴人曰：此相火也。太阳阳明，血气俱盛，乃刺其鼻中^{〔1〕}、攒竹穴与顶前五穴^{〔2〕}，大出血，目立明。

（《儒门事亲》）

注

〔1〕鼻中：指内迎香穴。参见目痛案。

〔2〕项前五穴：即神庭、上星、囟会、前顶、百会。

74.倪新溪母陶氏，哭子丧，失明已十一年。忽一人踵门曰：吾能疗瞽。时其孙上成钧^{〔1〕}，宗党会钱具在。其人曰：诸君但少留此视之。发囊出针，针其目两眦，目顿能见物，抚其孙顶曰：吾久不睹汝，今成人矣。新溪德之，手百金谢，其人不受而去，众以为神。

（《续名医类案》）

注

〔1〕成钧：西周时称最高学府为成钧。《周礼·春官》：“大司乐掌成钧之法，以治建国之学政。”唐高宗时，改国子监曰成钧监。

75.福建按察使沈文敏，其母随养时，双目失明。延一医疗之，云：障翳已重，药不能效。乃先药之使不知痛，寻以物拨转眼睛向内一面向外，封闭三日而开，视物无一不见。

（《续名医类案》）

按 沈母之疾，似属老年性白内障。这种疾病，《外台秘要》首先提出“宜金篦决，一针之后，豁若开云而见日”，嗣后，不少眼科及针灸医籍也多所记述。近年，随着中西医结合工作的开展，改进了手术器械和方法，提高了疗效，减少了并发症，具有时间短、恢复快、痛苦少等优点，对老年

性白内障及年高体弱者更为合适。

76. 傅卧云年八旬余，两目茫然，几无所见。后闻粤东有某名医，术绝精，姑往就之。至则留具饮食，请宿。凡举动琐屑，及遗失溺，皆详视而辨别之。三数日后，出药一刀圭^{〔1〕}令饮讫，取长针将两睛刺破，蒙然盲矣，眶中流黑水，涓滴不绝，两日始止。乃于两太阳穴、脑后针四五处。以药纳眶中，用帛扎固，静睡一夕；用清水洗去药。从此明察秋毫，如五六岁童子，且永无目疾。医术奇哉矣。

（《怪病神医录》）

注

〔1〕刀圭：器具名。古代用以量取药末。因其形状如刀圭的圭角，一端尖形，中部略凹，因名。一刀圭，约等于一方寸匕的1/10量。

按 破睛疗睛，不无疑虑。但据名医何时希先生说：“今浙江东阳韦氏眼科，亦擅此术，但末闻可施之八旬老人者，因为韦氏的门人俞岐山先生愈过几例，均在十岁以上。他对我说：‘必须在长成发育年龄，才能使已破的瞳人和流去的瞳液复充。’”又说“丁济万先生的幼子，手持剪刀由桌上跳下，而成螺眼多少年，直到发育期才由俞先生治之复明，这是我亲知亲见之例。”据此，说明本法确有疗效，但不知适应何种眼疾？非大高手切不可轻易试用。

77. 赵良仁^{〔2〕}云：丹溪先生尝用参膏治一老人目暴不明，昏暗如夜。正《灵枢》谓：气脱者，目不明是也。余亦曾治一士人，患头风联左目壅痛，从戴人法，于百会、上星出血，皆不效。遂在头偏左之足太阳所过第二行与上星对平，按之痛甚处，出血立愈。由是而言，针之与药，必切中病所，药与邪对，然后可愈。前人之方，不过立规矩耳。

（《续名医类案》）

注

(1)赵良仁：元末明初医家。江甯（今江苏江浦）人。朱丹溪的弟子，在浙江有一定名声。

按 戴人治头风目疾，善用锋针，出血盈升盈斗，效如桴鼓。然赵氏用之不验。究其因，乃病同人异，穴同法异也。若胶柱鼓瑟，势必越治越烈。“不通则痛”先人钩旨，赵氏于脉络淤滞之处（相当于足太阳之五处穴），局部刺血使淤者通，滞者行，即时取效。此所谓“通则不痛”也。本案的可贵之处，在于尊古而不泥于古，崇方而不守于方，圆机活法，所谓“针之与药，必切中病所也。”

78. 刘××，女，20岁，学生。

自诉：于1972年7月28日患头痛20天后，突然右眼失明，灯光亮度全看不到，头痛目涩，情绪紧张、失眠，饮食减少，身体逐渐减瘦。曾经某医院检查，诊断为“瘰病性黑盲”，先后服中西药、针刺均无效，乃于1974年3月20日来我科诊治。

查：两眼外观一致，瞳孔对等，体质中等，精神苦闷，脉来弦细，舌淡无苔。诊断为暴盲。

治以疏肝理气，调血明目为法。故取睛明、太阳、风池、合谷，均取右侧穴。用补法，留针20分钟，每日一次，十次为一疗程。经过二次针刺后，患者目有光感，针三十次即可看到一般书上文字，视力仍为0.8，并已参加工作。

按 本病是由怒气伤肝，肝气上逆，气血郁闭，精明失用此致。治本疏肝理气，调血明目为主治。由于目为肝之窍，阳明、太阳、少阳的经脉均循行于目，故取合谷调阳明经气，以泻内热；睛明为太阳、阳明会穴，能通睛明目、清眼之余热；风池是足少阳、阳维之会，有清利头目、通利七窍

之力；太阳为经外奇穴，能清头明目，疏风活络，使目得血而能视。

（纪青山医案）

金 针 拨 翳（2则）

79. 宋显仁后韦氏两目失明，募医疗者，莫能奏效。有道士应募：金针一拨，左目脱然复明。

（《履斋笔记》）

80. 华州陈明远患翳十年，汉卿^[1]视之，曰：“可针也。”为翻睛刮翳，竟^[2]然辨五色。

（《明史·周汉卿传》）

注

〔1〕汉卿：指周汉卿。

〔2〕竟（×0虚）：俱然。

斜 视（1则）

81. 陈××，女，7岁，学生。1981年3月15日初诊。病历号：96564。

两岁患肺炎，高烧后出现内斜视。看书要离书本很近。曾到某医院检查，诊断为共同性内斜，远视散光。戴眼镜矫正4年，经同视机训练，遮盖疗法及服中药半年均未收效。纳谷欠佳，夜尿1次，大便有时稀溏。

检查：视力双眼均为0.4。散瞳验光，屈光度右眼远视+4.25度，散光+2.25度，矫正视力0.7；左眼远视+4.50度，散光+2.00度，矫正视力0.5。眼球向各方向运动均不受限。

经角膜映光法检查诊断为共同性内斜15度。正光穴处可

摸到结节和压痛。颈椎1~2及腰椎两侧可摸到条索和泡状软性物。面色欠华，脉细弱，苔薄，证属脾肾两虚型。遂按上法采用梅花针治疗1个疗程后，视力：右眼0.8、左眼0.7，外观和检查眼位已正。继续治疗1个疗程，视力：右眼1.0，左眼0.8；上课学习均不用戴眼镜，无不适感。又巩固治疗1个疗程后停止治疗。随访观察1年半，外观和检查眼位正常，视力保持未减。

按：共同性斜视属于中医“目偏视”与“双目睛通”范畴。隋·巢元方《诸病源候论》载：“目是五脏六腑之精华，人脏腑虚而风邪入于目，而瞳子被风所射，睛不正则偏视。”明代《审视瑶函》指出：“双目睛通……欲看东而反顾其西，彼有出而反顾其入。”这些基本概括了本病的特征和表现。本病“初起易治，日久难愈”，以早期治疗为佳。

（钟梅泉医案）

鼻 疾（7则）

鼻 渊（1则）

82. 丹溪^①治一中年人，右鼻管流浊且臭，脉弦小，右寸滑，左寸涩。灸上星、三里、合谷。次以酒芩二两，苍术、半夏各一两，辛夷、川芎、白芷、石膏、人参、葛根各五钱，分七帖服之痊愈。乃痰郁火热之症也。

一人鼻中流臭黄水，脑亦痛，名控脑沙（痧）。有虫食脑中。用丝瓜藤近根三五尺许，烧存性，为细末，酒调服即愈。又灸法：囟会、通天，灸七壮，随鼻左右灸。常见灸后

去臭肉一块，以鼻中出，臭不可言而愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕丹溪：即朱震亨。

按 上两则皆属鼻渊范畴。治宜宣肺通窍、凉血解毒。首例取上星，理参87案，合谷、三里，均属阳明，功擅祛风散热，宣肺通窍。三穴合用，远近相配，其功益善。次例为鼻渊重症——控脑痧，所用单方名“天罗散”，乃治控脑痧验方。天气通于鼻，鼻病取通天者，主散风热、通鼻窍。《百症赋》云：“通天去鼻内无闻之苦。”凶会属督脉，佐通天清头散风。

鼻 干（1则）

83. 执中母氏久病鼻干，有冷气。问诸医者，医者亦不晓，但云病去自愈。既而病去，亦不愈也。后因灸绝骨而渐愈。执中亦尝患此，偶绝骨微痛而著艾，鼻干亦失去。初不知是灸绝骨之力，后阅《千金方》有此证，始知鼻干之去，因绝骨也。若鼻涕多，宜灸凶会、前顶。

（《针灸资生经》）

衄 血（4则）

84. 一人患脑衄，日夜有数升，诸药不效。余〔1〕为针关元穴，入二寸，留二十呼。问病人曰：针下觉热否？曰：热矣。乃令吸气出针，其血立止。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕余：案材自称。

按 衄血多因于热，世医崇尚寒凉。殊不知亦有真气虚而血妄行者。若此，则当大补元气，温补关元，理精法当，甚妙。

85. 李时珍^{〔1〕}治一妇人衄血，一昼夜不止。诸治不效。令捣蒜敷足心，即时遂愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕李时珍：字东璧，号濒湖，明代医药学家。

按 此属上病下取、阳病治阴的案例。足心为足少阴肾经所过，用蒜泥外敷，可导热下行，引火归源，故衄血遂愈。

86. 徐德占教衄者，急灸项后发际两筋间宛宛中三壮立止。盖血自此入脑，注鼻中。常人以线勒项后尚可止衄，此灸决效无疑。

（《医说》）

按 “项后发际两筋间宛宛中，”疑指哑门。《外台》载治衄。有潜阳清热，热去衄止之功。

87. 执中母氏忽患鼻衄，急取药服，凡平昔与人服有效者皆不效。因阅《集效方》（本出千金）云：口鼻出血不止，名脑衄，灸上星五十壮。尚疑头上不宜多灸，只灸七壮而止，次日复作，再灸十四壮而愈。有人鼻常出脓血，予教灸囟会亦愈，则知囟会、上星，皆治鼻衄云。

（《针灸资生经》）

按 阳热亢盛，血液不循常道，渗溢鼻窍，谓之鼻衄。督脉为阳脉之海，取上星、囟会，意在清上亢之热，热清则衄止。至于热症用灸，此亦《素问·六元正纪大论》之“火郁发火”之义也。

鼻 瘰 肉 (1则)

88. 患者张××, 男, 38岁, 商人。门诊号: 5829。就诊日期: 1961年6月2日。

病历摘要: 左侧鼻腔内生瘰肉, 流涕时带血水, 引得前额昏痛已近2~3月, 曾在××医院五官科治疗, 嘱其摘除, 彼畏惧未做手术来诊。

检查诊断: 患者有肺结核史, 现大多硬结, 尚有部分不明。现在左侧鼻腔内充血灼痛, 有赤豆大瘰肉一块, 呼吸时有阻滞感, 流涕时带鲜红血液, 头额昏痛较甚, 影响工作, 肌肤微热, 体温37.2℃, 血压130/80毫米汞柱, 舌苔白薄尖红, 脉细弦兼数。症缘肺阴素虚, 挟阳明、少阳湿热上逆, 发为鼻痔。

治疗原则: 清疏肺胃、疏理少阳。

处方: (1)主穴: 合谷、列缺、迎香、足三里均泻。

(2)配穴: 风池、率谷、通天、太阳, 上俱用泻法, 不灸。

疗效观察: 自6月2日到7月8日共针四次(因患者畏针间断治疗, 中间未做其他治疗), 鼻痔自行脱落如黄豆大肉块一颗后, 头痛鼻塞均消失, 症情痊愈。

处方意义: 鼻为肺窍, 是清气出入之门户。当湿热上泛, 则肺失清降, 而少阳之火上腾, 湿热搏击于皮毛的时候, 故为鼻痔, 所以取肺经列缺以清肺气, 胃经三里以降胃浊, 配迎香、合谷, 清疏经气下行, 不使邪有所滞, 佐以率谷、风池以泻少阳, 使热邪得降而无炎上之势。手法均用泻法; 尤其是泻三里、合谷以通阳明、降湿浊, 腑气得清而脏气自宁、清窍自和, 用通天、太阳者, 借其泻热, 清头止痛, 为权宜之

计，可备一时之需；这是处方选穴的意义。

（张宗震医案）

口 齿 疾（13则）

木 舌 （1则）

89. 昔余以治一妇人，木舌胀，其舌满口，诸药不愈，余以铍针小而锐者砭之五、七度，肿减，三日方平。计所出血几盈斗^{〔1〕}。

（《针灸聚英》）

注

〔1〕出血几盈斗：斗，乃古代酒器。出血盈斗者，形容出血量甚多。

• 按 木舌，又名木舌胀，木舌风。临床主要症状为舌肿满口，舌体肿硬，不痛不胀，不能转动，严重者可语声不出，气闷窒息感。多有过敏史，相当于现代医学的血管神经性水肿，舌为心之苗，心主血脉，外感风热痰湿，或脾虚不健，寒湿蕴积，壅塞血脉，致使营卫不和，循经上扰苗窍而成。刺砭患处出血，以泄邪毒，宣通壅阻，使气血畅通，则肿胀自可清除。

舌 肿 痛（2则）

90. 南邻朱老翁，年六十余岁，身热数日不已，舌根肿起，和舌尖亦肿，肿至满口，比原舌大二倍。一外科以燔针刺其舌两旁下廉泉穴，病势转凶，将至颠峨^{〔1〕}。戴人曰：血实者宜决之。以铍针磨令锋极尖，轻砭之，日砭八九次，血出约

一、二盏。如此者三次，渐而血少、痛减、肿消。夫舌者，心之外候也，心主血，故血出则愈。又曰：“诸痛痒疮疡，皆属心火”。燔针艾火，是何义也？

（《儒门事亲》）

注

〔1〕颠𦨭（xī音希）：颠，倾颠；𦨭，危险。这里指病势凶险，将有一蹶不振之危。

91. 一膏粱^{〔1〕}之人，患舌痛，敷服皆消毒之药，舌肿势急。余刺舌尖及两旁，出紫血杯许，肿消一二。更服犀角地黄汤一剂。翌早，复肿胀，仍刺出紫血杯许，亦消一二。仍服前汤。良久，舌大肿，又刺出黑血二杯许，肿渐消。忽寒热作呕，头痛作晕，脉洪浮而数，此邪虽去而真气愈伤。与补中益气倍加参、芪、归、术，四剂而安，又数剂而愈。

（《口齿类要》）

注

〔1〕膏粱：泛指肥甘美味食物。《素问·生气通天论》：“膏（膏）粱（粱）之变，足生大丁（疔）。”

舌出不入（1则）

92. 王况^{〔1〕}字子亨，本土人，为南京宋毅叔壻。毅叔既以医名擅南北，况初传其学，未精，薄游京师，甚凄然。会盐法忽变，有大贾睹^{〔2〕}揭示，失惊吐舌，遂不能复入，经旬食不下咽，尪羸^{〔3〕}日甚，国医^{〔4〕}不能疗，其家忧惧，榜于市曰：有治之者，当以千万为谢。况利其所售之厚，姑往应其求，既见贾之状，忽发笑不能制，心以谓未易措手也，其家人怪而诘之，况谬为大言，答之曰：所笑者，鞞^{〔5〕}之大如此，乃无人治此小疾耳。语主人家曰：试取《针经》^{〔6〕}来，况漫

检之。偶有穴与其疾似是者，况曰：尔家当勒状与我，万一不能治则勿尤。^{〔8〕}，我为针之，可立效。主病者不得已亦从之。急针舌之底，抽针之际，其人若委顿状，顷刻舌遂伸缩如平时矣。其家大喜，谢之如约，又为之延誉，自是翕然名动京师。

（《医说》）

注

〔1〕王况：宋时医家。字子亨。今南京人。著有《全生指迷方》问世。

〔2〕大贾：贾，商人。大商人。

〔3〕睹：同睹，看见。

〔4〕羸羸（wēng lái 汪雷）：瘦弱、瘠病。苏轼《上皇帝书》：“世有羸羸而寿者，亦有壮盛而暴亡。”

〔5〕国医：医之国手。这里形容医术非常高明的医生。

〔6〕辇毂：指京都。司马迁《报任少卿书》：“仆赖先人绪业，得待罪辇毂下，二十余年矣。”

〔7〕针经：《灵枢》一名。但亦有单本者，如《亡名氏针经》。

〔8〕尤：责怪。《左传·昭公二十一年》：“公饮之酒，厚酬之；赐及从者，司马亦如之。张勾尤之，曰：‘必有故’。杜预注：“尤，怪赐之厚。”或作怨恨解，如《论语·宪问》：“不怨天，不尤人。”

按 重舌、吐舌，皆因心脾积热，风邪客搏所致，急用三棱针点刺舌下之金津、玉液，去其恶血，可以清心脾积热，调舌本气机。

吐 舌（1 则）

93. 有男子病后吐舌，云兄^{〔1〕}亦知医，谓云曰：“此病后近女色太蚤^{〔2〕}也。舌乃心之苗，肾水竭不能制心火，病在阴虚，其穴在左股太阳，是当以阳功阴。”云曰：“然”。如

其穴针之，舌吐如故。云曰：“此知泻而不知补也”。补数剂，舌渐复。

〔《明史·凌云传》〕

注

〔1〕云兄：凌云之兄长。

〔2〕蚤：同早。

失 语（1 则）

94. 乔××，男，23岁，某矿务局工人。失语已70天左右。

自诉：于1979年11月27日在坑下作业时，头部砸伤后发生昏迷。1小时后醒来发生失语，经诊断为：（1）头颈部挫伤；（2）胸部左侧肋骨骨折；（3）胸₁₂，腰₁脊柱压缩性骨折；（4）运动性失语。曾住当地医院一月余，出院后骨折已基本恢复。

查：不能对话，但能理解别人语意，左耳听力差，饮食、二便正常，舌尖红，脉弦。

针取：百合、左风池、左听宫、廉泉、列缺、照海。用平补平泻，留针30分钟（廉泉不留针）。经针十次后，已经能数字，但声音较小，在一尺左右的近处方能听到。针十八次，已能大声说话，声音清晰，但句子短，内容简单。前后共二十四次，经神经科复查，已能正确对答问题，听力恢复。

（程莘农医案）

牙 痛（5 则）

95. 辛帅^{〔1〕}旧患伤寒方愈，食青梅，既而牙疼甚。有道人为之灸，屈手大指本节后陷中，灸三壮，初灸觉病牙痒，再灸

觉牙有声，三壮痛止。今二十年矣，恐阳溪穴也。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕辛帅：疑指宋代词人辛弃疾，山东历城人。曾任河南安抚使。

按 热病方愈，正气大虚，或有余热未尽，食酸梅以致牙疼。阳溪为手阳明火穴，灸之可清泄余热，疏通阳明，但应左痛灸右，右痛灸左。

96. 有老妇人旧患牙疼，人教将两手掌交叉〔1〕，以中指头尽处为穴，灸七壮，永不疼。恐是外关穴也，穴在手少阳去腕后二寸陷中。

臬司〔2〕梢子妻旧亦苦牙疼。人为灸手外踝穴近前些子〔3〕。遂永不疼。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕两手掌交叉：据下文注为外关穴，当指两虎口交叉。

〔2〕臬司：官名。又称按察使。

〔3〕手外踝穴近前些子：疑阳谷穴。

按 牙疼病因有风火、胃火、虚火等不同，治法、选穴也随之有异。第一例取外关，推测为风火牙痛。外关为三焦经络穴，又是八脉交会穴，通阳维，灸之可疏风解表，清泄三焦实热。第二例在手外踝前取穴，疑是阳谷。《甲乙》云：“上齿齲痛，阳谷主之”。阳谷为手太阳的“经”（火）穴，亦有泻火清热之效。

97. 张季明〔1〕治一人患牙疼，为灸肩尖（即肩髃穴），微近骨后缝中，小拳臂取之，当骨解陷中，灸五壮即差〔2〕。尝灸数人皆愈，随左右所患无不立验。灸毕项大痛，良久乃定，永不发。季明曰：予亲病齿痛，百方治之不效，用此法治之遂

差。

(《名医类案》)

注

〔1〕张季明：即张果，新安人，著《医说》。

〔2〕差：同瘥，减轻或痊愈之意。

98. 齐中大夫〔1〕病齩齿，臣意〔2〕灸其左大阳明脉〔3〕，即为苦参汤，日嗽〔4〕三升，出入五六日，病已，得之风，及卧开口，食而不嗽。

(《史记·扁鹊仓公列传》)

注

〔1〕中大夫：官名。职务不固定，供顾问议事。

〔2〕意：即淳于意。

〔3〕左大阳明脉：《资生》、《名医类案》引作“左太阳明脉”，《证类本草》引作“左手阳明脉”。因手阳明循经齿中，又《素问·缪刺论》：“齿齩，刺手阳明”，故从后说。

〔4〕嗽：通漱，漱口。

按 齿疾取手阳明，早见《帛书》。案中虽未言具体穴名，与当时穴位发展还欠完善有关。《内经》曾提出一些穴名，可供参考。如《灵枢·寒热病》：“臂阳明有入颊通齿者，名曰大迎，下齿齩取之”。又《灵枢·经脉》：“手阳明之别，名曰偏历……实则齩聋……，取之所别也。”今多取合谷等穴。

99. 黄××，女，68岁，门诊号：补79—3—88。

初诊：1979年10月26日。自觉牙龈疼痛已半月余，每在午后及劳累后加重。检查：无齩齿，牙龈无红肿，舌尖红无苔，脉细数。拟为阴虚牙痛，针太溪（双），三次后疼痛消失。

按 牙痛之症多属胃经实火，症多见于牙龈肿痛，故临

床上多取合谷、内庭等穴。本例患者本属阴虚之体，虚火上炎，故午后及劳累后牙痛即发。取太溪以益滋肾阴，肾阳得复，则虚阳不致上扰为病。

（陈作霖医案）

牙 关 脱 臼（1 则）

100. 家岳母黄刘氏，年六十五岁，因呵欠牙关脱臼，饮食俱废，经外科医治无效，至第四日，来舍就医，琚^{〔1〕}即刺颊车、地仓、承浆、合谷、间使、支沟、百劳、三阴交等穴；另用芪、归、术、草、防风以助治；外用生南星末调姜汁敷患处。当针刺后，已能略进饮食，次晨下颌亦收上，惟未能复原，乃依法复治一日，竟获全愈，已恢复原本状态，饮食如常。

（柳兆璐医案）

注

〔1〕琚：即作者柳兆璐。

牙 槽 风（1 则）

101. 刘汉卿郎中^{〔1〕}患牙槽风^{〔2〕}，久之颌穿，脓血淋漓，医皆不效。在维扬时，有丘经历^{〔3〕}，益都人，妙针法，与汉卿针委中及女膝^{〔4〕}穴。是夕^{〔5〕}脓血即止；旬日后，颌骨脱去，别生新者，完美如昔。又张师道亦患此证，复用此法，针之亦愈。

（《医说》）

注

〔1〕郎中：官名。

〔2〕牙槽风：又名穿腮毒、牙叉发、穿腮发、骨槽风。多因风火邪毒上灼而成。初起于耳前并连接腮项，隐于皮肤内，略有小核，渐大如胡桃，或腐溃，溃后难愈。牙龈肿痛，久则腐烂而臭，甚或骨槽腐

烂，牙齿脱落。

〔3〕丘经历：宋代针灸家，妙于针法。

〔4〕女膝：经外奇穴名，别名女须。位于足后跟部，跟骨中央，跟腱附着部下缘处。主治牙槽风、齿龈炎、吐泻转筋等。

〔5〕是夕：是，代词。这天晚上。

按本案取穴，不循常规，弃阳明而从太阳，乃足太阳居三阳之首，“诸阳之属”，（《素问·热论》）。委中，一名血郄，可清热解毒，舒筋利腰，法宜泻血；女膝乃治牙槽风奇穴，两穴合用，其功益彰。《灵枢·终始》云：“病在上者，下取之，……病在头者，取之头”。本案验之。

咽 喉 疾（21则）

咽 喉 肿 痛（15则）

102. 一男子咽喉肿痛，药不能下，针患处，出紫血少愈，以破棺丹^{〔1〕}噙之，更以清咽消毒散^{〔2〕}，服之而愈。

（《外科发挥》）

注

〔1〕破棺丹：方用大黄二两（半生，半熟），芒硝、甘草各一两。共研末，炼蜜为丸，弹子大，每服半丸，茶水或酒送下。治诸疮肿热。

〔2〕清咽消毒散：用鲜金银花、连翘、犀角、栀子、黄连、牛蒡子、玄参心、人中黄、马勃、薄荷、绿豆衣、板兰根。共为粗末，水煎去渣，徐徐嗽咽。治痰喉腐烂等。

103. 一男子咽喉肿痛，余欲针之，以泄其毒，彼畏针，止服药，然药既熟，已不能下矣，始急针患处，出毒血，更以清咽消毒药而愈。

（《外科发挥》）

按 刺络放血为针灸治疗咽喉肿痛的常法。具有开窍泻热、活血消肿的作用。《素问·血气形志篇》曰：“凡治病必先去其血”。特别有明显瘀血现象的各种病症，刺络可“泻之万全”。喉痹一症，大抵因火为患居多，其害甚速，喉又为呼吸之门，一经瘀阻，则呼吸不畅，危在顷刻。先贤告诫：“治喉闭之火，如救火同，不容少待”。实乃经验之谈。本案取三棱针点刺局部，泄出恶血，具有清热毒、消肿痛，启喉关等作用，适用于肺胃实热所致的咽喉肿痛。

104. 一男子咽喉作痛，痰涎上壅，余欲治以荆防败毒散，加连翘、山桅、牛蒡子，彼自服甘寒降火之药，反加发热，咽愈肿痛，急刺少商二穴，仍以前药加麻黄汗之，诸证并退，惟咽间一紫处仍痛，此欲作脓，以前药去麻黄一剂，脓溃而愈。凡咽痛之疾，治之早，或势轻者，宜用荆防败毒散以散之；治之迟，或势重者，须刺少商穴。瘀血已结，必刺患处，亦有刺少商。咽虽利而未全消者，必成脓也，然脓去即安。若有大便秘结者，虽经针刺出血，必欲以防风通圣散攻之，甘寒之剂，非虚火不宜用。

（《外科发挥》）

注

〔1〕荆防败毒散方用：羌活、独活、柴胡、前胡、人参、桔梗、枳壳、茯苓、川芎、荆芥、薄荷、人中黄、牛蒡子各一钱，防风一钱半。水煎服，加金汁一匙尤妙。治喉痹失音，虾蟆瘟等。

〔2〕防风通圣散：方用防风、川芎、当归、芍药、大黄、芒硝、连翘、薄荷、麻黄各半两，石膏、黄芩、桔梗各一两，白术、栀子、荆芥穗各二钱半，滑石三两。甘草二两。为粗末，每服一两，加生姜水煎服，日三次。功能疏风解表、清热泻下。

105. 太守叶，咽喉肿痛，痰涎不利，手足发热，喜冷饮食。用清咽利膈汤二剂，不应。刺少商穴，喉少宽，痰从鼻出如

咬，患处出紫血稍宽，至七日咳出秽脓而愈。

（《口齿类要》）

按 少商为手太阴井穴，针之，可清肺热、利咽喉，为治咽喉肿痛的经验效穴。若点刺出血更妙。

106. 吴孚先治一小儿咽喉忽肿胀，痛甚，米饮汤水不下，危甚。吴曰：此名锁喉风^{〔1〕}。以银针刺少商、然谷二穴出血，其喉即宽，与之茶即下，咽无苦，饮食遂进。

（《续名医类案》）

注

〔1〕锁喉风：病名。又名咬牙风。症状类似今之扁桃体周围脓肿、咽后壁脓肿等。

按 锁喉风乃儿科急症，多由痰涎或疫毒之邪结聚于喉，致使气血凝结，脉络瘀阻，气道阻塞。临床常见牙关拘急，口噤如锁，气道受阻，死在须臾。喉既锁，水药难进，非针莫属，少商乃喉症主穴，配荣（火）穴然谷泄血，火随血泻，喉宽锁开，方能化险为夷。

107. 一人患喉痹，颐颌粗肿，粥药不下，四肢逆冷，六脉沉细，急灸关元穴二百壮，四肢方暖，六脉渐生，但咽喉尚肿，仍令服黄药子散^{〔1〕}，吐出稠痰一合乃愈，此治肾也。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕黄药子散：黄药子（即斑根）一两，研末。每服一钱，白汤下。治缠喉风，颐颌肿及胸膈有痰，汤水不下者，用此吐之。

108. 一人患喉痹，痰气上攻，咽喉闭塞，灸天突穴五十壮，即可进粥，服姜附汤一剂即愈，此治肺也。

（《扁鹊心书》）

109. 一人患喉痹，六脉细，余为灸关元二百壮，六脉渐生。

一医曰：此乃热症，复以火攻，是抱薪救火也。遂进凉药一剂，六脉复沉，咽中更肿，医计穷。用尖刀于肿处刺之，出血一升而愈。盖此证忌用凉药，痰见寒则凝，故用刀出其肺血，而肿亦随消也。

（《扁鹊心书》）

按 窦材认为喉痹之症，多由肺肾阴虚，风寒客之所致，令人颐颌粗肿，咽喉闭塞，汤药不下，死在反掌。故疗治之法，重在肺肾。必先开豁痰涎，痰涎既涌，咽喉自然通快，然后再视轻重施治。姜、附、灼艾，诚为治本之法，但人多畏之，不肯为用。殊不知肺肾阴虚，虚火上炎，此乃无根之火，断不可妄用白虎等剂。盖一味寒凉，痰见寒则凝；既有外邪，亦致冰伏，若元本亏损，未有不闭闷而毙者。今择关元、天突，功在肾、肺。前者温阳散结，消痰利咽；后者宣肺化痰、清利咽喉，可独用，亦可互用。所以灼艾者，乃热因热用。若谓其“抱薪救火”则非；但唯泥灼艾而弃他法，亦非。法当审因处治，方保无虞。可与楼英治法并参。

110. 大抵治喉痹，用针出血，最为上策，但人畏针，委曲傍求，瞬息丧命。凡用针而有针创者，宜捣生姜一块，调以热白汤，时时呷之，则创口易合。《铜人》中亦有灸法，然痛微者可用；病速者，恐迟则杀人。故治喉痹之火，与救火同，不容少待。《内经》火郁发之，发谓发汗，然咽喉中，岂能发汗，故出血者，乃发汗之一端也。后之君子，毋执小方，而曰吾药不动脏腑，又妙于出血，若幸遇小疾而获功，不幸遇大病而死矣，毋遗后悔可矣。

（《儒门事亲》）

111. 夫男子妇人，喉闭肿痛不能言，微刺两手大拇指，去爪甲如韭叶，是少商穴。少商是肺金之井穴，以铍针刺出血

立愈，如不愈，以温白汤口中含漱，是以热导热也。

（《儒门事亲》）

112. 楼全善治一男子喉痹，于太溪穴刺出黑血半盏而愈，由是言之，喉痹以恶血不散故也。凡治此疾，暴者必先发散，发散不愈，次取痰；不愈，又次取污血也。

（《续名医类案》）

按 楼氏治喉痹，法计有三：凡属风热犯肺，化火上逆者，以疏风解表，清热利咽为主。近世常用少商、曲池、合谷等穴。若因肺胃风热，火毒上炎，津液受灼，煎炼成痰，痰火壅结，致使咽喉肿痛者，则以清胃热、化痰浊、利咽喉为主。方用内庭、丰隆、商阳、天突等穴。以上皆属实证，针用泻法。但亦有因真阴不足，虚火上炎，灼于咽喉者，对此，则以滋阴降火为主，可用太溪、照海等穴。

113. 郑惟康主簿^{〔1〕}，尝苦喉闭，虽水亦不能下咽，灸三里穴而愈。

（《医说续编》）

注

〔1〕主簿：官名。为参与机要，总领府事的官。

按 咽喉之疾，常责之于肺、胃两经。足阳明“循喉咙，入缺盆”，气通咽喉，胃气健旺，则功能正常，若过食煎炒，致使胃腑蕴热，热毒上攻，搏于咽喉，则可见疼痛肿胀，吞咽不利。本案灸三里者，从胃论治，意在通调胃腑积热，引火下行。

114. 薛立斋治于县尹^{〔1〕}喉痹，肿痛寒热。此手少阴心火、足少阴相火二经为病，其症最恶。惟刺患处，出血为上。因彼畏针，先以凉膈散^{〔2〕}服之，药从鼻出，急乃愿刺，则牙关已紧，不可刺，遂刺少商二穴，以手勒出黑血，口即开，乃

刺发间，治以前药，及金锁匙^{〔3〕}吹之顿退；又以人参败毒散^{〔4〕}加芩、连、元参、牛蒡子，四剂而平。经曰：火郁发之。谓发汗，出血乃发汗之一端也。

（《续名医类案》）

注

〔1〕县尹：元代官名。为县之长官。

〔2〕凉膈散：方用连翘、大黄、芒硝、甘草、黄芩、薄荷、栀子，有疏泄膈结，通便泻火的作用。

〔3〕金锁匙：方用火硝一两五钱，硼砂五钱，龙脑香二分五厘，僵蚕一钱，雄黄二钱。为细末，吹喉。治喉闭、缠喉风，痰涎壅塞，口噤不开，汤水不下等。

〔4〕人参败毒散：方用人参、羌活、独活、柴胡、前胡、川芎、枳壳、桔梗、茯苓、甘草、生姜、薄荷。功能益气发汗，散风祛湿。

按 风热邪毒侵袭咽喉，内伤于肺，乃致红肿疼痛，阻塞不通，此属喉痹。本案咽肿口噤，水药不入，作者以少商点刺出血，并针局部，使热为之泄，喉为之开，痛为之定，肿为之消，即时奏效。

115. 安康公李袭兴称，武德^{〔1〕}中出镇潞州，属随徵士甄权^{〔2〕}以新撰《明堂》示予。余既暗昧，未之奇也。时有深州刺史成君绰，忽患颈肿如数升，喉中闭塞，水粒不下已三日矣。以状告余，余屈权救之。针其右手次指之端，如食顷，气息即通。明日饮啖如故。

（《千金翼方》）

注

〔1〕武德：唐代年号。即公元618～626年。

〔2〕甄权：唐时医家。许州扶沟（今河南许昌）人。《旧唐书》有传。精专针灸。曾奉旨修订《明堂》。

按 颈肿喉闭，浆水不下，甚或痰涎壅塞，呼吸不利，症属喉风。多由肺胃积热，抑遏咽喉所致。次指之端者，当指商阳。属于阳明多气多血之经，刺之出血，有清热降火，化痰涤浊之功，若与手太阴之少商、鱼际，手少阳之液门和足阳明之内庭、丰隆同用，则其功莫大也。

116. 一男子咽喉肿闭，牙关紧急，针不能入。先刺少商二穴，出黑血，口即开，更针患处，饮清咽利膈散，一剂而愈。大抵吐痰、针刺，皆有发散之意，故多效。尝见此证，不针刺，多致不救。

（《外科发挥》）

乳 蛾（3 则）

117. 一男子乳蛾肿痛，饮食不入，疮色白，其脓已成，针之脓出即安。

（《外科发挥》），

按 风热客搏不解，蒸灼肌膜，肉腐成脓。脓排则毒去，毒去则肿消，肿消则痛失，奏效甚捷。

118. 一男子乳蛾肿痛，脉浮数，尚未成脓。针去恶血，饮荆防败毒散，二剂而消。

一人患乳蛾，其色已绝，心头尚温，急针患处，出黑血即苏，如鲍符卿、乔侍御素有此证，每患皆以针去血即愈。

（《外科发挥》）

119. 嘉佑中有太傅⁽¹⁾程公，守任于江夏，因母之暴患咽中有痈，卒然而长，塞气不通，命医者止可用药治之，勿施针以损之。医曰：咽中气尚不通，岂能用药，药即下之，岂能卒效，故众医不敢措治。寻有医博范九思⁽²⁾云：有药须用未使新笔点之，痈疽即便差，公遂取新笔与之，九思乃以点药

上痛，药到则有紫血顿出，渐气通而差。公曰：此达神圣之妙矣。公命九思饮，而求其方。九思大笑曰：其患是热毒结于喉中，塞之气不宣通，病以危甚。公坚执只可用药，不可用针，若从公意，则必误命；若不从公意，固不能施治，九思当日，曾以小针藏于笔头中，妄以点药，乃针开其痛而效也。若非如此，何如紫血顿下也？公方省而叹曰：针有劫病之功，验于今日。古人云：为将不察士卒之能否，则不能决胜；为医不察药性之主治，则不能便差；又将无深谋远虑，则无必胜；医无先机远见，治无必效也。

（《予午流注针经》）

注

〔1〕太傅，官名。为辅弼国君的官。次于太师，并无实职。或指辅导太子的官。

〔2〕范九思：北宋医家。精针术，亦擅医药，善治危重病人。

按 范公治咽闭，别出新裁。佯与末药，许以笔点，却暗中藏针刺之，旋即化险为夷。其思路之敏捷，手法之熟练，治疗之把握，令人叹服。既可免患者之恐惧，又可达医者之目的，乃一举两得也。

音 哑（2则）

120. 著名京剧艺术大师周信芳，曾因疲劳过度，或感受风寒，常会发音嘶哑甚则失音，以致无法登台演出，引为苦闷。闻杨老师^{〔1〕}善于针药并治，特来求治。杨老师在治疗时，常针刺天鼎双 列缺双 合谷双，用平补平泻法，留针十五分钟，在留针期间加雀啄术二到三次，即见收效。另予内服中药：炙麻黄2.4克 玉蝴蝶4对 蝉衣2.4克。以宣肺化痰，清利咽喉，消除病痛而巩固其歌喉。经杨老师针药并用后疗

效迅速，能立即登台演出。因此，周信芳对杨老师的医术也十分敬佩。

（《杨永璇中医针灸经验选》）

注 杨老师：指杨永璇。现代针灸家。上海南汇人。

121. 一男子，年近五十，久病痰嗽。忽一日，感风寒，食酒肉，遂厥气走喉，病暴暗。与灸足阳明别丰隆二穴，各三壮，足少阴照海穴，各一壮，其声立出。信哉！圣经^{〔1〕}之言也。仍以黄芩降火为君，杏仁、陈皮、桔梗泻厥气为臣，诃子泻逆，甘草和元气为佐。服之良愈。

（《名医类案》）

注

〔1〕圣经：此指《内经》。

按 久病咳嗽，肺阴必伤，喉失濡养，复感风寒，以致寒痰逆气走喉，阻于声户，发为暴暗。丰隆乃足阳明络穴。《灵枢·经脉》载：“其病气逆则喉痹、卒暗”。刺之能降逆、消痰。照海属肾，为阴跷脉所起，八脉交会穴之一，具有养阴、利咽等作用。是治疗咽喉疾患的常用要穴。《标幽赋》云：“治喉中之闭塞”。信无诞也。

梅 核 气（1 则）

122. 辛未夏，刑部王念颐公，患咽噎之疾，似有核上下于其间。此疾在肺膈，岂药餌所能愈？东皋徐公推予针之，取膻中、气海，下取三里二穴，更灸数十壮，徐徐调之而痊。

（《针灸大成》）

注

〔1〕刑部：官署名，掌管国家的法律、刑狱事务。

按 所谓咽噎之疾，属“梅核气”。《医宗金鉴》曰：

“咽中如有炙腐，谓咽中如有痰涎，如同炙肉，咯之不出，咽之不下者，即今之梅核病也。”由情怀郁结，气滞痰凝，阴阳不得升降而致。《行针指要歌》曰：“或针气，膻中一穴分明记。”膻中位居胸部，别名“上气海”，又为八会穴之气会穴，所以有宽胸利膈，顺气化痰的作用，配以任脉之气海，相得益彰，同调气机，作用更强。足三里属足阳明经，足阳明“循喉咙，入缺盆，下膈……”故能调脾胃，宽胸膈，化痰核、调气机，亦属循经远取之法。

耳 疾（3则）

耳 肿 痛（1则）

123. 吴孚先治张司马^{〔1〕}，素有火症，两耳肿痛，系少阳风热，劝延针灸科，刺听会、合谷、临泣寻愈^{〔2〕}。

（《续名医类案》）

注

〔1〕司马：官名。在将军之下，参与军事计划。

〔2〕寻：旋即，不久。

按 耳疾多责于少阳。盖少阳脉“从耳后，入耳中，出走耳前”故也。张司马素有火症，复感风邪，风火相煽，燔灼少阳，以致两耳肿痛，清空不灵。当以清胆聪耳为主。本方用听会祛风、聪耳，疏调耳部经气，是治疗各种耳疾的主要穴位。《玉龙歌》曰：“耳聋之症不闻声，痛痒蝉鸣不快情；红肿生疮需用泻，宜以听会用针行”。足临泣清头目、利耳窍、祛风、泻火，与手阳明合谷配伍，引气上头，而泻火之功益彰。风去火清，则肿消痛停也。

耳 鸣 (1 则)

124. 潘妇产后失调，肝肾两亏。遂患耳鸣症，甚至半头隐痛，颇为焦虑。问治于余，观其形神憔悴，知为木水失濡使然。乃为试针风池、听会各二穴，并欲处方调补。詎料出针之后，耳鸣倏失，尽欢而去。

(陆善仲医案)

注

(1) 詎：岂。

按 耳鸣一症，按经络辨证，多因少阳经气闭塞所致。《百症赋》曰：“耳中蝉噪有声，听会堪攻。”说明听会是治疗本症的主要穴位，功能祛风聪耳，疏少阳耳部经气，益风池，其祛风之力益强，风除则鸣止矣。是一种舍脏从经之治。

耳 聋 (1 则)

125. 庆安小学校仆，名陈良者，病后七月，患耳聋，虽雷霆巨声不闻也。该校长因之欲停其役。陈颇忧之，盖八口之家，日日仰之生活。果遽失业，被累奚如。陈与余距不远。登门求治。余曰：欲耳复聪，固非难事，只须针灸耳。陈曰：君能之乎？果能治愈，惠我多矣。余乃为针肾俞并灸之，次针灸风池，听会，先泻后补，一次能辨语，三次全愈。

(陆善仲医案)

按 聋分虚实。实证多因肝阳上僭，清空被扰；虚证多因肾气亏乏，无以上输。本例聋于久病之后，故先取肾俞，补肾培元，使肾气充实，上注于耳，配风池、听会，通达少阳经气，三穴共用，使耳聋得以复聪。

中身病症(103则)

胸部疾(17则)

咳嗽(6则)

126. 有一男子咳嗽，忽气出不绝声，病数日矣。以手按其膻中穴而应^{〔1〕}，微以冷针^{〔2〕}频频刺之而愈。

(《针灸资生经》)

注

〔1〕应：相应；反应。这里指按压膻中穴有疼痛或舒快等反应。

〔2〕冷针：与温针对举，指单纯毫针刺法。

按 膻中属气会，居胸中，乃上焦之要穴。《难经》曰：“上焦者……其治在膻中”，诸凡咳嗽气喘，胸满等气机疾患。此处常有酸胀压痛等反应，诊治皆有其用。

127. 施秘监^{〔1〕}尊人^{〔2〕}患伤寒咳甚，医告技穷。施检《灸经》，于结喉下灸三壮即差，盖天突穴也。

(《针灸资生经》)

注

〔1〕秘监：官名，即秘书监。南北朝末期以后为秘书省之长官，掌图书著作等事。明废之。

〔2〕尊人：父亲。

128. 一人暑月饮食冷物，伤肺气，致咳嗽，胸膈不利，先服金液丹百粒，泄去一行，痛减三分，又服五膈散^{〔1〕}而安，

但觉常发，后五年，复大发，灸中府穴五百壮，方有极臭下气难闻，自后永不再发。

(《扁鹊心书》)

注

〔1〕五膈散：人参，黄芪，白术，麦冬，官桂，附子，干姜，远志，台椒，北细辛，百部，杏仁。

按 夏月伏阴在内，冷物不可于过，有过则伤。本案若以热气伤肺论治，一派寒冷，致使水气不消，势必酿成大病也。

129. 一人得伤寒症，七日热退而咳连声不绝，择家傍徨，召虞^{〔1〕}诊，其脉皆沉细无力，人倦甚，以补中益气汤作大剂，加炮姜附子一钱，一日三帖，兼与灸气海、乳根三处，当日咳止，脉亦充而平安。

(《名医类案》)

注

〔1〕虞：指虞抟(tuán)，明代医家。字天民，自号花溪恒德老人，浙江义乌人。

按 病后作咳，多属气虚，除大剂温补之外，灸气海者，乃《医学入门》“气海可主一切气疾”之理；辅乳根理气降逆，亦为治咳要穴。《医说》曰：久病得咳逆者，乳根灸之立愈。

130. 里人^{〔1〕}病嗽，绝食五日，众投以补剂，益甚。云^{〔2〕}曰：“此寒湿积也，穴在顶^{〔3〕}，针之必晕绝，逾时始苏。”命四人分牵其发，使勿倾侧乃针，果晕绝，家人皆哭，云言笑自如，顷之气渐苏，复加补，始出针，呕积痰斗许，病即除。

(《明史·凌云传》)

注

(1)里人，街坊邻居。

(2)云：嘉云，明代医家，字汉章，号卧岩，归安（今浙江吴兴）人，精针灸术，明孝宗时任太医院御医。

(3)顶：头顶，疑指百会。百会一名顶心。

131. 予族中有病霍乱吐痢，垂困忽发咳逆，半月之间，遂至危殆。有一客云有灸咳逆法，遂令灸之，火至肌，咳逆已定。

（《苏沈良方》）

哮喘（2则）

132. 有贵人久患喘，夜卧不得而起行，夏月亦衣夹背心，予知是膏肓病也，令灸膏肓（俞）而愈。

（《针灸资生经》）

按 喘久气虚，阳气不足，“阳虚则外寒”，迁延日久，积渐冰坚，遂成膏肓之疾。膏肓俞，灸能温肺补虚，善治羸瘦虚损，上气喘逆。《行针指要歌》：“或针劳，须向膏肓及百劳”，指本穴以治虚劳为主。

133. 患者楼××，男，13岁。

病起于麻疹后，至今已5～6年，初时仅年发2～3次，近年来频繁反复发作，遇冷尤甚。发时带哮鸣音，呼吸困难，运动则更剧，胸部窘迫，呼气较吸气延长，不能平卧，面呈青紫色，曾经中西药物治疗，效果不显。

患儿形体消瘦，面色㿠白，舌淡苔薄，脉象细弱。病由痰浊内阻，肺失宣降，故一遇风寒则气郁痰壅而哮喘作矣。又因反复发作，肺气受损，累及于肾，致肾不纳气，而动则喘甚。征之于平时的一派虚象，当属肺肾两虚所致，治宜求

其本，用隔姜灸法以补肺肾二脏真元之气，而防治其发作。

处方：分下列三组，顺序轮流使用。

(1)肺俞、灵台。

(2)肾俞。

(3)天突、膻中。

操作：用隔姜灸法。以生姜切片一分厚，针刺数孔，置于施灸穴位，上放艾炷（约半个枣核大）燃烧，患者觉灼痛时，将姜片微微提起，待稍缓和仍放置之。上述三组俞穴，每日施用一组，每次每穴灸5~7壮，以九天（每组穴位轮灸三次）为一疗程。

按 针灸治疗本病，笔者曾观察过多例，效果堪称满意。哮喘发作时以针刺合谷，列缺、定喘（大椎穴旁开5分~1寸）等穴，用捻转泻法，结合留针10~15分钟，常可立即缓解喘息。缓解期（常在伏天）则灸上述三组穴位。其中取肺俞以培益肺气，肾俞以填补肾气，合膻中以顺气，灵台以止喘，天突利咽喉而调肺系，则哮喘之发作自可防止。实践证明，尤以儿童疗效为佳。本例灸治后曾追踪观察达5年之久，未见复发。

（楼百层医案）

心 痹（5则）

134. 予旧患心痹，发则疼不可忍，急用瓦片置炭火中，烧令通红，取出投米醋中，滴^{〔1〕}出，以纸三二重裹之，置疼处，稍止，冷即再易，耆^{〔2〕}旧所传也。后阅《千金方》有云：“凡心腹冷痛，熬盐一半熨，或熬蚕沙烧砖石蒸熨取其里温暖止，或蒸土亦大佳，始知予家所用，盖出《千金方》也。他日心痛甚，急灸中管（腕）数壮，觉小腹两边有冷气

自下而上，至灸处即散，此灸之功也。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕漉：沥出。

〔2〕耆：老也。《孟子·梁惠王下》：“乃属其耆老而告之。”

135. 予旧患心气。偶睹《阴阳书》有云：“人身有四穴最急应，四百四病皆能治之。”百会盖其一也，因灸此穴而心气愈。后阅《灸经》，此穴果主心烦惊悸，健忘无心力。

（《针灸资生经》）

136. 会帝〔1〕患心痛，召迭里特〔2〕视之。迭里特曰：“膏肓有淤血如弹丸，然药不能及，必针而后愈。”帝从之。呕出淤血，痛止。帝以其亲，每加赐赉〔3〕。

（《辽史·迭里特传策》）

注

〔1〕会帝：辽太祖耶律阿保机。

〔2〕迭里特：辽代医生。契丹族，姓耶律，字海邻。善骑射，尤精医术。

〔3〕赐赉：赏赐。赉（lài 赖）：赠物予人。

137. 义乌〔1〕令〔2〕病心痛，垂死。明甫〔3〕视之曰：“有虫在肺下，药力所不及，惟砭之可愈。”乃始谓于背上点穴，密取水以喷〔4〕之，令方惊而针已入，即而腹大痛，下黑水数升，虫尽出。病遂愈。

（《嘉兴府志》）

注

〔1〕义乌：县名。在浙江省。

〔2〕令：此指县令。

〔3〕明甫：李明甫。宋代医生。东阳（今浙江东阳）人。

〔4〕喷：嘴含水而喷之。

138. 陈××，女，50岁，医务人员。于1976年3月8日初诊。

自诉：近一年来心前区不适，胸闷，心悸不宁，时有不寐，胃纳尚可，二便正常。

查：面色无华，舌淡红苔少，脉沉缓而结，血压126/82毫米汞柱，曾在某医院作心电图检查为早期冠心病（冠状动脉供血不足）。证属虚劳心悸，心气不足所致厥心痛。

治以补益心气，调畅气血。针取心俞、膏肓俞、足三里、内关。先用维生素B₁100毫克，维生素B₆50毫克混合注射心俞、膏肓俞（交替使用），并用补法针刺内关与间使，隔天一次，十次为一疗程。第一疗程后，症状无明显改善。再经研究认为患者属心血管功能有关疾病，治当补益心气以调整心血管功能为主，加灸心俞，故第二疗程结束乃告临床治愈，并恢复正常工作。

按 本病乃心气不足，即阳气不足。阳气不足则应使用“以火补之”的艾炷灸为主，补益心气，促使心血管的功能得到改善。从心俞穴能治心血管有关功能性疾患的例证中，术者体会到《灵枢·背俞篇》说：“灸之则可，刺之则不可”，乃总结了运用灸背俞穴治五脏疾病的经验，很值得我们重视。

（司徒铃医案）

心 律 失 常（3 则）

139. 沈××，男，50岁，工人。1979年9月10日初诊。

自诉1978年12月因高热、心悸住院，诊断为病毒性心肌炎。热退后遗留过早搏动，出院后用中西药物治疗三个多月，疗效不显。8月初患左半身不遂，迄已月余，某医院诊断为

脑血管梗塞。

今胸闷、心悸。左肢不遂，夜眠不稳，胃纳、二便尚可，舌质红，苔薄腻，脉结代，血压152/92毫米汞柱。心电图：(1)频发室性早搏。(2)左室外膜高电压。诊断为：(1)心悸、阴虚阳亢(2)左半身不遂。治宜宁心益气，育阴潜阳，疏导左肢经气。

处方：内关(双)、曲池(双)、风池(双)、环跳(左)、足三里(左)、三阴交(左)、太冲(双)。

操作：毫针平补平泻，间歇动留针10分钟。

9月12日复诊，针治后自觉胸闷较轻，夜卧尚安；处方操作同前，留针延长至20分钟。

9月14日复诊，结代脉有所减少，病人自觉针灸有效。治法同前。

如此隔1~2日针治一次，8次后早搏已极少。又巩固治疗五次，脉律正常，心电图复查正常，血压138/84毫米汞柱，正常。以后重点治疗半身不遂。

1979年12月20日心电图复查正常。

1981年11月随访脉律正常，每日上班工作。

按：本例心律失常中医辨证为心悸，阴虚阳亢，选内关可宁心益气；三阴交、太冲能育阴潜阳；二池可以潜阳，合上下肢诸穴并可疏导左肢经气。患者针灸后有效，密切合作，故收效比较满意。

140. 夏××，男，42岁，工人。1981年5月7日初诊。

胸闷、气短，有时胸痛，头晕，寐劣，经常畏寒，病起已三年余。踝部浮肿，至暮尤甚。口干，舌质淡胖，边有齿痕。脉细缓，频频结代。曾在××医院治疗两次。心电图检查：(1)窦性心动过缓(48次/分)；(2)频发房室交界性早搏

伴差异性传导（部分呈二联律）；（3）左室外膜高电压。诊断为：（1）窦性心动过缓；（2）频发房室交界性早搏。中医辨证：心痹、气阴两虚。治宜补益心气，宁神安眠。

处方：内关、素髻、安眠。

操作：毫针捻转少许提插补法。

得气有弱或中等感应后，“守气”半分钟左右（勿让气脱失），静留针5分钟，素髻穴刺皮刮针柄1次/秒，刮1～2分钟。

5月9日复诊，针后胸闷觉减，治法同前，加三阴交。

5月11日三诊，脉率50次/分，结代脉减少，治法同前。

5月14日四诊，夜眠较安，脉律齐，无结代，心率听诊54次/分。针治效佳，患者欣喜，隔1～2日针治一次。处方或以列缺易内关，或以膻中易内关。操作同前，留针时间一般在5～10分钟之间。

连续针治九次后，自觉症状消失，复查心率58次/分，疗效显著。为巩固疗效，继续针治四次，心率64次/分，正常。

141. 戈××，男，54岁，工人。1981年5月14日。

胸闷、胸痛、气短、头晕，发病四年左右。有高压病史，经常服降压药片。近来至暮踝部浮肿，胃纳二便尚可，夜寐时安时差。舌质红、苔少。脉细迟缓。血压165/92毫米汞柱。心电图检查：（1）窦性心动过缓（45次/分），（2）左室高电压。中医辨证：心痹，气阴两虚、肝阳偏亢。治拟补益心气，育阴潜阳。

处方：内关、三阴交。

操作：捻转结合提插补法，缓慢得气，有弱、中感应后，守气半分钟左右，勿让气脱失，静留针5分钟后出针。

5月16日复诊，胸闷、胸痛等有所减轻，治法同前。

5月18日三诊，近日夜卧尚安，胸痛未作，脉率50次/分。治法同前。

5月21日四诊，头晕未作，脉率52次/分。血压152/86毫米汞柱。治法同前。

5月23日五诊，自觉症状明显好转，夜卧亦安，血压146/84毫米汞柱。

处方：列缺、三阴交、素髀。

操作：前二穴针用捻转补法，静留针10分钟，素髀穴刺皮、刮针柄1次/秒，刮1~2分钟。

5月26日六诊，疗效稳定，复查心率58次/分，处方操作同前。

以后隔1~2日针治一次，十次满一疗程。针休一周后续第二疗程。内关、列缺、足三里、三阴交、素髀等每次取2~3穴，轮流使用。

6月18日心电图复查：心率64次/分。血压126/84毫米汞柱。下肢已不浮肿，为巩固疗效，又续针治六次，心率、血压稳定，痊愈。

按：本病位于心脏及其所属经络，故选与心脏相联系的经穴，如内关、膻中等。少阴心脉“复从心系却上肺”，故心病取肺经络穴列缺，可宽胸利气，祛痰薷痹；三阴交乃肝肾交会之穴，能育阴潜阳；足阳明经别“上通于心”，可补益心气；督脉主一身阳气，其脉“上贯心”（《素问·骨空论》），取素髀可振奋心阳。

针刺操作手法是提高疗效的关键之一。本病中医辨证均系虚证，治宜补之。具体操作方法：得气须徐缓，感应以弱或中等为宜，并守气半分钟，留针以5~10分钟为宜，最长勿超过15分钟。曾观察到数例由于“得气”感应突然而强烈，

或持续强感应时间过长，尤其是内关穴如麻电感强烈或扩至手指或手指变冷者，常疗效不佳，这是值得注意的。

病人在治疗期间及初愈不久，必须避疲劳、受凉与感冒，要保持充足的睡眠，节制烟酒肥腻，并注意情志修养，避免精神刺激，这对稳定、巩固疗效密切相关。

(高镇五医案)

怔 忡 (1 则)

142. 任××，男，36岁，于1973年9月14日初诊。

自诉：睡眠不安，心慌悸动，精神恍惚，久治不愈，在家休息。

查：精神疲倦，面色微黄，舌赤无苔，六脉沉细，左寸尤虚，诊为心阳虚怔忡。

治以虚则补之。阳虚者宜补气回阳。循经取穴选用神堂穴，针感传导至臀部，行旋捻补法2分钟，又加督脉之大椎，陶道，针感均至尾部，行旋捻法2分钟，当即起针，针一次效果良好，睡眠稳熟，醒后周身舒畅，心悸减轻，隔日又如法针刺一次，恢复健康，上班工作。

按：督脉总督一身之阳，大椎、陶道所以能增加强壮，乃兴奋督脉并增进其功能，神堂为膀胱经俞穴，在背部第二行，横对心俞，心主血脉，又主神门，三穴合用，具有养心安神镇静之效，针刺以旋捻补法，以补其虚，故两次收功。

(彭静山医案)

腹部疾(63则)

黄疸(5则)

143. 一人伤寒，至八日，脉大而紧，发黄，生紫斑，噎气，足指冷至脚面，此太阴证也，最重难治。为灸命关五十壮，关元二十壮，服金液丹、钟乳粉，四日，汗出而愈。

(《扁鹊心书》)

按 太阴见大脉属虚，紧为寒象，证属虚寒。一般太阴病在临床主要表现为脾虚湿盛的证候。本案取命关穴艾灸，驱寒温中，健脾除湿，加关元温阳助火，以消阴翳。且脾为五脏之母，后无之本，属土，生长万物。若中土健运，则清阳得升，浊阴能降，精微四布，水液运行，病复安有？

144. 一人病伤寒，至六日，微发黄，一医与茵陈汤，次日更深黄色，遍身如梔子，此太阴证，误服凉药，而致肝木侮脾，余为灸命关五十壮，服金液丹而愈。

(《扁鹊心书》)

按 本案系伤寒误下变证，发阴黄是也。阴黄系寒湿中阻，影响肝胆疏泄功能，胆汁不循常道，溢于肌肤。艾灸命关(食窦)，健脾利湿退黄。脾之阳气充实，则运化转输有权，水液代谢有序，肝胆疏泄循常，方得黄消，病除而体质康复。

145. 一人患伤寒，至六日，脉弦紧，身发黄，自汗，亦太阴证也。先服金液丹，点命关穴，病人不肯灸。伤寒惟太阴、少阴二证死人最速，若不早灸，虽服药无效。不信，至九日，

泻血而死。

(《扁鹊心书》)

按 不知医而不信医者，往往至此。及至不救，悔之晚矣。

145. 一人遍身皆黄，小便赤色而涩。灸食窦穴五十壮，服姜附汤、全真丹^{〔1〕}而愈

(《扁鹊心书》)

注

〔1〕全真丹：高良姜、干姜、吴茱萸、大附子、陈皮、青皮，上为末，醋糊为丸，梧桐子大，每服五十丸，小儿三十丸，米汤送下。有补脾肾虚损，和胃，健下元，进饮食，行湿气等作用。

146. 沈以潜、葛可久俱神医也。一日有一老姬患黄疸，诣^{〔1〕}沈求治，曰：吾固未之能，荐于葛。葛延沈饮，以针针其左右乳下，而与沈饮者，顷刻时出启左针，而左半身肉色莹然，启右针，而右半身肉如左。

(《续名医类案》)

注

〔1〕诣(yì意)，到某人所在的地方。

慢性肝炎(1则)

148. 杨××，男，22岁，战士。1983年10月10日入院。住院号：142284。(南京军区××医院传染病房)

主诉：右肋下隐痛，纳呆乏力一年余。

病史摘要：患者于1982年6月感全身乏力，工作易疲劳，无其它不适，未重视。至9月，疲劳情况加重，并有右肋下隐痛，纳食减少而就医。经检查肝功能不正常，即住院。经用西药治疗，症状好转而出院。1983年3月7日多次反复，均

住院治疗，虽症状缓解，但肝功能均未恢复正常，出院时诊断断为慢性肝炎。

刻下患者感肝区隐痛，上腹部饱胀不适，食后为甚，厌食油腻，精神倦怠，四肢酸软，小便黄，大便不成形，有时溏薄，面色一般，巩膜无黄染，舌苔薄腻，舌质偏红，脉象细缓。肝肋下1厘米，肝质Ⅰ度，剑下6厘米，肝质Ⅱ度，表面光滑，轻压痛，肝功能检查黄疸指数4，麝浊8，谷丙转氨酶183单位，表面抗原（+）诊断：病毒性肝炎乙型慢性活动期。患者因长期服药未愈，要求针灸治疗。

临床分析：患者右肋下隐痛而拒按，显属肝气郁结，血运欠调所致。肝为罢极之本，故长期疲劳乏力，肝气久郁，势必影响脾之运化，因而纳呆、腕胀、便溏薄，脾虚不运之象互见，所谓经肝病传脾者此也。拟此论治，一面当疏调肝气，一面当益脾助运，两者不可偏废。

处方：肝俞，脾俞，足三里，阳陵泉，太冲，用平补平泻法，以调理肝脾，留针30分钟，间日一次。

上方经治疗一个月后，腹胀好转，纳食增加，大便正常，精神转佳，仅肝区隐痛未除，可见脾运已渐复常，肝气仍欠条达，故减少穴位，仅用肝俞、足三里、太冲三穴，以着重疏调肝气连续治疗二个月，症状全部消失，肝功能复查已恢复正常，表面抗原阴转而出院。

（邱茂良医案）

蛔厥（1则）

149. 吴××，男，29岁，农民。于1962年11月17日入院。

自诉：右上腹部阵性绞痛三天，入院前常感脐周隐隐作痛，按之侧舒，时吞酸吐水，住院前四天口服派吡嗪糖浆驱

蛔，便下蛔虫十多条后觉剑突下右侧处剧烈疼痛，约半小时缓解，尔后胀痛，疼痛无明显扩散，阵发性疼痛日三四次，注射止痛剂无效，现仍上腹部疼痛日三四次，疼痛如绞似刺，痛彻心背难忍，啼哭大叫，辗转床第，坐卧皆非，其妻见状，互相抱头大哭，适院长查房至，鉴及前医治之用杜冷丁止痛无效，因而请笔者治疗。

查：呈痛苦面容，面苍白，舌红润，苔腻浊，呻吟声宏无肠鸣，腹软，剑突下右侧处压痛明显，肢冷脉细，四诊合参，症属蛔厥。

查：白细胞21 500，中性23%，淋巴77%，红细胞500万，血色素87%；大便检查：蛔虫卵(+)；胸透：心肺(-)；肝功能检查：黄疸指数4单位，其他正常。诊断为胆道蛔虫病。

治取阳陵泉、中脘、胆俞，施以龙虎交战法，当针刺阳陵泉得气后，感传循胆经至上腹，痛立减，留针20分钟以上，在留针15分钟后如法再施一次，起针后疼痛基本消失，翌日按上穴如法再针一次，观察三天，病未复发，验血白细胞降至8000，痊愈出院。

按：本病的发生常由蛔虫钻入胆道，刺激总胆管引起奥狄氏括约肌强烈痉挛与胆管内压增高后的强力收缩，而造成阵发性剧烈绞痛。笔者认为针中脘可调升降、理中焦、通六腑，取阳陵泉可通经络、舒筋脉、清胆热；阳陵泉善治胸胁痛及少阳经病变，“合治内府”。实践证明，针刺这些穴位，使经气感传至病所，以调理虚实而收驱蛔功效。

(黄建章医案)

急性胰腺炎(1则)

150. 刘××，女，33岁，社员。于1981年10月8日初诊。

自诉：左上腹突然剧痛，伴有呕吐二天，持续阵发性疼痛，其痛走窜向后背部，大便秘结，小便黄赤。入院诊断：急性胰腺炎。因剧痛、呕吐而约我科会诊。

查：急性病容，呻吟，巩膜无黄染，病人坐起向前倾斜时疼痛稍有缓解。左上腹压痛明显，无反跳痛，肝脾未触及。舌质绛，苔黄腻，脉弦细数。经脉反应左足三里穴下1寸处有明显压痛。证属肝郁气滞，郁久化热，湿热蕴积肝胆，胃失和降，湿热郁结损伤脾阴。

治以舒肝理气，清解郁热，活血止痛。针取足三里下一寸阿是穴，以泻法施术。梁丘（胃经郄穴双取）、内关、公孙、太冲，均双取以泻法施术。针后病人立即痛止，仅有腹胀感。

二诊：病人感到腹胀，欲思饮食，一天来仅恶心无呕吐。舌质红、苔黄、脉弦。足三里穴下反应点消失。除前处方取穴外，重点针刺脾俞、肝俞、双足三里。

该患者连续随症配方针刺四次，症状消失，出院用药调理以巩固疗效。

1982年4月30日，探问其病，至今未犯。

按 胰腺炎属于中医的“胃心痛”、“脾心痛”范围。多因过食生冷，气滞而发痛。本例因饮食失节，情志不顺则痛；肝气横逆犯胃则呕吐；脾气不通，久郁化热，湿热蕴阻中焦，传化失常则脾胃实热；大肠津枯则便秘；热深入里则舌绛；湿热交蒸则苔转黄腻；脉症合参乃为脾胃实热之证。首取足三里下一寸反应点，以泻法可调解脾胃，镇痉止痛；梁丘为胃经之郄穴，经气深聚之处，有舒肝和胃、止痛效速之功；内关配公孙为八脉交会之穴，可泻脾胃湿热，理气降逆止呕吐。经云：治脏治其俞。故二诊时重点针刺脾俞、肝

俞，以健脾利湿、舒肝理气，解久郁之实热。

(徐凤林医案)

痞 气 (5 则)

151. 东垣治一贵妇，八月中，先因劳役，饮食失节，加之忧思，病结痞。心腹胀满，旦食则不能暮食，两胁刺痛。诊其脉，弦而细。至夜，浊阴之气当降而不降，腹胀尤甚。大抵阳主运化，饮食劳倦，损伤脾胃，阳气不能运化精微，聚而不散，故为胀满。先灸中脘，乃胃之募穴，引胃中生发之气上行阳道。又以木香顺气汤⁽¹⁾助之，使浊阴之气自此而降矣。

(《名医类案》)

注

(1)木香顺气汤：木香三分，厚朴四分，青皮、益智仁、茯苓、泽泻、生姜、半夏、吴茱萸各二分，当归五分，升麻、柴胡各一分，草豆蔻、苍术各三分。为粗末。

152. 景岳治一少年，素日饮酒，亦多失饥饱。一日偶因饭后胁肋大痛，自服行气化滞等药，复用吐法，尽出饮食。吐后逆气上升，胁痛虽止，而上塞胸膈，胀痛更甚，且加呕吐。再用行滞破气等药，呕痛渐愈，而在乳胸肋之下结一块，胀痛拒按，脐腹膈闭，不能下达。每于戌亥子丑之时⁽¹⁾，则胀不可当，因其呕吐即止，已可用下，凡大黄、芒硝、棱、莪、巴豆等药，及煎子、朴硝、大蒜、橘叶捣髹等法，毫不能效。而愈攻愈胀，因疑为脾气受伤，用补尤觉不便，汤水不入者凡二十余日，无计可施，窘剧待毙，只得手揉按其处，彼云肋下一点，按着则痛连胸腹，乃细为揣摸，则正在章门穴也。章门为脾之募，为脏之会。且乳下肋间，正属虚里大络。乃

胃气所出之道路，而气实通于章门。因悟其日轻夜重，本非有形之积，而按此连彼，则病在气分无疑也。必须经火则气散。乃以艾灸章门十四壮，兼制神香散，使日服三四次，胀果渐平，食亦渐进，始得保全。

（《古今医案接》）133

注

〔1〕戌亥子丑之时，指整个夜晚。

153. 己卯^{〔1〕}岁，因磁州一同乡，欠俸资往取，道经临洛关，会旧知宋宪副公，云：……“去年长子得一痞疾，近因下第^{〔2〕}抑郁，疾转加增，诸药不效，如之奈何？”予答曰：即刻可愈。……予即针章门等穴，饮食渐进，形体清爽，而腹块即消矣。欢洽数日，偕亲友送至吕洞宾度卢生祠，不忍分袂^{〔3〕}而别。

（《针灸大成》）

注

〔1〕己卯，明万历七年，即公元1579年。

〔2〕下第，科举制度考进士不中谓之。又曰“落第”。

〔3〕分袂（mèi 魅），犹分手离别。

按 痞疾所成，多因脾虚气郁，痞塞不通，留滞积结。临床常见胃脘部有肿块突起，状如复盘，肌肉消瘦，四肢无力。今下第气郁伤肝，肝木犯土，其症又剧。舒肝理气，健脾散结当是治也。考章门属肝，又为脾募、脏会之穴。舒肝解郁，健脾消痞乃其擅。故能纳食于顷刻，消痞于针下。张介宾灸章门、水道，以治痞疾痞成难消。近人则用作灸治肝脾肿大，均有显效，故信其不伪。

154. 戊辰^{〔1〕}岁，吏部^{〔2〕}观岐李遼麓公，胃旁一痞块如复杯，形体羸瘦，药勿愈。予视之曰：既有形于内，岂药力所

能除？必针灸可消。详取块中，用以盘针之法，更灸食仓^{〔3〕}中腕穴而愈。遑麓公问曰：人之生痞，与痞癖、积聚、癥瘕，是如何？曰：痞者，否也。如《易》所谓天地不交之否。内柔外刚，万物不通之义也。物不可以终否，故痞久则成胀满，而莫能疗焉。痞癖者，愚绝隐癖，又玄妙莫测之名也。积者迹也，挟瘀血以成形迹，亦郁积至久之谓尔，聚者绪也，依元气为端绪，亦聚散不常之意云。癥者征也，又精也，以其有所征验，及久而成精萃也。瘕者假也，又遐也，以其假借气血成形，及历年遐远之谓也。大抵痞与痞癖，乃胸膈之候；积与聚为腹内之疾。其为上、中二焦之病，故多见于男子。其癥与瘕见于脐下，是为下焦之候，故常于妇人。大凡腹中有块，不问男妇，积聚、癥瘕，俱为恶症，切勿视为寻常。初起而不求早治，若待痞疾胀满已成，胸腹鼓急，虽扁鹊复生，亦莫能救其万一。有斯疾者，可不惧乎？李公深以为然。

（《针灸大成》）

注

〔1〕戊辰：明隆庆二年，即公元1568年。

〔2〕吏部：官署名。隋唐列为六部之首，掌管全国官吏的任免、考课、升降调动等事务，长官为吏部尚书，历代相沿不改。

〔3〕食仓：经外奇穴名。《医经小学》名血门。位于中腕穴旁开三寸处。

155. 韩貽丰治咎中翰如颖，病数日，二旬不食矣，已治木。韩视之，病色如灰，声低喉涩，瞳神黯然无光。私与其子曰：此甚难治。病者觉之，乃哀恳曰：我今年六十七矣，即死不为夭，但遇神针而不一用而死，死且不瞑目。我生平好酒，而不好色，幸为我下一针。于是乃勉为用针，令卧床袒腹，拊其脐下有一痞，周围径七寸，坚硬如石，乃以梅花针

法^{〔1〕}，重重针之。又针其三脘^{〔2〕}，又针其百劳、百会，皆二十一针，针毕令饮醇酒一杯。乃摇手曰：恶闻酒气已两月矣，强之初攒眉，既而满引如初。

（《续名医类案》）

注

〔1〕梅花针法：指在痞块上、下、左、右、中各一针，形如梅花，故名，非今之梅花针刺法。

〔2〕三脘：即上脘、中脘、下脘三穴之总称。

呃 逆（3则）

156. 陈良甫^{〔1〕}……尝治许主簿痢疾，呃逆不止，诸药无效，灸期门穴，不三壮而愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕陈良甫：宋代著名医学家，名自明。临川（今江西抚州）人世世代业医，曾任建康府明道书院医学教授。

按 痢伴呃逆，多从其胃，和胃不成，当顾其肝。肝气横逆，克制脾土，既可发呃，又能致泄生痢，期门为肝之募穴，既能疏肝，又可调脾。一举双得。可知穴在精而不在多也。

157. 娄东吴大令^{〔1〕}梅顿先生弟也。丁未夏归自燕台，炎风烈日，不无感受，萑苻^{〔2〕}不靖^{〔3〕}，不无惊恐，舟中兼有当夕者，至中途疲沓殊甚，急棹^{〔4〕}抵吴门^{〔5〕}，或憔悴之体，竟应投补。沈^{〔6〕}见脉数未平，气口独盛，以为虚中有实热，初用藿苓等剂，溯其源也，继用刺利等剂，导其流也。宿垢既除，旋培元气，元气渐复，行且勿药矣。因设酬劳之宴，劳倦急甚。其夕，神昏肢倦，俄而发呃。沈曰：劳复发呃，当施温

补无疑，第虚气上逆，其势方张，恐汤药未能即降，须艾炷佐之为妙。一炷于期门穴一壮，即缓，三壮全除，调补而瘳。

（《续名医类案》）

注

〔1〕大令：官名。知县。

〔2〕蕞(huǒn环)苻：泽名。《左传》：“郑国多盗，取人于蕞苻之泽。”后因称盗贼出没之处为蕞苻。

〔3〕不靖：不安静。

〔4〕棹：划船。

〔5〕吴门：苏州别称。

〔6〕沈：沈明生。

158. 有病霍乱吐痢垂困，忽发咳逆，半月间遂至危殆。一医云：凡伤寒及久病得咳逆，皆恶候，投药不效者，灸之愈。遂令灸之，火至肌，咳逆随定。元丰中壶为鄜延经略使〔1〕，有幕官〔2〕张平序病伤寒已困咳逆甚，气已不属，忽记灸法，试令灸之，未食顷〔3〕遂瘳。其法乳下一指许（乳根穴），正与乳相直骨间陷中，妇人即屈乳头度之，乳头齐处是穴，艾柱如小豆大，灸三壮，男左女右，只一处，火到肌即瘳，若不瘳，则多不救矣。

（《名医类案》）

注

〔1〕经略使：官名。边防军事长官，多由节度使兼任。

〔2〕幕官：将帅参谋、书记之类。

〔3〕食顷：一顿饭工夫。

膈 气（2则）

159. 一人每饭后饮酒，伤其肺气，致胸膈作胀，气促欲死。服钟乳粉、五膈散而愈。若重者，灸中府穴亦好，服凉药则

戒中满难治矣。

(《扁鹊心书》)

按 胡珏曰：“酒后吃饭，中气不伤，若饭后饮酒，清气浊乱，所以致胀。”中府乃手、足太阴之会穴，不独调气，亦擅理脾。此一举两得，妙哉。

160. 壬申岁，行人虞绍东翁，患膈气^{〔1〕}之疾，形体羸瘦^{〔2〕}，药餌难愈。召予视之，六脉沉涩，须取膻中，以调和其膈，再取气海，以保养其源。而元气充实，脉息自盛矣。后择时针上穴，行六阴之数，下穴行九阳之数，各灸七壮，遂全愈。今任扬州府太守，庚辰^{〔3〕}过扬，复覩^{〔4〕}形体丰厚。

(《针灸大成》)

注

〔1〕膈气：肝郁气滞、胸膈气短之症，症见胸膈噎气不畅。

〔2〕羸(161雷)瘦：指身体极瘦弱。《史记·扁鹊传》：“形羸不能服药。”

〔3〕庚辰：明·万历八年，即公元1580年。

〔4〕覩：通“睹”。见，看见。

按 人体之气来源于脾胃，出入升降治节于肺，升发泄于肝，帅血贯脉而周行于心。故气为血帅，血为气母。气行则血行，气滞血亦滞。肝郁气滞可影响脾胃生化之源。叶天士说：“气本无形，郁则气聚，聚则似有形而实无质，如胸膈似阻，心下虚痞，胁胀背胀，腕闷不食。”久而久之，则形体羸瘦，气血俱虚。脉沉涩，乃属气虚血流迟滞之象。治疗取膻中、气海相配，是为疏导其气，乃为固本之治。

噎 膈(1则)

161. 郭××，女，73岁。南汇县黄路公社卫生院门诊号：

6387。

据家属代诉：患者于前日下午起，突然眩晕，肢体麻木，滴水不进，得食即吐，一昼夜达数十次，胸部痞闷，精神疲乏，闭目懒语已二天，脉弦大，两尺微细，舌淡苔薄腻，按神阙，中脘有动悸应指。病系中气不足，肝木犯胃，胃气不能下降，遂致得食即吐。症属噎膈，宗前人经验取中魁灸之。

处方：中魁（灸）。

灸法：米粒灸各七壮。

灸后患者自诉胸脾无异常。次日随访，眩晕平，呕吐止，并能吃稀粥几匙。

按 噎是吞咽之时，梗噎不顺；膈是胸膈阻塞，饮食不下。临床上都以噎膈并称。《素问·通评虚实论》说：“膈塞闭绝，上下不通，则暴忧之病也。”陆老采用古人经验穴“中魁”灸之而愈。

（陆瘦燕^{〔1〕}医案）

注

〔1〕陆瘦燕：现代针灸学家，名昌，江苏昆山人。著有《针灸验穴图谱》、《经络学图说》、《刺灸法汇论》等。

反 胃（2则）

162. 有老妇人患反胃，饮食至晚即吐出，见其气绕脐而转，予为点水分、气海，并夹脐边两穴^{〔1〕}既归。只灸水分、气海即愈。神效。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕夹脐两穴，疑指天枢。

按 反胃又名翻胃。多为幽门梗阻痉挛或胃内新生物所

致。上腹部疼痛明显，其呕吐特点总是朝食暮吐暮食朝吐，食物在胃内停留时间较长。本证多由脾胃虚寒，胃失和降，或命门火衰，不能腐熟水谷所致。故治宜灸炳温补。脐上水分当胃之分，取之用以温运脾胃，分利水谷，和中降逆，灸气海以温肾助阳，脾胃阳气得充，故效神迅。

163. 陈×，男，68岁。南汇县黄路公社卫生院老中医。

去年六月，胃脘疼痛，纳谷不香，呕吐泛酸，得食即痛，痛甚则吐。经中西医结合治疗，疗效不显，呕吐加剧，精神虚惫，遂于今年2月送中心医院采取支持疗法。治疗7日，全身情况好转，出院回家休养，2个月后能上班工作。20天后旧病复发，神乏怯冷，呕吐更剧，不能进食。迭经中西医结合治疗无效，患者丧失信心，囑家属准备后事。是日中午，余趋前会诊。脾肾阳虚，命门火衰，釜底无薪，不能腐熟水谷，拟温补脾胃，施灸之。

处方：中魁 足三里（均灸）。

灸法：每穴十一壮米粒灸，二穴轮灸。

经灸治后，呕吐即止。次日复灸足三里。脘腹温暖舒服，能吃稀粥，脘痛顿减。后以中药调治，食欲渐增，十余日即能起床行走，一个月后恢复工作。

按 本病多因饮食不当，嗜食生冷，损及脾阳，或思虑伤脾，以致脾胃虚寒，不能消化水谷，饮食停留，终至尽吐而出。本例反胃日久，以致脾肾阳虚，下焦火衰，釜底无薪，病情危急，非灸法不能急挽其危。

灸法有温经散寒，扶阳固脱，通运气血的作用。本例意在振复元阳，温阳固脱。中魁为经外奇穴，在手中指背面中节骨尖上，是古人治疗噎膈反胃的经验穴，疗效较速。

（陆瘦燕医案）

胃 脘 痛 (6 则)

164. 张仲文疗卒心痛，不可忍，吐冷酸水，灸足大趾、次趾内横纹中各一壮，炷如小麦，立愈。

(《针灸资生经》)

165. 荆妇旧侍亲疾，累日不食，因得心脾痛，发则攻心腹，后心痛亦应之，至不可忍，则与儿女别，以药饮之，疼反甚，若灸则遍身不胜灸矣，不免令儿女各以火针微刺之，不拘心腹，须臾痛定，即欲起矣。神哉。

(《针灸资生经》)

166. 一人慵懒，饮食即卧，致宿食结于中焦，不能饮食，四肢倦怠，令灸中脘五十壮，服分气丸〔1〕、丁香丸〔2〕即愈。

(《扁鹊心书》)

注

〔1〕分气丸：由黑丑四两、陈皮、青皮、广姜、肉桂各一两制成。

〔2〕丁香丸：由丁香、乌梅肉、青皮、肉桂、三棱各二两，巴豆一两制成。

按 四肢不勤，食物易停，升降有乖，焉有不病之理。方以胃募中脘施灸，温中焦，健脾胃，消积滞。穴精，理成，可法。

167. 一人年十五，因大忧大恼，却转脾虚。庸医用五苓散及青皮、枳壳等药，遂致饮食不进，胸中作闷。余令灸命关二百壮，饮食渐进，灸关元五百壮，服姜附汤一二剂，金液丹二斤，方愈。方书混作劳损，用温平小药，误人不少，悲夫。

(《扁鹊心书》)

按 七情所伤，五志之过，伤人脾胃。脾胃伤则虚，治当温补。而五苓散、青皮、枳壳等温平小剂，非但未能理气化湿，却反伤脾胃，致使胸中闷胀，饮食不下，脾阳益虚，故案材转用温热大补。灸命关，意在接脾阳真气，取关元，有补脾胃、理气温阳的作用。

168. 甲戌岁^{〔1〕}，观政^{〔2〕}田春野公乃翁，患脾胃之疾，养病天坛，致散宅数里，春野公每请必亲至，竭力尽孝。予感其诚，不憚^{〔3〕}其远，出朝必趋视。告曰：脾胃乃一身之根蒂，五行之成基，万物之父母，安可不由其至健至顺哉？苟不至健至顺，则沉疴之咎必致矣。然公之疾，非一朝所致，但脾喜甘燥，而恶苦湿，药热则消于肌肉，药寒则减于饮食，但治久不获当，莫若早灸中脘、食仓^{〔4〕}穴。忻然从之。每穴各灸九壮，更针行九阳之数，疮发渐愈。

（《针灸大成》）

注

〔1〕甲戌岁：明·万历二年，即公元1574年。

〔2〕观政：吏部内所设的官职名称。

〔3〕憚：畏惧。

〔4〕食仓：经外奇穴，中脘两旁各三寸处。

169.（江应宿^{〔1〕}曰）予长子，年三十二岁，素饮食无节，性懒于动作。丙戌^{〔2〕}秋，从予自燕都^{〔3〕}抵家，舟行饱餐，多昼寝，有时背胀，胃微痛。初冬过苏州，夜赴酒筵，后脱衣用力，次早遂觉喉口有败卵臭，厌厌^{〔4〕}成疾，瘦减，口吐酸水，背胀腹痛，一日，忽大痛垂死，欲人击打，又炒热盐熨之，稍宽快，顷刻吐紫黑血二碗许，连日不食，食入即吐，痛止即能食，食饱又复痛，诸药不应，递发递愈^{〔5〕}，六脉弦而搏指，此食伤太阴，脾虚气滞，与香砂橘半枳术丸，灸中

腕，侠脐〔1〕，膏肓，禁饱食二月而愈。

（《名医类案》）

注

〔1〕江应宿，明代医家，安徽歙县人，名医江珣之子。曾以十九年功夫，编次增补其父之《名医类案》。

〔2〕丙戌，明·万历十四年，即公元1586年。

〔3〕燕都，明代都城，即今北京。

〔4〕厌厌，同恹恹，微弱貌；精神不振貌。

〔5〕递发递愈：递，顺次。递发递愈即越发越重。

〔6〕侠脐，疑指挟脐两旁的天枢。《甲乙经》：“腹胀肠鸣，气上冲胸，不能久立，腹中痛濯濯。冬日重感于寒则泄，当脐而痛，肠胃间游行切痛，食不化，不嗜食，身肿，侠脐急，天枢主之。”

腹 痛（7则）

170. 一小儿食生杏致伤脾，腹闷欲死。灸左命关二十壮即愈，又服全真丹五十丸，即有气下降而愈。

（《扁鹊心书》）

按 《扁鹊心书》所云：“命关”穴，又名食窦，谓“能接脾脏真气”，“一切大病属脾者并皆治之”。

171. 赵运使夫人，年五十八岁，于至元甲戌〔1〕三月中，病脐腹冷痛，相引胁下痛不可忍，反复闷乱，不得安卧，予以当归四逆汤主之，先灸中庭穴。数服而愈。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕至元甲戌，即公元1274年。

按 寒滞中焦，气机逆乱，以当归四逆汤温阳散寒，先灸中庭，意在宽胸降逆，调理气机，针药合用，标本同治，良医所为也。

172. 真定一秀士，年三十有一。肌体本弱，在胁下有积气，不敢食冷物，得寒则痛。或呕吐清水，眩暈欲倒，目不敢开。恶人烦冗^{〔1〕}，静卧一、二日。及服辛热之剂则病退。延至甲戌^{〔2〕}初秋，因劳役及食冷物，其病大作，腹痛不止，冷汗自出，四肢厥冷，口鼻气亦冷，面色青黄不泽。全不得卧，扶几而坐。又兼咳嗽，咽膈不利。故《内经》云：寒气客于小肠膜原之间，络血之中，血滞不得注于大经，血气稽留不得行，故宿昔而成积矣。又寒气客于肠胃，厥逆口出，故痛而呕也。诸寒在内作痛，得灵^{〔3〕}则痛立止。予与药服之，药不得入，见药则吐，无如之何治之。遂以熟艾约半斤，白纸一张，铺于腹上，纸上摊艾令匀。又以葱数枝，批作两半铺于熟艾上数重，再用白纸一张复之，以慢火熨斗熨之。冷则易^{〔4〕}之。若觉腹中热，腹皮暖不禁，以绵^{〔5〕}三襜多缝带^{〔6〕}系之，待冷时方解。冷熨时得暖则痛减，大暖而痛止，至夜得睡。翌日^{〔7〕}再与对证药服之，良愈。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕恶人烦冗：见到人就感到心烦意乱。

〔2〕甲戌：至元十一年，即公元1274年。

〔3〕灵：日光。

〔4〕易：换。

〔5〕绵：同“棉”。

〔6〕绵三襜多缝带：用棉布缝制的绸带。

〔7〕翌日：第二天。

173. 永康^{〔1〕}人腹疾佝偻行，汉卿解衣视之，气冲起腹间者二，其大如臂，刺其一，砅然鸣^{〔2〕}；又刺其一，亦如之，加以按摩，疾遂愈。

（《明史·周汉卿传》）

注

〔1〕永康：县名。在浙江省。

〔2〕砧(huì惠)然鸣：破裂有声。

174. 一男子壮年，寒月入水网鱼，饥甚，遇凉粥食之，腹大痛，二昼夜不止。医与大黄丸不通，与大承气汤，下粪水而痛愈甚。诊其六脉，沉伏而实，面青黑色。虞曰：此大寒症，及下焦有燥屎作痛，先与丁附治中汤一帖，又与灸气海穴二十一壮，痛减半；继以巴豆、沉香、木香作丸，如绿豆大，生姜汁送下五粒，下五七次而愈。

（《名医类案》）

按 寒月入水，复啜凉食，以致阴寒内生，留于肠胃，阴气结固，阳气不运，使肠道传送无力，腹中攻痛。灸气海，可温散寒邪而益气助运，配以温下之剂，相得益彰。

175. 赵从先治保义郎顿公，苦冷疾。时方盛暑，俾就屋开三天窗，于日光下射处使顿仰卧，操艾遍铺腹上，约数斤，移时日光透脐腹，不可忍。俄而腹中雷鸣下泻。口鼻间皆浓艾气乃止。明天复为之。如是一月，疾良已。乃令满百二十日，宿病如洗，壮健如少年时。赵曰：“此孙真人秘诀也，世人但知灼艾，而不知点穴，又不审虚实，徒受痛楚，损耗气力。日者，太阳真火，艾即遍腹，徐徐照射，入腹之功极大。五、六、七月最佳。若秋冬间，当以厚艾铺腹，蒙以棉衣，以熨斗盛炭火慢熨之，以闻浓艾气为度，亦其次也。

（《续名医类案》）

按 灸之用火，素有讲究。如《黄帝虾蟆经》就有“八木（松、柏、竹、桔、榆、枳、桑、枣）之火以灸，人皆伤血脉肌肉骨髓”之说。今先生之法固创出前贤，然古法亦不可毁，辨证论法以治，则于沉痾痼疾，方可游刃有余。

176. 冯××，女，27岁，工人。

自诉：三个月来腹部坠痛，食欲不振，打呃，大便时干时泻，有时恶心呕吐，全身无力，曾在某医院注射青、链霉素，口服雷米封等无效，腹痛、呕吐渐重，甚则食后即吐，吐苦绿水，腹胀不能平卧，有时可见腹部有肿物隆起，自闻腹内作响，随之即有虚恭及水样大便，消化道钡餐造影，诊为结核性腹膜炎，不全肠梗阻，服中药症状无好转而来我科门诊。

查：体弱消瘦，舌苔白，脉弦细。心肺（一），腹部极度膨隆，有肠型，肠鸣音亢进，全腹有压痛及反跳痛，腹壁肌肉紧张，无明显移动性浊音。化验：血沉第一小时4毫米，白细胞9200，嗜中性90%，淋巴10%。消化道造影：上消化道未见异常，小肠有明显分段现象，粗细不等，粘膜紊乱。

诊为腹痛（结核性腹膜炎，不全肠梗阻）。

经用梅花针治疗九次症状明显好转，又治疗二十次腹部包块消失，四十次后症状消失，体重增加。

针刺部位是脊柱两侧，由第一胸椎至尾椎两侧，重刺胸5~12、颈部胸锁乳突肌以及上下腹部，使之调节肠蠕动，恢复胃肠功能。

消化道造影复查，小肠粘膜影像正常，无扩张及狭窄，触之活动度正常，无粘连现象。

按：叩打梅花针，可以疏通经气，调和气血，消除病变之淤结，促进新陈代谢，故可试用于上症。

（天津中医学院附院针灸科医案）

霍乱（2则）

177. 江篁南^{〔1〕}治从叔于七月间得霍乱症，吐泻转筋，足冷

多汗，囊缩，一医以伤寒治之，增剧。江诊之，左右寸关皆伏不应，尺部极微，口渴欲饮冷水，乃以五苓散与之，觉稍定，向午犹渴，以五苓加麦冬、五味子、滑石投之，更以黄连香薷饮冷进一服。次早脉稍出，按之无根，人脱形且吃忒，手足厥冷，饮食不入，入则吐，大便稍不禁，为灸丹田^{〔2〕}八九壮，囊缩稍舒，手足稍温，继以理中汤二三服，渴犹甚，咽痛热不解，时或昏沉，乃以竹叶石膏汤投之而愈。

（《名医类案》）

注

〔1〕江筭南，即江瑾。

178. 黄××，男，50岁，干部。于1977年7月初诊。

自诉，在时令热天，误食生冷不洁之物后三小时许，即起恶心呕吐，吐出为胃内容物色黄味酸，量不多但次数较频繁，伴有腹痛，以胃脘及脐周为剧，系阵发性痉挛性疼痛，腹泻水样大便十多次。未服任何药物即来院急诊。

查：病人呈痛苦急性病容，呻吟不已，但不发热，有轻度脱水征象，证属霍乱。

治取华佗夹脊肝、脾、胃（胸9、11、12），用平补平泻法留针20分钟，起针后，患者腹痛即减，恶心感明显减轻，此后再无腹泻。经二次针刺，腹痛、恶心、呕吐诸症尽除。

按 华佗夹脊穴的位置目前有两种说法：一种认为自第一颈椎起至第五腰椎止，每椎棘突旁开0.5~1.0寸，每侧24穴，左右共48穴；另一种认为自第一胸椎起至第五腰椎止，每椎棘突旁开0.5寸，每侧17穴，左右共34穴。两种说法之差为前者比后者多颈椎一段之穴位，其主治功用一般记载为治疗痹瘵、咳嗽、喘息及一切慢性疾患。根据本人多年之临床经验，应用于下述两方面的疾患效果最佳：

一为呼吸系统疾病的肺炎、支气管炎、喘息性支气管炎和支气管哮喘，采用夹脊胸1～3段针后加拔火罐。

二为消化系疾病的急性胃炎、胃及十二指肠溃疡之疼痛，急性胃肠炎之上吐下泻等。采用夹脊胸7～12段，单纯针刺，必要时配以拔火罐，对此类疾病往往有针到病除之功。此例病人经一次针刺后即告痊愈。

(张涛清医案)

食 物 中 毒 (2 则)

179. 张××，男，13岁。

自诉：于1958年12月12日中午吃驴肉，约2小时后发现腹痛，且逐渐加重，并现持续性呕吐，大便泻泄，头昏无力，四肢发凉，来我院急诊。

查：腹痛拒按，呕吐，腹泻，四肢厥冷，有明显失水症，血压50/25毫米汞柱，脉象沉细而弱，微数，舌无苔。

治以针刺中脘、内关、天枢、关元、足三里，针入15分钟后，腹痛、呕吐、腹泄均明显减轻，但血压仍低，以艾条灸神阙，1小时后，血压逐渐复至100/70毫米汞柱，手足渐渐复温，脉象有力，精神好转。

180. 王××，男，39岁。

自诉：在某县参观，中午吃猪肉拌黄瓜，晚间赶来××市住某招待所，到达后即感周身无力，继则腹痛急剧、呕吐泄泻，呕吐物皆食物与白色粘液，时恶心，头痛眩晕，手足发凉，腿肚抽痛，小便短黄，出冷汗。

查：患者面色黄，腹痛拒按，四肢厥冷，腿时转筋，卧床辗转呻吟，舌苔薄白，脉象沉弦，血压80/60毫米汞柱。

针取中脘、内关、天枢、关元、足三里，针刺入后行泻法，留针30分钟，捻针三次，因血压较低，加灸神阙15分钟，更针承山以疗腿肚转筋。针后20分钟则腹痛、呕吐、腹泻明显减轻，30分钟后四肢复温，转筋已止，灸后血压恢复至104/70毫米汞柱，夜卧甚安，次日即愈。

按 针灸治疗食物中毒，是根据祖国医学中对霍乱的病因、症治而进行的。《灵枢·五乱篇》云：“气乱于肠胃，则为霍乱；……取之足太阴、阳明”。中医所谓的霍乱，包括病种比较广泛，食物中毒也不出此范围。食物中毒的上吐下泻，系肠胃失和，升降失司，所治宜健中和胃，故取胃募中脘以健中和胃，内关镇逆止吐，天枢、关元分别为大肠小肠之募，疗腹痛以止泻利；足三里为阳明之合穴，能培土以强身，和脾胃以治吐泻；神阙加灸，以治元阳之失守，委中放血可治疗腹痛、吐泻，合承山则转筋可舒。

操作和留针时间：进针后，找到酸、麻、胀感觉后，则用提插补泻的泻法，加重刺激约1分钟左右，留针20~30分钟，在留针过程中，每隔10分钟，则施行一次手法，待病情减轻则出针。小儿及老年人多用单刺法。灸神阙，最好用艾柱隔盐灸。如来不及准备，用艾条也可，我们就是采取艾条灸，效果亦佳，灸15分钟~1小时，待四肢复温，血压上升则止。

(藏郁文医案)

泄 泻 (7 则)

181. 予尝久患溏利，一夕灸^①三七壮，则次日不如厕^②。连数夕灸，则数日不如厕。

(《针灸资生经》)

注

(1)灸：据上文系用鼠粪灸脐中。

(2)不如厕：不解大便。

182. 予旧苦脐中疼，则欲溲泄，常以手中指按之少止，或正泻下，亦按之，则不疼，它日灸脐中，遂不疼矣。后又尝溲利不已，灸之则止。凡脐疼者，宜灸神阙。

(《针灸资生经》)

按 灸神阙治溲泻，临床屡治不爽。以脾肾阳虚者更佳。

183. 一人患暴注，因忧思伤脾也，服金液丹，霹雳汤不效，盖伤之深耳。灸命关二百壮，小便始长，服革神丹而愈。

(《扁鹊心书》)

按 忧思伤脾，肝气横逆，脾胃受制，运化失常，以致泄泻如注。命关系脾经食窦，灸之能调理脾胃，分清泌浊。

184. 征南副元帅夫武木儿，年旬六有八。戊午秋征南。予从之，过扬州十里，时仲冬，病自利，完谷不化，脐冷腹痛，足胫寒，以手搔之不知痛痒，尝烧石以温之，亦不得暖。予思之，年高气弱，深入敌境，军事烦冗，朝暮形寒，饮食失节，多饮乳酪，履于卑湿，阳不能外固，由是清湿袭虚，病起于下，故胫寒而逆，《内经》云：感于寒而受病，微则为咳，盛则为泄为痛，此寒湿相合而为病也，法当急退寒湿之邪，峻补其阳，非灸不能病已。先以大艾炷于气海灸百壮，补下焦阳虚；次灸三里二穴，各三七壮，治胫寒而逆，且接引阳气下行；又灸三阴交二穴，以散足受寒湿之邪。遂处方云：寒湿所胜，治以辛热，湿淫于外，平以苦热，以苦发之，以附子大辛热助阳退阴，温经散寒，故以为君；干姜、官桂大热辛甘，亦除寒湿；白术、半夏苦辛温而燥脾湿，故以为

臣：人参，草豆蔻，炙甘草，甘辛大温，温中益气；生姜大辛温，能散清湿之邪；葱白辛温，以通上焦阳气，故以为佐。又云：补下治下，制以急，急则气味厚，故作大剂服之。不数服，泻止痛减，足脂渐温，调其饮食，逾十日平复。明年秋，过襄阳，值霖雨旬余，前证复作，再依前灸，添阳辅，各灸三七壮，再以前药投之，数服良愈。

（《卫生宝鉴》）

185. 一人吐泻三日，垂死，为灸天枢、气海二穴立止。

（《名医类案》）

186. 一富翁，病泄泻弥年^{〔1〕}，礼致子厚，诊疗浹旬^{〔2〕}不效。子厚曰^{〔3〕}：予未得其说，求归。一日读《易》^{〔4〕}至乾卦天行健，朱子^{〔5〕}有曰，天之气运转不息，故阁得地在中间，如人弄碗珠，只运动不住，故在空中不坠，少有息则坠矣。因悟向者富翁之病，乃气不能举为下脱也，又作字，持禾滴吸水，初以大指按滴上窍，则水滴筒，旋其按则水下溜无余，乃豁然悟曰：吾可治翁症矣，即治装往，翁家惊喜，至即为治艾，灸百会穴，未三四十壮，泄泻止矣。

（《类案》）

注

〔1〕弥年，满一年。

〔2〕浹旬，满一月。

〔3〕子厚：即王子厚，元代医生，江西人，与滑寿同时，善易象法治病。

〔4〕易：《周易》。

〔5〕朱子：即朱熹。

187. 维阳府判赵显之，病虚羸泄泻褐色，乃洞泄寒中证也。每闻大黄气味即注泻。张诊之，两手脉沉而软。令灸水分穴

一百余壮，次服桂苓甘露散，胃风汤，白朮丸等药，不数月而愈。

（《续名臣类案》）

按 水分穴位于脐上一寸，穴下为小肠之所在。究其名义，水，指水液；水气，分，指分别，分利。小肠分清浊，司化物之功能失调，则清浊不分而溏泻泄利，取水分者，乃分清泌浊也。

痢疾（12则）

188. 有老嫗大肠中常里急后重，自言人必无老新妇，此奇疾也。为按其大肠俞疼甚，令归灸之而愈。

（《针灸资生经》）

按 脾肾阳虚，水湿运化失衡，久之，受碍气机，病蓄里急后重。背俞穴，是人体相应脏腑经络之气输注背部的穴位。《灵枢·背俞》说：“欲得而验之，按其处，应在中而痛解，乃其俞也，灸之则可”。故施灸法，以疏通肠腑气机，调畅血脉，温通经络，使之归于和平。

189. 一人休息痢已半年，元气将脱，六脉将绝，十分危笃。予为灸命关三百壮，关元三百壮，六脉已平，痢已止。两胁刺痛，再服草神丹^{〔1〕}霹雳汤^{〔2〕}，方愈，一月后，大便二日一次矣。

（《高鹤心书》）

注

〔1〕草神丹：川附子五两，吴茱萸、肉桂各二两，琥珀、辰砂各五钱，麝香二钱。

〔2〕霹雳汤：川附子五两、桂心、当归各二两，甘草一两。

190.人病休息痢，余令灸命关二百壮，病愈二日，变注下，一时五七次。令服震雳汤二服立止。后四肢浮肿，乃脾虚欲成水胀也。又灸关元二百壮，服金液丹十两，一月而愈。

(《扁鹊心书》)

191.至元己亥^{〔1〕}，王千户^{〔2〕}年四十有五，领兵镇涟水。此地卑湿，因劳役过度，饮食失节，至秋，疟痢并作，月余不愈，饮食全减，形容羸瘦，乘马轿以归。时值仲冬，求予治之，具陈其由，诊得脉弦细而微如蛛丝，身体沉重，手足寒逆，时复麻痹，皮肤痂疥，如痹风之状，无力以动，心腹痞满，呕逆不止，此皆寒湿为病，久淹^{〔3〕}，真气衰弱，形气不足，病气亦不足，阴阳皆不足也。针经云，阴阳皆虚，针所不为，灸之所宜。《内经》曰，损者益之，劳者温之。《十剂》云，补可去弱，先以理中汤加附子，温养脾胃，散寒湿，涩可去脱，养脏汤加附子，固肠胃，止泻痢，仍灸诸穴，以并除之。经云，府会太仓，即中脘也。先灸五、七壮，以温脾胃之气，进美饮食，次灸气海百壮，生发元气，滋荣百脉，充实肌肉，复灸足三里，胃之合也，三七壮，引阴气下交阴分，亦助胃气，后灸阳辅三七壮，接续阳气，令灸经温暖，散清湿之邪。迨月余，病气去，渐平复。

(《马宝堂医案》)

注 释

〔1〕至元己亥：己亥应作乙亥，即至元十二年，公元1275年。

〔2〕千户：官名。

〔3〕久淹：长期受湿邪浸害。

192.真定^{〔1〕}总管史^{〔2〕}侯男哥，年四十有五，肢体本瘦弱，于至元辛巳^{〔3〕}，因收秋租，佣人致酒，味酸不欲饮，勉强三两杯，少时腹痛，次作泄泻无度，日十余行。越十日，便

后见血，红紫之类，肠鸣腹痛，求医治之。曰：诸见血皆以为热，用芍药槲皮凡治之，不愈，仍不欲食，食则呕酸，形体愈疲，面色青黄不泽，心下痞，恶冷物，口干，时有烦躁，不得安卧，请予治之，且说其由，诊得脉弦细而微迟，手足稍冷，《内经》云：结阴者便血一升，再结二升，三结三升。经云：邪在五脏，则阴脉不和，阴脉不和则血留之。结阴之病，阴气内结，不得外行，无所禀，渗入肠间，故便血也。宜以平胃地榆汤治之。此药温中散寒，除湿和胃，服之数服，病减大半，仍灸中脘三七壮，乃胃募穴，引胃上升，滋荣百脉，次灸气海百余壮，生发之气，灸则强食生肉。又以还少丹服之，则喜饮食，添肌肉，至春再灸三里二七壮，壮脾胃，生发元气，此穴乃胃之合穴也。改服芳香之剂，或以慎言语，节饮食良愈。

（《卫生宝鉴》）

注

（1）冀定，府，路名。今河北正定。

（2）总管史：官名。

（3）至元辛巳：至元十八年，即公元1281年。

193. 浦江⁽¹⁾郑义宗患滞下⁽²⁾昏仆，目上视，溲注，汗泄，脉大。此阴虚阳暴绝，得之病后酒色，丹溪⁽³⁾为灸气海渐苏，服人参膏数斤愈。

（《针灸聚英》）

注

（1）浦江，县名。在浙江省东部。

（2）滞下：即痢疾。

（3）丹溪：朱丹溪。元代著名医学家。金元四大家之一。字彦修。又称雁亨。婺州义乌人。

按：丹溪倡“阳有余阴不足”论，多以滋阴降火之法。

但他并非唯阴精论者，相反，在临证时，往往使用补阳益气之法。针灸多以灼艾为之，故在针灸流派中属重灸派。从本例痢疾阴虚阳绝，施灸气海，重补阳气可知。丹溪临证辨证精细，施治灵巧，实不同于墨守一隅之见者。

194. 甲戌^{〔1〕}夏，员外^{〔2〕}熊可山公患痢，兼吐血不止，身热咳嗽，绕脐一块痛至死，脉气将危绝。众医云：不可治矣。工部^{〔3〕}正郎^{〔4〕}隗月潭公素善，迎予视，其脉虽危绝，而胸尚暖，脐中一块高起如拳大，是日不宜针刺，不得已，急针气海，更灸至五十壮而苏，其块即散，痛即止。后治痢，痢愈，治嗽血，以次调理得痊。次年升职方^{〔5〕}，公向其故。予曰：病有标本，治有缓急，若拘于日忌^{〔6〕}，而不针气海，则决何由而散？块既消散，则气得疏通，而痛止脉复矣。正所谓急则治标之意也。公体虽安，饮食后不可多怒，以保和其本，否则，正气乖而肝气盛，致脾土受克，可计日而复矣。

（《针灸大成》）

注

〔1〕甲戌：明万历二年，即公元1574年。

〔2〕员外：员外郎。官名。

〔3〕工部：官署名。

〔4〕正郎：郎中，官名。

〔5〕职方：官名。

〔6〕日忌：旧相禁针日。

〔7〕乖：错乱。

195. 戊寅^{〔1〕}冬，张相公^{〔2〕}长孙患泻痢半载，诸药不效，相公命予治之。曰：“昔翰林^{〔3〕}时，患肚腹之疾，不能饮食，诸药不效，灸中脘、章门即饮食，其针灸之神如此。今长孙患泻痢，不能进食，可针灸乎？”予对曰：“泻痢日久，体

貌已变，须元气稍复，择日针灸可也。”华岑公子云：“事已危笃矣，望即治之，不俟^{〔4〕}再择日期”。即针灸中脘、章门，果能饮食。

（《针灸大成》）

注

〔1〕戊寅：明·万历六年，即公元1578年。

〔2〕相公：旧时称成年男子。

〔3〕翰林：唐以后皇帝的文学侍从官。

〔4〕俟：等待。

按 久泻不已，脾胃虚弱，生化精微益受影响。取脾募章门，胃募中脘，以期健脾和胃，温中散寒也。

196. 方荫山治一小儿，八岁，患滞下，每夜百度，食入即吐。乃以熟面作果，分作二片，以一片中空之，用木鳖子三个，去壳，捣如泥，加麝香三泥，填入果心，贴脐上，外以帕系定，用热鞋熨之，待腹中作响，喉中知有香气，即思食能进，是夜痢减大半。二三日渐愈，后以此法治噤口痢多验。

（《名医类案》）

197. 一妇，年三十余，病滑泄经年。皆云虚中有积。以无忧散，五七日一服，至二十服不效。又服缠积丹、软金丸诸药，皆不效。其人服药愈速，病势愈甚，食饮日减。人或谓曰：此休息痢也，宜灸中脘及左右穴^{〔1〕}，脐下气海及膀胱穴^{〔2〕}，以三里引之，每年当冬至日，夏至日灸之。

（《儒门事亲》）

注

〔1〕中脘及左右穴：似指中脘及其左右之阴都穴或梁门穴。

〔2〕膀胱穴：似指中极穴。

按 痢疾湿热未尽，误投止涩，或过服寒凉，或饮食不

节，均可使脾肾受伐，元气下陷，正虚邪留，则休息痢成也。本案用中脘调脾胃，气海培元气，功在益火生土，盖肾主二便，肾气作强则火土合德，泄痢可止，此所以用中脘之左右穴也，以中极治痢，非常人之见，乃戴人之杰作，意在利导水湿从小便而出，所谓利小便即以实大便也。足三里与中脘为伍，重在调补胃气，也可通肠化积，因余邪未尽而取用。

198. 荣右，37岁，暑湿热三气郁于阳明，发为下利，利下血积，少腹胀满，小溲不利，里急后重，如厕不爽，脉象沉弦而数，当用通因通用法。

处方：小肠俞（泻） 阴陵泉（泻） 天枢（泻）
内庭（泻） 支沟（泻） 上巨虚（泻）

（黄鸿舫医案）

199. 薛左 45岁

夏秋伏邪，由疟转痢，此表邪传里，至今痢根未脱，湿热留恋，续增咳呛，脉形滑数，有里邪外解之象，拟从太阴阳明转化。

处方：列缺（泻） 尺泽（泻） 上巨虚（泻）
天枢（泻）

（黄鸿舫医案）

疝 气（6则）

200. 齐北宫^[1]司空^[2]命妇^[3]出于^[4]病，众医皆以为风入中^[5]，病主在肺^[6]，刺其足少阳脉。臣意诊其脉，曰：“病气疝，客于膀胱，难于前后溲，而溺赤。病见寒气则遗溺，使人腹肿”。出于病得之欲溺不得，因以接内，所以知出于病者，切其脉大而实，其来难，是厥阴之动也。脉来难者，疝

气之客于膀胱也。腹之所以肿者，言厥阴之络结小腹也。厥阴有过则脉结动，动则腹肿，臣意即灸其足厥阴之脉，左右各一所，即不遗溺而溲清，小腹痛止。即更为火齐汤以饮之，三日而疝气散，即愈。

（《史记·扁鹊仓公列传》）

注

〔1〕北宫，复姓。

〔2〕司空，官名。

〔3〕命妇：古代妇女有封号者之称，一般指多官员之母、妻而言。

〔4〕出于：命妇的名字。

〔5〕风入中：风邪袭入人体。

〔6〕肺：《集解》徐广曰：“一作‘肝’。”

201. 舍弟少戕举重，得偏坠之疾。有道人为当关元两旁相去各三寸青脉上灸七壮，即愈。

王彦之患小肠气，亦如此灸之愈。

（《针灸资生经》）

202. 顷关一男子，病卒疝，暴痛不任，倒于街衢，人莫能助，呼予救之。予引经证之，邪气客于足厥阴之络，令人卒疝，故病阴丸痛也。予泻大敦二穴，大痛立已。夫大敦穴者，乃足厥阴之二穴也。

（《儒门事亲》）

203. 郑亨老病疝，灸之得效。其法以净草一条，茅及麦秆尤妙，度病人两口角为一折折断，如此三折，则折成三角，以一角按脐中心，两角在脐之下，两旁尖尽是穴。若患在右侧灸左，在左侧灸右，两边俱患，则两穴皆灸，艾炷如麦粒大，灸十四壮或二十一壮，即安也。

（《医说续编》）

204. （龚子才^①治）赵雪山因劳碌，五更起早感寒，疝气

痛不可忍，增寒战栗，六脉微而无力。以五积散加吴茱萸小茴香，又与蟠葱散，俱不效。后以艾灸之；将患人两脚掌相对，以带子绑住两中指合缝处，以艾炷麦粒大灸七壮，灸完痛止神效。

（《续名医类案》）

注

〔1〕龚子才：明代医家。名延贤，号云林，江西金溪人。

205. 玉山周仅调官京师，旧患膀胱气，外肾偏坠。有货药人云：“只立谈间可使之止。”约以万钱及三缣〔1〕之报。相次入室中，施一针，所若果平，周大喜，即如数酬金帛而去，后半月，其疾如故。使人访医者，已不见矣。

（《泊宅编》）

注

〔1〕缣：（jiān 间）古代一种质地柔软的丝织品。在纸发明以前，常于此书写文字，称为缣帛。

按 医、药一家。卖药人懂些医道，不足为奇，但这些人多有商人习气，好夸海口，动辄“包治百病”、“一针即愈”、“手到病除”等等，病者往往信以为真，每致上当，叫苦不迭，自欺欺人者医德何在？

背 腰 疾 （8 则）

曲 背（1 则）

206. 诸暨⁴¹²黄生背曲，须杖行。他医皆以风治之。汉舞曰，血涩也。刺两足昆仑穴，顷之投杖行去，其捷效如此。

（《明史·周汉舞传》）

注

〔1〕诸暨：今浙江省诸暨县。

按《杂病穴法歌》曰：“腰痛环跳委中神，若连背痛昆仑武”。黄生背曲，腰背同病，针昆仑，功调气血，舒筋脉，亦循经远取，上病下治之法。

腰 痛（7 则）

207. 吴孚先治君端之腰痛异常，从目内眦进药而愈。或问之曰：是乃睛明穴也，在目内眦红肉中，其脉行足太阳，经手腰背，下应足少阴，通于心。腹腰背之痛，以睛明进药，良有奇验，古来神圣有从耳进药者，病愈而耳聋，针之则愈矣。

（《续名医类案》）

按睛明在“目内眦红肉中”，此说见《医学入门》。是处给药（点眼药）治腹背腰痛，实属循经取穴，确有效验，尤对急性腰痛更佳。

208. 尝夜有鬼呻吟声，其凄怆，秋夫〔1〕问何须？答言：姓某，家在东阳，患腰痛死，虽为鬼，痛犹难忍，请疗之。秋夫云：何疗法〔2〕？鬼请为刍人〔3〕，案孔穴针之。秋夫如言，为灸四处，又针肩井三处，设祭埋之。明日见一人谢恩，忽然不见，当世伏其通灵。

（《南史·张融传》）

注

〔1〕秋夫：指徐秋夫，南朝刘宋医家。传其父之学，精针灸。

〔2〕疗法：法（cuò音错）。安置；措办。法《医说》作治，意即怎样安排治疗，疗法两字之前，《医说》有“欲是鬼而无形”句。可接解。

〔3〕刍人：刍，草把。《礼记·祭统》：“土执刍。”郑玄注：“刍谓草也，杀牲时用荐之。”刍人，即用草扎的人。

按 秋夫疗鬼的故事，已传为千古美谈。其文字描述，不免带有迷信色彩，但作者的本意，主要是借以烘托徐秋夫的医术高明——鬼的腰痛，尚且手到病除，何况于生人乎。至于具体穴位，《标幽赋》载的腰俞，不含“四处”之数，肩井三处，均阙解，有待阐明。

209. 有妇人久病而腰甚疼，腰眼忌灸，医以针置火中令热，缪刺^{〔1〕}痛处，初不深入，既而疼止，则知火不负人之说犹信云。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕缪刺：即缪刺。

210. 许知可因淮南大水，忽腹中如水吼，调治得愈。自此腰痛不可屈伸，思之，此必肾经感水气而得，乃灸肾俞三七壮，服麋茸元丸愈。予于谓腰痛不可屈伸，灸肾俞自效，不服麋茸元亦可。

（《针灸资生经》）

211. 舍弟腰疼，出入甚艰。予用火针微微频刺肾俞，则行履如故，初不灸也。屡有人腰背伛偻来觅点灸，予意其是筋病使然，为点阳陵泉，令归灸即愈。筋会阳陵泉也，然则腰疼又不可专泥肾俞，不灸其他穴也。

（《针灸资生经》）

212. 一老人腰脚痛，不能行步，令灸关元三百壮，更服金液丹，强健如前。

（《扁鹊心书》）

按 老年肾气衰，又兼风寒客之，腰脚作痛，治宜温补，兼逐风湿。灸关元者，因肾培本，祛寒除湿。亦偶《素问·阴阳应象大论》“阳病治阴”之理。

213. 王戌^{〔1〕}岁，吏部许敬庵公，寓灵济宫，患腰痛之甚。

同乡董龙山公推予视之。诊其脉，尺部沉数有力，然男子尺脉固宜沉定，但带数有力，是湿热所致，有余之疾也。医作不足治之，则非矣。性畏针，遂以手指于肾俞穴行补泻之法^{〔2〕}，痛稍减，空心再与除湿行气之剂，一服而定。公曰：手法代针，已觉痛减，何乃再服渗利之药乎？予曰：针能劫病，公性畏针，故不得已。而用手指之法，岂能驱除其病根，不过暂减其痛而已。若欲全可，须针肾俞穴，今既不针，是用渗利之剂也。岂不闻前肾云：腰乃肾之府，一身之大关节。脉沉数者，多是湿热壅滞，须宜渗利之，不可用补剂。今人不分虚实，一概误用，多致绵缠，疼痛不休。大抵喜补恶功，人之恒情也。邪湿去而新血生，此非攻中有补存焉者乎！

（《针灸大成》）

注

〔1〕壬戌：明嘉靖四十一年，即公元1562年。

〔2〕遂以手指……行补泻之法：此谓指针之法。

二 阴 病 症（15则）

前 阴 臊 臭（1则）

214. 东垣曰：一富者前阴^{〔1〕}臊臭，又因连日饮酒，腹中不和。求先师治之，曰：夫前阴足厥阴之脉络，循阴器，出其挺末^{〔2〕}。凡臭者，心之所主，散入五方^{〔3〕}为五臭^{〔4〕}，入肝为臊^{〔5〕}此其一也。当于肝经中泻行间是治其本，后于心经中泻少冲，乃治其标。

（《针灸聚英》）

注

(1)前阴：男女生殖器及尿道的总称。

(2)挺末：阴茎末端，这里泛指阴器。

(3)五方：指东、南、中、西、北五个方位。

(4)五臭：即臊臭、焦臭、香臭、腥臭、腐臭五种臭味。

(5)入肝为臊：《素问·六节脏象论》：“天食人以五气”。张景岳注：“天以五气食人者，臊气入肝，焦气入心，香气入脾，腥气入肺，腐气入肾”。

按 前阴诸疼，莫不与足厥阴肝经有干。是症多因郁怒伤肝，肝气郁结，日久化火，横逆犯脾，以致脾胃受伤，运化失宜，湿热内生，郁而化热。湿热合邪，流注下焦，乃兹病由所生也。今方用肝（木）经子穴行间（火），意在清肝泻火。肝火平则脾胃和，脾胃和则湿热清，一穴二用，本标兼顾。少冲（井）虽属心（火）经，实亦泻子（经），且井穴均能泄热。两穴合用，其功益彰。本案特点是用穴少，穴理精，一泻子经，一泻子穴，法专于泻，着眼于肝。虽未用健脾和胃之穴，而泻肝实已寓和脾胃于其中也。

淋 浊（5则）

215.新安富室，有男子淋浊不止，渐萎黄，诸医束手。孙卓三^①治之，亦弗效。偶隐几坐，以手戏弄水罐，后孔塞前窍止，开则可通，悟后遂针脑后一穴，为灸火至三炷立愈。

（《江西通志》）

注

(1)孙卓三：明代医生。浮梁（今江西景德镇北）人，精医术，治病多用土法。

216. 文学道卿，传治血淋方，独蒜一枚，山栀子七枚，

盐少许，三物共捣如泥，贴患人脐上。所亲患血淋二年余，殊甚，诸医治之罔效，一日，张过视，谩试以前方即时去紫血黑片碗许，遂愈。

（《名医类案》）

217. 淡安^{〔1〕}治锡城许康君劳淋，小腹胀满，小溲混浊淋漓而热，困难奇痛，经二年余未少痊，西医欲为剖割，畏危险未敢允。适余甫迁锡城，来针。为针阴陵、涌泉却肾经湿热，针合谷、尺泽以开肺气，膀胱俞、中极以鼓下元气化，针后约三小时，小溲通畅而愈。快甚！后以要事行急路四十里，病复发，仍针前穴，再补肾俞而愈。

（《承淡安针灸选集》）

注

〔1〕淡安：指承淡安。现代针灸学家。江苏江阴人。著有《中国针灸治病学》、《中国针灸学》等书。

218. 颜××，男，26岁，南京大学研究生。1982年7月1日入院，住院号474。

主诉：左侧少腹与腰部发作性疼痛一年余。

病历：患者于1981年5月因左少腹与腰部剧烈疼痛而入当地医院检查治疗，经肾盂造影，发现左侧输尿管下段有1×0.6厘米大小密度不同的阴影，左侧肾盂积水，确诊为输尿管下段结石，经反复治疗未愈。

入院时左侧少腹与腰部常隐隐作痛，局部有轻压痛，活动后加重，小便清长、有时色黄不畅，面色少华，精神较差，饮食欠香，口淡无味，口不渴，舌苔薄白，舌质淡，脉象沉细少力。

尿检：蛋白微量，红细胞0—3，pH弱酸性。

处方：1. 肾俞 膀胱俞 次髂 委阳

2.气海 水道 照海

以上两组穴位，交替使用，每日一组。

操作：各穴针刺较深，用捻转手法，以通调气机，针腰腹各穴，使针感向四周传运并加艾条灸，以皮肤淡红色为度，下肢各穴，针刺得气后，针尖宜向上下斜刺，使针感向上下放散，留针30分钟，然后出针。

治疗10次后，于7月10日患者少腹与腰部疼痛加重，小便不畅，按照以往观察经验，常为排石先兆，仍按原方并加强手法，继续治疗，至7月15日，患者小便时少腹有下坠感，小便中断，经努责后，排出结石一块，其大小与造影报告相符合。经X线摄片复查，证实结石与肾盂积水均消失，治愈出院。

按 尿路结石的形成，多由湿热蕴结下焦，煎熬尿液，结而成为沙石，在病之初，当以清热利湿为主，但一经久涎，不但暗耗肾阴，肾阳亦常受累。本例患者，从神色与苔脉合参，属于下焦阳虚，肾与膀胱气化无权，故结石停滞不下，引起肾盂积水，治当鼓舞下焦阳气，温阳以利水，有助结石之排出，针灸并用为宜。

（邱茂良医案）

219.王××，男，57岁，干部。门诊号36912。于1975年5月12日初诊。

自诉：两年多来，腰骶部经常酸痛，尿后淋漓不净，夜尿达7、8次之多，近两个月来因出现尿频、尿急、尿道刺痛等现象，而来院进一步检查。

查：尿验：红细胞（+）、白细胞（++）；肛检：前列腺肥大。脉濡细，舌质胖淡，舌苔薄黄滑腻。

诊断：淋症（前列腺肥大并发前列腺炎）。此系肾气不

足，湿热蕴于下焦，膀胱气化失常。

治取内、外至阴，三棱针点刺放血20滴左右，每天左右交替取治，当天尿道刺痛即见缓解，三天后尿频好转，十天后果情基本消失。

按：前列腺病属肾与膀胱两经病变，外至阴为足太阳膀胱经井穴，内至阴为足少阴肾经之井穴，内外至阴交替刺血治疗，有通调下焦，清热利湿之效，包涵着“脏之病，取之井”之意。

注

内至阴，即足小趾甲内侧后角去甲一分许，涌泉穴的分支。

（陈太中医案）

遗 精（1则）

220.有士人^{〔1〕}年少，觅灸梦遗。为点肾俞酸痛，其令灸而愈。则不拘老少，肾皆虚也，古人云：百病皆生于心。又云百病皆生于肾。心劳生百病，人皆知之。肾虚亦生百病，人未知也。盖天一生水，地二生火，肾水不上升，则心火不下降。兹病所由生也。人不可不养心，不爱护肾乎。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕士人：读书人。

阳 萎（1则）

221.多哥人某 38岁 非洲航空公司高级职员。

患阳萎十余年，诸治无效，深感苦闷，于绝望中来我医疗队试探针灸治疗，询知少年期间接触异性，现房内已有妻妾三人，显然少壮色欲过度，精竭至损，遂致初为触即泄，继则阴茎弛不坚举，后成垂倒不勃，夜间尿意频至，白昼腰臀酸楚，舌淡苔薄白，尺脉沉弱难寻，是精液走泄太过，致肾虚封蛰不固，精道滑脱，尿腴不约，肾府失却支撑，宗筋弛缓不用，故欲使玉柱挺勃，必于益肾壮元中求之，盖益肾则精能因摄，壮则阳道振兴，然务必节制房实，方能贮精蓄髓，不使所伤致复。

处方：体针——肾俞、命门、关元、复溜（双），耳针——肾、肝、心（双）。

操作：针肾俞、命门、复溜，得气后作捻转补法。关元用28号5寸长针，针尖斜向下，作45度角刺入，进针一寸左右可得一放射至阴茎头部的感应。一般轻症阳萎，针就停留在此深度，作捻转稍加提插手手法，持续运针5分钟，在运针过程中，要求阴茎头部有持续的感应。倘若重症阳萎，尤为肾虚型，在此深度往往不易得气，还需继续进针到四寸左右，才能寻得一放射到阴茎头部的感应，操作手法及针感要求同上。耳针手法：得气后加电针，留针30分钟，隔天一次，12次为一疗程。

第二疗程后已能勃起，但欠坚事，早泄亦有好转，于第二疗程中基本转为正常，再巩固一疗程，以后改为每周一次。连针三月余，后因患者有事出差而中断治疗，时隔半年后因症状有所退步而再次来门诊治疗。自述头几个月一直较好，近半月来又欠满意，按前法又连针一个疗程，诸恙又瘳，又改为每周针一次，直到我离开多哥时仍较稳定。

按肾为先天封藏之本，若肾中命火式微，则下焦失于禁

固，玉柱痿柔靡软。补肾俞、命门、复溜，能益肾壮阳，肾气充沛则精气蒸蒸以生，龙宫温暖则精窍坚固不滑。关元为人身元气之所系，亦是宗筋生发之根，补关元能使元气鼓舞而不乏支撑之力，宗筋坚韧而不曲。耳穴肾、肝、心，能补肾益精、养肝强筋、宁心安神，对心肝气怯的早泄和肾虚滑精者，有良好的作用。

(孙吉山医案)

急性腮腺炎合并睾丸炎(1则)

222. 吕××，男，10岁，学生。1972年4月1日初诊。

家长代诉：患儿发烧四天，双侧腮颊肿胀觉痛两天，今天诉两侧睾丸痛。

四天来呈持续性发烧，且病势日趋加剧，两天来二腮颊肿胀而痛，左侧尤甚，张口、咀嚼困难，并牵及耳后和下颌。咽干，口燥，喜凉饮，今日又觉二耳憋胀、两侧睾丸肿大且痛。食欲不振，小便黄赤。西医诊断：急性传染性腮腺炎合并急性睾丸炎。

体温39.2℃，面红气粗，烦躁，两腮焮热，右腮大如鸡卵，左侧状如核桃，触之中心质稍硬，四周红晕压痛。睾丸压痛(+++)，右甚于左。脉象弦数，舌质红，苔黄腻。

恙由瘟邪蕴结，经气阻遏，发为痄腮。治拟清热解毒、疏风通络、消肿散结。

治疗经过：

4月1日上午初诊 耳尖、商阳、大敦，均三棱针点刺出血；大椎、曲池，针泻。

4月1日下午二诊 体温38.8℃，觉精神稍好，睾丸痛好

转，其余症状如上。上方加颊车透大迎。

4月2日上午三诊 体温38℃，两腮及睾丸疼痛明显减轻，张口及咀嚼时自感方便，腮部红肿见消过半，右腮肿已缩小成核桃大。上方加风池，行泻法操作。

4月3日四诊 体温37.6℃，左腮肿胀基本消失，唯压迫时尚有轻微作痛，右腮肿又较昨日为小，张口无碍，睾丸已不疼痛。饮食增加、精神好转。脉象弦、舌苔薄黄。此瘟邪渐去、正气恢复之状。效不更方。嘱仍须注意饮食，忌油腻厚味、辛辣刺激食物，并需适当休息。

4月5日五诊 体温37.4℃，体征基本消失，精神恢复，食纳基本正常，脉象小弦，舌质清淡苔薄白，嘱停诊。家长要求再巩固一次。

针耳尖、大椎、曲池、颊车，平补平泻法。

4月7日六诊 复查一切正常，诸症悉除。针曲池，足三里以善其后。

按 急性传染性腮腺炎，属于急性热病之一，为祖国医学“瘟毒”范畴。本案由于湿邪客于少阳、阳明之脉，蕴热不散，结于二腮，故症见肿胀作痛。瘟毒内袭、累及厥阴，因足厥阴之脉绕阴器，故睾丸肿痛。斯症当属实热无疑，治用泻法，乃宗“急则治其标”之意。三棱针点刺井穴出血，以清泄邪热，疏导经气；泻大椎、曲池等穴，以清瘟解毒、消肿散结，审证求因，治疗合拍，故效速捷。

（杨楣良医案）

肠 风 便 血（5则）

223. 近李仓患肠风，市医以杖量脐中，于脊骨当脐处灸，

即愈。予因此为人灸肠风，皆除根。

（《针灸资生经》）

224. 虞恒德治一男子，四十余，素饮酒无度，得大便下血症，一日如厕二、三次，每次便血一碗。以四物汤加条芩、防风、荆芥、白芷、槐花等药，连日服之不效。后用橡斗烧灰二钱七分，调入前药汁内服之，又灸脊中对脐一穴，血遂止，自是不发。

（《名医类案》）

225. 陆氏《续集验方》：治下血不已，量脐心与脊骨平，与脊骨上灸七壮，即止。如再发，即再灸七壮，永除根。目睹数人有效。余常用此灸人肠风，皆除根，神效无比。然亦须按此骨突酸痛方灸之，不痛则不灸也。但便血，本因肠风，肠风即肠痔，不可分为三，或分三治之，非也。

（《医说续编》）

按 应灸棘突之处，而非棘突与棘突之间。观者当察。

226. 唐峡州王及郎中，充西路安抚使判官，乘骡入骆谷，及宿有痔瘡，因此大作，其状如胡瓜，贯于肠头，热如塘灰火，至驛僵仆。主驛^{〔1〕}吏云：此病某曾患来，须灸即差。用槐枝浓煎汤，先洗痔，便以艾炷灸其上，连灸三五壮，忽觉一道热气入肠中，因大转泻，先血后秽，一时至痛楚，泻后遂失胡瓜，登骡而驰。

（《普济本事方》）

注

〔1〕驛：古时供递送公文的人或来往官员暂住或换马的处所。

227. 辛未^{〔1〕}岁，浙抚^{〔2〕}郭黄匡公祖，患大便下血，愈而复作，问其致痰之由？予对曰：心生血，而肝藏之，则脾为

之统。《内经》云：饮食自倍，肠胃乃伤，肠癖而下血，是皆前圣之言而可考者。殊不知肠胃本无血，多是痔疾，隐于肛门之内，或因饮食过伤，或因劳欲怒气，触动痔竅，血随大便而出。先贤虽有远血、近血之殊，而实无心、肺、大肠之分。又有所谓气虚肠薄，自荣卫渗入者，所感不同，须求其根。于长强穴针二分，灸七壮，内痔一消而血不出。但时值公冗，不暇于针灸，逾数载，升工部尚书，前疾大作，始知有痔隐于肛门之内，以法调之愈。至己卯复会于汶上云，不发矣。

(《针灸大成》)

注

(1)辛未：明·隆庆五年，即公元1571年。

(2)浙抚：浙江巡抚。

痃 癖⁽¹⁾ (1 则)

228.张德俊灸便毒，亲曾取效。云：屡以灸他人皆验，以细草或软篦一茎，随所患左右手量中指，自手掌尽处横纹量起，通三节至指尽处为则，不量指甲集（截）断，却将此草于手腕横纹量起，引草向臂，当中草尽处，即是穴。麦粒大灸三壮，肿散痛止即时安。

(《续名医类案》)

注

(1)痃癖：一名便痃，一名便毒，一名血痃，又俗名石米疮。左为鱼口，右为便毒，生于两腋合缝之间，结肿名曰横痃，又名外痃。

四 肢 病 症（52则）

痿 症（2则）

229. 一人身長五尺，因伤酒色，渐觉肌肉消瘦。予令灸关元三壮，服保元丹一斤，自后大便滑，小便长，饮食渐加，肌肉渐生，半年如故。

（《扁鹊心书》）

228. 安抚初病时右肩臂疼无主持，不能举动，多汗出，肌肉瘦，不能正卧，卧则痛甚。经曰：汗出偏沮，使人偏枯。予思《内经》云，虚与实邻，决而通之。又云：留瘦不移，节而刺之。使经络通和，血气乃复。又言：陷下者灸之。为阳气下陷阴中，肩膀时痛，不能运动，以火导之，火引而上，补之温之。已上证皆宜灸刺，谓此先刺十二经之井穴。于四月十二日右肩臂上肩井穴内先针后灸二七壮，及至疮发，于枯瘦处渐添肌肉，汗出少，肩臂微有力；至五月初八日，再灸肩井，次于尺泽穴各灸廿八壮，引气下行，与正气相接，次日臂膀又添气力，自能摇动矣。

（《卫生宝鉴》）

痹 症（15则）

肩 痹（5则）

230. 隋鲁州^{〔1〕}刺史庾狄嶽苦风患，手不得引弓，诸医莫能

疗。权〔2〕谓曰：但将弓箭向垛〔3〕，一针可射矣。针其肩髃一穴，应时即射。权之料疾，多此类也。

（《旧唐书·甄权传》）

注

〔1〕鲁州：地名。今山东境内。

〔2〕权：指唐代针灸家甄权。

〔3〕垛：墙上向外或向上突出的部分。

按 风邪入客阳明，闭阻气血，留滞肩臂，经脉不通，不通则痛矣。以致屈伸不利，废其功用。《玉龙赋》云：

“风湿传于两肩，肩髃可疗”，是指肩髃有疏风逐湿、通经活络的作用，是治疗上肢疾患的要穴。

232.予尝肩背痛，已灸膏肓，肩痛犹未已，遂灸肩井三壮而愈。以此知虽灸膏肓而他处亦不可灸云。

（《针灸资生经》）

按 肩背痛为灸膏肓之穴，意在扶正祛邪，但强弩之末，力不从心。遂灸肩井，直抵病所，祛风通络，立竿见影。《甲乙经》曰：肩井，治肩背脾痛，臂不举。

233.予中年每遇寒月，肩上多冷。常以手掌心抚摩之，夜卧则多以被拥之，仅能不冷。后灸肩髃，方免此患。盖肩髃系两手之安否；环跳系两足之安否，不可不灸也。

（《针灸资生经》）

234.予尝于膏肓之侧去脊骨四寸半，隐隐微疼，按之则疼甚。漫〔1〕以小艾灸三壮，即不疼。它日复连肩上疼，却灸肩疼处愈。方知《千金方》之阿是穴犹信云。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕漫：这里指随便的意思。

235.某患者：左肩膊先剧痛而后微痛，不能运动，已十余

年。针刺肩髃穴后，发生晕针，及至清醒，本人觉得像睡了一觉，非常舒服，退针后，起来穿衣服，当即运动自如，十余年的病顷刻消了。

（朱璉〔1〕《新针灸学》）

注

〔1〕朱璉：现代针灸家。江苏溧阳人。著有《新针灸学》一书。

臂 痹（2则）

236. 镇南王妃苦风疾。秃鲁〔1〕御史〔2〕以〔3〕文中〔4〕闻〔5〕。文书丐〔6〕诊候，按以合谷，曲池而潜针〔7〕入焉，妃殊不知也。未几，手足并举。次日起坐如常。

（《古今医统》）

注

〔1〕秃鲁：人名。

〔2〕御史：官名。

〔3〕以：指派。

〔4〕文中：徐文中，字用和，元朝宣州人，善针术。

〔5〕闻：往诊。

〔6〕丐：请求。

〔7〕潜针：手不露针，暗中将针刺入。

237. 乙卯〔1〕岁，至建宁〔2〕。滕柯山母，患手臂不举，背恶寒而体倦困，虽盛暑喜穿棉袄，诸医俱作虚冷治之。予诊其脉沉滑，此痰在经络也。予针肺俞、曲池、三里穴。是日即觉身轻手举，寒亦不畏，棉袄不复着矣。后投除湿化痰剂，至今康健，诸疾不发。若作虚寒，愈补而痰愈结，可不慎欤！

（《针灸大成》）

注

〔1〕乙卯：明嘉靖三十四年，即公元1555年。

〔2〕建宁：府名，今福建的建瓯。

按 本案扣住脉象沉滑，即虑及“疾在经络”。用肺俞宣肺化痰；三里健脾化湿，曲池既可祛风湿，利关节，也是治疗“手臂不举”的循经取穴。本案辨证准确，择穴精当，标本同治，效如桴鼓。

指 痹（1则）

238. 有贵人〔1〕手中指挛，已而〔2〕无名指、小指亦挛。为医灸肩髃〔3〕、曲池、支沟而愈。支沟在腕后三寸。或灸风疾，多有不灸支沟，只灸合谷云。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕贵人：指地位显贵的人。或为古代宫中的女官名。

〔2〕已而：后来；接着。

〔3〕肩髃：疑肩髃误。《甲乙经》曰：“肩中热，指臂痛，肩髃主之。”

腿 痹（3则）

239. 癸酉〔1〕秋，大理〔2〕李义河翁，患两腿痛十余载，诸药不能奏效。相公推予治之，诊其脉滑浮，风湿入于筋骨，岂药力能愈？须针可痊。即取风市、阴市等穴针之。官至工部尚书〔3〕，病不再发。

（《针灸大成》）

注

〔1〕癸酉：明万历一年，即公元1573年。

〔2〕大理：府名。今云南省大理白族自治州中部。

〔3〕工部尚书：官名。为六部之一，掌管各项工程、屯田、水利、交通等政令，长官为工部尚书。

按 经云：风寒湿三气杂至，合而为痹。风夹寒则痛且行，寒夹湿则痛且滞。今取风市、阴市，乃风邪寒邪散集之处，刺之可疏风、散寒，活络通经。通则不痛矣。

240. 庚辰〔1〕夏，工部郎许鸿宇公，患两腿风，日夜痛不能止，卧床月余。宝源局〔2〕王公，乃其属官，力荐予治之。时名医诸公，坚执不从。许公疑而言曰：两腿及足，无处不痛，岂一、二针所能愈？予曰：治病必求其本，得其本穴会归〔3〕之处，痛可立而止，痛止即步履，旬日之内，必能进部〔4〕。此公明爽，独听予言。针环跳、绝骨，随针而愈。不过旬日，果进部。人皆骇异。假使当时不信王公之言，而听旁人之语，则药力岂能及哉？是惟在乎信之笃〔5〕而已。信之笃，是以获其效也。

（《针灸大成》）

注

〔1〕庚辰：明万历八年，即公元1580年。

〔2〕宝源局：铸造钱币的机构。

〔3〕会归：指经脉会聚。

〔4〕进部：到工部去。

〔5〕笃：诚心。

按 《素问·缪刺论》曰：“邪客于是少阳之络，令人留于枢中痛，髀不可举，刺枢中以毫针，寒则久留针”，所指即本穴。与绝骨配伍，有祛风湿、利腰腿、舒筋脉的作用，通治下肢诸疾。《标幽赋》曰：悬钟，环跳，华佗刺髀足而

立行。杨公亦受其术也。

241. 予^{〔1〕}冬月当风市处多冷痹，急擦热手温之，略止。日或两三痹，偶谬刺以温针，遂愈。信乎治冷痹也。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕予：指《针灸资生经》作者王执中本人。

膝 痹（1 则）

242. 舍弟行一、二里路，膝必酸疼不可行，须坐定以手抚摩久之，而后能行，后因多服附子而愈。予冬月膝亦酸疼，灸犊鼻而愈。以此见药与灸不可偏废也。若灸膝关、三里亦得，但按其穴酸疼即是受病处，灸之不拘。

（《针灸资生经》）

按 “有诸内必形于诸外”，体表局部压痛，即是局部或机体内部疾患的一种反应，若以是处设穴，即古之所谓“以痛为输”，灸刺皆验。

足 痹（2 则）

243. 文安公守姑苏^{〔1〕}，以銮兴巡幸^{〔2〕}，虚府舍^{〔3〕}，暂徙^{〔4〕}吴县。县治卑湿^{〔5〕}，旋感足痹，痛掣不堪，服药不效，乃用所闻灼^{〔6〕}风市、肩髃、曲池三穴，终身不复发。

（《名医类案》）

注

〔1〕姑苏：今江苏苏州。

〔2〕以銮兴巡幸：乘车外出游玩。

〔3〕虚府舍：错过了住宿的地方。

〔4〕徒：步行。

〔5〕卑湿：湿盛，低洼潮湿之地。

〔6〕灼：烧。即用灸法。

按 湿邪袭人，得风寒而痹成。痹者闭也。经脉不通，遂致“痛掣不堪”，治当以祛寒湿为法。案中用灸，以温通散寒，且可祛湿；风市为祛风要穴；肩髃、曲池乃下病上取。三穴共用，可以疏经络闭滞，使经气流畅，则风、寒、湿三气无所凭借，而痹痛得解。

244. 晦翁有足疾，有道人为行针熨之术，旋觉轻安。公大喜，厚谢之，且赠以诗云云。

（《医暇危言》）

注

〔1〕晦翁，指朱熹。

骨 痹（1则）

245. 魏德新因赴冬选〔1〕，犯寒〔2〕而行，真元气衰，加之坐卧冷湿，饮食失节，以冬遇此，遂作骨痹，骨属肾，腰之高骨坏而不用，两胯似折，面黑如炭，前后痛，痿厥嗜卧。遍问诸医，皆作肾虚治之。先以玲珑灶熨蒸数日，次以苦剂上涌寒痰二三升。下虚上实明见矣，次以淡剂，使白术除脾湿，茯苓养肾水，官桂伐风木。寒气偏胜，则加姜附，否则不加，又刺肾俞，太溪二穴，二日一次，前后一月半，平复如初。

（《名医类案》）

注

〔1〕冬选：冬季应试考举。

〔2〕犯寒：冒着寒冷。

痛 风（1则）

246. 一少年患血痢，用涩药取效，致痛风听号，此恶血入经络也。血受湿热，久必凝浊，所下未尽，留滞遂道，所以作痛。久则必成枯细。与四物汤加桃仁、红花、牛膝、黄芩、陈皮、生甘草，煎入生姜，研潜行散，入少酒，饮之数十贴。又刺委中，出黑血三合而安。

（《名医类案》）

手 足 麻 木（2则）

247. 李东垣治杜意远患左手右腿麻木，右手大指亦常麻木至腕，已三、四年矣。诸医不效。求治，曰：麻者气之虚也，真气弱，不能流通，至填塞经络，四肢俱虚，故生麻木不仁。与一药决三日效，遂制人参益气汤。服二日，手心便觉热，手指中间如气胀满，至三日后，又觉两手指中间如手擦各傍触之，曰：真气遍至矣。遂于两手指甲傍各以三棱针一刺之，微见血如黍粘^{〔1〕}则痹自息矣。后再与调理而愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕黍粘：即黍子。

按 《灵枢·官针》曰：病在经络痼痹者……取以锋针。麻虽属虚，刺血而已。因此，不能仅以刺络属泻而论矣。

248. 陆养愚治丁慕云患麻木，左手足不能举，恶风，或时自汗，服小续命十剂不效，或谓风症，宜大汗之，小续命汤

参以补养气血之品，故不效耳。因倍风药，减参芍辈，二剂汗如雨，反觉一身尽痛，游走不定，并左手足不能举，昏沉厥逆甚危，诊之阳脉弦细而数，阴脉迟涩而空。谓此虽似风，然昔人云：麻者气虚，木者血虚，手足不任者脾虚，具此三虚，只宜调养气血，则风症自除。小续命正以风药过倍，血药殊少。何反倍风药而去参芍。宜其剧矣。仲景云：大法夏宜汗，以阳气在外也，春月阳尚稚，初出地下，大汗之，使卫气亟夺而失守，荣血不随，所以遍身走痛，昏沉厥逆皆气血虚垂绝之象也，急用大料十全大补汤，浓煎灌之少苏。为灸风池、百会、肩井、曲池、间使、三里六穴各数壮，以防中脏之危。自此诸症渐减，饮食渐进，第大便常结，痞闷微热。此汗多津液不足，故下不去则上不舒，以润字丸五分日二服，便行犹燥，以八物倍归加麦冬、知母以润之，少佐槟榔、木香、豆仁以调其气，自后每燥结，服润字丸五分，甚则一钱，月余全愈。

（《续名医类案》）

枯 涩 痹（1则）

249. 郾城梁贾人，年六十余，忽晓起梳头，觉左手指麻，斯须^{〔1〕}半臂麻，又一臂麻，斯须头一半麻，比及梳毕，从胁至足皆麻。大便二三日不通。往问他医，皆云风也，或药或针皆不解。求治于戴人，戴人曰：左手三部脉皆伏，比右手小三倍，此枯涩痹也，不可纯归之风，亦有火爆相兼，乃命一涌、一泄、一汗，其麻立已。后以卒凉之剂调之，润燥之剂濡之。惟小指次指尚麻。戴人曰：病根已去，此余烈也，方可针溪谷，溪谷者，骨空也。一日请晴和，往针之。用《灵

枢》中鸡足法〔2〕，向上卧针，三进三引讫，复卓针起〔3〕，向下卧针，送入指间皆然，手热如火，其麻全去。

（《儒门事亲》）

注

〔1〕斯须：很短的时间；一会儿。

〔2〕鸡足法：即合谷刺。进针至一定深度后，退至浅层，又依次再向两旁斜刺，形如鸡爪分叉，故名。

〔3〕复卓针起：将针退至皮下，直立其针。

腰 脚 痛（2则）

250. 仁寿宫备身患脚。奉敕〔1〕针环跳、阳陵泉、巨虚下廉、阳辅，即起行。

251. 大理赵卿患风，腰脚不随，不能跪起。针上髂一穴，环跳一穴，阳陵泉一穴，巨虚下廉一穴，即得跪起。

（《千金要方》）

注

〔1〕敕：皇帝的诏令。

坐 骨 神 经 痛（1则）

252. 王××，男，50岁，干部。

罹患左侧腰腿痛已一年之久，某医院诊断为坐骨神经痛，经多方医治无效而来我院针灸科就诊。

主诉：左侧腰腿牵引性麻痛，窜至踝部，并沿大腿前部向胫骨前外缘和足背部放散，走路不便，并伴有倦怠无力，心跳气短等症。脉两尺少力，舌淡而红。左侧直腿抬高试验

阳性，按压足阳明经循行路线有压痛。证系坐骨神经痛。中医辨证为腰腿痛，乃气血失调，阳明经气失畅所致，治宜调和气血，舒筋活络。

处方：气海、大肠俞、伏兔、足三里、解溪。

操作：气海艾条温和灸15分钟，以皮肤红晕为度。大肠俞等四穴进针得气后，施行提插（重插轻提）、捻转（大指向前用力较重、向后用力较轻）补法。患者有重胀之“得气”感应为度，不留针。

第一周每日针灸一次，从第二周开始，隔日针灸一次，共治疗五周，症状基本消失。

按：本病例据其病史证候分析，脏腑辨证为气血失调，经络辨证为阳明经气失畅，八纲辨证属虚证，故温灸气海以补虚，调和气血；取腰部大肠俞，下肢部足阳明经之伏兔、足三里、解溪等穴，以疏通腰腿（主要是足阳明）之经气。穴法，刺灸法合乎体质病情，拖延一年之久的疾病，仅治五周而基本告愈。

（曹一鸣医案）

脚 气（6则）

253. 有人旧患脚弱^{〔1〕}且瘦削，后灸三里、绝骨，而脚如故，益知黄君《针灸图》所谓绝骨治脚疾神效尤信也。

（《针灸资生经》）

注 ·

〔1〕脚弱：指脚痹。

254. 执中母氏常久病，夏中脚忽肿，旧传夏不理足，不敢著艾，谩以针置火中令热，于三里穴刺之，微见血，凡数次，

其肿如失去。

(《针灸资生经》)

255. 一人患脚气，两胫骨^{〔1〕}连腰日夜痛不可忍，为灸涌泉穴五十壮，服金液丹，五日全愈。

(《扁鹊心书》)

注

〔1〕胫(háng抗)骨：即胫骨。

按 下元虚损，寒湿之气壅滞于下，久而不除，湿气上攻，连及肾府，拘挛疼痛，此乃肾经湿盛。灸涌泉，既可益肾气，利水湿，又可起到引而下之的作用。

256. 僧^{〔1〕}普清^{〔2〕}苦此(脚气)二十年，每发率^{〔3〕}两月，用此^{〔4〕}灸二十一壮，即时痛止。

(《夷坚志》)

注

〔1〕僧：出家人。

〔2〕普清：患者(出家人)法名。

〔3〕率：大约有。

〔4〕此用：指风市、肩髃、曲池三穴。

257. 中书^{〔1〕}精舍公，年四旬有余，躯干魁梧。丙辰^{〔2〕}春，从征至扬州北之东武隅，脚气忽作，遍身肢体微肿，其痛不能近，足胫尤甚，履不任穿，跣^{〔3〕}以骑马，按两镫而以竹器盛之，以困急来告。予思《内经》云：饮食于中，脂肪于上。又云：诸痛为实，血实者宜次之。比三棱针数刺其肿上，血突出高二尺余，渐渐如线流于地，约半斤许，其血紫黑。顷时肿消痛减。以当归拈痛汤^{〔4〕}重一两半服之，是夜得睡，明日再服而愈。

(《卫生宝鉴》)

注

〔1〕中书：官名。于内阁中掌撰拟，记载，翻译等。

〔2〕丙辰：此指公元1258年。

〔3〕跣：赤足。

〔4〕当归拈痛汤：炙甘草、酒炒茵陈蒿、酒黄芩、羌活、防风、酒炒知母、猪苓、泽漆、当归、酒洗苦参、升麻、炒黄芩、人参、葛根、苍术、白术。

258. 蔡元长知^{〔1〕}开封，正据案治事，忽觉如有虫自足心行至腰间，即坠笔晕绝，久之方苏。掾属^{〔2〕}云：此病非俞山人不能疗。趣使呼之。俞曰：是真脚气也，法当灸风市。为灸一壮，蔡晏然^{〔3〕}复常；明日，疾如初。再呼俞，曰：除病欲根，非干艾不可。从其言，灸五百壮，自此遂愈。

（《夷坚志》）

注

〔1〕知：主，主宰，主持；或作接，接管。

〔2〕掾属：掾，古代属官的统称。掾属，指分曹治事的长官。

〔3〕晏然：平安。

按 《千金方》：“凡脚气初得弱脚，使速灸之……初灸风市，次灸伏兔，次灸腓鼻，次灸两膝眼，次灸三里，次灸上廉，次灸绝骨”。

脚 肿（1则）

259. 有范光禄得脚肿不能饮食，忽一人不通名，径入斋中谓曰：“佛使我来理君疾也。光禄废衣示之，因以刀针^{〔1〕}其肿上，倏忽间顿针两脚及膀胱百余下，出黄脓水三升许而去，至明并无针伤而患渐愈。

（《齐谐录》）

注

〔1〕刀针：刀，指铍刀，即九针中之铍针；针，刺入也。

转 筋（1 则）

260. 人患脚转筋〔1〕，时发不可忍，灸脚踝上一壮。内筋急灸内，外筋急灸外。

（《名医类案》）

注

〔1〕转筋：俗名“抽筋”，多指腓肠肌挛急。

脚 蹠（1 则）

261. 有人病两脚蹠不能行，舆诣佗，佗望见云：“已饱针灸服药矣，不复须看脉。”便使解衣，点背数十处，相去或一寸，或五寸，纵邪不相当。言灸此各十壮，灸疮愈即行。

（《三国志·魏书·华佗传》）

历 节 风（1 则）

262. 门诊号，1900，性别：女。

住址：重庆市新华路247号。

姓名：胡侠影。年龄：34。籍贯：巴县。

诊断起止日期：1953年10月21日至1954年11月14日。

症状：两膝关节冷痛，历时年余，腰以上汗出，腰以下无汗，左肩部亦痛，夙有白带之疾，曾经多种治疗，未能奏效。

诊断：历节风。

治疗过程：

1953年10月21日：灸风市、膝眼、足三里、上廉、下廉（补火）、绝骨（泻火）后，髌关上出透汗，膝关以下无汗。

1953年11月8日：灸左肩髃、曲池、合谷，左足风市、伏兔、腓鼻、内外膝眼、足三里、巨虚、上廉、下廉、阳辅后，膝关冷痛已瘥，肩痛大减微觉不能高举。

1954年10月5日：因重感寒湿，膝关冷痛复作，并增心中恶寒不足等症。灸两足风节、伏兔、腓鼻、内外膝眼、足三里、巨虚、上廉、巨虚、下廉、阳辅后，膝关冷痛减轻，心中仍恶寒不足。

1954年10月29日：针奇经开穴申脉（此日霜降）后，症状稳定。

1954年11月14日：针奇经开穴足临泣（此日立冬）后，膝关冷痛大减，病愈。

（吴棹仙医案）

手足抽搐症

263. 聂××，女，7岁，门诊号24417，于1963年12月14日初诊。

代诉：患儿无意识不自主的抽搐已7天。日有20余次，每次约3～4秒钟，抽时两手紧握，有时手指伸直，拇指紧贴掌心，足趾强直且向蹠侧屈曲，摇头、眨眼、咬牙。白昼易发，入夜较缓。精神不佳，表情淡漠，胃纳尚可，二便调。

查：发育营养中等，心肺未见异常；腹部柔软，无压痛；肝脾未触及；骨骼系统正常。佛斯特氏征阳性。血钙8毫克%，无机磷5.05毫克%。舌苔薄，脉弦数。

治以人中、后溪、行间为主穴，足三里、三阴交（灸5壮）、大椎（灸7壮）为配穴。每次主穴必针，配穴取一二个轮流刺激。以均匀的左右捻转（2次/呼吸）手法，留针10分钟。初诊后，抽搐次数减少，每日发作十余次，持续时间缩短。12月18日复诊后，精神恢复如常，白天偶然抽一二次。12月30日六诊后，已停止抽搐，一切复常。至1964年1月25日巩固治疗7次，抽搐未见发作，血钙增至9.5毫克%。

按：督脉为诸阳之海，有督导全身的作用。若督脉受病则失去平衡，抽搐不止。脉证相参，当属风证。《内经》谓：“诸风掉眩，皆归于肝”。故针人中、后溪（为八脉交会穴之一，通于督脉），灸大椎以调理督脉，配行间以平肝熄风，足三里、三阴交以健脾实胃，帮助消化，促进消化和利用。因而不但症状消除，血钙也恢复正常。至1964年12月中旬止，先后随访三次，未见复发。

（陈克勤医案）

伤 足（1则）

264. 德宗^{〔1〕}时，有朝士坠马伤足。国医为针腿，去针，有气如烟出。夕渐困急，将至不救，国医惶惧。有道士诣门^{〔2〕}云：某合视得。视针处，责国医曰：公何容易，死生之穴，乃在分毫，人血脉相通如江河，针灸在思其要津，公亦好手，但误中孔穴。乃令舁^{〔3〕}床前，于左腿气满处下针，曰：此针下，彼针跳出，当至于檐板。言讫遂针八寸余，旧穴之针

拂然跃至檐板，气出之所，泯然而合，疾者当时平愈。朝士与国医拜谢，以全帛赠遗，道士不受，啜茶一瓿而出，竟不知所之矣。

（《太平广记》）

注

〔1〕德宗：唐·李适之年号。

〔2〕诣门：来至门前。

〔8〕舁（yú与）：担也。

按 从史学角度看，我国唐朝时砭石已几乎绝迹，而铁、铜等针具仍在使用。但针质低劣，意外之事，虽国医也在所不免。本案云起针以后，竟“有气如烟出”，不知气从何来？恐文学家夸张之事。至于旧针“拂然跃至檐板”，并不可信。不过，道士主动登门，且敢于责备国医，说明他身怀绝技，后果应验，且不受名利，惟存救人之心，精神可佳。

中 风 后 遗 症（16则）

265. 予年逾壮^{〔1〕}，觉左手足无力，偶灸此^{〔2〕}而愈。后见同官说中风人多灸此，或百壮或三五百壮，皆愈。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕逾壮：年龄超过壮年。

〔2〕此：指神阙穴。

按 人愈壮年，阳气渐衰，故觉手足无力，见于一侧，则为半身不遂之先兆。神阙位于脐中，脐为生命之根蒂，真气所系，灸之可温补阳气。

266. 一人病半身不遂，先灸关元五百壮，一日二服八仙

丹^{〔1〕}，五日一服换骨丹，其夜觉患处汗出，来日病减四分，一月全愈，再服延寿丹半斤、保元丹一斤，五十年病不作。千金等方不灸关元，不服丹药，惟以寻常药治之，虽愈难久。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕八仙丹：由附子、高良姜、藜蘆、砂仁、肉蔻、生姜、厚朴制成。

按 寻常之药，非不能救疾，亦非不能除疾。但若药针并用，内外合攻，则疾无所逃焉。

267. 真定府临济寺赵僧判，于至元庚辰八月间，患中风，半身不遂，精神昏愤，面红颊赤，耳聋鼻塞，语言不出。诊其两手，六脉弦数。尝记洁古有云：中脏者，多滞九窍；中腑者，多著四肢。今语言不出，耳聋鼻塞，精神昏愤，是中脏也。半身不遂，是中腑也。此脏腑俱受病邪，先以三化汤^{〔1〕}一两，内疏三两行，散其壅滞，使清气上升，充实四肢。次与至宝丹如龙骨、南星，安心、定志、养神治之。使各脏之气上升，通利九窍，五日，声音出，语言稍利。后随四时脉证，加减用药，不旬，即稍能行步，日以绳络其病脚，如履阈^{〔2〕}，或高处，得人扶之，方可踰也。又刺十二经之井穴^{〔3〕}，以接经络。翌日舍绳络，能行几百步，大势皆去，戒之慎言语，节饮食，一年方愈。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕三化汤：方用厚朴、大黄、枳实、羌活各等分，共为粗末，每服三两，水煎服，以微利为度。治中风在外六经形证已解，内有便秘之阻格者。

〔2〕阈：门槛。

〔3〕十二经之井穴：即肺井少商、大肠井商阳、胃井厉兑、脾井隐白、心井少冲、小肠井少泽、膀胱井至阴、肾井涌泉、心包井中冲、三焦井少冲、胆井足窍阴、肝井大敦。

按 以十二井穴治疗中风偏枯，名为大接经。分“以阳引阴”和“以阴引阳”二法，皆取十二井穴。井穴位于四肢末端，为经络之“根”“本”，取之通经接气，活血行瘀。

268. 太尉忠武史公^{〔1〕}，年六十八岁，于至元戊辰十月初，待国师于圣安寺。丈室^{〔2〕}中，煤炭火一炉在左侧边，遂觉面热，左颊微有汗。师及左右诸人皆出。因左颊流缓，被风寒客之，右颊急，口喎于右，脉得浮紧，按之洪缓。予举^{〔3〕}医学提举^{〔4〕}忽君吉甫，专科针灸，先于左颊上灸地仓穴一七壮，次灸颊车穴二七壮，后于右颊上热手熨之，议以升麻汤加防风、秦艽、白芷、桂枝，发散风寒，数服而愈。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕忠武史公：史忠武之尊称。

〔2〕丈室：寺中方丈的住室。

〔3〕举：推荐。

〔4〕医学提举：医官职务。

按 风寒客于阳明，则见口喎。《灵枢·经筋》云：足阳明经筋，其病“卒口僻，……颊筋有寒，则急颊移口；有热则筋弛纵，缓不胜收，故僻。”经筋病的治疗，重在“以痛为输。”也可循经取穴。地仓、颊车为足阳明经穴，又当局部，既可疏通阳明经气，又可调和局部气血，选用得当。辅以热熨、服药等法疏散风寒，更妙。

269. 北京按察书史李仲宽，年逾五旬。至元己巳^{〔1〕}春，患风症半身不遂，四肢麻痹，言语蹇涩，精神昏溃，一友处一法，用大黄半斤，黑豆三升，水一斛同煮豆，熟去大黄，新

汲水淘净黑豆，每日服二三合，则风热自去，服之过半。又一友云，通圣散、四物汤、黄连解毒汤相合服之，其效尤速，服月余，精神愈困。遂还其定，归家养病。亲旧献方无数，不能悉录。又增嗜嘔不能言，气冷手足寒。命予诊视，细询前由，尽得其说。予诊之六脉如蛛丝细。谓之曰：夫病表里虚实寒热不等，药有君臣佐使大小奇偶之制，君所服药无考凭，故病愈甚。今为不救，君自取耳。未儿而死。

有曹通甫外郎妻肖氏，六旬有余，孤寒无依，春月忽患风疾半身不遂，语言蹇涩，精神昏溃，口眼歪斜，与李仲宽症同，于刺十二经井穴，处药服之减半。予曰不须服药，病将自愈。明年春张子敬郎中家，见其行步如故。予叹曰，夫人病得全者，不乱服药之力。由此论之，李仲宽乱服药，终身不救。肖氏贫困，恬憺自如而获安。《内经》曰：“用药无据，反为气贼。圣人戒之。”一日，姚雪斋举许先生之言曰：富贵人有两事反不如贫贱人，有过恶不能匡救，有病不能医疗。噫！其李氏之谓欤。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕至元己巳：至元，年号，至元己巳，指至元六年，即公元1269年。

270. 陕帅郭巨济病偏枯，二指着足底不能伸，杲^{〔1〕}以长针刺腓中^{〔2〕}，深至骨而不知痛，出血一二升，其色如墨，又且缪刺之，如此者六七，服药三月，病良已。

（《元史·李杲传》）

注

〔1〕杲，指李杲。

(2)孰中：孰，通委。即委中。

按 用长针治疗偏枯，可谓源于《内经》。《灵枢·热病》曰：“偏枯，身偏不用而痛，……宜巨刺取之，益其不足，损其有余，乃可复也。”巨针，可以理解成长针。委中，又称血郤。东垣善刺血，损益有余不足，无论理论实践，均有建树。今“恶血”去则新血生，血气得通，则肢体活络也。

271. 平安公患偏风，甄叔针风池、肩髃、曲池、支沟、五枢、阳陵泉、巨虚下廉即差。

(《针灸聚英》)

272. 徐评卒中不省，得桃源^{〔1〕}簿^{〔2〕}为灸脐中百壮始苏。更^{〔3〕}数月，乃不起。郑纠云：有一亲卒中风，医者为灸五百壮而苏，后年余八十。向使徐评灸至三五百壮，安知其不永年耶？

(《针灸资生经》)

注

〔1〕桃源：县名。在湖北省，沅江下游。

〔2〕簿：主簿，官名。

〔3〕更：经过。

按 本例为中风脱症。根据“孤阴不生，独阳不长”的阴阳互根原理，元阳外脱必从阴救之。任脉为阴脉之海，取其神阙，又因穴当脐中，为真气所系，元神所注。艾灸以回垂绝之阳，阳气复则苏矣。

273. 辛酉^{〔1〕}，夏中贵患瘫痪，不能动履，有医何鹤松，久治未愈。召予视，曰：此疾一针可愈。鹤松惭去。予遂针环跳穴，果即能履。夏厚赠，予受之。逾数载又瘫矣。复来召予，因侍禁廷，不暇即往，遂受鹤反间以致忿。视昔之刺鹤

于伏道者^{〔2〕}，为何如？

（《针灸大成》）

注

〔1〕辛酉：指明嘉靖四十年，即公元1561年。

〔2〕昔之刺醵于伏道者：指秦太医令李醯嫉贤妒能，派人刺杀扁鹊一事。

274. 一人中风，口眼歪斜，语言不正^{〔1〕}，口角涎流，或半身不遂，或全体如是。此因无气虚弱而受外邪，又兼酒色之过也。以人参、防风、麻黄、羌活、升麻、桔梗、石膏、黄芩、荆芥、天麻、南星、薄荷、葛根、赤芍药、杏仁、川归、川芎、白术、细辛、皂角等分，加葱姜水煎，入竹沥半盏，随灸风市、百会、曲池，合绝骨、环跳、肩髃、三里等穴，以凿窍疏风，得微汗而愈。

（《名医类案》）

注

〔1〕语言不正，指吐字不清。

275. 邹春元心泉年未五旬，患中风，耳聋鼻塞，二便不通，四肢不遂而厥，语言不出，或言皆说亡故之人，已灌牛黄钱许矣。或曰经云：脱阳者见鬼，脱阴者目盲。今日说亡人，目无所见，是见鬼与目盲也。又洁古云：中腑者著四肢，中脏者滞九窍。今手足不随，上下秘塞，是脏腑兼中也，且六脉弦数无伦。《脉诀》云：中风之脉迟浮吉，急实大数三魂孤，脉症俱危，恐无生理。立方：人参五钱，熟地一两，桂、附各二钱半，未服。陆^{〔1〕}至脉之，浮按果极急数，中按稍觉和缓，此犹有胃气，第两尺重按觉空耳。乃曰阴阳兼补，诚治本之法也。第上下秘塞之时，恐不能奏效，宜先通二便，使浊阴降，则清阳之气得以上升，然后论补。经谓：病发急则先标而后本，先治其标，后治其本。咸^{〔2〕}谓病势已危急，

恐不可虚缓，遂将前药灌之，连进数剂，俱停胸中，操之作声而不下腹。再促诊脉仍前，即袖中出家制神祐丸数十粒，抉其口纳之，令灌以淡姜汤，药已下，即为灸百会穴，使阳气上升，又灸关元穴，不使阳气下陷，一、二壮目即能开，眉频蹙。问痛否？能点头，四肢亦少动。谓之曰：忍至七壮可生矣，亦点头。灸将毕，腹欲便，既而前后俱通，去垢秽极多，少顷又泻一行，令急以前药倍入参煎候，及再便有晕意，徐灌之，自苏，此后人事渐省。……盖此症初起，气血不足为本，九窍闭塞为标。先通其秘者，急则治其标也。迨后见风症，亦不足为本，风症为标。而专补气血，少佐风药者，缓则治其本也。

（《续名医类案》）

注

〔1〕陆：指陆养愚。

〔2〕咸：全，都。

276. 颧长吏病口眼喎邪，张疗之。目之斜，灸以承泣；口之嫪，灸以地仓，俱效。苟不效者，当灸人迎。夫气虚风入而为偏，上不得出，下不得泻，真气为风邪所陷，故宜灸。《内经》曰：陷下则灸之，正谓此也，所以立愈。

（《续名医类案》）

按 对症取穴，无可抨击。然承泣、人迎用灸，乃欠稳妥。前者离目过近，法不当灸。且《太平圣惠方》等早已提出警告：“特不可灸，若灸，无问多少，三日以后眼下大如拳。息肉日加长，如桃许大。至三十日定都不见物。”后者因位于颈动脉部，直接施灸更不相宜。若以针代灸，则既不损人，又可同样收效，岂不更妙。

277. 韩貽丰治孔学使^{〔1〕}尚先，患半身不遂，步履艰难，语

言蹇涩，音含糊，气断续，为针环跳、风市、三里各二十一针，即下床自走，不烦扶掖，筋舒血活，无复病楚意，惟语言声音如旧，翌日，又为针天突、膻中十四针，遂吐言措词，琅然条贯矣。

（《续名医类案》）

注

〔1〕学使：官名。

278. 穆大司农〔1〕和伦，先是左手患木风，指不能伸屈，此半身不遂之兆也。召韩〔2〕治，为用七针〔3〕，指即伸缩无恙。逾两月复患腿疾，必持杖而行，因力辞乞休，已而韩为针环跳、风市、三里，针数次而疾顿瘳〔4〕，遂视事如故。

（《续名医类案》）

注

〔1〕大司农：官名。

〔2〕韩：韩贻丰。

〔3〕七针：指治疗中风偏瘫的七个经验效穴。始见《太平圣惠方》，所指为百会、耳前发际、肩井、曲池、风市、足三里、绝骨。常用灸法，病左灸右，病右灸左，七处一齐下火。

〔4〕瘳（chōu抽）：病愈。

按 阳主动，手足活动不利，其病在阳。故取阳经七穴治之。上、下同名经配伍，有加强疏通经脉，调和气血的作用。半身不遂，尚须疏风熄风，故取督脉之百会，以其位居巅顶，肝经来会，既可疏外风，又可平内风也。

279. 韩贻丰治司空〔1〕徐元正风气〔2〕，满面浮虚，口角流涎不已，语含糊不能出喉，两腿沉重，足走趑趄〔3〕不克逾户限〔4〕。脉之曰：此症非针不可。遂呼燃烛。举手向顶门欲用针。徐公及其令孙皆大惶骇云：此处安可用火攻？强之再

三，终究不允而罢。后闻韩之针颇神。复邀，与针百会、神庭、肾门（俞）、命门、环跳、风市、三里、涌泉诸穴道，俱二十一针。方针之初下也，以为不知当作如何痛楚，及药热气氤氲^{〔5〕}，不可名状，连声赞叹，以为美效。积久周身之病，一时顿去。

（《续名医类案》）

注

〔1〕司空：官名。

〔2〕风气：即风气内动。指由于脏腑功能失调，气血逆乱，筋脉失养而出现的眩晕、抽搐、昏仆、口喎等症状。

〔3〕趑趄（zīqū 资居）：指行走困难。

〔4〕不克逾户限：不能跨越门槛。户限：门槛。

〔5〕氤氲（yīnyūn 阴晕）：形容气动荡弥漫貌。

按 风气内动，多责之于肝。足厥阴肝与督脉会于巅，故取督脉之百会、神庭，以熄风潜阳；取肾俞、命门、涌泉，滋肾水以涵木；另取环跳、风市、三里，疏通下肢经气。诸穴合用，标本兼治，远近相宜，故病顿去。

280. 关××，男，65岁，社员。于1975年2月18日初诊，病历246045号。

自诉：五天前晨起自觉左侧上下肢无力，活动困难，尤以下肢为重，不能下地步行，坐位困难，左手不能握物，伴有头痛，便秘。

查：神清，左侧鼻唇沟较对侧浅，舌正，左上肢肌张力增加，手握力较对侧差，肱二、三头肌反射正常，左侧霍夫曼氏征阳性，左侧膝反射亢进，左踝阵挛阳性，跟腱反射正常，巴宾斯基氏征阴性。脉虚弦，血压160/100毫米汞柱，苔薄白。据此诊为中风偏瘫（中经），属络脉空虚，风痰痹阻。

所致。

治以疏风通络。取内关（双），扶突、臂中、合谷、秩边、三阴交（均左侧）。针刺感觉传导至瘫痪肢体，刺激要强才能取得较好的效果。具体穴位针刺情况如下，扶突：直刺1寸左右，闪电麻感由肩、上臂、前臂传至手拇、食指尖。本穴除治疗上肢瘫痪外，尚可治疗项、肩、臂之麻木或疼痛等症。臂中：在掌心向上，前臂肘横纹与腕横纹中点，针刺时针尖方向偏于中线尺侧，针7分~1寸，使触电麻感传向手拇、食、中、无名指。本穴尚可治疗前臂及手指关节痛、手麻等症。合谷：针刺后先使针感麻胀传至拇、食二指，再将针尖向后溪穴处刺入，使针感传至中、无名及小指，刺入约2寸左右。本穴尚可用于类风湿性关节炎之手关节肿胀、疼痛和手麻等症。秩边：直刺3~3.5寸，触电麻感自臂部、大腿、小腿至足跟、足趾。本穴尚可用于下肢麻木疼痛，下肢发凉等症。三阴交：针1寸左右，闪电麻感传向足跟、足趾。本穴尚可用于癔病性瘫痪，踝关节痛，足麻，足冷，失眠。内关：针2分左右，麻电感传至指尖，在此用以清心安神。

（蒋幼光医案）

全 身 性 病 症(66则)

伤 寒 (4 则)

284.一人患肺伤寒，头痛、发热，恶寒、咳嗽，肢节疼，脉沉紧，服华盖散^{〔1〕}、黄芪建中汤，略解。至五日，昏睡、谵语，四肢微厥，乃肾气虚也。灸关元百壮，服姜附汤^{〔2〕}，始汗出，愈。

(《扁鹊心书》)

注

〔1〕华盖散：麻黄，苍术，陈皮，官桂，杏仁，甘草。

〔2〕姜附汤：生姜，川附子。

按 本案属太阳病兼及里证，五日后证情复故，出现少阴危候。少阴属水，内寄真阴真阳，心火得肾水而滋，由于寒水被凝，不能上济心主，而现谵语、昏睡；四肢微厥，乃属肾气虚证。是故取关元大灸，兼服温里之剂，双管齐下，回阳救逆，固脱拯危，独具慧眼，焉有不愈之理？

275.一人初得病，四肢逆冷，脐下筑痛，身痛如被杖^{〔1〕}，盖阴证也。急服金液^{〔2〕}、破阴^{〔3〕}、来复^{〔4〕}等丹，其脉遂沉而滑。沉者阴也，滑者阳也，阴病得阳脉者生，仍灸气海、丹田百壮，手足俱温，阳回，得微汗而解。或问滑沉之脉，如何便有生理？曰：仲景云，翕奄沉名曰滑。何谓也？沉为纯阴，翕为正阳，阴阳和合，故名曰滑。古人论脉滑，虽曰

往来前却，流利旋转，替替然与数相似。仲景三语而足也，此三字极难晓，翕合也，言张而复合也，故曰翕为正阳。沉言忽降而下也，故曰沉为正阴，方翕而合，俄降而沉，奄为忽忽间。仲景论滑脉，可谓谛当矣。其言皆有法，故读者难晓，宜细思之。

(《续名医类案》)

注

〔1〕被杖：杖抽打在身上。

〔2〕金液丹：由舶上硫黄熬化七次，再缀研而成。

〔3〕破阴丹：药物组成不详。

286. 壬申岁，大尹夏梅源公，行取至峨眉庵寓，患伤寒。同寅诸公^{〔5〕}，迎视六脉微细，阳症得阴脉。经云：阳脉见于阴经，其生也可知；阴脉见于阳经，其死也可许。予居玉河坊，正值考绩^{〔3〕}，不暇往返之劳，若辞而不治，此公在远方客邸，且蒞政清苦，予甚惻之^{〔4〕}。先与柴胡加减之剂，少效，其脉尚未合症。予竭精殚思^{〔5〕}，又易别药，更针内关六脉转阳矣。遂次第^{〔6〕}进以汤散而愈。后转升户部，今为正郎。

注

〔1〕壬申岁：明·隆庆六年，即公元1572年。

〔2〕同寅：旧称同官曰“同寅”。

〔3〕考绩：考核成绩，此处指正值考试。

〔4〕惻(cè侧)：怜悯、同情。

〔5〕竭精殚(dān丹)思：耗尽心血和思虑。

〔6〕次第：表示顺序之词。

按 气衰无力运血，症至六脉微细，已属气血不足之候，非柴胡之辈所能起。杨公改弦更张，易其药，更针内关，针药并用，和营复脉。圆机活法，妙在其中也。

281. 郭雍治一人盛年时健，不善养，因极饮冷酒、食肉，外有所感，初得疾，即便身凉、自利、手足厥、额上冷汗不止、遍身痛、呻吟不绝、偃卧不能转侧、心神俱无、不昏愤、不恍惚。请医视之，治不力。言曰：此证甚重，而病人甚静，殊不昏愤，身重不能起，自汗自利四肢厥，此阴证无疑矣。又遍身痛，不知处所，出则身如被杖，阴毒证矣。当急治之。医言缪悠，不可听。郭令服四逆汤，灸关元及三阴交。未知。加服九炼金液丹。利、厥、汗证皆少止。微缓药艾，则诸证复出，再急灸治，如此进退者三。凡三日两夜灸千余壮，服金液丹亦千余粒，四逆汤一二斗，方能住灸、汤药。阳气虽复，而汗不出，证复如太阳病。未敢服药以待汗。二三日复大烦躁饮水，次则谵语、斑出、热甚。无可奈何，复与调胃承气汤。得利、大汗而解。

（《名医类案》）

流行性出血热（2 则）

285. 陈××，男，30岁。住院号：2604。

发病4天入院，颜面及两耳红紫浮肿，球结膜水肿充血，视力模糊，上颌充血有出血点，舌苔白腻秽浊，六脉沉数细弱，呼吸急迫，胸腹饱满思吐，肢体沉重酸痛，头痛难忍，体温40.5℃，属发热期及阳明怫郁、腠理不宣型，是当时危重病人之一。

先采用刮背法以疏通腠理，再用三棱针点刺左右少商、少泽出血以解表泻热，体温当即下降至39.8℃，但仍有吐意。4小时后用三腕五针、火针代灸以行气利湿，快膈宽中。吐意止，病势趋于缓和，次日感下腹及腰胀部痛难忍，热未续

退，取阴交四针，腰痛立减，热度下降至 37.4°C ，神清，可谈笑。仅食后略感上腹饱满，嘱每日自行熏灸中脘2次，前后4天，症状基本消失，仅一度曾有微热（ 37.3°C ），余无其他反复。又观察5天出院。

（周楣声医案）

286. 甄××，男，30岁。住院号：1978。

发病3天入院，呈急性痛苦病容，颜面潮红，双目充血，腋下及前胸有出血点，腰痛难忍，端坐低头，双手抱腰呻吟，舌苔白腻秽浊，六脉沉细微弱，血压逐次下降至 $30/10$ 毫米汞柱，体温 34.9°C ，呕吐，上腹饱胀，尿量每天约为500毫升。属低血压期及湿浊内阻、心阳不振型。已发出病危通知。

首先熏阳交以护肾止腰痛。30分钟后热感可以透入腹腔，2小时后腰痛减可平卧。夜间嘱其自行熏灸阴交，次晨腰痛续减，尿量增至800毫升，血压回升，热全退。但有吐重、厌食。改灸中脘。又续取阴交四针、火针代灸，腰痛全止，尿量增至1000毫升以上。因灸后思食，暴食过量，体温曾一度上升，续灸中脘，症状得到控制，以后未出现反复。又观察三天出院。

（周楣声医案）

虚 劳(10则)

287. 叶余庄，字元善，平江人。自云：尝病瘵疾，其居对桥，而行不能度。有僧为之灸膏肓穴，得百壮。后二日，即能行数里，登降皆不倦，自是康强。其取穴法，但并足垂手，正身直立，勿令俯仰，取第四椎下两旁同身寸各三寸。灸时以软物枕头覆面卧，垂手附身，或临时置身，取安便而已。

其转为人灸，亦用此法，云皆有功。

（《灸膏肓腧穴法》）

注

〔1〕瘵（zài）疾：病名。多指癆病。虚损之重症也称劳瘵，如《杂病源流犀烛》中有：“五脏之气，有一损伤，积久成癆，甚则为瘵。”

按 清·沈金鳌说：“癆者，劳也，劳困疲惫也。瘵者，败也，羸败凋敝也。虚损癆瘵，其病相因。”根据损有余、益不足的原则，选用膀胱经腧穴膏肓俞，补虚抗癆，固气益损，是治疗诸虚百损的主要穴位，然针不及灸。

288.一幼女病咳嗽，发热、咯血、减食。先灸脐下百壮，服延寿丹〔1〕，黄芪建中汤而愈。戒其不可出嫁，犯房事必死，过四年而适人〔2〕，前病复作。余曰：此女胎稟素弱，只宜固守终老，不信余言，破损天真，元气将脱，不可救矣。强余丹药服之，竟死。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕延寿丹：即保命延寿丹。由硫黄，明雄黄，辰砂，赤石脂，紫石英，阳起石组成。

〔2〕适人：旧时指女子出嫁。

289.一妇人伤寒瘥后，转成虚劳，乃前医下冷药，损其元气故也。病人发热、咳嗽、吐血、少食。为灸关元二百壮，服金液、保命〔1〕、四神、钟乳粉，一月全愈。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕保命：即保命延寿丹。由硫黄、明雄黄、辰砂、赤石脂、紫石英组成。

〔2〕四神：即四神丹。由雌黄、雄黄、硫黄、辰砂组成。

290. 一人病咳嗽、盗汗发热，因倦减食、四肢逆冷、六脉弦紧，乃肾气虚也。先灸关元，五百壮，服保命延寿丹二十丸，钟乳粉二钱，间日，服金液丹百丸，一月全安。

（《扁鹊心书》）

按 案材曰：“此病由七情六欲，损伤脾肾，早尚易治，迟则难愈。必用火灸，方得回生，若用温平药及黄耆建中鳖甲饮之类，皆无益于病，反伤元气。”按虚劳之病，多有发热，但主要责于脏腑阴阳气血偏盛，或阳气不足，气虚下陷，郁而发热；或阴血不充，明不配阳，阳亢发热。不论何种原因，病均以虚为本，治当用补。案公极明此理，重灸关元，温肾益元，以正祛邪，可使虚者得复，陷者得升，郁者得解，乃治本之法也。

291. 建康道^{〔1〕}按察副使^{〔2〕}奥屯周卿子，年二十有三，至元戊寅^{〔3〕}三月间病发热，肌肉消瘦，四肢困倦，嗜卧盗汗，大便溏多，肠鸣不思饮食，舌不知味，懒言语，时来时去，约半载余。请予治之，诊其脉浮数，按之无力，正应王叔和脉浮歌云：“脏中积冷荣中热，欲得生精要补虚。”先灸中脘，乃胃之经也，使引清气上行，肥腠理。又灸气海，乃生发元气，滋荣百脉，长养肌肉。又灸三里，为胃之合穴，亦助胃气，撤上热，使下于阴分。以甘寒之剂泻热，其佐以甘温，养其中气。又食粳米羊肉之类，固其胃气。戒于慎言语，节饮食，惩忿窒欲，病气日减，数月，气得平复。逮^{〔4〕}二年，肥盛僭常。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕道：行政区划名。

〔2〕按察使：官名，主管一路司法刑狱和官吏考核。

〔8〕戊寅，至元十五年，即公元1278年。

〔4〕逮：及至。

292. 胡念庵治王在庭之室，病虚劳十余载，喘促吐沫，呕血不食，形体骨立。诸医束手。诊之，见其平日之方，皆滋阴润肺温平之剂。曰：“以如是之病，而乃用如是之药，自然日趋鬼趣，焉望生机？独不思仲景云：咳者则剧，数吐痰沫，以脾虚也。又昔贤云：肾家生阳，不能上交于肺则喘。又云：脾虚而肺失生化之源则喘。今脾肾败脱，用药如此，焉望其生？”乃重投参、芪、姜、附等，二剂而喘定。缘泄泻更甚，再加萸、蔻十余剂，而病减十七。又灸关元，因畏痛，只灸五十壮。迄今十余年，而形体大健矣。

（《扁鹊心书》）

293. 一壮年患嗽而咯血，发热肌瘦，医用补药，数年而病甚，脉涩。此因好色而多怒，精神耗少，又补塞药多，荣卫不行，瘀血内积，肺气壅遏不能下降。治肺壅，非吐不可，精血耗，非补不可。唯倒仓法二者兼备，但使吐多于泻耳。兼灸肺俞两穴在三椎骨下，横过各一寸半，灸五次而愈。

（《名医类案》）

294. 女童庄妙真顷缘二姐，坐瘵疾不起，余孽亦寝寝^{〔1〕}见及，偶一赵道人过门，见而言曰：“汝有瘵疾，不治何耶？”答曰：“吃了多少药，弗效。”赵笑曰：“吾得一法，治此甚易，当以癸亥夜二更，六神皆聚之时，解去下体衣服，於腰上两傍微陷处，针灸家谓之腰眼，直身平立，用笔点定，然后上床合面而卧，每灼小艾炷七壮，劳蛊或吐出，或泻下，即时平安断根不发，更不传染。敬如其教，因此获全生。

（《医说》）

注

〔1〕寝寝：原为马速行貌。这里是指很快或骤然的意思。

295. 罗聘人物轴题云：戊戌冬十月，沐手图绘，以为西坛居士寿，居士年四十，精岐黄之术，不屑与群医较优劣，独身树立。群之病人赖以活者，皆群医所不能活者也。今夏，山妻病肺，已知无复生理，得居士为针疏之功，遽令振起，因并书数语以志感云。”

（《伟大的祖国传统图录》）

296. 荆州人王元礼，尝家患骨蒸，传尸死尽，有一道士忽教灸，即断，兼更数人，无有不差者。

（《外台秘要》）

高 血 压(1则)

297. 李××，男，48岁，干部。

患者心烦怔忡，夜不成寐，欲寐即惕然而惊，心躁烦，中午尤甚，手心出汗欲滴，足凉过膝，血压忽高忽低，一日数变，已年余。怀疑肾上腺肿瘤，后经上海某医院排除，诊断为“阵发性高血压”。住院四月，未见效，近来鼻衄三次均在早晨3～5时（即寅时）。每次出血量约100多毫升，至中午11～13时（即午时）则心内发冷，手心出汗欲滴，足凉过膝，心神躁烦不安。于1968年元月22日来针灸科就医。

血压上午8时150/90毫米汞柱，中午12时190/100毫米汞柱，晚8时130/80毫米汞柱。

脉浮芤而数，舌红嫩有裂，颧面潮红，此肾阴不升、心阳不降、心肾不交、心阳外越之证。拟潜镇心阳，交通心肾，佐以健脾和胃法。是日（甲申日）于卯时开穴进针。

开穴：神门（阳中隐阴） 太溪（阴中隐阳） 大陵（阳中隐阴）

配穴：足三里（平补平泻） 三阴交（平补平泻） 留针30分钟。

二诊：元月廿三日。自云针后即感舒适，诸症稍见好转。于乙酉日卯时开穴进针。

开穴：间使（阳中隐阴）

配穴：太渊（阳中隐阴） 复溜（烧山火） 合谷（透天凉） 足三里（平补平泻） 束骨（透天凉） 小海（透天凉）

三诊：元月廿四日。血压较稳定，早晨150/90毫米汞柱，中午160/80毫米汞柱，晚上150/80毫米汞柱，余症续见好转。于丙戌日午时开穴进针。

开穴：神门（阳中隐阴）

配穴：太溪（阴中隐阳） 足三里（平补平泻） 三阴交（平补平泻）。

四诊：元月26日。脉仍浮扎，舌红，苔微薄白，病势稍瘥，仍拟原方击鼓再进。于戊子日巳时开穴进针。

开穴：大陵（阳中隐阴）

配穴：太渊（阳中隐阴） 太溪（阴中隐阳） 束骨（透天凉） 小海（透天凉） 复溜（烧山火）

五诊：元月27日。己丑日酉时开穴，戌时进针。

开穴：太溪（阴中隐阳） 太白（阴中隐阳）

配穴：阴郄（阳中隐阴） 足三里（平补平泻）

六诊：元月29日。辛卯日未时开穴，申时进针。

开穴：太冲（阴中隐阳） 太渊（阳中隐阴）

配穴：大陵（阳中隐阴） 足三里（平补平泻） 复溜（烧

山火)

七诊：元月30日壬辰日午时开穴午时进针。

开穴：后溪(泻) 阳池(泻) 京骨(泻)

配穴：阴郄(补) 筑宾(补)

八诊：元月31日脉象微芤，舌苔薄白，血压稳定但较正常略高，早晨150/80毫米汞柱，中午160/80毫米汞柱，晚上150/80毫米汞柱。睡眠亦渐好转，每夜约能熟睡5~6小时，手汗止，神志清，足渐温，食欲增进，惟中午偶见短暂的烦躁。停针三天，以观疗效。

九诊：2月4日，脉舌俱如前，停针后诸症好转无反复。仍遵前法。丁酉日亥时开穴亥时进针。

开穴：太溪(泻) 神门(泻)

配穴：太溪(补) 足三里(平补平泻)

十诊：2月8日，脉象和缓，舌苔薄白，舌质稍红，血压正常(130/80毫米汞柱)，睡眠良好，主症消失，宜服磁珠丸，继刺足三里、曲池、阴郄、太溪，以善其后。将息月余全愈，随访年余未复发，身体健康，正常上班。

按 患者于寅时鼻衄，乃心阳不降上逆于肺，肺旺于寅时，肺不受邪，排邪外出故衄；心旺于午时，心经通于手，汗乃心之液，故手汗出，足凉过膝者，肾经通于足，经云“午时一阴生”，此阴气上溢于阳，阳气不得下降，水火不能既济，以致于躁烦、寒颤、失眠等诸症俱见。血压不正常，因心肾二经病引起者更为常见。在治疗上抓住心肾不交这一主要矛盾，掌握病人发病的规律及其本身的生物节律，因势利导，运用传统的子午流注针法，施以迎随补泻，烧山火，透天凉，阳中隐阴，阴中隐阳等手法以达其交通心肾的目的。

(秦德铨医案)

癲、狂、癩（20则）

298. 有士人妄语异常，且欲打人，病数月矣。予意其是心疾，为灸百会，百会治心疾故也。又疑是鬼邪。用秦承祖^{〔1〕}灸鬼邪法，并两手大拇指，用软帛绳急缚定，当肉甲相接处灸七壮，四处皆著火而后愈。更有二贵人子，亦有此患，有医僧亦为灸此穴愈。更有二贵人子，亦有此患，有医僧^{〔2〕}亦为灸此穴愈。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕秦承祖：南朝刘宋针灸学家，精方药，尤擅针灸。著有《偃侧杂针灸经》三卷，《偃侧人经》二卷，并绘制《明堂图》。

〔2〕医僧：僧，指出家人。僧人知医而为人治病者称医僧。

299. 一人得风狂已五年，时发时止，百法不效。余为灌睡圣散三钱，先灸巨阙五十壮，醒时再服；又灸心俞五十壮，服镇心丹^{〔1〕}一料。余曰：病患已久，须大发一回方愈，后果大发一日，全好。

（《扁鹊心书》）

300. 一妇人产后得此症，亦如前灸，服姜附汤而愈。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕镇心汤（丹）：方用人参、茯苓、石菖蒲、远志、木香、丁香、甘草、干姜、大枣，水煎空心服。

按 风狂之疾，心神失主，首当治心。巨阙，心俞为俞募配穴，从阴引阳，从阳和阴，阴阳得和，心神得宁。

301. 金华富家妇，少寡得狂疾，至裸形野立。云视曰：“是

谓丧心，吾针其心，心正必知耻。”蔽之帐中，慰以好言，释以好言，释其愧，可不发，乃令二人坚持用凉水喷面，针之果愈。

（《明史·凌云传》）

按 所谓针其心者，针心之募穴巨阙也。巨阙深部为肝脏，针刺务必谨慎。冷凉水喷面令其惊，惊则肝上提，免损其肝也。

302. 长山徐姬痼疾，手足颠掉，裸而走，或歌或笑，汉卿^{〔1〕}刺其十指端出血而痊。

303. 韩貽丰^{〔1〕}治永和一少年患风狂，百治不效，其父兄缚送求医。为针百会二十针，升堂公坐，呼少年前来，命去其缚，予杖者再杖，毕而醒，问以前事，茫然不知也。

（《续名医类案》）

304. 一妇因夫病垂危，心患之，乃夫病愈，妇即病风狂，昼夜不思眠食，白日裸身狂走，或登高阜，或上窑房，莫能禁也。乞韩治。将至其家，其妇正在袒裼^{〔2〕}狂跳中，忽自觅衣覆体，敛容屏息，若有所俟者，邻媪讶之初不解其何意，俄而韩至，令之跪则跪。因跪而受针，（时韩为本邑宰）为针其百会一穴，鬼眼二穴，各二十一针，针毕即叩头谢曰：“吾今不敢为祟矣，愿乞饶命，吾去矣。”言毕而醒。

（《续名医类案》）

注

〔1〕韩貽丰：清代医家，著有《太乙神针心法》。

〔2〕袒裼：脱去上衣，露出身体的一部分。

305. 有人患痼疾，发则僵仆在地，久之方苏。予意其用心所致，为灸百会；又疑是痰厥致僵仆，为灸中管，其疾稍减，未除根也。后阅《脉诀》后通真子^{〔1〕}有爱养小儿，谨护

风池之说，人来觅灸痼疾，必为之按风池穴，皆应手酸疼，使灸之而愈。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕通真子，即刘元宾，字子仪，自号通真子。北宋医家，精方脉。

按 《针灸大成》云：“凡患风痼疾，发则身尚仆在地，灸风池百会”说明风池亦为治痼要穴。与中脘穴不同者，风池主要用来治标，与百会配伍，有祛风痰、清神志的作用；中脘主要用来治本，可杜痰湿化生。

306. 一人病痼三年余，灸中脘五十壮，即愈。

（《扁鹊心书》）

307. 一妇人病痼已十年，亦灸中脘五十壮，愈。凡人有此疾，惟灸法取效最速，药不及也。

（《扁鹊心书》）

按 痼证多因于痰。《医学纲目》认为，癰痼是痰邪逆上，头中气乱，脉道闭，孔窍不通所致。痼证初期多属实，日久病多属虚，虚证当补益脾胃，化痰熄风宁神，中脘为胃之募穴，《行针指要歌》云：或针痰，先针中脘三里间。脾胃得振，清浊分利，水湿不得聚痰上乘，则痼症可止矣。

308. 张子和治一妇，年三十，病风搐目眩，角弓反张，数月不愈，诸医作惊风风痼治之，用南星、乌、附等不效。子和曰：“诸风掉眩，皆属于肝木。木曲直摇动，风之用也。阳主动，阴主静，由火盛制金，金衰不能平木，肝木茂而自病故也。”先涌风涎二三升，次以寒剂下十余行，又以钜针^①刺百会，出血二杯，立愈。

（《古今医案按》）

注

〔1〕排针，铍针。

309. 丹溪治一妇人，久积怒与酒，病癩。目上视，扬手踣足，筋牵，喉响，流涎，定则昏昧，腹胀痛冲心，头至胸大汗，痛与痛间作。此肝有怒邪，因血少而气独行，脾受刑，脾胃间有酒疾，为肝气所侮而为痛。酒性喜动，出入升降，入内则痛，出外则痛。用竹沥、姜汁、参朮膏等药甚多，痛间作无度。乘痛时灸大敦、行间、中脘，间以陈皮、芍药、甘草、川芎汤调石膏与竹沥服之，无数。又灸太冲、然谷、巨阙，及大指甲肉。且言鬼怪怒骂巫者。丹溪曰：“邪乘虚而入，理或有之。与前药佐以荆、沥防痰，又灸鬼哭穴，余证调理而安。”

（《针灸聚英》）

310.（蔡都尉之）女患风癩甚危，其乃郎秀山，乃婿张少泉，邀予治之。乃针内关而苏。以礼厚赠，予固辞不受。遂以女许聘豚儿〔1〕杨承祺焉。

（《针灸大成》）

注

〔1〕豚儿：旧时对人称自己儿子的谦词。

311. 丁丑〔1〕夏，锦衣〔2〕张少泉公夫人，患痛症二十余载，曾经医数十，俱未验。来告予，诊其脉，知病入经络，故手足牵引，眼目黑瞤〔3〕，入心则搐叫，须依理取穴，方保得痊。张公善书而知医，非常人也，悉听予言。取鸠尾、中脘，快其脾胃；取肩髃、曲池等穴，理其经络、疏其痰气，使气血流通，而痛自定矣。次日即平妥，然后以法制化痰健脾之药，每日与服。

（《针灸大成》）

注

〔1〕丁丑：明·万历五年，即公元1577年。

〔2〕锦衣：“锦衣卫”简称。明洪武十五年（1382年）设置。原为护卫皇宫的亲军，掌管皇帝出入仪仗，明太祖为了加强专制统治，特令掌管刑狱，有缉捕权。

〔3〕瞽：眩。

〔3〕快：畅达。

312. 戊辰^{〔1〕}岁，产部^{〔2〕}王缙庵公乃弟，患心痛疾数载矣。徐堂翁召予视之，须行八法开阖^{〔3〕}方可，公如其言。而刺照海、列缺，灸心俞等穴，其针待气至，乃行生成之数而愈。凡治此症，须分五病^{〔4〕}，此卷前载之详矣，兹不悉录。

（《针灸大成》）

注

〔1〕戊辰：明·隆庆二年，即公元1568年。

〔2〕户部：官署名，掌管全国土地、户籍、赋税、财政支出，长官为户部尚书。

〔3〕八法开阖，指灵龟八法八穴的按时开穴。

〔3〕五病：古代对各种痛证的统称。有二说：①马痢、羊痢、鸡痢、猪痢、牛痢（见《名医别录》）。②犬痢、羊痢、牛痢、鸡痢、猪痢（见《小儿药症直诀》）。上述分类，多以发病的五畜叫声及病时体态而命名的。《丹溪心法》等认为痢发时的似畜叫声，无非是痰涎阻塞诸窍所致，治法无需区分五类。

313. 一小儿四岁，与长老念咒摩顶受记发搐，后见皂衣人即发。罗谦甫先与灸两跷^{〔1〕}各二七壮，次服沈香天麻汤。

（《针灸聚英》）

注

〔1〕两跷：阴阳两跷之总称。洁古云：昼发灸阳跷，夜发灸阴跷。阳跷、阴跷者即申脉、照海也。

314. 陈××，女，17岁，营业员。于1956年4月17月初诊。

自诉：本年三月下旬因工作繁重等因素引起精神沉闷不舒，致使轻度失眠，后神志失常或哭或笑，不辨人事，经××县人民医院诊断为“癔病”，内服镇静药，效果不显而来诊治。

查：体格营养中等，面部表情痴呆，或哭或笑，神志昏沉，脉滑，舌苔黄腻，证属癔症。良由思虑太过，所求不遂，以致肝气郁结，脾气不运，津液凝聚成痰，痰邪上逆，神明失常使然，亦即《六科准绳》所谓：“癔病，俗谓之失心风多因抑郁不遂”所致。

治以开郁化痰，宁心安神为主，乃宗《席弘赋》所谓：

“人中治癔功最高，十三鬼穴不须饶”的明训，随取十三鬼穴，即人中、上星、承浆、颊车、风府、少商、大陵、劳宫、曲池、隐白、申脉、舌下中缝，会阴（女针玉门头），并加间使、后溪等穴，每次选用六穴，予以强刺激，留针30分钟，每日针刺一次。经针一次后，仍叫骂，不得眠。经针二次后，能睡眠2小时，醒后精神仍然失常，但笑泣比以前减少。经针四次后，神识较清，已不哭笑。经针五次后，睡眠可达7小时，神志清楚，饮食亦增。经针六次后，精神已正常，诸症消失，食欲佳，而告痊愈。

（肖少卿医案）

315. 郁××，女25岁，农民。于1956年8月16日初诊。

自诉：于十四年前，因战乱惊吓，而致精神失常。起初如呆如痴，因高声喧哗，则惶惶失措，全身颤抖，惊恐骇叫，举发无度。近五年来更加不避亲疏，或笑或哭，蓬头垢面，秽洁不知，曾服中药并经西医治疗无效。

查：体格中等，营养不良，蓬头垢面，行动无常，疑神

疑鬼，胡言乱语，不思饮食，脉象弦细，舌苔微腻，证属癲症。良由惊伤心，恐伤肾，心肾失主，则神志不清而成斯疾。

治以宁心安神，醒脑益智为主。方用扁鹊与孙真人所运用的十三鬼穴，分为两组处方：

(1)人中、上星、承浆、大陵、曲池、申脉、后溪；

(2)风府、颊车、舌下中缝、间使、少商、隐白、会阴（女针玉门头）。

以上两组穴位，每日选用一组，交替使用，施强刺激法，留针半小时。经针一次后，未见效果，或哭或笑依然，神志昏瞢如故。第二次复诊施术留针时，患者即熟睡20分钟但回家又发作两次。第三次复诊时，即按照孙真人十三鬼穴的操作程序进行施术，乃取人中、少商、隐白、大陵、申脉、风府、颊车、承浆、间使、上星、玉门头、曲池、舌下中缝针之，此次施术时患者又熟睡一时许，回家后仅于黄昏时有片刻的轻度笑骂，但已不需用绳捆绑。自随其母前来诊治，神志较清楚。第四次施术同上，针后神志清晰，精神静，自觉针后疲劳，时欲嗜睡，饮食益增，唯间有头昏现象。第五次即改用上述第一方，针后头昏已觉轻松，饮食大增，经水亦通，谈笑自如，宛如常人。第六次选用第二方，针后精神恢复正常，全部症状消失，睡眠8小时，食欲佳，表情愉快而愈。

按：“十三鬼穴”是主治癲、狂症的重要穴位，为春秋战国时期的扁鹊所创。迨至于唐·孙思邈（时人尊称为孙真人）又在此穴的基础上，“更加间使、后溪尤妙”。共计十五穴，这些俞穴，已成为历代医家主治癲狂症的主要处方。其中取人中、风府、上星、后溪诸穴，以泻督脉之阳邪而醒

脑清神；取手厥阴经之原穴大陵、经穴间使，以泻心包络之火邪而宁心益智；取手、足阳明经之曲池、颊车，以疏导阳明之经而通腑泄热；取手、足太阴经之井穴少商、隐白，以清肺健脾而化痰浊；更取任脉之承浆、会阴，以宣通阴脉之海而滋阴降火；独取舌下中缝（舌者心之苗），以泄心经之火邪而开窍清神。如此诸穴合用，共奏开窍化痰，醒脑清神，宁心益智之效。故癫、狂之症，取用“十三鬼穴”，辄获良效。

（肖少卿医案）

316. 王××，男，28岁。于1969年5月16日初诊。

自诉：患者于两年前因受刺激后精神失常，曾经××医学院诊治未获显效，现仍不识亲人，少卧不饥，时而喜笑好乐，妄行不休，甚则登高而歌，弃衣而走。

查：脉象弦数，舌质偏红，苔黄而腻。证属狂证。由情志抑郁，肝胆火炽，痰浊交阻，扰乱神明所致。

治以清热化痰，醒脑安神。针取水沟、风府、大椎、太冲、间使、神门、中脘，丰隆。均用强刺激泻法。

复诊：5月18日，前日针后，精神躁动渐见平静，惟夜间恼怒间作，不能入睡，仍宗原法治疗。前方加四神聪、心俞、太溪。

三诊：5月20日，针治二次后，神识渐清，狂躁已定，夜寐较酣，今日能协作，唯觉头昏神疲，胃纳呆滞，治宜疏肝和胃，宁心安神，原方去丰隆，加印堂、肝俞、胃俞。

四诊：5月22日，针治三次后，神志清晰，睡眠甚佳，食欲亦振。上方既效，效不更方，再予进治，以巩固之。共针四次，而告痊愈。

按：《内经》云：重阳则狂。本症由精神受刺激之后，

郁而化火，兼夹痰浊，上扰神明所致，故取水沟、风府、大椎，以泻督脉之阳邪而醒脑，取太冲、中脘、丰隆，以疏肝和胃而化痰，配间使、神门、心俞、太溪诸穴，以交通心肾，而安神益智。上穴共用，以奏清热化痰，醒脑安神之功。

(肖少卿医案)

317. 张××，女，24岁，职员。

一向夜寐不深，两周前因情志不遂，精神忧郁，连续失眠，导致情绪不宁，近四五天又出现表情淡漠，行动迟钝，终日呆坐，自言自语，不思饮食，不知秽洁，苔白脉滑，曾于××医院诊断为：精神分裂症。因服药后效果不显，故来针灸治疗。

病因所求不遂，思虑太过，气郁生痰，痰迷心窍所致。

处方：神门(双)，间使(双)，肝俞(双)，脾俞(双)。

操作：概用平补平泻手法，每穴行针1～2分钟。第一次针后，患者当夜睡眠转好，次日自言自语减少，至第三次针后，神志转清。以后改为隔日针治一次，共针10次而获痊愈。

按：精神分裂症按其临床表现，属祖国医学“癫症”的范畴，究其发病原因，主要是由思虑太过，所求不遂，以致肝气郁滞，脾气失运，痰浊上逆，神明失常而成，由于证现虚实兼有，故法用“平补平泻”，取肝俞、脾俞，疏肝运脾以化痰浊，神门、间使疏通心经与包络经气，以开心窍而苏神明。

(楼百层医案)

邪 祟(4则)

318. 一贵人妻为鬼所著^[1]，百法不效。有一法师，书天医

符^{〔2〕}奏玉帝，亦不效。余令服睡圣散^{〔3〕}三钱，灸巨阙穴五十壮，又灸石门穴三百壮，至二百壮，病人开眼如故，服姜附汤，镇心丹五日而愈。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕著：缠身。

〔2〕符：指道士用来“驱鬼召神”或“治病延年”的秘密文书。

〔3〕睡圣散：麻醉药。主要成分为山茄花和火麻花，难忍艾火灸痛者，服此即昏睡不知痛。

按 怪诞之疾，古人往往归之于鬼邪作祟。世上本无鬼邪，天医符岂能为力。本案以穴测病，患者当本元虚损，或病后虚脱所致。用艾灸丹田（按：石门穴别名）者，所以补阳，阳生则阴长故也。灸巨阙重在治神，取丹田乃重在补阳，所服镇心丹、姜附汤，其意亦然。

319. 一妇人病虚劳，真气将脱，为鬼所着。余用大艾火灸关元，彼难忍痛，乃令服睡圣散三钱，复灸至一百五十壮而醒，又服又灸，至三百壮，鬼邪去，劳病亦瘥。

（《扁鹊心书》）

320. 朱丹溪治一妇人如痴，或作或辍，恍惚不省人事。一日略醒，诊视忽闻床上有香气，继又无所知识^{〔1〕}。朱曰：气因血虚，亦从而虚，邪因虚入，理或有之。遂以秦承祖灸鬼法^{〔2〕}灸治，病者哀告曰：我自去，我自去，即愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕知识：知觉意识。

〔2〕秦承祖灸鬼法：并患者两手大指，用软丝缚定，着艾柱，半在甲上，半在肉上，四处尽着，灸三壮。

321. 乙亥^{〔1〕}岁，通州^{〔2〕}李户候夫人患怪病，予用孙真人治

邪十三针之法^{〔3〕}。问病者是何邪为害？对曰：乃某日至某处，鸡精之为害也。令其速去。病者对曰：吾疾愈矣，怪邪已去。言语遂正，精神复旧，以见十三针之有验也。

（《针灸大成》）

注

〔1〕乙亥：明·万历三年（公元1575年）。

〔2〕通州：州名，今北京市通县。

〔3〕孙真人治邪十三针之法，指《千金方》所载用来治疗癫等症的十三个经验效穴。认为其病由于鬼邪作祟，故穴以鬼名，亦称十三鬼穴。即人中、少商、隐白、大陵、申脉、风府、颊车、承浆、劳宫、上星、曲池、舌下中缝和男子的阴下缝或女子的玉门头。

郁 证（4则）

322. 执中母氏久病，忽泣涕不可禁，知是心病也。灸百会而愈。执中凡遇忧愁凄怆，亦必灸此，有此疾者，不可不之信也。

（《针灸资生经》）

323. 景佑元年^{〔1〕}，仁宗不豫^{〔2〕}，侍医数进药不效，人心忧恐，冀国^{〔3〕}大长公主荐希^{〔4〕}，希诊曰：“针心下包络之间亟愈。”左右争以为不可。诸黄门^{〔5〕}祈以身试，试之无所害，遂以针进而帝疾愈。

（《宋史·许希传》）

注

〔1〕景佑元年：即公元1034年。

〔2〕不豫：不快乐，不安适。

〔3〕冀国：古国名。在今山西河津。

〔4〕希：指许希，宋代医生。开封人。擅长针灸。

(5)黄门，指宦官。汉代给事内廷有黄门令、中黄门诸官，皆以宦者充任，故称。

324. 一人功名不遂，神思不乐，饮食渐少，日夜昏默已半年矣，诸医不效，此病药不能治，令灸巨阙百壮，关元二百壮，病减半，令服醇酒，一日三度，一月全安，盖醺酣忘其所慕也。

(《扁鹊心书》)

按 心藏神，神思不乐，当虑其心。日夜昏默，乃阴盛于阳也。灸关元，温阳益气，除阴霾沉郁之气；灸巨阙，清心窍宁神志。并以醉酒陶情，弃其所慕，病竟愈，此公独有之治妙哉。

325. 一人因大恼悲伤得病，昼则安静，夜则烦惋^{〔1〕}，不进食，左手无脉，右手沉细，世医以死证论之。余曰：此肾厥病也，因寒气客脾肾二经，灸中脘五十壮，关元五百壮，每日服金液丹，四神丹，至七日，左手脉生，少顷，大便下青白脓数升许，全安，此由真气大衰，非药能治，惟艾火灸之。

(《扁鹊心书》)

注

〔1〕烦惋，烦闷、惑乱。

肿 胀 (9 则)

326. 水肿惟得针水沟，若针余穴，水尽即死，此《明堂》、《铜人》所戒也。庸医多为人针水分，杀人多矣，若其他穴，亦有针得差者，特幸焉耳，不可为法也。或用药，禹余粮丸为第一，予屡见人服验，故书于此。然灸水分，则最为要穴也。

(《针灸资生经》)

327. 有里医^{〔1〕}为李生治水肿，以药饮之，久之不效。以受其延待之勤，一日忽为灸水分与气海穴，翌早观面如削矣。信乎水分之能治水肿也。《明堂》固云若是水病，灸大良，盖以此穴能分水，不使妄行云焉耳。但不知《明堂》又云针四分者，岂治其他病当针四分耶。

(《针灸资生经》)

注

〔1〕里医：指当地村医。

按 水液运行，全赖肺气通调、脾气输布、肾气蒸化、三焦决渎、膀胱气化而小便通利、水气畅行。若三焦气化失职，气机不利，水液壅滞肌肤，遂成水肿。本案以气海助阳化气，用水分分利水邪，气行则水行，水行则肿消，故灸水分、气海治疗水肿，遂为后世效法。

328. 一人秋冬患肿，午前上甚，午后不甚，口渴乏力，脉涩弱，食减。此气怯，汗不能出，郁而为痿。遂灸肺俞、大椎、合谷、水分；用葛根、苏叶、白术、木通、海金沙、大腹皮、茯苓、厚朴、陈皮、黄芩、甘草渐愈。

(《夷坚志》)

按 风寒外袭，致使肺气不宜，脾失输布，遂成肿证。灸肺俞者，意在宣肺散寒；取大椎、合谷，共具清热发汗，使在表之水得以汗解；水分属任脉，通调水道，使在里之水下输膀胱。表里分消，立竿见影。

329. 一妇人，遍身浮肿，露地而坐。余曰：何不在门内坐？妇曰：昨日蒙土地告我，明日有扁鹊过比，可求治病，我故于此候之。余曰：汝若听我，我当救汝。妇曰：汝非医人，安能治病？余曰：我虽非医，然得扁鹊真传，有奇方，故神

預告汝，遂与保命延寿丹十粒服之，夜间小便约去二升，五更觉饥，二次又服十五粒，点左命关穴，灸二百壮，五日后，大便下白脓五七块，半月全安。

（《扁鹊心书》）

330.一人遍身赤肿如锥刺。余曰：汝病易治，令灸心俞、肺俞四穴，各一百壮。服胡麻散^{〔1〕}二料而愈。但手足微不随，复灸前穴五十壮，又服胡麻散二料，全愈。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕胡麻散：方用紫背浮萍（七月半采）、黑芝麻、薄荷、牛蒡子（炒）、甘草（炒）。其为末。每服三钱，茶酒任下，日三服。治筋风，浑身顽麻，或如针刺，遍身疼痛，手足瘫痪。

按 色赤属心属血。取肺俞祛风宣肺，调理气机；心俞通血脉而散瘀，故赤肿得消，疼痛得止，手足得利。

331.余^{〔1〕}自许昌遭金狄^{〔2〕}之难，忧劳艰难，冲冒寒暑，过此东下。丁未^{〔3〕}八月，抵泗滨^{〔4〕}，感痲症。既至琴川^{〔5〕}，为医妄治，荣卫衰耗，明年^{〔6〕}春末，尚苦肘肿^{〔7〕}，腹胀，气促，不能食，而大便利，身重足痿，杖而后起。得陈了翁家专灸膏肓俞，自丁亥至癸巳^{〔8〕}，积三百壮。灸之次日，既胸中气平，肿胀俱损^{〔9〕}，利止而食进。甲午^{〔10〕}已能肩舆出谒，后再报^{〔11〕}之，仍得百壮，自是疾症浸^{〔12〕}减，以至康宁。时亲旧间见此殊功，灸者数人，宿痼^{〔13〕}皆除。孙真人谓：若能用心方便，求得其穴而灸之，无疾不愈，信不虚也。

（《灸膏肓俞穴法·跋》）

注

〔1〕余：作者庄綽，宋代针灸医家。清源（今山西清徐）人。字季裕。

〔2〕金狄：指来自北方的入侵者金兵。

〔3〕丁未：即建兴六年（公元1127年）。

〔4〕酒滨：泗水之滨。

〔5〕琴川：江苏常熟别称。

〔6〕明年：次年。

〔7〕肿胀：臃，音义同浮。肌肤臃肿曰臃肿。

〔8〕丁亥至癸巳：以干支记日，前后计6天。

〔9〕损：消。

〔10〕甲午：指癸日的第二天。

〔11〕报：报灸，分次重复灸的方法，灸一次算一次。

〔12〕浸：渐也；稍也。

〔13〕宿病：陈年久病。

332.一人因饮冷酒，吃生菜，成泄泻，服寒凉药反伤脾气，致腹胀，命灸关元三百壮，当日小便长，有下气，又服保元丹一斤，十日即愈。再服全真丹，永不发矣。

（《扁鹊心书》）

按 恣食生冷，损伤脾胃，更服寒凉之品，损伤益甚。水湿内生，气机失和，以致脘腹胀满，在所不免。灸关元，可除寒湿阴冷，调元散邪，分清别浊。故湿邪得比，气机得和，当日气下胀消，亦属意料之中。

333.范郎中夫人，中统五年^{〔1〕}八月二十日，先因劳役，饮食失节，加之忧思气结，病心腹胀满，旦食则呕，暮不能食，两胁刺痛，诊其脉弦而细。黄帝针经《五乱》篇云：清气在阴，浊气在阳，乱于胸中，是以大惋。《内经》曰：清气在下则生飧泄，浊气在上，则生腹胀，此阴阳反作病之逆以也。至夜，浊阴之气当降不降，膜胀尤甚。又云：脏寒生满病。大抵阳主运化精微，聚而不散，故为胀满。先灸中脘穴乃胃之募，引胃中生发之气上行，次以此方（温中益气汤）助之。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕中统五年：即公元1264年。

334.三原民荀氏妇者，病虫胀，诸医束手，气已绝矣。逾二鼓忽苏，家人惊喜。问之，曰：适已出门，若将远行者，途遇一老人云：吾已延孙思邈真人医汝，速返也。及入门，见真人已先在，年可三十许，以连环针针心窝上，久之遂醒，不可身之已死也，视之果有上下二孔，八日始合，又十一年而终。

（《续名医类案》）

按 本案假唐代名医孙思邈之名，道出针灸在急救时的作用。但非真是孙思邈之为治也，千年古人，焉能为后世之人疗疾哉！

疟 疾（3则）

335.有人患久疟，诸药不效。或〔1〕教之以灸脾俞即愈。更有一人亦久患疟，闻之，亦灸此穴而愈，盖疟多因饮食得之，故灸脾俞作效。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕或：有人。

按 昔云：“无痰不成疟”。认为疟疾发生是由于脾胃虚弱，痰湿内生，复感外邪，遂被疟邪侵入。截疟药中的常山、槟榔、草果等均有化痰湿的作用。本案既为“久疟”，久病必虚，灸脾俞者，既能化痰湿，又能扶正祛邪。

336.一人病疟月余，发热未退，一医与白虎汤，热愈甚。余曰：公病脾气大虚，而服寒凉，恐伤脾胃。病人云：不服凉药，热何时得退？余曰：《内经》云疟之始发，其寒也，烈火不能止；其热也，冰水不能遏。当是时，良工不能措其

手。且扶元气，待其自衰，公元气大虚，服凉剂退火，吾恐热未去，而元气脱矣。因为之灸命关，才五七壮，胁中有气下降，三十壮，全愈。

（《扁鹊心书》）

按 症用白虎，论理未尝不可，然适于湿症，用以清热疏表，加桂枝更佳。本案久症不愈，正不胜邪，因称虚症，用白虎清热泻火，犯虚虚实实之忌，故热愈甚。当用何人饮加减，扶正截症，为其正法。今窦材公为灸命关，接脾脏真气，亦属扶正之治。

337. 会陈下有病症二年不愈者，只服温热之剂，渐至衰羸。命予药之，余见其羸，亦不敢便投寒凉之剂。乃取《内经·刺症论》之曰：“诸症不已，刺十指间出血”。正当发时，余刺其十指出血，血止而寒热亦止。咸骇^{〔1〕}其神。

（《儒门事亲》）

注

〔1〕咸骇：都惊叹。

消 渴（1 则）

338. 一人频饮水而渴不止，余曰：“君病是消渴也，乃脾肺气虚，非内热也。”其人曰：“前服凉药六剂，热虽退而渴不止，觉胸胁气痞而喘”。余曰：“前证止伤脾肺，因凉药复损元气，故不能健运，而水停心下也”。急灸关元、气海各三百壮，服四神丹。六十日，津液复生。方书皆作三焦猛热，下以凉药，杀人甚于刀剑，慎之。

（《扁鹊心书》）

按 消渴成因，多从阴虚内热立论，实不知亦有气虚津

液不布者。《医学纲目》：“肺病则津液无气管摄，精微者亦随洩下，故饮一洩二，亦成消渴。”气虚用凉药，气益虚而阳亦衰，阴损及阳，元气式微。灸关元、气海，意在益气补阳，使命门火复，气化得行，肺津可布也。

多 汗（2则）

339. 一人额上时时汗出，乃肾气虚也，不治则成癆瘵，先灸脐下百壮，服金液丹而愈。

（《扁鹊心书》）

340. 一人每日四五遍出汗，灸关元穴，亦不止。乃房事后，饮冷伤脾气，灸左命关^{〔1〕}百壮而愈。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕命关，即食窦穴。

按 《三因方》曰：“无问昏醒，浸浸自出者，名曰自汗”。多因气虚，阳虚所致。“脾王不受邪”，取食窦，灸关元，亦为扶本之治。

痰 火（2则）

341, 己巳岁^{〔1〕}，蔡都尉^{〔2〕}长子碧川公患痰火，药餌不愈。辱^{〔3〕}钱诚斋堂翁荐予治之，予针肺俞等穴愈。

（《针灸大成》）

注

〔1〕己巳岁：明隆庆三年，即公元1569年。

〔2〕都尉：明代略低于将军的武官。

〔3〕辱，承蒙。

按 《素问·刺热论》：“热病气穴：三椎下间，主胸

中热。”“肺为贮痰之器，”肺俞乃肺之背俞。痰火之疾，针肺俞，清热除痰。

342. 壬申^{〔1〕}夏，户部尚书王疎翁，患痰火炽盛，手臂难伸。予见形体强壮，多是湿痰流注经络之中，针肩髃，疏通手太阴经与手阳明经之湿痰，复灸肺俞穴，以理其本，则痰气可清，而手臂能举矣。至吏部尚书，形体益壮。

（《针灸大成》）

注

〔1〕壬申：明·隆庆六年，即公元1572年。

疔 风^{〔1〕}（2则）

343. 一人病疔证，须眉尽落，面目赤肿，手足悉成疮痍。令灸肺俞、心俞四穴，各十壮，服换骨丹一料，二月全愈，须眉更生。

（《扁鹊心书》）

注

〔1〕疔风：出《素问·风论》。即麻风，又名大风、脉风、大麻风等。

344. 戊寅岁正月，美库使病大风，满面连颈极痒，眉毛已脱落，须以热得治之则微缓，昼夜数次治之，或砭刺^{〔2〕}亦缓。先师曰：脉风者，疔风也，荣卫热附，其气不清，故使鼻柱坏，皮肤色败^{〔2〕}。大风者，风寒客于脉而不去，治之当刺其肿上，以锐针针其处，按出其恶气，肿尽乃止。常食方食，勿食他食^{〔3〕}。宜以补气泻荣汤治之，此药破血散热，升阳去痒泻荣，辛温散之，甘温升之，以行阴阳之经，泻心火，补肺气，乃正治之方。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕砭刺：泛指针刺。

〔2〕荣卫热附……皮肤色败：《素问·风论》原作“病者，有荣气热附，其气不清，故使其鼻柱坏而色败，皮肤疡溃”。附，音义同腐。今风入于脉，内攻于血，瘀血凝滞内不通而外不泄，久则化热，而血腐坏也，以致其气不清，挟风而循经上攻于鼻目，故鼻崩、眉落，目损，皮肤破而溃也。

〔3〕常食方食，勿食他食：指平时常吃的食物可吃，不常吃的食物食用时一定要慎重，特别是一些辛发之物。

按 外卫不固则腠理开疏，风邪入客于皮肤之间，玄府闭封，日久则气有所凝，致使内不得通，外不得泄。蕴而成热，腐败血肉，用锐针针其处，出其恶气，以开其门，如利其户，精气不伤而邪气乃下，功专于祛风活血也。

肾 风（1则）

345. 桑惠民病风，面黑色，畏风不敢出，抓搔不已，眉毛脱落，作^{〔1〕}癩^{〔2〕}医三年。一日，戴人到棠溪，来求治于戴人。戴人曰：非癩也。乃出《素问·风论》曰：肾风^{〔3〕}之状，多汗恶风。脊痛不能正立，其色治^{〔4〕}面庞然浮肿。今公之病，肾风也。宜先刺其面，大出血，其血当如墨色，三刺血变色矣。于是下针，自额上就排针，直至颠顶，皆出血，果如墨色。偏肿处皆针之。惟不针目锐眦外两旁，盖少阳经，此少血多气也。隔日又针之，血色乃紫。二日外又刺，其血色变赤，初针时痒，再刺则额觉痛，三刺其痛不可任，盖邪退而然也。待二十余日，又轻刺一遍方已。每刺必以水洗其面血，十日黑色退，一月面稍赤，三月乃红白。但不服除根下热之药，病再作，戴人在东方，无能治者。（《儒门事亲》）

注

〔1〕作：当作。

〔2〕癰：即痲风，麻风病。

〔3〕肾风：证候名，《素问·风论》肾风之状，多汗恶风，面庞然浮肿，脊痛不能正立，其色焮，隐曲不利，诊在肌上，其色黑”。《素问·奇病论》：“有病庞然如水之状，切脉大紧，身无痛者，形不瘦。不能食，食少……，病生在肾，名为肾风。肾风而不能食，善惊，惊已，心气痿者死”。

〔4〕焮：由烟凝积成的黑灰。

无脉症（1则）

346.叶××，男性，30岁。住院号2778。

患者于1958年3月30日因亚急性心内膜炎入院。持续发热已三星期，用青霉素、链霉素合并治疗，在4月2日突觉恶寒战栗，心跳增快至每分钟120次，当即皮下注射鲁米那0.1克，半小时后，恶寒消失。4月5日，上述症状又发作二次，在发作后约2小时，即觉左上肢发麻剧痛，尤以左肘关节为甚，压迫时加剧。患肢皮色苍白冰冷，肱及桡动脉均不能扪及；当时在右肘部肱动脉分支上下以1%普鲁卡因作局部封闭，疼痛虽略有减轻，但效果不持久。至4月7日，患肢疼痛更剧烈，手指感觉麻木，不能握筷进餐，肱及桡动脉已不能扪及。

4月8日开始用针刺疗法，取穴：少海、通里、神门、曲泽、大陵。上午针刺后，疼痛减轻，肱及桡动脉搏动可扪及，但较弱；中午进餐时，可以握筷。次日按原方再针治一次，针后患肢疼痛完全消失，动作恢复正常，肱及桡动脉搏动又

有好转。在留针时，加以捻旋，脉搏之动更有力。此后改针少海、通里、大陵三穴，留针30分钟，隔日一次，连续针治两星期，以巩固疗效。此后情况良好。

（《方幼全医案》）

儿 科 病 症 (16则)

急、慢惊风 (10则)

347. 一小儿因观神戏^{〔1〕}受惊，时时悲啼，如醉不食，已九十日，危甚。令灸巨阙五十壮，即知人事。曰：适间心上有如火滚下，即好，服镇心丸而愈。

(《扁鹊心书》)

注

〔1〕神戏：鬼戏。

按 惊则气乱，以至心无所依，神无所归，痰涎入客胞络，故昏昏如醉，母病及子，则不思饮食。今取心募巨阙，治其本也。

348. 辛未^{〔1〕}岁，浙抚郭黄崖……公子箕川公长爱，忽患惊风，势甚危笃。灸中冲、印堂、合谷等穴各数十壮，方作声。若依古法而只灸三五壮，岂能得愈？是当量其病势之轻重而已。

(《针灸大成》)

注

〔1〕辛未：明·隆庆五年，即公元1571年。

按 经云：“病有浮沉，刺有浅深”，而灸亦有大小多寡，因病益损，庶无太过不及之虞。设或病沉而灸少，灸火不足，力不胜邪，徒受炮烙；病浮而灸多，灸火太过，则邪

反从之，徒伤皮肉，于病亦无益也。

349.魏敬甫之子四岁，一长老摩顶授记^{〔1〕}，众僧念咒，因而大恐，遂惊搐，痰涎壅塞，目多白睛，项背强急，喉中有声。一时许方省。后每见衣皂^{〔2〕}之人辄发。多服朱、犀、龙、麝镇坠之药，四十余日，前证仍在，又添行步动作神思如痴，命予治之，诊其脉，沉弦而急。《黄帝针经》云心脉满大，器痛筋挛，又肝脉小急，病癰筋挛，盖小儿血气未定，神气尚弱，因而惊恐，神无所依，又动于肝，肝主筋，故病癰筋挛，病久气弱，小儿易为虚实，多服镇坠寒凉之品，复损其气，故行步动作如痴。《内经》云：暴挛痛眩，足不任身，取天柱穴者是也。无柱穴乃是太阳之脉所发，阻痹附而行也。又云：“癰病癰疽，不知所苦，两跷主之，男阳女阴。治古老人云：昼发取阳跷申脉，夜发取阴跷照海，先各灸二七壮。阳跷申脉穴在外踝下容爪甲白肉际陷中，阴跷照海穴在足内踝下陷中是也。次与沉香天麻汤，服三剂而痊愈。

（《卫生宝鉴》）

注

〔1〕摩顶受记：佛教出家时在头部做的一种标记。

〔2〕衣皂：皂衣，即黑色的衣服。

350.万密斋^{〔1〕}治一儿，四岁，病惊痰涌，针其涌泉穴而醒，自后不发。谓曰：未服豁痰之药，恐发痫也。不信。似痰迷，饮食便溺皆不知，时复昏倒，果成痫矣。问其发时能自知乎，曰：“目昏即发。”乃与钱氏安神丸，加胆草服之。教其父曰，病将发时急掐两手合谷。如此调理，一月而安。

（《续名医类案》）

注

〔1〕万密斋：明代医家。罗田县（今湖北省）人。世医出身，为明

代著名儿科医家。在理论上宗钱乙，并有发挥。强调小儿肝常有余，脾常不足的病理特点，治小儿杂证颇具经验。

351.陈自明^{〔1〕}治小儿，昏愤六日不省，惊风发搐，诸药不效，手足尚温。谓其父母曰：吾能活之。与之针涌泉二穴足心，良久而苏，喜而称谢，曰：此病得之伤食、宿食成痰，痰壅作搐，今病虽愈，宿痰未去，恐他日再作，当制丸药以除其根，不然神气渐昏，必成痫也。乃谓为牟利不信，次年八月，果成痰迷之病，二便不知，水火不避，复求治。因治一方，以黄连、山梔泻其浮越之火，胆星、白附子炮以去其壅积之痰，茯神、远志、石菖蒲、朱砂以安其神，麝香以利心窍，用獾猪心中血和神曲糊为丸如黍米大，灯心汤下，调理半年，不复发矣。又与之灸风池、曲池，（手）三里六穴而安。

（《续名医类案》）

注

〔1〕陈自明（约1190~1280），宋代名医，字良父，临川（今江西抚州）人。

按 惊风，古时多与痫证混淆。如《千金方》、《外台秘要》等均以惊痫、风痫、食痫命名。宋后立惊风病名，并分急惊风与慢惊风两类。由于惊风的主要症状为强直，痉挛，故有些学者把“痉”和“惊”通用，如《温病条辨》中就有“痉为惊风”之说。近代习惯上将小儿时期的抽搐、痉挛等症状称为惊风。痉挛、抽搐，干系于肝。取涌泉者，不仅可镇惊醒神，亦能滋水涵木。神清风停，诸症悉减，但宿痰未除，终成后患，若能遣中脘、三里、丰隆等穴，健运脾胃，荡涤痰浊，岂不两全？

352.一儿发搐，五日不醒，药石难入。万^{〔1〕}针其三里、合

谷，人中而醒。父母喜曰：吾儿未出痘疹，愿结拜为父，乞调养之。万曰：囊^{〔2〕}用针时，针下无气，此禀赋不足也，如调理数年后出痘，可保无事，若在近年，不敢许。次年果以痘疹死。

（《续名医类案》）

注

〔1〕万：指万密斋。见前。

〔2〕囊（nǎng囊）：从前，以往。

353.万密斋治一小儿二岁，发搐已死，家人痛哭，乃阻之曰：此儿面色未脱，手足未冷，乃气结痰涌而闷绝，非真死也。取艾作小炷，灸两手中冲穴，火方及肉，而醒大哭，父母皆喜。遂用家传治惊方，以雄黄解毒丸十五丸，利其痰；镇惊丸二十五丸，去其热，合之，煎薄荷汤送下，须臾利下痰涎，而搐止矣。

（《续名医类案》）

按 本案起病急骤，症属急惊。此乃“小儿疾之最危者”也。临床上往往痰、热、惊、风四症并见。痰热上涌，蔽于心包，激动肝风，发为神昏、痉厥，然患儿面色未脱、手足不冷，知其阳气尚存，故非真死。中冲乃手厥阴心包井穴，亦为“十宣”之一。灸之可醒神、苏厥，清热镇惊，治其标，然后以豁痰、祛风之剂调治，治其本也。

354.民国十五年，同先父梦琴公在北溷，治一黄氏之子，急惊甚剧，目上视，背反张，四肢牵引，身热不哭，脉浮数，先父为针大椎、人中、曲池、承山等穴，惊搐遂平；余为处散热定搐之剂而愈。余近年来遇此症，俱刺人中、大椎、曲池、中脘等穴，效果甚佳。

（《中国针灸学》）

355, 王××, 女, 6岁, 于1967年6月9日初诊。

代诉: 两天来发热头痛, 今晨呕吐不止, 抽搐数次, 高烧, 项强, 闭目, 腿强直, 时有屈膝, 躁动, 神志不清, 不食不哭, 便干尿黄量少。

查: 脉洪数, 舌红苔黄。经县医院诊为“流脑”, 白细胞36,000/立方毫米, 家长拒绝腰穿, 抱儿归家。晚七时许邀余往诊。观脉证属外感时邪, 阳明里热, 热极灼伤液津, 热动肝风则生。

治本清热熄风为主。穴取: 百会, 大椎, 涌泉, 内庭, 后溪, 申脉, 尺泽(放血数滴), 十宣出血, 脑静, 太冲(重泻)。针后二小时抽搐见止。随后按子午流注纳子法取穴针治, 一夜共针六次, 寅时见哭, 辰时热退, 巳时能进食, 申时能起立行动, 次日痊愈。一年后随访, 患儿聪明伶俐, 至今健康无恙。

按: 此例治验纯系临证所遇, 虽属意外偶拾, 但深知针灸对急症亦有良效, 需有胆有识, 不可贸然行事。此例采清热熄风法获效, 配尺泽放血与脑静穴而加强疗效, 后用纳子法补虚泻实, 使正盛邪衰。仅一昼夜如此重症竟获痊愈。

(费久治医案)

356. 冯鲸川治麻宪许淮江翁女, 二岁。患慢脾风, 余皆为不可救矣, 冯曰: 脾胃亏损, 元气虚弱, 而舌不甚短, 头不甚低, 或有可治。急用附子理中汤, 三四服而少安, 仍灸百会、三里穴, 二十壮而愈。

(《名医类案》)

按 慢脾风, 多由于吐泻过度, 正气虚弱, 出现闭目摇头, 面唇青黯, 神昏嗜睡, 四肢厥冷, 手足搐动等症, 属于慢惊风范畴。主要是脾阴受损, 脾阳衰竭所致。案中用附子

理中汤，功能温阳祛寒，治脾胃虚寒所致诸疾。三里属胃，培中土，资健运，灸之则温补脾胃；百会清神志，苏厥逆，兼可升阳。

脐 风（1则）

357. 枢密^{〔1〕}孙公梓生数日，患脐风不救。家人乃盛以盘盒，将送诸江。道遇老嫗曰：“儿可活”。即与俱归，以艾灸脐下，即活。

（《青箱记》）

注

〔1〕枢密：军机大臣。

痞 疾（1则）

358. 戊辰^{〔1〕}岁，给事^{〔2〕}杨后山公祖^{〔3〕}乃郎，患痞疾，药日服而人日瘦。同科^{〔4〕}郑湘溪公，迎予治之。予曰：此子形羸，虽是痞症，而腹内有积块，附于脾胃之旁，若徒治其痞，而不治其块，是不求其本，而揣^{〔5〕}其末矣。治之之法，宜先取章门灸针，消散积块，后次第理治脾胃，是小人已除，而吾子得行其道于天下矣。果如其言，而针块中，灸章门。再以增蜆丸药兼用之，形体渐盛，痞疾俱痊。

（《针灸大成》）

注

〔1〕戊辰：明·隆庆二年，即公元1568年。

〔2〕给事：即给事中，古代官名。

〔3〕公祖：明代绅士称知府以上的地方官为公祖。

〔4〕同科：科举时代，称同届考中的人为“同科”，多指乡会试。

〔5〕揣：揣摩，推求。

按 《卫生宝鉴》曰：“凡脾胃虚弱，不能克化，致成积聚结块。”积块之因，由乎脾虚，反之，积块之成，又可耗气伤中，虚中挟实，互为因果，积证日久，正虚气耗，痞积诸证蜂起。积块不除则气不可复，故曰：“徒治其痞，而不求其本，而揣其末矣”。于病处下针，可直捣其巢穴；再灸脾募章门，益中气以助行积，积块消散，气机畅通，生化之源自可恢复，不徒治痞，痞证自愈。纵观全案，妙在辨证精当，治病求本；再则用穴精少，却力简效宏，针药俱中其的。

胸 前 突 起（1 则）

359. 壬申岁〔1〕，四川陈相公长孙，患胸前突起，此异疾也。人皆曰：此非药力所能愈。钱诚翁堂尊，推予治之。予曰：此乃痰结肺经而不能疏散，久而愈高，必早针俞府、膻中。后择日针，行六阴之数〔2〕，更〔3〕灸五壮，令贴膏，痰出而平。乃翁编修公甚悦之。

（《针灸大成》）

注

〔1〕壬申岁：明·隆庆六年，即公元1572年。

〔2〕六阴之数：六为偶数，属阴。为针刺补泻法——九六补泻法的泻法。

〔3〕更：再。

按 昔云：“导痰必行顺气，”“理气而痰自消，”意谓治痰重在于气也。今痰在肺而治之于肾，盖肺为气之主，肾为气之根，肺肾同源也。故《玉龙歌》曰：“俞府、乳根

一样刺，气喘风痰渐渐磨。”膻中乃气之会穴，行气益气之功独擅，两穴合用，气调而痰除也。

赤 丹（3则）

360. 张子和治黄氏小儿面赤肿，两目不开，以铍针^{〔1〕}刺轻砭之，除两目尖外，乱刺数十针，出血乃愈，此法人多不肯从，必治病不可谨护。

（《续名医类案》）

注

〔1〕铍针：又称披针。古九针之一。

按 丹毒发于头面部，重者称“大头瘟”，轻者称“抱头火丹”。多为天行邪热疫毒之气或风热之邪化为火毒而成。子和用铍针刺血，使火毒邪热随血外泄，而达清热解毒之目的。此属针灸正治之法。

361. 一小儿遍身皆赤，砭之，投解毒药而愈。

（《保婴撮要》）

362. 一小儿腿上患之（胎毒发丹），神思如故，乳食如常，余谓毒发于肌表，令急砭出毒血自愈。不信。外敷寒凉，内服峻剂，腹胀不乳而死。

（《保婴撮要》）

按 此丹毒也。多因热毒炽盛，客于血分，郁于肌肤而致。砭刺出血，旨在去“恶血”，泻热毒，也偶“菟陈则除之”之意。

妇 科 病 症（24则）

痛 经（2 则）

363.（李东恒治）一妇，年三十余，因每洗浴后，必用冷水淋通身，又尝大惊，遂患经来时必先小腹大痛，口吐涎水。经行后又吐水三日，其痛又倍，至六七日经水止时方住，百药不效。诊其脉，寸滑大而弦，关尺皆弦大急，尺小于关，关小于寸，所谓前大后小也。遂用香附三两，半夏二两，茯苓、黄芩各一两半，枳实、元胡索、牡丹皮、人参、当归、白术、桃仁各一两，黄连七钱，川楝、远志、甘草各半两，肉桂三钱，吴茱萸钱半。分十五帖，入姜汁两蚬壳，热服之。后用热汤洗浴，得微汗乃已，忌当风坐卧，手足见水，并吃生冷。服三十帖全愈。半年后因惊忧其痛复举，腰腹时痛，小便淋痛，心惕惕惊悸，意其表已解，病独在里。先为灸少冲、劳宫、昆仑、三阴交，止悸定痛，次用桃仁承气汤大下之。下后用醋香附、醋蓬术、当归身各一两半，醋三棱、元胡索、醋大黄、醋青皮、青木香、茴香、滑石、木通、桃仁各一两，乌药、甘草、砂仁、槟榔、苦楝各半两，木香、吴茱萸各二钱，分作二十帖。入新取牛膝湿者二钱，生姜五片，用荷叶汤煎，愈。

（《名医类案》）

364. 李××，女，15岁，1965年9月23日急诊。

昨夜月经来临，量少色暗，少腹隐痛。今晨起少腹剧痛，喜热喜按，痛苦颜脸，其色晄白，四肢欠温，畏寒。脉弦细带紧，苔薄白。证系阴寒凝滞冲任，治拟温壮督阳，以消冲任阴寒，取从阳治阴之理。

处方：哑门、风府、下脑户、风池（双）。

操作：银温针灸七壮。即时收效，腹痛缓解，四肢转温。

按：此乃阳气式微，阴寒内盛，寒凝血滞胞宫，经水艰以畅流。施以银温针灸，温壮督阳，疏通冲任，消阴寒，散凝滞，气血调和，其病自愈矣。

（华廷龄医案）

崩 漏（2则）

365. 己卯^{〔1〕}岁，行人张靖宸公夫人，崩不止，身热骨痛，烦躁病笃^{〔2〕}，召予诊，得六脉数而止，必是外感，误用凉药。与羌活汤热退，余疾渐可。但元气难复，后灸膏肓、三里而愈。凡医之用药，须凭脉理，若外感误作内伤，实实虚虚，损不足而益有余，其不夭灭人生也，几希？

（《针灸大成》）

注

〔1〕己卯：明万历七年，即公元1579年。

366. 李××，女，31岁，职工。

自诉：平素身体尚健，17岁月经初潮后，经量常偏多，每次持续7～8天。今月经已持续半月，开始月量较多，以后乃淋漓不断，并伴有倦怠无力，少气懒言，食欲不振，头晕眼花。

查：面色微黄，心烦不安，多梦，二便调，舌淡苔少，

脉细数。经妇科诊断为功能性子宫出血，经服药疗效不显，随即邀予诊治，观其脉证皆属虚象，因肝不藏血，而脾又失统摄，故经水淋漓不断，所属漏症。

治以清热健脾而止血。乃针刺合谷以清热调气，刺阴陵泉以健脾调中，刺三阴交以滋阴养肝健脾而止血，每日一针。合谷针刺得气后令针感顺经传至膝腿部。首次针后症状如故，血量未减，惟觉体力稍增，再次针后血量即见显著减少而血色变成淡黄色，三针之后经血即止，他症亦除。

按：此例经漏，乃由脾不统血，肝不藏血，致使月水淋漓不断，持续半月。由于日久，脾虚则面淡黄，肢倦矣，肝郁则心烦夜寐不宁。治取三阴交调健脾气，使统血有权以止漏，刺脾之合穴阴陵泉以健脾气。

（张善忱医案）

带 下（1则）

367.有妇人患赤白带，林亲得予针灸经，初为灸气海穴未效。次日，为灸带脉穴，有鬼附患身云：昨日灸亦好，只灸我未著；今灸着我，我今去矣。可为酒食祭我。其家如其言祭之，其病如失，此实事也。予初怪其事，因思晋景公膏肓之病，盖有二鬼焉，以其虚劳甚矣，鬼得乘虚而居之，今此妇人之疾，亦有鬼者，岂其用心而虚损，故有此疾，鬼亦乘虚居之。灸既着穴，其鬼不得不去，虽不祭之可也。自此有祟冤灸者，每为之按此穴，莫不应手酸疼，予知是正穴也。令归灸之，无有不愈。……若更灸百会尤佳，此疾多因用心使然故也。

（《针灸资生经》）

按 鬼邪附身，纯属荒诞之说。瑜穴岂是藏鬼之所？艾灸何属驱鬼之术？灸穴之功，焉能为“鬼”说所蒙，读者当有所辨析。

阴 部 瘙 痒（2 则）

368，张××，女，53岁，×公司会计。门诊日期：1978年10月24日初诊。

主诉：绝经3年后，白带多，外阴及阴道瘙痒难忍，坐卧不宁，已缠绵年余，精神疲倦乏力，头晕目眩，腰酸，口干不欲饮，纳呆，便溏，舌淡红苔薄，脉细弦。

体检：外阴经产式，阴道粘膜潮红，白带多，色淡，宫颈光滑，宫体平位正常，附件（一）。

化验：查白带未发现霉菌和滴虫。

辨证：脾虚湿盛，肝郁化热，湿热下注。

治则：清肝泻热，健脾渗湿。

取穴：曲池、少府、三阴交、血海。

手法：快速进针，留针20分钟，每10分钟行捻针术一次，同上法治疗3次，症状完全消失，后随访未复发。

369，芦××，女，24岁，已婚，工人。门诊日期：1978年10月19日就诊。

主诉：外阴及阴道严重瘙痒已半年。曾用中西药外洗，但效果不显，灼热瘙痒，甚则夜寐难眠；带下微黄，偶夹血样，腰酸乏力，小便黄，五心烦热，头晕目眩，口干欲饮，舌红少苔，脉细弦数。

体检：阴道口大量块状白带，粘膜泛红。

化验：白带未发现滴虫和霉菌。

辨证：肝肾阴虚，湿毒乘虚内侵，带下量多。

治则：滋阴降火，调补肝肾，渗湿止痒。

取穴：左侧少府、三阴交、血海。

手法：快速进针，留针30分钟，10分钟行捻针术一次。

二诊：1978年10月20日。

体检：阴道口块状白带未减少。痒感减轻。针刺双侧三阴交、曲池、少府、血海。

三诊：1978年10月21日。

自诉自昨日针后，痒消失，白带已无。巩固疗效，再同法针刺一次，已痊愈，后随访未有复发。

按：外阴瘙痒症，在临床上以滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎和外阴白斑为多。如《女科经纶》徐春甫云：“妇人阴痒，多属虫蚀所为，始因湿热不已”。《医宗金鉴·妇科心法要诀》云“妇人阴痒，多因湿热生虫”。

上两例，例一属年老体弱，脾虚湿盛，肝郁化火，精血双亏，血虚生风燥，致令阴痒。例二属肝肾阴虚，精血两亏，血虚生风燥，则阴部干涩，灼热瘙痒。肾虚带脉失约，任脉不固，阴虚生内热，则带下色黄，甚则血样。总之，此例阴虚阳亢，以致五心烦热，头晕、耳鸣。故宜滋阴降火，调补肝肾。

方用曲池为大肠经合穴，走而不守，擅能宣气行血，凡气血阻滞之病皆能舒畅而调和之，又有化腐生肌之功。三阴交为肝、脾、肾三脏三交会穴，其在补脾之中，兼补肝肾、肾阳，独取气血双补之功。血海为脾经穴，脾统血、主肌肉，用来统血充养肌肉，是治疗湿热之要穴，主治生疮痒痛，红肿化脓，月经不调。少府属于少阴心经，主治胸痛，心绞痛，心悸，心律不齐，又有止痒之功。

（周德宜医案）

热入血室（1则）

370. 一妇人患热入血室证，医者不识，用补血调气血药，涵养数日，遂成血结胸。或劝用前药^{〔1〕}。予曰：小柴胡用已迟，不可行也，无已，则有一焉，刺期门穴斯何矣。予不能针，请善针者治之。如言而愈。或问曰：热入血室，何为而成结胸也？予曰：邪气传入经络，与正气相搏，上下流行，或遇经水适来适断，邪气乘虚而入血室，血为邪迫，上入肝经，肝受邪则谵语而见鬼，复入膈中，则血结于胸也。何以言之？妇人平居^{〔2〕}，水当养于木，血当养于肝也。方未受孕，则下行之以为月水。既妊娠，则中畜之以养胎，及已产则上壅之以为乳，皆血也。今邪逐血，并归肝经，聚于膈中，结于乳下，故手触之则痛，非汤剂可及，故当刺期门也。

（《普济本事方》）

注

〔1〕前药：指小柴胡汤加生地黄。

〔2〕平居：平时，平常。

按 用刺期门治妇人“热入血室，”首见仲景《伤寒论》。本案因误治转为血结胸，瘀热聚于胸胁，邪陷既深，正不胜邪。治疗上既不宜发表，和解也无济于事，因此，必求于针法。刺期门者，可开结泄热，逐水消痰。

脱 脬（1则）

371. 舒氏云：曾医一妇人腹中急痛，恶寒厥逆，呕而下利，脉见微涩。予以四逆汤投之，无效。其夫告曰：昨夜依然作

泄无度，然多空坐，醉^{〔1〕}胀异常。尤可奇者，前阴醉出一物，大如袖子，想是尿脬^{〔2〕}。老妇尚可生乎？予即商之仲远，仲远踌躇曰：是证不可温其下以逼迫其阴，当用灸法温其上以升其阳，而病自愈。予然其言而依其法，用生姜一片贴头顶百会穴上，灸艾火三壮，其脬即收；仍服四逆汤加芪、术，一剂而愈。

（《伤寒论今释》）

注

〔1〕醉：同瘁。醉胀，是指腹部胀坠。

〔2〕尿脬：即膀胱。

按 此为伤寒少阴与太阴同病。以四逆汤温阴，驱散下焦少阴、太阴之寒气；灸百会以升下陷之阳，故能取得一剂而愈也。

难 产（8则）

372. 尝诣舒^{〔1〕}之^{〔2〕}桐城^{〔3〕}，有民家妇孕将产，七日而子不下，百术无所效。安时^{〔4〕}之弟子李百全适在旁舍，邀安时往视之，才见即连呼不死，令其家人以汤温其腰腹，自为上下拊^{〔5〕}摩，孕者觉肠胃微痛，呻吟间生一男子，其家惊喜而不知所以然。安时曰：儿已出胞，而一手误执母肠，不复能脱，故非符药所能为，吾隔腹扪儿手所在，针其虎口，既痛即缩手，所以遽^{〔6〕}生，无他术也。取儿视之，右手寸口针痕存焉，其妙如此。

（《宋史·庞安时传》）

注

〔1〕舒：指安徽舒城。

〔2〕之：犹“与”。和。《左传·文公十一年》：“皇父之二子

死焉。”

〔3〕桐城：地名。今属安徽。

〔4〕安时：指庞安时，字安常。蕲州蕲水（今湖北浠水）人。北宋著名医家。

〔5〕搯：同“抚”。或作击，拍。

〔6〕遽：（jù音据）遂；就。《淮南子·人间训》：“堦有万穴，塞其一，鱼何遽无由出？室有百户闭其一，盗何遽无从入？”或作急；骤然。《左传·僖公二十四年》：“公遽见之。”

373. 供奉官郭垣在母胎，年余不育。有善针人针百余，竟亦不动。至二十二月生，子母俱安，惟胸臆中有黑点数十处，乃当日针痕也。

（《珍珠船》）

374. 吴江^{〔1〕}临妇产，胎不下者三日，呼号求死。云^{〔2〕}针刺其（手）心，针出，儿应手下。主人喜问故，曰：此抱心生也。手针痛则舒。取儿掌视之，有针痕。

注

（《明史·凌云传》）

〔1〕吴江：今江苏吴江县。

〔2〕云：指凌云。明代针灸家。字汉章，号卧岩。归安双林（今属浙江）人，精针灸经络，明孝宗赐任太医院御医。

按 以针灸纠正胎位，缩短产程，临床屡试不爽，但多于四肢远端进行。上吴江一案，“针刺其心”，不知何指？据其掌“有针痕”云云，则指掌心无疑。而庞安时则针虎口，两者均在手上。惟《珍珠船》所载一案，与上不同，这位“善针人”竟一鼓作气，重兵压城，连发百余针，终因不得要领，胎儿仍稳坐胞宫，素丝不动，心肠不能说不“狠”。但更狠更毒的则是这位“善针者”，他“网猎诸野，以冀一兔。”试问胎儿各部，岂是随便刺处？特别是胸臆心肺之地，稍有不慎，后果不堪设想，如此胆大妄为，此“善针人”不

誓也。

375. 李洞元^①，唐为医博士。长孙后怀高宗数日不能分娩，洞元诊之，曰：“留子母不全，母全子必死。”后曰：“留子，帝业永昌。”遂刺腹针之，后崩^②，太子即诞。

（《齐东野语》）

注

①李洞元：唐代医生。唐太宗时为医博士。

②崩：古称皇帝死为崩。《礼记·曲礼下》：“天子死曰崩。”此指长孙后死。

376. 李将军妻唐甚，呼佗视脉，曰：“伤娠而胎不去。”将军言：“闻实伤娠，胎已去矣。”佗曰：“案脉，胎未去也。”将军以为不然。佗舍去，妇稍小差。百余日复动，更呼佗，佗曰：“此脉故事有胎。前当生两儿，一儿先出，血出甚多，后儿不及生。母不自觉，旁人亦不寝，不复迎，遂不得生。胎死，血脉不复归，必燥著母脊，故使多背痛。今当与汤，并针一处，此死胎必出。汤针既出，妇痛急如欲生者。佗曰：“此死胎久枯，不能自出，宜使人探之。”果得一死男，手足完具，色黑，长可尺所。

（《三国志·魏书·华佗传》）

377. 陆××，女，26岁，初诊：1978年11月2日。

第一胎足月临产，因素体气血不足，滞产不下，脉弦滑，苔薄白。属原发性宫缩乏力，针前宫口开大仅2厘米，宫缩不规则，与益气温补以下胎。

处方：合谷（补），三阴交（泻），脐中（隔药灸）。

操作：合谷（补），三阴交（泻），间歇动，留针30分钟；用肉桂粉合樟脑少许敷脐中，上贴伤湿止痛膏四层，再用艾条温灸15分钟。

针入后15分钟开始正规宫缩，起针后检查宫口已开大6厘米；再隔15分钟则羊膜破水，腹阵紧，距起针后2小时10分顺利分娩，婴儿体重3450克，母女俱安。

按 初产妇第一产程延长超过30小时为宫缩乏力，又称滞产。滞产往往对产妇和胎儿健康不利，尤其胎儿，如胎心发生变化，造成宫内窒息等危险，必须及时处理。针灸有加强宫缩、催生下胎之功用，且无副作用。早在宋代就有徐文伯补合谷泻三阴交下胎的记载。临床用于因产力不足，宫缩乏力而滞产者确实有效。今又用肉桂粉敷脐，乃宗《沈氏尊生方》下胎用“脱花煎”，方中有肉桂乃温运之意，庶加强催生作用。

378. 曹××，女，30岁。初诊：1978年10月。

第一胎足月临产，因素有胃脘痛史（虚寒型），临产腹痛更不欲食，气虚累累，宫缩乏力，滞产不下，历时一昼夜，宫口仅开5厘米，神色极为疲惫，脉弦滑而细，苔薄白，与益气和胃以下胎。

处方：中脘、足三里、合谷、三阴交。

操作：先针合谷、三阴交，观察15分钟，宫缩仍未加强；继针中脘、足三里，并在中脘加用艾条温灸，顿觉胃脘舒服，中脘起针，孕妇索饮食，与食蛋糕等物，食后10分钟，正规宫缩即开始，共留针45分钟，起针后检查宫口已开大至7厘米，距起针4小时55分顺产，母子俱安，婴儿体重3150克。

按 上例原有脾胃虚寒，中气不足，临产不欲饮食则气更虚、故推送无力而滞产，先针合谷、三阴交无效，继针中脘、足三里而胃脘舒，得食后中气足，宫缩加强，则胎速下。笔者又曾治一滞产孕妇，因胃中感酸，泛泛欲吐，不欲饮食

而宫缩乏力，医嘱作好剖腹产准备，孕妇惧怕，要求先用针刺催生，即与一针阳陵，针入患者即感泛酸顿消，胃脘得舒，而索饮食，食入气足，宫缩不久即转正规，顺利正产而母子俱安，免除了剖腹之苦。

从以上滞产病例，说明辨证施治在针灸治疗的重要性，尤其合谷、三阴交两穴对加强子宫收缩，确有一定作用，曾应用宫缩描记仪客观指标而证实。

（虞孝贞医案）

379.张文仲救妇人横产手先出，诸符药不捷^{〔1〕}，灸妇人右脚小趾尖头^{〔2〕}三壮，炷如小麦大，下火立产。

（《太平圣惠方》）

注

〔1〕捷：胜也。《诗·采芣》：“一月三捷。”或作速解，《荀子·君子》：“则事业捷成而有所休。”

〔2〕右脚小趾尖头：指右脚之至阴穴。独取右侧者，按男左女右之习俗也。

按 妇人横产，灸至阴，旨在纠正胎位，且兼可催产。现代研究表明，艾灸至阴，可增强子宫及宫体内胎儿活动，有利于胎位的转动，也可促使胎儿的娩出，以达转胎、催产的双重目的。

引 产（1则）

380.宋后废帝^{〔1〕}出乐游苑^{〔2〕}门，逢一妇人有娠，帝亦善诊之。曰：“此腹是女也。”问文伯^{〔3〕}曰：“腹有两子，一男一女，男左边青黑，形小于女。”帝性急，便欲使剖。文伯恻^{〔4〕}然曰：“若刀斧恐其变异，请针之，立落。”便泻足太阴

补手阳明，胎便应针而落，两儿相续出，如其言。

（《南史·张融传》）

注

〔1〕宋后废帝：宋指南北朝时刘宋，后废帝是刘昱。

〔2〕苑：古代养禽兽，植林木的地方（多指帝王的花园）。

〔3〕文伯：南北朝时期南齐医家。出身世医。撰有《药方》、《疗妇人瘕》等书。

〔4〕惻：惻隐之心、怜悯。

按 《针灸大成》曰：“……后世道以三阴交、合谷为妊妇禁针，然文伯泻三阴交、补合谷而堕胎，今独不可补三阴交、泻合谷而安胎乎？盖三阴交，肾肝脾三脉之交会，主阴血，血当补不当泻；合谷为大肠之原，大肠为肺之腑，主气，当泻不当补，文伯泻三阴交、以补合谷，是血衰气旺也。今补三阴交，泻合谷，是血旺气衰矣”。故刘元宾亦曰：“血衰气旺定无妊，血旺气衰亦有体。”杨公之论，颇寓深意。然近代实验研究，多支持前说。所以合谷、三阴交保胎之说，有待深入研讨。

产 后 昏 厥（4 则）

381. 一妇人产后发昏，二目滞涩，面上发麻，牙关紧急，二手拘挛。余曰：此胃气闭也，胃脉挟口环唇，出于齿缝，故见此证。令灸中脘穴五十壮，即日而愈。

（《扁鹊心书》）

按 此产后血厥也。病及胃脉。《灵枢·五味》曰：“胃者，五藏六府之海也，五藏六府皆禀气于胃。”胃为六府之首，中脘乃腑之会、胃之募也。健脾胃，益中气，气行血运，何惧病之不复也。

382.己巳⁽¹⁾岁夏，文选李渐庵公祖夫人，患产后血厥，两足忽肿大如股，甚危急。徐、何二堂尊召予视之，诊其脉芤而歇止，此必得之产后恶露未尽，兼风邪所乘，阴阳邪正激搏，是以厥逆，不知人事，下体肿痛，病势虽危，针足三阴经，可以无虞。果如其言，针行饭顷而苏，肿痛立消矣。

(《针灸大成》)

注

(1)己巳，明隆庆三年，即公元1569年。

383.有贵人内子⁽¹⁾，产后暴卒，急呼其母为办后事。母至，为灸会阴、三阴交各数壮而苏。母盖名医女也。

(《针灸资生经》)

注

(1)内子：妻子。古时人之妻，已之妻都可称为内子。或指古代卿大夫的嫡妻。

按 此属产后血晕。故灸此二穴乃愈。

384.丹溪⁽¹⁾治一妇，面白、形长、心郁，半夜生产，侵晨⁽²⁾晕厥，急灸气海十五壮而苏，后以参、朮等药，服两月而安。

(《名医类案》)

注

(1)丹溪：即朱丹溪。

(2)侵晨：即凌晨。

产 中 假 死 (1 则)

385.丁毅⁽¹⁾，明·江浦人，字德刚，路逢疾者，棺下流血，毅熟视之，曰：“此生人⁽²⁾血也。”止舁者⁽³⁾，欲启之，

丧家不之信。毅随至墓所，强使启棺，乃孕妇也。诊之，以针刺其胸。俄而产一儿，妇亦旋苏。

（《江宁府志》）

注

〔1〕丁毅：明代针灸家。江浦（今属江苏）人。

〔2〕生人：活人。

〔3〕舁（yú）者：舁，抬。抬抬棺之人。

按 医者司人生命，不可玩忽。虽不能强生死人，更不能死生人也。德刚察血决人死生，果如其言。知其术之精，心之仁也。

产 后 风（1则）

386. 薛立斋治一产妇，患虚极生风。或用诸补剂，四肢逆冷，自汗，泄泻，肠鸣，腹痛。薛以阳气虚寒，用六君子，姜附各加至五钱，不应，以参附各一两始应。良久不应，仍肠鸣腹痛。后灸关元百余壮，及服十全大补汤方效。

（《续名医类案》）

外科病症（79则）

瘰癧（10则）

387. 有同舍项上患瘰^{〔1〕}，人教用忍冬草研细，酒与水煎服。以滓傅^{〔2〕}而愈。次年复生，用前药不效，以艾灸之^{〔3〕}而除根，有小儿耳后生瘰，用药傅不效，亦灸之而愈云。

（《针灸资生经》）

注

〔1〕瘰：即瘰癧，病名。出《灵枢·寒热》，又名鼠瘻、老鼠疮、瘰子颈等。小的为瘰，大的为癧。

〔2〕傅：通敷。

〔3〕以艾灸之：原文指隔蒜灸。法以独头蒜截两头留心，作艾炷如蒜大小，贴瘰子上灸之。勿令之破肉，但取热而已。七壮一易蒜，日日灸之，待瘰消止。

388. 钱塘王氏女生瘰癧，环头及腋凡十九窍^{〔1〕}，窍破白溜^{〔2〕}出，将死矣。汉卿为剔窍，贯深二寸，其余烙以火，数日结痂愈。

（《明史·周汉卿传》）

注

〔1〕窍：指孔道。此处指瘰癧被割而形成的瘻道。

〔2〕溜：《辞海》曰：“汁也”，释文：“北土呼汁为溜”。此处的“白溜”即流出的稀薄淡白色脓液。

按 瘰癧的外治之法，莫捷于火针、艾灸。火针有温阳

通络，活血化滞，软坚散结之功。且方法简便而疗效确实。例二结核已溃，久不收口，流出稀薄脓汁，危及生命。周汉卿施以烙法，破坏窦道，引流外出而挽危难。例一属瘰癧初发，以酒煎忍冬藤服之小愈，翌年复发，诸药罔效。而用艾攻其外，拔引蕴毒，疏通经气，以使邪去正复。

389. 缪仲淳治朱文学瘰患癧，为灸肩井、肘尖两穴各数壮而愈。

（《续名医类案》）

390. 灸瘰癧，以手仰置肩上，微举肘，取肘骨尖上是穴。随所患处，左即灸左，右即灸右。艾炷如小箸头许，三壮即愈。复作即再灸如前，不过三次，永绝根本。先倅汤寿资宰钟离，有一小鬢病疮已破，传此法于本州一漕官，早灸，晚间脓水已干，凡两灸遂无恙。后屡以治人皆验。骆安之妻患四五年，疮痂如田螺屨不破退。辰时著艾，申后即落，所感颇深。凡三作三灸遂除安矣。

（《续名医类案》）

391. 己巳⁽¹⁾岁，尚书王西翁乃爰，颈项患核肿痛，药不愈，召予问其故？曰：项颈之疾，自有各经原络并俞会合之处。取其原穴以刺之。后果刺，随针而愈，更灸数壮，永不见发，大抵颈项，乃横肉之地，经脉会聚之所，凡有核肿，非吉兆也。若不究其根，以灸刺之，则流窜之势，理所必致矣。患者慎之。

（《针灸大成》）

注

（1）己巳：明·嘉庆三年，即公元1569年。

392. 薛立斋治一男子，神劳多怒，颈肿一块，久而不消，诸药不应。以八珍汤加柴胡、香附，每日更隔蒜灸数壮，及

日饮远志酒二、三盏而渐消。

(《续名医类案》)

393. 一男子患此症(指瘰癧), 肿硬不作脓, 脉弦而数, 以小柴胡汤兼神效瓜蒌散各数剂及隔蒜灸数次, 月余而消。

(《续名医类案》)

394. 一男子患面肿硬, 久不消, 亦不作脓, 服散坚败毒药, 不应。令灸肘尖^{〔1〕}、肩尖^{〔2〕}二穴, 更服益气养荣汤, 月余而消。一男子面硬, 亦灸前穴, 饮前汤, 脓成, 针之而敛。

(《外科发源》)

注

〔1〕肘尖: 经外奇穴, 见《备急灸法》。位于尺骨鹰嘴突起之尖端。主治瘰癧、疔疮、疔疮等。

〔2〕肩尖: 经穴肩井之别名。见《外科枢要》。

395. 抑休祖者善卜筮^{〔1〕}, 其妻病鼠瘤^{〔2〕}积年不差, 垂命。休祖遂卜, 得颈之, 复按卦合得姓石人治之, 当获鼠而愈也。既而乡里有奴姓石, 能治此病, 遂灸鼠头上三处, 觉佳, 俄有一鼠逗前而伏呼犬咋之。视鼠头有三灸处, 妻遂差。

(《拾遗记》)

注

〔1〕卜筮: 古时占卜, 用龟甲称卜, 用蓍草称筮, 合称卜筮。

〔2〕鼠瘤: 即鼠瘻, 瘰癧之又名, 即现代所称之颈腋部的淋巴结结核。

按 文似兼荒诞, 但艾灸治疗瘰癧, 却可确信, 不必因文而疑。

396. 张××, 男性, 17岁。门诊号: 12278。

左颈项瘰癧急性发作, 引起高热, 肿块直径1.5厘米, 白

细胞13800,嗜中性85%,自外科转入针灸科试治。患者神情烦闷,两脉弦滑,苔薄白。根据当时病情,结合脉苔分析,初步诊断为少阳风热与厥阴郁火互结而成瘰癧,决定针取手足少阳之会穴医风、肩井,运用泻法久留针,以疏风热而散郁火;再温针瘰癧、劳瘵的经验奇穴百劳,以起散结通络之功效,针灸8次时,颈项间的肿块显著软化和缩小,两个疗程(每个疗程针灸12次)时,肿块完全消失无迹。

(陈慰苍医案)

瘰 (1则)

397.永明中虏中童谣云:“黑水流北,赤水入齐。”寻而京师人家忽生火,赤于常火,热小微,贵贱争取以治病,法以火灸桃板七炷,七日皆差,敕禁之不能断。京师有病婴者,以火灸数日而差。邻人笑曰:“病偶自差,岂火能为?”此人便觉颐间痒,明日瘰患如故。

(《南齐书·五行志》)

胶 瘤 (1则)

398.一女子未嫁,年十八。两手背皆有瘤,一类鸡距,一类角丸,腕不能钏。向明望之,如桃胶然。夫家欲弃之。戴人见之曰:在手背为胶瘤,在面者为粉瘤,此胶瘤也。以钜针十字刺破,按出黄胶脓三两匙,立平。瘤核更不再作,婚事复成。

(《儒门事亲》)

破 伤 风（1则）

399. 一人因拔鬚⁽¹⁾一茎，忽微肿起不食。有友人询余，余曰：此破伤风也。速灸为妙。疡医认作鬚疔，治以寒凉，不数日发痉而死。

（《医林指月》）

注

（1）鬚（^ㄅ资）：髭上须也。

按 此症所患甚微，殆害甚大，虽仅毛孔之伤，足以毙人。其治宜早，迟则不救，慎之。

痈 疽（17则）

喉 内 痈（1则）

400. 李王女公主患喉内痈数日，痈肿饮食不下。才召到医官，言须针刀开，方得溃破。公主闻用针刀，大哭不肯治。痈逼，水谷不入。忽有一草泽医人曰：“某不使针刀，只用笔头蘸药痈上，霎时便溃。”公主喜，遂令治之。方两次上药，遂溃出脓血一盂余，便宽，两日，疮无事。遂酬谢补官。令供其方，医者乃请罪云：“某乃以针系笔心中，轻轻划破其溃散尔，别无方。言医者意也，以意取效尔。”

（《历代名医蒙求》）

乳 痈（4则）

401. 一妇人久郁，右乳内肿硬，用八珍汤加远志、贝母、

柴胡、青皮及隔蒜灸，兼服神效瓜蒌散^{〔1〕}，两月余而消。

（《女科撮要》）

注

〔1〕神效瓜蒌散：方名。出明·龚廷贤《寿世保元》。方用括萎、酒当归、甘草、乳香、没药组成，共为粗末，酒煎服。《疡医大全》亦载此方，较之少乳香一药，余同。

按 乳痈是乳房部急性化脓性疾病。乳部的经络分布，乳头属肝，乳房属胃。《内经》云：“食气入胃，散精于肝”。肝为血脏，功能贮藏和调节全身的血量，肝以阴血为主，以气为用，体阴而用阳，故其性喜柔恶刚。若久郁其中，郁闷所遏，肝失疏泄，脾失健运，胃失和降，痰浊内生，蕴久化热，以致气血凝结，阻塞经络，发为乳痈也。《医宗金鉴·外科心法》总结此证，认为多由“肝气郁结，胃热壅滞而成”。故治疗急宜隔蒜灸之，使其开结拔毒，移深居浅，并投以药饵，内外兼施。对于痈肿之证，古之治法，重在艾灸。故有“灸法贵于早施，如证起二三日即灸，十证可全八九，四五日灸者，十证可全六七，六七日灸者，十证可全四五，愈早愈妙”。（《医宗金鉴·外科心法要诀·痈疽治法》）

402. 一妇人因怒，左乳作痛发热，表散太过，肿热益甚，用益气养荣汤，数剂热止脓成，不从用针，肿胀热渴，针脓大泄，仍以前汤，月余始愈。此症若脓成未破，有薄皮剥起者，用代针之剂，其脓自出。不若及时用针，不致大溃。若脓血未尽，辄用生肌，反助其邪。慎之！

（《女科撮要》）

403. 一妇人脓成胀痛，余欲针之，不从，数日始针，出败脓三四碗许，虚症蜂起，几至危殆，用大补两月余而安。若

元气虚弱，不作脓者，用益气养荣汤补之，脓成即针。若肿痛寒热，怠惰食少，或至夜热甚，用补中益气汤兼逍遥散，补之为善。

（《女科撮要》）

404. 周××，女，30岁，已婚，旅馆服务员。1962年12月12日初诊。

主诉及病史：右侧乳房已肿胀疼痛1周。开始于产后第七天，恶寒发热、周身不适，四肢疲惫，即觉右侧乳房发胀、乳汁不畅，继之渐趋红赤焮热。曾去某医院外科治疗，诊断为急性乳腺炎。经用抗生素及中草药治疗，未能控制病情，遂来针灸治疗。

体温38.9℃，面赤，右乳房肿胀，焮热红赤，右3～4肋乳中线处有3×5厘米之硬结，乳头之前下方有2.5×5厘米之硬块，触之质硬，局部压痛，尚无波动感。乳头有皲裂可见。脉象弦数、舌质淡红、舌苔黄腻。

辨证施治：

明由阳明湿热内蕴、少阳郁热化火，而热毒自成。属乳痈之症。治宜清热解毒、化痰散结。

治疗经过：12月12日上午初诊。

处方与操作：少泽、商阳（三棱针点刺出血），曲池、足三里（均双），肩井、极泉（均右），膻中，施透天凉手法。留针40分钟，留针期间重复手法二次。

12月12日下午二诊：体温降至38℃，已不觉恶寒，乳房胀感已减。脉象弦紧，舌苔黄腻，再按上方之意去足三里加刺患侧期门为治。

12月13日上午三诊：体温37.6℃，偶有乳汁溢出，乳房胀痛感大减，述昨日下午起，乳房出现凉感，有时右侧半身

亦有凉意，局部红肿基本消退，乳上之硬结缩小为 2×4 厘米，质稍软，乳下之肿块缩小为 2.5×3.5 厘米，患部压痛逐减，精神好转。惟大便已数日未解。脉弦滑、舌淡、苔薄白中黄。再拟清解兼通腑气为治。取肩井、期门（均右）、少泽三棱针出血，曲池、上巨虚、支沟（均双），透天凉手法，留针35分钟。

12月13日下午四诊：体温 37.3°C ，上午诊后有肠鸣、大便已下，自觉精神大为好转，食欲增进。针曲池（双）、肩井（右），均行泻法，足三里、膻中行平补平泻法。

12月15日五诊：体温 37°C ，乳房已无胀痛感，乳上之硬结已缩小为 1.5×2 厘米，乳下之肿块也缩小为 2×2 厘米，且按之质软。脉弦、舌苔薄黄。湿热渐解，此恙已为好转之象。针曲池、上巨虚（双）、肩井（右），施泻法，膻中施平补平泻法。

12月16日六诊：体温正常，乳上之硬块已基本消失、乳下之肿块缩小为 0.5×1 厘米，压之基本不痛，乳房肤色正常，脉转平和，舌苔薄白。治宜和营通络，巩固疗效，并嘱其隔日复诊。取足三里、曲池（均双）、膻中、肩井（右），施平补平泻手法。

12月18日七诊：肿块业已消失，诸症悉除，乳痛已愈矣。

按 急性乳腺炎，祖国医学称“乳痈”。本病常罹患于产后2至6周的哺乳期，初产妇尤为多见。其病因病机，多由于情志失调，肝郁不舒，导致乳汁壅滞；或因产后饮食不节、过食厚味，阳明蕴热，聚而成块，发为“乳痈”。本案乃由上述原因，加之乳头皲裂、邪毒经此侵及乳络，气血运行失畅，故病来势急骤。查乳房为足阳明经所过，乳头为足厥阴经所属，治疗时采用手阳明大肠经之合穴曲池，具有疏导

阳明积热功能,为清热解毒之要穴;三棱针点刺少泽、商阳等穴,以增强清泄邪热、行气止痛的效应;肩井为手少阳、足少阳、足阳明与阳维脉之会,加刺期门、极泉,以理气疏肝、清阳明、少阳之郁热;取足三里以健胃醒脾利湿;支沟、上巨虚以导滞通便;膻中为气会,治以宽胸理气,疏通乳络,消肿散结。

本案病之初起,乃属急症、热症,应首重标治,故概用泻法,且每日二诊以截断病势的逆转;随着病情的转机,治法亦当随症而异,可见辨证施治的意义,临床不可忽视。

(杨橘良医案)

肠 痛 (2 则)

405. 义乌^{〔1〕}陈氏子腹有块,扪之如罍^{〔2〕}。汉卿曰:“此肠痛也”。用大针灼而刺之,入三寸许,脓随针进出有声,愈。

(《明史·周汉卿传》)

注

〔1〕义乌:今浙江义乌县。

〔2〕罍(yíng英):《说文》笺注:“缶器之大者”,即大腹小口的瓶子。此处形容瘤肿状。

406. 唐××,男,32岁,社员,门诊号8123。

自诉:今早饭后因事急促远行后,即感小腹不适,当时未加注意,午后腹痛增剧,以右侧为甚,并伴发热,当阵痛发作时腹部如绞如钻,恶心,呕吐两次,吐出食物残渣及粘黄液,腹痛难忍,抬送门诊。

查:面呈急性病容,神情怠倦,蜷右足侧卧于床上,频

频呻吟，体温 38.5°C ，巩膜、皮肤无黄染，心肺正常，腹肌微紧，肝脾未触及，肠鸣音存在，右上腹（脐与髂前上棘连线外2/3处）拒按，未扪及包块，反跳痛及腰大肌征阳性，双下肢上巨虚穴压痛明显，大便二日未解，小便短赤，苔黄腻，脉滑数。血象：白细胞总数 1.6 万/立方毫米。分类：分叶核 85% 、淋巴细胞 10% 。

治疗根据：病始自饱饭后远途促走，腹痛初现脐周，继移右下腹，並伴发热，恶心，呕吐，相当于腹结穴及上巨虚穴压痛明显，白细胞总数及分叶核增高，此为肠络颠动过甚受伤，致使瘀血凝滞而成肠痈，属实证热型。

治以血散瘀，清热止痛为主。取穴本“经络所过，主治所在”及“以痛为俞”的原则，并适当随症配穴，针用泻刺久留。早晚针刺一次，待病情缓解后每日或隔日针一次。

一诊：针取天枢、上巨虚以疏通阴阳气血，刺曲池以泻大肠经瘀热，内关以开胸止呕。

刺法：双侧天枢穴用斜刺（针尖向下腹痛区），得气后多捻不提插，待针感向下腹痛区扩散后，则刺上巨虚（有针感后针尖转向上，循逆时针方向捻转，使针感向大腿及腹部扩散），可同时用提插操作法，增强针感，继取内关、曲池，各穴均按电针仪“疏密波”通电，腹痛缓解后留针2小时。

当进针至有适当针感后，患者阵发性腹痛顿减，继用电针仪通电30分钟，病人呻吟停，恶心止，渐而安静入睡。

当日晚二诊：神情尚疲乏，但痛苦病容已失，诉经下午针刺后阵发性腹部阵痛明显减少，尚感胀痛，思食，无呕吐，腹、足压痛点压痛减轻，体温下降至 38°C ，小便量较多，大便未解，苔薄黄腻，脉滑数。刺后阳明经气稍疏通，故腹痛

改善，体温下降，上法合度，仍按前法，去内关。

翌日三诊：精神明显好转，诉经昨晚第二次针刺后，腹部除微胀痛及偶现阵痛外，绞痛剧痛已消失，口干若减，大便已解，小便淡黄，体温 37.4°C ，腹柔，上巨虚穴及腹部压痛，反跳痛继续改善，苔淡黄，脉稍数。复查白细胞总数 1.2 万/立方毫米。分类：分叶核 75% ，淋巴 22% ，其他 3% 。

阳明气机得疏通，肠络瘀热渐散，但脉尚数，苔淡黄，乃肠络瘀热未清，泻刺足三里、腹结，留针 2 小时。

四诊：神气清爽，腹痛大减，除起坐时右腹感胀痛外，静止时腹痛不明显，口干渴缓解，右下腹及上巨虚穴轻度压痛，体温 37.2°C ，苔薄黄润，脉缓。取穴：上巨虚，留针 1 小时，右耳大肠点埋针。

第三日五诊：神情愉快，病容消失，诉右腹痛基本消失，下床步行无明显不适，胃纳二便正常，腹、足压痛点残存，体温 37°C ，苔薄润，脉缓。复检白细胞总数 9000 /立方毫米。分类：分叶核 70% 、淋巴细胞 25% 、其他 5% 。

针刺后阳明气机通畅，肠络瘀血消散，通则不痛，故腹痛止，脉静身凉，病势已去，采用平补平泻针法刺足三里、三阴交，增强受纳与运化功能。减为每日针刺一次，每次留针 30 分钟。

六诊：腹痛缓解，步行无不适，胃纳佳，体温正常，右下腹及上巨虚穴压痛消失，脉缓，苔薄润。复检白细胞总数 7600 /立方毫米。分类：分叶核 65% ，淋巴细胞 32% ，其他 3% 。

脏腑阴阳平衡，经络气机和利，肠络瘀血已除，除去耳埋针而终止治疗。经追踪观察月余，病人已能参加正常生产劳动而无不适，病已愈。

按 本例病发于饱饭后远途急促行走，由于肠道过度蠕动，肠络受损伤，引起气机失调，致瘀血凝滞蕴积，聚而成痈，证现腹痛拒按，发热，口渴引饮，脉滑数，苔黄腻，大便秘，小便短赤等一系列实热之象，故治疗主取手、足阳明经穴，泻刺久留，以达行气散瘀，清热止痛之功。

刺上巨虚、天枢、腹结可疏通阳明经气而散肠络之瘀滞，泻曲池以泄热邪，针内关可开胸腕之郁结而止呕，阳明气机能利，肠络蕴积瘀血则可消散，积热得清，通则不通，故诸症得缓，继取足三里，三阴交调和脾胃气机，增强受纳与运动化功能，脏腑阴阳平衡，经络气血调和，病则可愈。

（陈全新医案）

臂 痈（2则）

407. 一男子臂患痈，不作脓。灸以豆豉饼^{〔1〕}，及饮托里药三十余剂而溃，又月余而瘳^{〔2〕}。

（《外科发挥》）

408. 一妇人患臂痈，疮口紫陷，脓清不敛。彼以为毒未尽，欲服攻毒之剂。余谓：疮疡之症，肿起坚硬。脓稠者，实也。肿下软慢，脓稀者，虚也。遂以附子饼^{〔3〕}灸之，及饮十全大补汤百剂始愈。

（《外科发挥》）

注

〔1〕豆豉饼：即隔豆豉饼灸。将淡豆豉研末，用黄酒调制成6毫米厚的薄饼，用细针穿刺数孔，上置艾炷施灸。

〔2〕瘳（cōu抽）：病愈。

〔3〕附子饼：即隔附子饼灸。用生附子3份，肉桂2份，丁香1份，共碾细末，以炼蜜制成6毫米厚的薄饼，用细针穿刺数孔，上置艾炷施灸。

按 痈是发生于皮肉之间的急性化脓性疾患。“营气不从，逆于肉理，乃生痈肿”。痈肿初起，局部疼痛，红硬热肿。热胜肉腐，肉腐脓成。由于邪正相争，正气盛则脓稠证顺；若邪气实或肌肉烂腐，气血津液丢失过多，则脓稀清薄，邪陷内攻，则证情险恶。临床辨证时应谨慎审度，把握治疗时机，以上二例臂痈，其中第一例因“不作脓”用托里之剂内服，鼓舞正气，外用豆豉饼灸之，使其早日成脓，开泄邪毒，脓清症愈。例二为气血虚衰，邪毒欲陷，故用十全大补汤，加附子灸助火回阳，温结散结，调气行血，促使正气来复，而达生肌收口之目的。

腿 痈 （1 则）

409. 一男子，内股患毒，肿硬痛甚，不作脓。隔蒜灸五十余壮，势退七八。以仙方活命饮四剂而脓成；用十宣散六剂，脓溃而愈。凡疮或大痛，或不痛、麻木，灸最良。

（《外科发挥》）

按

宋·陈自明《论科精要》论隔蒜灸得效第五篇云：“治疽之法，灼艾之功胜于用药，盖使毒气外泄。譬诸盗入人家，当开户逐之，不然，则入室为害矣”。及早施用灸法，通过艾火燃烧的温热刺激，以达到活血散结，助阳祛寒，疏通经络，扶持正气，拔引郁毒，开泄腐败，生肌止痛之目的。痛者灸之不痛，不痛者灸至痛觉恢复，此即开门逐寇，治其外，清其内之妙法也。

臀 痈 （1 则）

410. 曹文部文兆，年逾四十，髀^①患毒，已半月余，头

甚多，状如粟许，内痛如癰，饮食不思，怯^{〔2〕}甚，脉歇止。此元气虚，疽畜^{〔3〕}于内也，非灸不可，遂灸二十五壮，以六君子汤加藿香、当归数剂，疮势渐起，内痛顿去，胃脉渐至。但色尚紫，瘀肉不溃，此阳气尚虚也。燃桑柴灸^{〔4〕}之，以补接阳气，解散其毒，仍以前药加参、芪、归、桂，色赤脓稠，瘀肉渐腐，取去，两月余而愈。夫邪气沉伏，真气怯弱，不能起发，须火灸而兼大补，投以常药，待其自溃，鲜有不误者。

（《续名医类案》）

注

〔1〕髀（bì毕）：股部（大腿部）。

〔2〕怯：虚劳血气虚衰，心常恐怯。在此形容脉象虚弱细微，元气虚，不能充营血脉。

〔3〕畜：通蓄。

〔4〕桑柴灸：即桑枝灸，古灸法之一。法用新鲜桑树根或桑树枝，劈如指粗，长约九寸。以一头燃火吹灭，即向患处施灸，火尽再燃再灸。如此复灸3～4次。直至热知、肿溃、肉腐为度。（见《医宗金鉴》）

按 臀部肌肉丰厚，感受邪毒后，疽肿较深，范围也大。脓成后坏死腐肉脱落较多，容易损失体内津液、血肉，以致疮口深坠而形成空腔，收口甚慢。早期可服清热解毒之剂，加艾火灼灸，散结活血，祛瘀拔毒。成脓期，用解毒活血之药，酌加托里之品，亦可并用艾灸，促使脓成。脓成待熟以后，应切开排脓，引毒外出，减少坏腐。本例年逾五八，肾气渐衰，因感邪毒，蕴蒸酿脓，扰乱气机运行，影响后天脾胃吸收，而致化生之源危急。调治以六君补虚健脾，加藿、归等活血理气，并加参、芪、归、桂，托里透脓，扶助正气。局部用桑柴灸，使坚而不溃或溃而不腐，新肉不生，疼

痛不止者，有解毒止痛，消肿散结，助阳生肌之效。诚如薛立斋所言：“夫邪气沉伏，真气怯弱，不能起发，须火灸而兼大补”。

天 疽 （1 则）

411. 立斋曰：“予丙子年^{〔1〕}，忽恶心，大椎骨甚痒，须臾臂不能举，神思甚倦，此天疽危病也”。急隔蒜灸之，痒甚愈，又明灸五十余壮，痒遂止，旬日而愈。《精要》^{〔2〕}云：灸法有回生之功信矣。大凡蒸灸，若未溃则拔引郁毒；已溃则接补阳气，祛散寒邪，疮口自合，其功甚大。其法用大独蒜，切片如三钱厚，贴疽顶上，以艾炷按蒜片上灸之，每三壮一易蒜。若灸时作痛，要灸至不痛，不痛，要灸至痛方止。大概以百壮为度。脓溃则以神异膏贴之，不日而安。一能使疮不开大，二内肉不坏；三疮口易合，见效甚神。丹溪云：椎头为诸阳所聚，艾壮宜小而宜少。

（《续名医类案》）

注

〔1〕丙子年：明·武宗正德十一年，即公元1516年。

〔2〕《精要》：指宋·陈自明编撰的《外科精要》。

心 口 疽 （1 则）

412. 王洪绪曰：井泉疽生于心口，又名慢心锐毒。初起若心口内有块渐大，心口发高，毒陷即死。此医家束手之症，诸书亦无治法。惟余家秘集载，以本人两手十指，以线量以长短，共积其线，在喉管正中处，双环至背脊之中，看两线头尽处为中穴，又以本人之中指中一节，用柴心量准，作一

寸，中穴之左右各远一寸，各以墨记，分立三穴如品字状，每穴用艾灸三大壮，一齐火灸，灸则全愈。

（《续名医类案》）

十

脱 疽 （4 则）

413. 一男子足趾患脱疽，肿焮痛赤，此三阳经虚，而外邪所乘也。用隔蒜灸，人参败毒散加银花、白芷、大黄，二剂而痛甚，又二剂而痛止。又与十宣散加天花粉、金银花，去桂，数剂而愈。又有足趾患之者，色紫不痛，此三阳经热毒壅滞，隔蒜灸五十余壮，又明灸百壮，始痛，投活命饮四剂，更以托里药，溃脱而愈。

（《外科枢要》）

414. 一男子足指患脱疽，大痛，色赤而肿，令隔蒜灸至痛止。以人参败毒散去桔梗，加金银花、白芷、大黄而溃，更以仙方活命饮而愈。此证形势虽小，其恶甚大，须隔蒜灸之。不痛者，宜明灸之，庶得少杀其毒。此证因膏粱厚味，酒面炙博，积毒所致；或不慎房劳，肾水枯竭；或服丹石补药。致有先渴而后患者，有先患而后渴者，皆肾水涸，不能制火故也。初发而色黑者，不治。赤者，水未涸，尚可。若先解其毒，以致肉死色黑者，急斩去之，缓则黑延上，足必死。此患不问肿溃，惟隔蒜灸有效，亦有色赤作痛而自溃者，元气未脱易治。夫至阴之下，血气难到，毒易腐肉，药力又不易达。况所用皆攻痛之药，未免先于肠胃，又不能攻敌其毒。不若隔蒜灸，并割去，最为良法。故孙真人云：“在指则截，在内则割”。即此意也。

（《外科发挥》）

415.一男子患前症(脱疽)，赤痛作渴，此足三阴虚，而火内动。用隔蒜灸，活命饮，三剂而溃；更服托里药，及加减八味丸^{〔1〕}，溃脱而愈。若早用前法，不至于此。

(《外科枢要》)

注

〔1〕加减八味丸：方用山药、桂心、山茱萸、白茯苓、泽泻、五味子、丹皮、熟地黄组成。共研细末，炼蜜为丸。

416.一男子足指患之，色黑不痛，令明灸三十余壮而痛，喜饮食如常。余谓：“急割去之，速服补剂”。彼不信。果延上，遂至不救。

(《外科发挥》)

发 背 (9 则)

417.立斋治张锦衣，年逾四十，患发背，心脉洪数，势危剧。经云：心脉洪数，乃心火炽盛。诸症痒疮疡，皆属心火，心主血，心气滞则血不行，故生痛也。骑竹马灸穴^{〔1〕}，是心脉所由之地，急灸之，以泻心火，隔蒜灸^{〔2〕}以拔其毒，再以托里消毒，果愈。

(《续名医类案》)

注

〔1〕骑竹马灸穴：骑竹马灸法，最早见于南宋闻人耆年编《备急灸法》一书，是治疗痈疽发背的一个有效穴位。其法：先令病人以肘凭几，竖臂腕要直，用篾一条自臂腕中曲处横纹，男左女右，贴肉量起，直至中指指尖尽处截断为则，不量指甲。却用竹杠一根，让病人脱衣，正身骑定，前后用两人扛起，令病者脚不着地，又令二人扶持病者，勿令伛偻。却将前所量臂篾，从坐竹杠处的尾骶骨尽处向上直贴臂量至篾尽处，用墨笔点定，此只是取中，非灸穴也。再用薄篾透患者

中指节，取同身寸一寸为则，就前所点记处向外各量一则，尽处即是灸穴也。若疽发于左则灸右；发于右则灸左，甚则左右皆灸。

〔2〕隔蒜灸：间隔灸之一。用独头大蒜切成3毫米左右薄片，以细针刺数孔，上置艾炷放在疮头上施灸，或把大蒜捣成蒜泥，敷于患处约2~3分厚，置艾施灸。

418. 京师万胜门，剩员王超，忽觉背上如有疮隐起，倩人〔1〕看之，已如盏大，其头无数。或教往梁门里外科金龟儿张家买药，张视嘖眉曰：“此疮甚恶，非药所能治，只有灼艾一法，庶可冀望万分。然恐费力。”乃撮艾与之曰：“且归家试灸疮上，只怕不疼，直待灸疼方可疗耳。”灼火十余，殊不知痛，妻守之而哭。至第十三壮，始大痛，四旁恶肉卷烂，随手坠地，即似稍愈。再诣张谢，张付病敷贴，数数日安，则知痼疽发于背肋，其捷法莫如灸也。

（《医说》）

注

〔1〕倩（qiàn欠）人，倩，意借也，见《方言》：“凡事请人代为之曰倩”。倩人，意为：倩代。（请人代为察看之）。

419. 史源母氏背胛间微痒，视之有赤半寸许，方有白粒如粟黍。乃急著艾灸，其赤随消，二七壮而止。信宿〔1〕，复觉微痛，视之有赤下流长二寸，阔如韭叶。举家皆以前灸为悔〔2〕。或云等慈寺尼智全者，前病疮甚大，得灸而愈。奔问之，全曰：“剧时昏不知，但小师辈言，范八奉议守定灸八百余壮，方苏。约艾一筛耳。”亟归白之〔3〕，见从。始以艾作炷如银杏大，灸其上十数，殊不知痛。乃截四旁赤引，其炷减四之三，皆觉痛，七壮后觉痒。每一壮尽，则赤随缩入。灸至二十余壮，赤晕收退，病者不憚〔4〕。遂以艾作团大灸其上，渐加至鸡黄大，约四十团方觉痛。视火焦处已寸余，盖灸之迟。而初发处肉已坏，坏肉成隔，直至好肉方

痛，四旁知痛，肉未坏也。病者六夜不寐，至是食粥安寝。至晚视之，疮如覆一甑^{〔5〕}，突高三四寸，上有百数小窍^{〔6〕}，色正黑。突然高者，毒气出外而聚也；百数小窍，毒未聚而浮攻肌肤也；色正黑者，皮与肉俱坏也，非灸火出其毒于坏肉之里，则五脏逼矣。

（《续名医类案》）

注

〔1〕信宿：《辞海》谓“再宿曰信，宿犹处也”。

〔2〕悔：后悔，懊悔过去做得不对。

〔3〕亟归白之：亟，急也；白，诉说。此意为急忙返回告诉所打听的事。

〔4〕不憚：憚，怕，畏惧；形容不畏惧或不害怕。

〔5〕甑（zèng赠）：古代做饭的一种瓦器；此处形容疮溃烂的大小。

〔6〕窍：指孔道。

420. 薛立斋治王通府，患背发十余日，势危脉大，先与槐花酒^{〔1〕}二服，杀退其势，更以败毒散二剂，再以托里数剂渐溃。又用桑柴燃灸患处，每日灸良久，仍以膏药贴之，灸至数次，脓溃腐脱，以托里药加白术，陈皮，月余而愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕槐花酒：方名。见《医方摘要》。

421. 刘大尹发背六七日，满背肿痛，势甚危。与隔蒜灸百壮，饮槐花酒二碗，即睡觉。与托里消毒药，十去五六。令以桑枝灸患处而溃，数日愈。凡灸及饮槐花酒，则托里之效甚速。

（《续名医类案》）

422. 王薏^{〔1〕}《发背方·序》云：元祐三年^{〔2〕}夏四月官京

师，疽发于背，召国医治之，逾日势益甚。得徐州肖县人张生^{〔3〕}以艾火加疮上，自旦及暮，凡一百五十壮，知痛方已，明日，撮去黑痂，脓尽溃，肉里皆红，亦不复痛。始别以膏药贴之，日一易焉。易时旋翦去恶烂肉许，疮乃平。是岁秋夏间，京师士大夫^{〔4〕}病疽者七人，余独生。此虽司命自然，固有定数，不知其方，遂致不幸者，以人意论之，可为慨然，于是撰次^{〔5〕}前后所得方，模板^{〔6〕}以施，庶几^{〔7〕}古人济众之意。

（《续名医类案》）

注

〔1〕王蓬：（95渠）宋代医家。

〔2〕元祐三年：北宋哲宗赵煦年号，即公元1088年。

〔3〕徐州肖县人张生：肖县，即今安徽省萧县。张生，生平无考。

〔4〕士大夫：古代有职居官者称士大夫。

〔5〕撰次：编辑整理。次，编排。

〔6〕模板：呆板，不灵活。表示谦辞。

〔7〕庶几：表示希望之意。

423. 一男子，年逾五十，患此（发背），色紫肿痛，外皮将溃，寝食不安，神思甚疲。用桑柴灸患处出黑血，即鼾睡觉，而诸症如失。服仙方活命饮二剂，又灸一次，脓血皆出，更二剂，肿痛大退，又服托里消毒散数剂而敛。夫疮势炽甚，宜用峻剂攻之，但年老血气衰弱，况又发在肌表，若专于攻毒，则胃气先损，反致误事。

（《续名医类案》）

424. 近有一医以治外科得名。有人发背疮大如碗，有数孔，医亦无药可治，只以艾遍敷在疮上，灸之久而方疼，则以疮上皆死肉，故初不觉疼也，旋以药调治之愈，盖出于意

表^①也。

(《针灸资生经》)

注

〔1〕意表：犹言意外。

425. 秋官^①高竹真患之(背痛)，色黯坚硬，重如负石，神志昏愤。遂以蒜杵烂，置疮头，以艾如钱大，灸二十余壮，竟不知。又以蒜随摊黯处，以艾铺蒜上，灸亦不知，乃著肉灸，良久方知，再灸方痛。内用大温补剂而起。

(《名医类案》)

注

〔1〕秋官：古代官名。《明史·安然传》：“明太祖置四辅官，以春、夏、秋、冬为名”。

按 “发背”指疽疔发生的部位。该病属“有头疽”的范畴，亦即现代医学所称的痈。是多个相邻的毛囊和皮脂腺的急性化脓性感染。其特点是初起皮肤上有粟粒样脓头，焮热红肿疼痛，易于向深部及周围扩散，溃后状如蜂窝，肿块范围小如盏，大如碗，甚至大逾盈尺。该病多为外感风温、湿热或恣食膏粱厚味而使湿热火毒内生，凝聚肌表，以致营卫不和，气血凝滞，经络阻隔，发为斯证。若气实者肿多焮痛，气虚者肿处麻痒。其治法，初起“不论虚实，即宜隔蒜艾灸，灸之不应，即就患顶当肉灸之，至知痛为效，以大化小，移深居浅，灸后用针当疮顶点破一孔，随用拔法，务使毒气内外疏通，庶不致内攻”。(《医宗金鉴·外科心法要诀》)。明·虞抟在《医学正传》中指出：“痈疽始发，即以艾多灸之，可使轻浅，骑竹马灸法最妙。盖艾火畅达，拔引郁毒，此从治之意”。由于该病局部损害范围较大，脓量也多，故易于造成体内正气虚衰，而使邪毒内陷，临床上倍须留意调护，内服外治，注意扶助正气，托里攻毒，以防变故。

疮 疡 (6 则)

426. 武昌张启明，述其父治江西商人，背左偏中疮起，根红肿，头白点，痒甚。张取蕲艾隔蒜灸三七壮，愈而不发。此上策也。

(《名医类案》)

427. 一男子疮溃而瘀肉不腐，以参、芪、归、术，峻补气血，更以桑木灸^{〔1〕}之，腐而愈。

(《外科发挥》)

注

〔1〕桑木灸：以桑枝为施灸材料，点燃后，吹熄明火，灸患处。多用来治疗阴疮、瘰癧、流注、膝疮、恶疮久而不愈诸证。本证发背不起，属阳气虚弱，故瘀肉不溃，可每日三五次直接烧灼患处。若腐肉溃去，促其生新，宜灸四旁。

428. 皇祐中学究任道，腿间患一疮，始发赤肿，复绝便变黑，后穴则有黄水出，四边浮浆起，累治不瘥。医王通看之，此疮狭长，似鱼脐下疮也。遂以大针针四向并中，随针有紫赤水汁出如豆汁。言此一因风毒蕴结而成；二因久坐血气凝涩而至；三因食肉有人汗落其间也。道曰：某素好读书而久坐，此疾数岁前，夏月道中，买猪肺味水饭，疑似人肉，食已后得此疾也。通曰：于误食人汗不远矣。以一异味散用鸡子清调敷其疮，日三易^{〔1〕}，数日得愈。

(《名医类案》)

注

〔1〕日三易：一日更换三次。

429. 一男子脓熟不溃，予欲针之，补以托里。彼不信，乃

服攻毒药，乃致恶心少食，始稍而用针。更以六君子汤，加藿香、当归四剂，稍可；再以加味十全大补汤，数剂而敛。凡疮脓熟，不行针，脓毒侵蚀，轻者难疗，重者不治。老弱之人，或偏僻之处，及紧要之所，若一有脓，宜急针之，更以托里，庶无变证。

（《外科发挥》）

430.薛己治四明屠寿卿，孟夏^{〔1〕}，当门齿如有所击，痛不可忍，脉洪大而弦。薛曰：“弦洪相搏，欲发疮毒也。”先用清胃散^{〔2〕}加白芷、金银花、连翘一剂，痛即止。至晚鼻上发一疮，面肿黯痛，更用前药加犀角一剂，肿至两额，口出秽气，脉益大，恶寒内热。此毒炽血瘀，药力不能骤敌^{〔3〕}。乃数砭^{〔4〕}患处出紫血，服犀角解毒之剂。翌日，肿痛尤甚。又砭患处与唇上，并刺口内赤脉各出毒血，再服前药，至数剂而愈。若泥尻神^{〔5〕}，不行砭刺或全仗药力，鲜不误矣。

（《名医类案》）

注

〔1〕孟夏：阴历四月曰孟夏，为夏季之首。

〔2〕清胃散：方名。药有归身、黄连、生地黄、丹皮、升麻组成。

〔3〕骤敌：骤，急、疾速。

〔4〕砭（biān 编）：古代用石针扎皮肉治病，曰针砭。后来泛指针刺。

〔5〕尻神：是指发于人体尻部的一种功能，这种功能按九宫的周期，每年影响着人体的一个部位。这种说法认为当尻神某一年在人体的某一部位时，这个部位就要禁刺。

按 本例当门齿如有所击，痛不可忍，属足阳明胃经实火之证。《灵枢·经脉》曰：“胃足阳明之脉，起于鼻，交頞中，旁纳太阳之脉，下循鼻外，入上齿中，还出挟口环

唇、下交承浆……”。由于阳明之脉络于齿龈，胃腑热毒则外现于此，而脉象亦出现洪大而弦。洪属阳脉，在时应夏，洪大有力，多由营络大热，血气燔灼。所以，薛氏参合脉证，预卜既发疮毒，并投清胃散加清热解毒之品抑制胃经之热。由于邪盛正实，两相搏击，病势乃进，故脉益大。为速解其毒，化险为夷，宗《灵枢》“宛陈则除之”之意，刺络出血，泻热解毒，消肿止痛，内服外治，针药并进，收效捷速。

431. 张姓男孩，14岁，患千日疮（俗名竖头肉）自右手指上起，延及手背肘臂，甚至面颊颈项等部大小合计不下四五百颗，其中小者占绝多数，满布皮肤表面，中者如绿豆大小，为数甚少，而其中有一颗特大，直径约一厘米，用数种药水涂搽无效。余即施以灸术，先在该手上曲池穴、外关穴、支正穴，各灸七壮；继则在最大之一颗顶上灸三壮，其色不变，乃继灸三壮，见疮略有点紫黑色，其四围色赤，乃再灸三壮，共计九壮，疮面全变黑色。三天后复诊，见此大疮已落去，疮根深入肉内约一厘米，余即用灸疮膏九张，命彼每日换一张，待九天后，疮已收口，又一星期，所有全身千日疮患，不待灸治已完全解决，亦奇矣哉！

（党波平医案）

漏 疮（1则）

432. 京师^{〔1〕}董煜，年逾四十，胸患疮成漏，日出脓粒^{〔2〕}许，喜饮食如常，以十全大补汤加贝母、远志、白薇、续断。灸以附子饼^{〔3〕}，脓渐少，谨调之，岁余而愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕京师：国都。此处指明朝京都南京。

〔2〕梳：通“碗。”《辞海》谓“同盂，小盂也。”

〔3〕附子饼：即隔附子饼灸，间接灸法之一。将附子切细研末，以黄酒调和作饼，约2~8分厚，放在穴位上，饼上置艾柱灸之。

按 疮已成漏，脓出不止，此正伤邪实，精血亏损。内服十全大补汤，补虚扶正；外施附子饼灸，温肾助阳，使之气血充盈，正复邪克，逐瘀生新，去腐收敛。更用贝母、远志、白菰、续断以化痰浊，泻火散结。因此，《外科精义》提醒说：“凡属疡医，不可一日无托里之法”。但在运用中亦应注意使用方法得宜，正实邪盛之时，不可施用，免犯实实之戒。

杨 梅 疮（2 则）

433. 一男子患杨梅疮〔1〕后，两腿一臂各溃二寸许，一穴脓水淋漓，少食不睡，久而不愈。以八珍汤加枣仁、茯神服之。每日以蒜捣涂患处，灸之良久，遂贴膏药数日稍可，却〔2〕用豆豉饼灸之，更服十全大补汤而愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕杨梅疮：又名霉疮、广疮、时疮、棉花疮。即梅毒。

〔2〕却：还也。却用即还用之意。

434. 一男子（杨梅疮）愈后，腿肿一块，久而溃烂不敛。以蒜捣烂，敷患处，用艾隔蒜灸之；更贴神异膏〔1〕，及服黑丸子并托里药，两月而愈。

（《外科发挥》）

注

〔1〕神异膏：方用露蜂房、蛇蜕、玄参、黄耆、男子发、杏仁、黄丹、真麻油等组成。依法熬制成膏，治痛疽毒甚效，为痈疡中之第一药也。

按 遗毒内串，久不收口，以致气血败坏，正气亏损，无力敛邪。施之以灸，扶正助元，调血和脉，借蒜之解毒，拔引郁毒，逐瘀布新，驱邪外出。

疔（10则）

435. 一男子患疔作痒，恶心呕吐，时发昏乱，脉浮数。明灸〔1〕二十余壮始痛。以夺命丹一服，肿始起。更用神异膏，及荆防败毒散而愈。

（《外科发挥》）

注

〔1〕明灸：即直接灸。见明·汪机《外科理例·灸法总论》。

436. 一老妇手大指患疔，为人针破出鲜血，手背俱肿，半体皆痛，神志昏愤五日矣。用活命饮，始知痛在手，疮势虽恶，不宜大攻，再用大补剂，又各一剂，外用隔蒜灸，喜此手背赤肿而出毒水，又各一剂，赤肿渐溃，又用托里药而瘥。

（《外科枢要》）

437. 立斋〔1〕治刘贯卿脚面生疔，形虽如粟，其毒甚大，宜峻利之药攻之，因其怯弱，以隔蒜灸五十余壮，痒遂止。再灸片刻，乃知痛，更用膏药封贴，再以人参败毒散，一服渐愈。夫至阴之下，道远位僻，且怯弱之人，用峻利之药，则药力未到，胃气先伤，虚脱之祸，有所不免，不如灸之为

宜。

(《续名医类案》)

注

(1)立斋：即薛立斋。

438. 张所望治理安寺一僧，患手疔走黄，绝水谷者已三日，众莫能治。延所望入视，曰：“毒已入内。奈何？须下一针方可。”因向疮顶刺入寸余，始闻痛声。曰：“生矣。”随之符涂之，复投以丹药数粒，拔其疔根寸许，坚黑如铁，遂愈。

(《钱塘县志》)

439. 都宪张恒山，左足指患之（疔疮），痛不可忍，急隔蒜灸三十余壮，即能行步。欲速愈，或用凉药敷贴，遂致血凝肉死，毒气复炽，再灸百壮，服活命饮，出紫血，毒才得解。脚底通溃，腐筋烂肉甚多，将愈，误用生肌药，反助其毒，元气亏损而不能愈。薛^[1]治以托里药，喜其禀实客处，三月余方愈。大凡疔患于肢节，灸法有回生之功。设投以凉剂，收敛腠理，隧道壅塞，邪气愈甚，多致不起。若毒未尽，骤用生肌，轻者反增溃烂，重者必致危亡。

(《名医类案》)

注

(1)薛：指薛己（立斋）。

440. 一老妇足大指患疔，甚痛。令灸之，彼不从，专服败毒药，致真气虚而邪气愈实，竟至不救。盖败毒散虽能表散疮毒，然而感有表里，所发有轻重，体段有上下，所禀有虚实，岂可一概而用之耶。且至阴之下，药力之所难到，揣假^[1]药力，则缓不及事，不若灸之为良。故下部患疮，皆宜隔蒜灸之。痛则灸至不痛，不痛则灸至痛，若灸之而不痛

者，宜明灸之，及针疔四畔去恶血，以夺命丹一粒入疮头孔内，仍以膏药贴之。若针之不痛，或无血者，以针烧赤，频烙患处，以痛为度。或不痛，眼黑如见火光者，此毒气入脏腑也，不治。若患在手足，红丝攻心腹者，就于丝尽处，刺去恶血，宜服荆防败毒散。若丝近心腹者，宜挑破疮头，去恶水，亦以膏药贴之。如麻木者，服夺命丹。如牙关紧急，或喉内患者，并宜嚥一二丸。凡人暴死，多是疔毒，用灯照看遍身，若有小疮，即是。宜急灸之，俟醒，更服败毒药，或夺命丹。人污入肉，食之则生疔疮，不可不慎！

（《外科发挥》）

注

〔1〕出假：出，单纯，单一；假，通“借”。指单纯借用药物之功。

441. 马氏室忽恶寒作呕，肩臂麻木，手心骚痒，遂瞢^{〔1〕}不自知其故。但手有一泡，此乃患疔毒也。令急灸患处，至五十余壮知痛。投以荆防败毒散而愈。古人谓暴死，多是疔毒。急用灯照遍身，若有小疮，即是此毒。宜急灸其疮，但是胸腹温者可灸。先君云：有人因剥死牛瞢，令看遍身，俱有紫泡，便急灸泡处，良久遂苏，更以败毒药而愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕瞢：瞢（māo茂），形容昏蒙、昏迷。

按 疔疮是发病迅速而危险较大的疾病。如《外科正宗》曰：“夫疔疮者，乃外科迅速之病也。有朝发夕死，随发随死，有三日、五日不死，一月半月而终死”者。对于它的病机又说：“在于毒中之浅深，脏腑之乖逆，节候之寒温，肃杀之瞬息，畜类尸忤，性情激变，暴戾一时，发生立判，

人之气血虚者，各随脏腑而中之。”责其病因，多由恣食膏粱厚味，脏腑蕴热，毒从内发，或由邪毒外感，流窜经络而致。所以，该病范围很广，根据部位不同，常见的有：颜面部的“锁口疔”、“人中疔”、“眉心疔”，该类疔疮毒邪，易于扩散，变化迅速，最易“走黄”。疔发心经，名“火焰疔”；发于肝经，名“紫燕疔”；毒发脾经者名“黄鼓疔”；毒发肺经，名曰“白刃疔”；发于肾经者，为“黑靥疔”。还有手足感染邪毒引起的红丝疔，即现代医学称为“淋巴管炎”的。该证初起红肿热痛，渐发红丝，上攻手肘，令人寒热往来，甚至恶心呕吐等全身症状。治迟者，红丝攻心，常能坏人。由于感染可致腋下或腹股沟淋巴结肿大，压痛。治疗则根据不同情况分别对待。初发必先艾灸，以杀其势，使不侵良肉。针刺之后，疮不作腐，边肿不消，局部可加插药（如夺命丹入疮孔内）并服补托之剂，如有红丝出现，可截丝头刺红络砭除恶血。上述之治，以反面启发后人，在临床上要多加注意，把握病机，严防差谬。诚如《医宗金鉴》所云：“凡治疗证贵乎早，三阴三阳更宜晓，在下宜灸上宜针，速医即愈缓难得”。应提醒的是，凡疔毒俱是火毒而生，忌服辛热之药，恐反助其邪；忌敷寒凉之药，恐逼毒攻里；初溃时，忌用生肌药，恐毒未尽，反增溃烂。生于项以上者，属三阳经，慎用灸或不用灸。赵献可说：“临证之工，更宜详辨，毫厘之差，枉人性命，慎哉慎哉！”

442. 胡××，男，18岁，学生。于1979年6月28日就诊。

患者左足大拇趾外侧剪甲后，破皮感染一周，局部红肿疼痛，已化脓。经市×医院诊为化脓性甲沟炎。建议拔甲治疗，患者不同意而来我科就诊。

治法：(1)点刺阿是穴放出脓液。

(2)针刺取穴：太冲（患侧），三阴交（患侧）。手法：强刺激，不留针。

(3)薰灸法：于放脓、针刺之后，随即用纯艾绒置于长颈薰灸器中点燃，烟薰局部30分钟，灸后包扎即可。每日针刺、薰灸各一次。

二诊：6月29日，患趾红肿消退大半，已无脓性分泌物，疼痛减轻。继用上法治疗。

三诊：6月30，右拇趾红肿消退，已无分泌物，不痛，已痊愈。一月后随访未复发。

443.陈××，女，24岁，学生。于1979年9月20日就诊。

患者左足拇趾外伤后引起甲沟炎已三月余。反复发作，红肿、疼痛，有血性分泌物，嵌甲1.5厘米深。经省×医院诊断为嵌顿性甲沟炎，需拔甲治疗。患者不同意。曾用庆大霉素肌注及口服消炎片治疗三天无效，特来就诊。

治法：(1)剪去嵌甲趾甲。

(2)针刺取穴：行间（患侧），太冲（患侧），三阴交（患侧）。手法：强刺激，不留针。

(3)薰灸法：同上例。每日针刺、薰灸各一次。

二诊：9月21日，来复诊时患趾红肿消退，表面干燥，已不痛。

治法：针刺、薰灸同前。

三诊：9月25日，症状完全消失，已愈。于10月4日复查，患趾完全恢复健康。

444.沈××，男，32岁，工人。于1980年6月10日就诊。

患者于本年6月5日右大拇指被机器压伤，红肿胀痛，于市×医院诊为外伤性甲沟炎。用红霉素、金黄散等药外敷无效，需拔甲。患者不同意，转来针灸科治疗。

治法：(1)针刺取穴：灵台、合谷（患侧），阿是穴为辅。
手法：强刺激，不留针。

(2)放血：肿胀处经严格消毒后，以三棱针点刺放血少许。

(3)薰灸：方法同前。

二诊：6月11日，患处肿胀，疼痛均已消失，仍用前面针刺、薰灸法继续治疗。

三诊：6月12日，症状完全消失，已愈，遂停止治疗。嘱其10日后再来复查。

至期前来，见其健好，未复发。

按 指疔为生于手足指趾之疮痛，其生于甲下者又名代指（趾），临床较为常见。本病位于四末，不但给病人带来生活与工作不便，而且因瘀肿血行不畅，疼痛异常，若经久不愈，可引起骨髓炎。

中医对疮痛之病机，《素问·至真要大论》曰：“诸病痒疮，皆属于心”。因心主血脉，属火，为全身血液运行之总枢纽。机体任何部位之血脉瘀阻滞凝，均可出现红肿疼痛，甚至化脓等症状，均与心脏有关。根据上述中医理论，再结合个人临床实践经验，创用针刺薰灸疗法，疗效极高，收效极快，尤以甲沟炎之西医认为需要拔甲者，改用本法治疗，不仅可免拔甲之苦，且治愈更速。

根据中医对外科疮痛治疗法则，多以活血化瘀、清热解毒为主。指疔生于手（足）指（趾）部，采用阿是穴点刺放血，能泻热毒和改善血行，血脉流通，通则不痛；瘀血得去，则新血自至，可促进愈合。同时根据中医“热因热用”反治法之原理，以艾绒薰灸局部，血得温则行，能起活血化瘀、散热止痛之效。并且艾叶中含有多种化学成份，对金黄色葡萄球菌

有杀灭作用，其烟很可能也有这类功效，所以熏灸是治疗本病的一项重要方法。关于针刺穴位中的灵台穴，《素问刺热篇》中谓其“主脾热”。后世医家又多用以治疗哮喘。但我在临床发现它对上肢疮痍有较好之清热止痛之效。合谷穴，《杂病穴法歌》谓其善治“手指连肩相引痛”。指疗亦常使患肢皆痛，故以此二穴为主。趾疗刺三阴交、行间，激发下肢经气，调节血液循环，能活血化瘀，消肿止痛。考《千金方》谓：“三阴交主足下热，胫痛不能久立”。《杂病穴法歌》曰：“脚膝诸痛寻行间”。故用此二穴为主。根据大量临床实践证明，指（趾）疗应用上述方法治疗，确改善血液循环，加强局部血液流份，提高机体肌肉组织气血供应，促使红肿热痛消散和局部吸收，达到祛瘀生新、通则不痛的治疗目的。

以本法治疗指（趾）疗，病人没有痛苦，又无任何副作用。所以知之者皆乐于接受。治疗时不拔甲，则病变部位损伤少，痊愈快，愈后毫无功能障碍现象，实堪大力推广。

（周德宜医案）

疔（1则）

445. 一省椽^{〔1〕}，背项常有瘰疬，愈而复生。戴人曰：“太阳血有余也。”先令涌泻之，次于委中以铍针出紫血，病更不复作也。

（《儒门事亲》）

注

〔1〕省椽（yuàn院）：椽，古代属官的统称。省椽，指省级属官。

流 注（2则）

446. 一男子胁肿一块，日久不溃，按也微痛，脉微而涩，此形症俱虚也，当补不当泻。乃用人参养荣汤，及热艾熨患处。脓成，以火针刺之，用豆豉饼、十全大补汤，百剂而愈。

（《外科枢要》）

447. 一妇人（患流注）脓溃清稀，脉弱恶寒，久而不愈，服内塞散^{〔1〕}，灸以附子饼而瘳。

（《外科精要》）

注

〔1〕内塞散：方用附子、肉桂、赤小豆、甘草、黄芪、当归、茯苓、白芷、桔梗、川芎、人参、远志、厚朴、防风组成，共研为末。每服二钱。

痰 核（1则）

448. 戊午^{〔1〕}春，鸿臚^{〔2〕}吕小山，患结核^{〔3〕}在臂，大如柿，不红不痛。医云是肿毒。予曰：此是痰核，结于皮里膜外，非药可愈。后针手曲池，行六阴数，更灸二七壮，以通其经气，不数日即平复矣。若作肿毒，用以托里之剂，岂不伤脾胃清纯之气耶。

（《针灸大成》）

注

〔1〕戊午：明·嘉靖二十七年，即公元1558年。

〔2〕鸿臚（16声）：鸿臚寺，明代官署名，主官为鸿臚寺卿。

(3)结核：病名。出自《千金方》，自风火气郁或痰湿气郁聚结而生的肿块。

按 痰核结于皮里膜外，位于臂，属手阳明所过。痰湿阻络，致使气机流通失畅，形成结核。故取该经合穴曲池刺之。手阳明与手太阴互为表里，经气相通，针曲池亦可激发肺经之气，气行则痰行，且其穴属土，合于脏腑，刺激该穴，具有调整脾经经气，加强运化功能，促进痰湿排泄。针行六阴之数，以泻邪实；复加艾灸，以温化痰湿，疏通气机。实是针灸并进，相得益彰也。故《景岳全书》谓“见痰休治痰”，“善治者，治其生痰之源”。

鹤 膝 风（1则）

449. 沈×，女，76岁。

右膝关节酸痛月余，肿胀发热，伸屈不利，得温痛不减，大腿小腿肌肉日削。脉弦细带数，苔腻。年逾古稀，气血已虚，风湿之邪，乘隙内注，郁久有热，经气受阻，流行不畅，络道阻塞，痹阻不通。治拟祛风通络，和气血利关节为法。

处方：右膝关刺^{〔1〕}，阴三阳四^{〔2〕}。

针右膝“关刺”，七次后肿退痛减，伸屈较利，仅留关节酸楚。此邪去正虚，再予上法续治3次，基本痊愈。

注

〔1〕关刺：古刺法。五刺之一。《灵枢·官针》：“关刺者，直刺左右尽筋上，以取筋痹，慎无出血，此肝之应也。或曰渊刺，一曰岂刺”。是指直刺关节周围筋腱附着部的一种刺法。因其刺在关节附近部位，因名。

〔2〕阴三阳四：阴，指内侧面，阳，指外侧面；三、四指针刺的

刺数多少。

按 鹤膝风系膝部肿痛之总称。症见单膝肿大，屈伸不利，有风湿、寒湿、湿热、痰湿等原因。处方以局部为主，一般用两膝眼、两陵泉、委中、鹤顶诸穴治之。病程为有热者较短，痰湿者较长。若梅毒性、结核性及陈伤等则病程更长，缠绵不易愈。针灸疗效颇佳。关刺是常用法，属热者单刺，属寒者加温针，病深而病程已长者可留针较久，约30～40分钟，肿甚者加拔火罐。单侧者易治，双侧者每流走他处关节。其属于外科酿脓已熟者，不宜针灸。

（《杨永璇针灸经验选》）

赘 瘤（3则）

450.一日，魏寿之与戴人入食肆中，见一夫病一瘤，正当目之上纲^{〔1〕}内眦，色如灰李，下垂覆目之睛，不能视物。戴人谓寿之曰：吾不待食熟，立取此瘤。魏未之信也。戴人曰：吾与尔取此瘤何如？其人曰：人皆不敢割。戴人曰：吾不用刀割，别有一术焉。其人从之，乃引入一小室中，令俛^{〔2〕}卧一床，以绳束其肘，刺乳中大出血，先令以手揉其目，瘤上亦刺出雀粪，立平出户，寿之大惊。戴人曰：人之有技，可尽窥乎。

（《儒门事亲》）

注

〔1〕目之上纲：上眼睑。

〔2〕俛：同“俯”。

451.一人眼皮下弦生一小瘤^{〔1〕}，初如米粒，渐大如豆。用攒针三四枚^{〔2〕}，翻转眼皮，刺其内膜，少少出血，如此二

三次，其瘤日缩，竟得尽消。

（《续名医类案》）

注

〔1〕瘤：此处指皮肤赘生物而言。

〔2〕攒针三四枚：攒，聚也。这里指将三四枚针聚在一起。类似今之丛针。

452. 一人臂上生一瘤，渐大如龙眼。其人用小艾于瘤上灸七壮，竟尔渐消，亦善法也。或用隔蒜灸之，亦无不可。

（《续名医类案》）

按 “疣”，多由肝经血燥，筋气不荣，气血失和，腠理不密，感受病毒，凝聚肌肤而成。治以调和气血，软坚解毒为法。故砭刺以除邪毒，艾灸以枯根源，使其气调血行，肌肤濡润，疣失给养，自行脱落。

蛇 丹（1则）

453. 吴××，男，16岁，学生。于1981年6月15日就诊。

患者于一周前发现右侧乳下自胸正中线至脊椎部，有针尖和米粒样大小之皮疹十余个，很快增多，串连成带状密集水疱，宽约3.5寸。曾在×医院治疗，用过肤轻松软膏、红霉素软膏、龙胆紫药水、板蓝根针剂等药物，均未获效，转来我科治疗。

现患处水泡已多数如绿豆至黄豆样大，顶端光亮，根底红肿，内充乳色混浊液，疼痛较剧。此乃湿热之毒蕴结皮下，发为蛇丹。拟予针刺灸以活血化瘀、燥湿解毒治之。

治法 （1）针刺取穴：大椎、委中（双侧）、曲池（双侧）、三阴交（双侧）。

手法：大椎用泻法，其余各穴均用平补平泻。均留针15分钟，中间运针二次。

(2)薰灸：以艾绒置于长盒薰灸器中点燃，薰灸患处20分钟。

(3)薰灸前局部用酒精消毒后，以三棱针破水疱放水。

二诊：6月16日。经治疗后，疼痛立即减轻，水疱缩小，部分干瘪，根脚红晕消散大半。疗效显著，继用上法施治。

三诊：6月20日。现水疱全部干瘪结痂，不痛，稍有痒感，戒其不可手抓，可用酒精搽之以止痒，候其脱痂即愈。仅住五天即痊愈出院。

按：本病为湿热俱盛，刺大椎用泻，泻诸阳之热毒；取三阴交用补，培三阴之阴液。配曲池解表以散外邪，利湿以清里热。且《千金》谓本穴能治诸瘾疹，主身湿淫。佐委中一穴，因其善治腰部诸疾，并能解毒疗疮，如《治疗捷要》曰：“委中穴，刺之不独疗疮有效，即如痲痘发背红肿及脚风淫；……针之亦效”。艾烟薰灸，善燥湿解毒，促进收水结痂，蛇丹为本疗法之适应症。

(周德宜医案)

癬(1则)

414.一女子年十五，两股间湿癬，长三四寸，下至膝发痒，时爬搔，汤火俱不解。痒定，黄赤水流，痛不可忍。灸炳薰燥，硫黄、茵茹、白僵蚕、羊蹄根之药，皆不效。其人姿性好巧，以此病不能出嫁。其父母求疗于戴人。戴人曰：能从我言则瘥。父母诺之。戴人以铍针磨令尖快，当以痒时，于

癬上各刺百余针，其血出尽，煎盐汤洗之。如此四次，大病方除。此方不书，以告后人，恐为癬药所误。湿淫于血，不可不砭者矣。

（《儒门事亲》）

按 《内经》云：“诸痛痒疮，皆属于心”；心主血脉，风湿之邪浸滋营血，流注肌肤，先痒后痛，搔破黄汁浸淫。《医宗金鉴》说：“此证初生如疥，瘙痒无时，蔓延无止，抓津黄水，浸淫成片，由心火、脾湿受风而成”。针刺痒部出血，一则直达病所，取其捷速，二则足阳明与足太阴之脉均循行于股部，砭刺之，使湿邪随血而洩，此开户逐寇之法也。

身 痒（1则）

455. 倪仲贤^{〔1〕}治吴陵盛架阁内子左右肩背上下患痒，至两臂、头面皆然。屡以艾灼痒处，暂止，且复作，如是数年。老人切其脉曰：左关浮盛，右口沉实，此酒食滋味所致也。投以清热化食行滞之剂，其痒遂止。

（《名医类案》）

注

〔1〕倪仲贤：明初医家。名维德，字仲贤。祖籍河南开封，迁居江苏吴县（今苏州）。著有《原机启微》一书，为现存较早的眼科专著。

按 遍身瘙痒，多因湿热蕴积肌肤，不得宣泄；或者血虚生风化燥，肌肤失养所致。艾灼局部，不失为法，但对范围广泛者，往往顾此失彼、并非上策。不若辨证论治，针艾并施。临床上常以委中、尺泽泄血，曲池、风池、血海、三

阴交针泻并艾条熏灸，每每收效。

遍身青（1则）

456. 尝有一家二奴，俱患身体遍青，渐虚羸不能食，访诸医无识者。嗣明^{〔1〕}为灸两足趺上各三七壮，便愈。

（北史·马嗣明传）

注

〔1〕嗣明：即马嗣明。北朝北齐时针灸家。河内（今河南沁阳）人。善针灸，其术精妙。

按 以证测病，当为脾胃气虚。气为血帅，气虚不能统血，摄血，以致血不循经，溢于脉络之外，渗与肌肤之间，故见身体遍青；中焦匮乏，症见羸瘦不食，治当补益脾胃。灸足趺者，指为胃原冲阳，灸之可调补后天，益气健脾，中气得健，血可归脾也。

紫 癍 风（1则）

457. 周桂娥，年二十六岁，两年前曾患血枯经闭，愈后渐觉手足酸痛，稍劳即发，今更痛甚而息短，痛时且有紫红色点，现于皮肤间，发过则隐。问情切脉，乃知瘀毒未经排泄，蕴于分肉之间，乘风而浮，风息则藏。盖心生血，脾统血，脾肺二官专司排瘀布新之职，以肝肾不调致土金失职。且脾主肌肉，四肢为脾之四末，根本颓长，紫红瘀现，随风止作也。乃为针肩髃、曲池、合谷、外关、风池、风府、阳陵泉、风市、足三里、三阴交、行间、申脉诸穴。三日后复诊，痛止点失，再针药一次而愈。

（陆善仲医案）

箭 伤（1 则）

458. 右臂中矢^{〔1〕}，炷以艾，力疾驰逐^{〔2〕}。

（《辽史·马人望传》）

注

〔1〕矢：古代称箭为矢。

〔2〕弛逐：快速追赶。

按 本案箭伤施灸，不仅立止疼痛，且可预防感染，收效捷速，此灸法之妙用也。

虫 兽 伤（7 则）

狼 咬 伤（1 则）

459. 一猎户，腿被狼咬，痛甚。治以乳香定痛散，不应。思至阴之下^{〔1〕}，血气凝结，药力难达，令隔蒜灸至五十余壮，瘀痛悉去，仍以托里药及膏药贴之而愈。

（《续名医类案》）

注

〔1〕至阴之下：马蒔曰：“地处于下，为至阴”。此指位置在下。

犬 咬 伤（3 则）

460. 一男子（为）疯犬所伤，牙关紧急，不省人事。急针

患处出毒血；更隔蒜灸，良久而醒。用太乙膏^{〔1〕}封贴；用玉真散^{〔2〕}二服稍愈，更以解毒散^{〔3〕}，二服而痊。若患重者，须先以苏合香丸灌之，后进汤药。

（《外科发挥》）

注

〔1〕太乙膏：方用大黄、赤芍、生地黄、玄参、肉桂、白芷、当归各一两。上药用麻油二斤，入铜锅熬煎至黑，滤去药渣，入黄丹十二两，再煎成膏。贴治一切疮疡。

〔2〕玉真散：方用生禹白附十二两（漂净），防风一两、白芷一两、生南星一两（漂净，姜汁炒）、天麻一两、羌活一两。上药共研细末，过筛即得，密闭贮藏。功能祛风止痉、止血止痛。治跌打损伤、金疮出血、破伤风、疯犬咬伤等症，可用冷开水调敷患处；或内服三分至五分，用热酒一盅调服。孕妇忌。

〔3〕解毒散：方用白矾一两、甘草末一两。共研细末，每服二钱，或冷开水调敷患处。主治一切毒蛇及虫兽所伤。

461. 一男子被犬伤，痛甚恶心，令急吮去毒血，隔蒜灸患处，数壮痛即止。更贴太乙膏，服玉真散而愈。

（《外科发挥》）

462. 王生被狂犬伤腿，顷间焮痛至股。翌日，牙关紧急。以玉真散治之，不应。隔蒜灸三十余壮而苏。仍以玉真散及托里消毒药而愈。

（《续名医类案》）

按 狂犬病，是一种人畜共患的自然疫源性疾病。常见于狗、狼、猫等动物引起，人被有病动物咬伤而感染。现代医学认为该病的病原体是“狂犬病毒”（又叫街毒），主要侵犯中枢神经系统。临床表现初起为乏力、头痛、呕吐、食欲差、喉部有紧缩感；继则出现狂躁、怕风、恐水等症状。数日后出现全身瘫痪，瞳孔散大等危象，病死率极高。历代对

狂犬病的治疗方法很多，上述各例，均经早期处理伤口，排出毒血，用隔蒜灸拔引邪毒，并外敷太乙膏，内服玉真散，昏迷者，可针刺人中、百会、十宣、内关等穴，并以苏合香丸灌服，温通开窍，解郁化浊。现在，如果明确被疯狗咬伤，应迅速彻底清创，及早注射狂犬疫苗，以防万一。

蝎 螫（1则）

463.立斋治陈鉴居庸关^{〔1〕}人，蝎螫手，疼痛彻心，顷刻，焮痛至腋，寒热拘急，头痛恶心，此邪正二气相搏而然。以飞龙奇命丹涂患处，及服止痛之药，俱不应。乃以隔蒜灸法灸之，遂愈。薛母及薛皆尝被螫，如前灸之，痛即止。薛母又尝为蜈蚣伤指，亦用前法而愈。凡蜈蚣毒之类所伤，依此疗之，并效。本草谓：蒜疗疮毒，有回生之功。

（《续名医类案》）

注

〔1〕庸关：地名。在今湖北省竹山县东南。

按 蝎，又名全虫。其尾刺呈钩状，上屈，内有毒腺。其毒系一种类似蛇毒神经毒的蛋白质。螫伤后局部红肿剧痛，重症可有寒战、高热、恶心、呕吐等症状。蜈蚣，又名百脚。其毒含蚁酸类，咬伤后局部肿胀，发痒，浑身麻木，重则危及生命。治疗除服解毒之品外，亦可针砭患处，放出毒血，并隔蒜灸患处，可以解毒止痛。隋代僧人梅深师曾治一蜈蚣咬人痛不止，用独头蒜摩螫处，痛止。（见《梅师集验方》）大蒜和艾配合使用，共奏解毒消肿，缓和疼痛之功。通过隔蒜灸，还可使郁毒外泄，扶正抗邪。不管是蝎螫还是蚊虫叮咬造成的疼痛、痒麻等不适感觉，经艾灸的温热刺

激，均可很快缓解症状。

毒蛇咬伤（2则）

464. 朝野签记载：毒蛇所伤，用艾灸，当啮处灸之，引去毒气即差。其余恶虫所螫、马汗入疮，用之亦效。

（《医说》）

465. 甘××，女，10岁，住汉阳县侏儒公社百赛大队三小队。

自诉：晚间在草丛中玩耍，突被蛇咬伤左足内踝下方，即来诊。

查：见伤处有四个明显的粗而深的毒蛇齿痕，局部青紫肿痛。为了进一步判断是否毒蛇咬伤，即叫患儿口嚼烟丝，患儿口中毫无辣味，诊断为毒蛇咬伤。

治疗：用带子将伤口上方扎紧，并用三棱针刺其伤口和周围，再用小口火罐拔出恶血，然后用枣大艾炷直接灸伤口上五壮，继之又切五分硬币大小蒜片贴伤口处，又灸了七壮，疼痛即止。继续观察半小时，病情稳定，嘱其回家休息。次日家访，患儿已玩耍自若。

按：在很多针灸文献中，有不少专治毒蛇咬伤的记载。如《针灸资生经》中记载：山居人，或被蛇所伤，即以溲溲之、拭干，以艾灸之效。又说：艾炷当毒蛇啮处灸，引出毒气差，薄切独头蒜贴蛇咬处灸，热彻即止。灸蛇毒上三七壮，无艾以火头称疮孔大小热之。《针灸聚英》中记载：凡人若是蛇伤者，亦把咬处灸三壮，仍以蒜片贴咬处，灸在蒜上即安康。《类经图翼》中记载：凡蛇伤中毒者，灸毒上三七壮。若一时无艾，以火炭头称疮孔大小热之。又说：凡蛇

蝎蜈蚣咬伤，痛极势危者，急用艾火于伤处灸之，拔散毒气即安。或用独头蒜片隔蒜灸之，二三壮换一片，毒甚者，灸五十壮，或内服紫金丹亦妙。《针灸集成》中记载：蛇咬伤人，灸伤处二三壮，仍以蒜片贴咬处灸蒜上。

（王永生医案）

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医